

尚论篇

喻昌

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们

尚论篇

卷首

卷一

卷二

卷三

卷四

尚论后篇

卷一

卷二

卷三

卷四

3

5

6

15

45

59

67

81

82

95

113

128

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

尚论篇

卷首

喻昌 撰

尚论张仲景伤寒论大意

后汉张仲景，着卒病伤寒论十六卷，当世兆民赖以生全，传之后世，如日月之光华，旦而复旦，万古常明可也，斯民不幸，至晋代不过两朝相隔，其卒病论六卷，已不可复睹，即伤寒论十卷，想亦劫火之余，仅得之读者之口授，故其篇目先后差错，赖有三百九十七法，一百一十三方之名目，可为校正，太医令王叔和附以己意，编集成书，共二十二篇，后人德之，称为仲景之徒，究竟述者之明，不及作者之圣，祇令学者童而习之，白首不得其解，虽有英贤辈出，卒莫能舍叔和疆畛，追溯仲景渊源，于是偶窥一斑者，各鸣一得，好庞安常，朱肱，许叔微，韩祇和，王实之流，非不互有阐发，然不过为叔和之功臣止耳，未见为仲景之功臣也，今世传仲景伤寒论，乃宋秘阁臣林亿所校正，宋人成无己所詮注之书也，林亿不辨朱紫菽粟，谓自仲景于今，八百余年，惟王叔和能学之，其间如葛洪，陶景，胡洽，徐之才，孙思邈辈，皆不及也，又传称成无己注伤寒论十卷，深得长沙公之秘旨，殊不知林，成二家，过于尊信叔和，往往先传后经，将叔和纬翼仲景之辞，且混编为仲景之书，况其他乎，如一卷之平脉法，二卷之序例，其文原不雅驯，反首列之以错乱圣言，则其所为校正，所谓詮注者，乃仲景之不幸，斯道之大厄也，元泰定间，程德斋作伤寒论法，尤多不经，国朝王履，并三百九十七法，一百一十三方，亦窃疑之，谓仲景书甚平易明白，本无深僻，但王叔和杂以己意，遂使客反胜主，而仲景所以创法之意，沦晦不明，今欲以伤寒例居前，六经病次之，类伤寒病又次之，至若杂病、杂脉、杂论，与伤寒无预者皆略去，计得二百八十三条，并以治字易法字，而曰二百八十三治，虽有深心，漫无卓识，亦何足取，万历间，方有执着伤寒条辨，始先即削去叔和序例，大得尊经之旨，然未免失之过激，不若爱礼存羊，取而驳正之，是非既定，功罪自明也，其余太阳三篇，改叔和之旧，以风寒之伤营卫者分属，卓识超越前人，此外不达立言之旨者尚多，大率千有余年，若明若昧之书，欲取而尚论之，加日月之光昭宇宙，必先振举其大纲，然后详明其节目，始为至当不易之规，诚以冬春夏秋，时之四序也，冬伤于寒，春伤于温，夏秋伤于暑热者，四序中主病之大纲也，举三百九十七法，分列于大纲之下，然后仲景之书，始为全书，其冬伤于寒一门，仲景立法，独详于春夏秋三时者，盖以春夏秋时令，虽有不同，其受外感则一，自可取治伤寒之法，错综用之耳，仲景自序云，学者若能寻余所集，思过半矣，可见引伸触类，治百病有余能，况同一外感乎，是春夏秋之伤温伤热，明以冬月伤寒为大纲矣，至伤寒六经中，又以太伤一经为大纲，而太阳经中，又以风伤卫，寒伤营，风寒两伤营卫为大纲，何也，大纲混于节目之中，无可寻绎，祇觉其书之残缺难读，今大纲既定，然后详求其节目，始知仲景书中，矩则森森母论法之中更有法，即方之中亦更有法，通身手眼，始得一一点出，读之而心开识朗，不复为从前之师说所燻，浸假繇其道而升堂入室，仲景弥光，而吾生大慰矣，

知我罪我，亦何计哉。

尚论仲景伤寒论先辨叔和编次之失

尝观王叔和汇集扁鹊、仲景、华元化先哲脉法为一书，名曰脉经，其于仲景伤寒论，尤加探讨，宜乎显微毕贯，曲畅创法制方之本旨，以后后人之信从可也，乃于汇脉之中，间一汇证，不该不贯，犹曰汇书之常也，至于编述伤寒全书，苟简粗率，仍非作者本意，则吾不知之矣，如始先序列一篇，蔓引赘辞其后，可与不可，诸篇独遗精髓平脉一篇，妄入己见，总之碎剪美锦，缀以败絮，盲瞽后世，无繇复睹黼黻之华泥于编述，大意私淑原委，自首至尾，不叙一语，明以贾人居奇之术，致令黄歧一脉，斩绝无遗，悠悠忽忽，沿习至今，所谓千古疑窦，莫此难破，兹欲直溯仲景全神，不得不先勘破叔和，如太阳经中证绪分头，后学已难入手，乃更插入温病、合病、并病、少阳病、过经不解病，坐令读者茫然，譬诸五谷，虽为食宝，设不各为区别，一概混种混收，鲜不貽耕者食者之困矣，如阳明经中，漫次仲景偶举问答一端隶于篇首，纲领倒置，先后差错，且无扼要，至于春温夏热之证，当另立大纲，颛自名篇者，乃懵然不识，此等大关一差，则冬伤于寒，春伤于温，夏秋伤于暑热之旨尽晦，致后人误以冬月之方，施于春夏，而归咎古方之不可以治今病者，谁之过欤，至于霍乱病、阴阳易、差后劳复等证，不过条目中事耳，乃别立篇名，与六经并峙，又何轻所重而重所轻耶，仲景之道，人但知得叔和而明，孰知其因叔和而坠也哉。

尚论仲景伤寒论先辨林亿成无己校注之失

王叔和于仲景书，不察大意，妄行编次补缀，尚存阙疑一线，观其篇首之辞，谓痉湿喝虽同为太阳经病，以为宜应另论者，其一征也，观其篇中，谓疾病至急，仓卒寻按，要旨难得，故重集可与不可方治者，其一征也，观其篇末补缀脉法，分为二篇，上篇仍仲景之旧，下篇托仲景以传，犹未至于颠倒大乱者，其一征也，第其不露补缀之痕，反以平脉本名，易为辨脉，而阴行一字之颠倒，此吾所为讥其僭窃耳，若夫林亿之校正，成无己之诠注，则以脉法为第一卷矣，按仲景自叙云，平脉辨证，为伤寒卒病论，合十六卷，则脉法洵当隶于篇首，但晋承汉统，仲景遗书未湮，叔和补缀之言，不敢混入，姑附于后，不为未见，二家不察，竟遗编篇首，此后羚羊挂角，无迹可求，讵能辨其孰为仲景，孰为叔和乎，然犹隐而难识也，其序例一篇，明系叔和所撰，何乃列于第二卷，岂以仲景之书，非序例不能明耶，即使言之无弊，亦无先传后经之理，况其蔓引赘辞，横插异气，寸踰尺瑕，何所见而崇信若是，致令后学画蛇添足，买椟还珠，煌煌圣言，千古无色，是二家羽翼叔和以成名，比以长君逢君，无所逃矣，至于注释之差，十居六七，夫先已视神髓为糟粕矣，更安望阐发精理乎。

驳正王叔和序例

〔王叔和序例，传习已久，中人已深，欲削去之，而坊刻盛行，难掩众目，姑存原文，驳正其失，以定所宗，非故攻击前贤，实不得已之思耳。〕

阴阳大论云，春气温和，夏气暑热，秋气清凉，冬气冷冽，此则四时正气之序也，冬时严寒，万类深藏，君子固密，则不伤于寒，触冒之者，乃名伤寒耳，其伤于四时之气，皆能为病，以伤寒为毒者，以其最成杀厉之气也。引用内经，足见大意，然入一毒字，便开过端。中而即病者，名曰伤寒，不即病者，寒毒藏于肌肤。寒邪繇肌肤而入，辛苦之人，邪藏肌肤则有之，若膏粱辈，冬不藏精者，其寒邪且有藏于骨髓者矣，是未可以一端定也。至春变为温病。变字下得诞怪骇人。设谓春气既转为温，则病发不当名伤寒，当变其名为温病则正矣。至夏变为暑病。此一语尤为无据，盖暑病乃夏月新受之病，岂有冬月伏寒，春时不发，至夏始发之理乎。设谓是气既转为热，外邪当变，名为热病则正矣。暑病者，热极重于温也。此一语更添蛇足，设有冬时伏寒，至春不发，其邪本轻可知，岂有反重于温之理乎，其误始于杨操是以辛苦之人，春夏多温热病，皆繇冬时触寒所致，非气行之气也。内经但言冬伤于寒，春必病温，未尝言夏必病暑也，但夏伤于暑，秋必痾，未尝牵引冬春也，其意盖谓春月之病，始于冬，秋月之病，始于夏耳，此等关头不彻，故以温热病并举，故谓暑重于温。

凡时行者，春时应暖而反大寒，夏时应热而反大凉，秋时应凉而反大热，冬时应寒而反大温，此非其时而有其气，是以一岁之中，长幼之病，多相似者，此则时行之气也。未明伤寒，先明异气，借客形主，似无不可，但伤寒要领，全不挈出，通篇有客无主，殊不可耳。

夫欲候知四时正气为病，及时行疫气之法，皆当按斗历占之，九月霜降后，宜渐寒，向冬大寒，至正月雨水节后宜解也，所以谓之雨水者，以冰雪解而为雨水故也，至惊蛰二月节后，气渐和暖，向夏大热，至秋便凉，从霜降以后，至春分以前，凡有触冒霜露，体中寒即病者，谓之伤寒也，其冬有非节之暖者，名曰冬温，冬温之毒，与伤寒大异，冬温复有先后，更相重沓，亦有轻重，为治不同，证如后章。漫衍己意，明异气之轻重不同，于仲景之文无涉，况所言纰谬。证如后章，其意指篇后，温疟、风温、温毒、温疫为言，此无识之最者也，然后来诸家偏奉之为祖，诎非得所托而传信耶，真紫之夺朱，郑声之乱雅乐矣，详辨附序例后。

从立春节后，其中无暴大寒，又不冰雪，而有人壮热为病者，此属春时阳气，发于冬时，伏寒变为温病，于字费解。到底说变为温病，真是诚淫生心。

从春分以后，至秋分节前，天有暴寒者，皆为时行寒疫也。此正春温夏暑秋湿三气主病之时，何乃全不序及，反重衍夏秋之异气，搅乱经常，岂非三时原无正气主病乎，抑仲景论中原无纲领可求乎，可见医事自晋代已失所宗，何况今日哉。

三月四月，或有暴寒，其时阳气尚弱，为寒所折，病热犹轻，五月六月，阳气已盛，为寒所折，病热则重，七月八月，阳气已衰，为寒所折，病热亦微，其病与温及暑病相似，但治有殊耳。以阳气为暴寒，所折，而为病热之轻重，前去暑病重于温，从此左见耳。叔和未尝序明温暑病也，兹云异气病，与温暑病相似，但治有殊，然则温暑病，将何似耶，将何治耶，疏漏多矣。十五日得一气，于四时之中，一时有六气，四六名为二十四气也，然气候亦有应至而不至，或有未应至而至者，或有至而太过者，皆成病气也，但天地动静，阴阳鼓击者，各正一气耳，是以彼春之暖，为夏之暑，彼秋之沍，为冬之怒。蔓衍内经不见大意是故冬至之后，一阳爻升，一阴爻降也，夏至之后，一阳气下，一阴气上也。此复姤二卦之义，引入序例不切。斯则冬夏二至，阴阳合也，春秋二分，阴阳离也。此分至之义，内经谓至则气同，分则气异，何等明显，纔换合离二字，便自骇观。阴阳交易，人变病焉。内经谓阴阳相错，而变由生也，何等圆活，纔换交易变病等字，便费解，此变温变暑所自来乎，此君子春夏养阳，秋冬养阴，顺天之刚柔也。内经谓养阳以凉以寒，养阴以温以热，所以然者，从其根故也，妙义合为疏出。小人触冒，必婴暴疹，须知毒烈之气，留在何经，而发何病，详而取之。前云寒毒藏于肌肤，此云不知留在何经，而发何病，非故自相矛盾，其意实为温症、风温、温毒、温疫，作开山祖师也，后人孰辨其为一场懵懂乎。是以春伤于风，夏必飧泄，夏伤于暑，秋必病疟，秋伤于湿，冬必咳嗽，冬伤于寒，春必病温，此必然之道，可不审明之。此伤于四时之正气而为病者，但内经先言冬伤于寒，春必病温，乃至伤风伤暑，以次递及，春夏秋三时之病，多始于冬，秋冬二时之病，多始于夏耳，然飧泄与咳嗽，兼涉内因，惟伤寒伤温伤暑，方是外感之证，仲景会此意，故以伤寒立论，而苞举温暑在内如丝入扣，殆非不知而作，若叔和引经，止以春夏秋冬为序，浑与流俗之见无别矣，此歧路之纷趋，所由来者远也。伤寒之病，逐日浅深，以施方治，今世人伤寒，或始不早治，或治不对病，或日数久淹，因乃告医，医人又不依次第而治之，则不中病，皆宜临时消息制方，无不效也，今搜采仲景旧论，录其证候诊脉声色对病真方，有神验者，拟防世急也。仲景之书，叔和但言搜采，其非寤寐神游可知，所以不窥作者之原，漫无表章之实，孰谓叔和为仲景之徒耶。又土地温凉高下不同，物性刚柔飧居亦异，是故黄帝兴四方之问，歧伯举四治之能，以训后贤，开其未悟者，临病之工，宜须两审也。仲景于黄歧之道，以述为作，另辟手眼，叔和凡引内经之文，皆非典要，安能发明其什一。凡伤于寒，则为病热，热虽甚不死，若两感于寒而病者必死，尺寸俱浮者，太阳受病也，当一二日发，以其脉上连风府，故头项痛，腰脊强，尺寸俱长者，阳明受病也，当二三日发，以其脉挟鼻络于目，故身热目疼鼻干，不得卧，尺寸俱弦者，少阳受病也，当三四日发，以其脉循胁络于耳，故胸胁痛而耳聋，此三经皆受病，未入于府者，可汗而已，尺寸俱沉细者，太阴受病也，当四五日发，以其脉布胃中，络于嗑，故腹满而噤干，尺寸俱沉者，少阴受病也，当五六日发，以其脉贯肾，络于肺，系舌本，故口燥舌干而渴，尺寸俱微缓者，厥阴受病也，当六七日发，以其脉循阴器，络于肝，故烦满而囊缩，此三经皆受病，已入于府，可下而已。入府未入府，少变内经入藏原文，此处却精。若两感于寒者，一日太阳受之，即与少阴俱病，则头痛口干，烦满而渴，二日阳明受之，即与

太阴俱病，则腹满身热，不欲食，讖语，三日少阳受之，即与厥阴俱病，则耳聋囊缩而厥，水浆不入，不知人者六日死，若三阴三阳五藏六府皆受病，则营卫不行，府藏不通，则死矣。其得病阴阳两证俱见，其传经亦阴阳两经俱传，则邪气弥满充斥，法当三日主死，然必水浆不入，不知人者，方为营卫不行，府藏不通，更越三日而阳明之经脉始绝也，引内经微旨，序两感病甚精。其不两感于寒，更不传经，不加异气者，至七日太阳病衰，头痛少愈也，八日阳明病衰，身热少歇也，九日少阳病衰，耳聋微闻也，十日太阴病衰，腹减如故，则思饮食，十一日少阴衰，渴止舌干，〔干当作润〕已而嚏也，十二日厥阴病衰，囊纵少腹微下，邪气皆去，病人精神爽慧也。自凡伤于寒，则为病热至此，皆内经热论篇原文，叔和但增更不传经八个字，便有许多牵强。若过十三日以上，不问尺寸陷者大危。尺寸之脉深陷，正气衰微，莫能载邪外出，既已通经，其病不间诚为危候。若更感异气变为他病者，当依旧坏症病而治之。仲景于坏症，全不立法，其太阳经之坏症，知犯何逆，原用太阳经本法治之，其少阳经之坏症，知犯何逆，原用少阳经本法治之，岂有更加异气，可虽用太少二经诸法治之之理，观此则叔和漫不知坏证作何解，乃教后人遵用其法，所谓一盲引众盲，相将入火坑也，悲哉。若脉阴阳俱盛，重感于寒者变为温疟，阳脉浮滑，阴脉濡弱者，更遇于风，变为风温，阳脉洪数，阴脉实大者，更遇温热，变为温毒，温毒为病最重也，阳脉濡弱，阴脉弦紧者，更遇温气，变为温疫，以此冬伤于寒，发为温病，脉之变证，方治如法。叔和每序伤寒，必插入异气，欲鸣已得也，及序异气，则借意难经，自作聪明，漫拟四变，疑鬼疑神，寝成妖妄，难经虽云，伤寒有五，其脉有变否，变者，辨也，辨脉定证也，设使叔和稍为平易，但云冬伤于寒，至春重感于寒，其脉阴阳俱盛者，名为温疟，冬伤于寒，至春更遇于风，其脉阳浮滑，阴濡弱者，名为风温，乃至温毒温疫，俱顺理立说，则虽拟病失伦，而大关不害为正，其加叔和未肯平易何，后世但知叔和为伤寒论作序例，不识其草泽奸雄，称孤道寡，故有晋以后之谭医者，皆伪统也，今移论春温大意，并论温疫大意二篇，附序例后，其详载在春温卷中。凡人有疾，不时即治，隐忍冀差，以成锢疾，小儿女子，益以滋甚，时气不和，便当早言，寻其邪由，及在腠理，以时治之，罕有不愈者，患人忍之，数日乃说，邪气入藏，则难可制，此为家有患备虑之要。凡作汤药，不可避晨夜，觉病须臾，即宜便治，不等早晚，则易愈矣，如或差迟，病即传变，虽欲除治，必难为力，服药不如方法，纵意违师，不须治之。此巴人下里之音，通国所为和之者乎。凡伤寒之病，多从风寒得之，始表中风寒，入里则不消矣，未有温覆而当，不消散者，不在证治，拟欲攻之，犹当先解表，乃可下之，若表已解，而内不消，非大满，犹生寒热，则病不除，若表已解，而内不消，大满大实，坚有躁屎，自可除下之，虽四五日，不能为祸也，若不宜下而便攻之，内虚热入，协热遂利烦躁，变不可胜数，轻者困笃，重者必死矣。叔和笔力软弱缠扰，如此一段，入理深谭，正未可及，后人不善读者，每遇阳明二三日下证，藉为口实，延至六七日方下，而枯槁无救者多矣，此则于叔和何尤。夫阳盛阴虚，汗之则死，下之则愈。引难经辞不达意，最足惑人，其意谓阳邪不解，下入阴中，以阳盛阴，则为阳盛阴虚，故可下而不可汗，然前云此三阴邪入于里，可下而已，于理甚精，此但云阳盛阴虚，则阳邪或在本位，而未入于府，尚不可知，安

见其可下乎，若然，所云大满犹生寒热，不可攻下之说，自相矛盾矣。阳虚阴盛，汗之则愈，下之则死。阳虚阴盛，多有直中阴经之候，汗之则愈，谭何容易，其意谓阴乘阳位，则为阳虚阴盛，故可汗而不可下，然外邪初入阳分，终非阴盛可拟，难经有问有答，即表病里曷不绎明引之。夫加是，则神丹安可以误发，甘遂何可以妄攻，虚盛之治，相背千里，吉凶之机，应若影响，岂容易哉，况桂枝下咽，阳盛则毙。风邪入卫，则为阳邪炽盛于表，仲景用桂枝汤，以解散肌表之邪，正天然不易之良法也，何反构此危词，岂误以寒邪入营为阳盛耶，夫寒邪入营，但为阴邪炽盛于表，所以仲景于脉浮紧无汗者，有桂枝之禁，谓当用麻黄汤也，即误用桂枝，亦未必遂成死证，于下咽即毙，视等砒霜，妄为郑重，叔和全不达仲景之旨，毋怪后人之吠声矣。承气入胃，阴盛以亡。即难经阳虚阴盛，下之则死之说，衍入承气，务以惑人。直中阴经之证，大势阴盛阳虚，传经伤寒之证，大势阳盛阴虚，症证，大势阴阳更盛更虚，内伤证，大势阴阳偏盛偏虚，而不可同语，亦不必语。死生之要，在乎须臾，视身之尽，不暇计日，此阴阳虚实之交错，其候至微，发汗吐下之相反，其祸至速，而医术浅狭，懵然不知病源，为治乃误，使病者殒没，自谓其分，至今冤魂塞于冥路，死尸盈于旷野，仁者鉴此，岂不痛欤。凡两感病俱作，治有先后，发表攻里，本自不同，而执迷妄意者，乃去神丹甘遂，合而饮之，且解其表，又除其里，言巧似是，其理实违，夫智者之举错也，尝审以慎，愚者之动作野也，必果而速，安危之变，岂可诡哉，世上之士，但务彼翦习之荣，而莫见此倾危之败，惟明者能护其本，近取诸身，夫何远之有焉。两感病，治有先后，发表攻里，本自不同，持说甚正，惜其不致详耳。凡发汗温服汤药，其方虽言日三服，若病剧不解，当促其间，可半日中进三服，若与病相阻，即便有所觉，病重者，一日一夜，当晬时观之，若服一剂，病证犹在，故当复作本汤服之，至有不肯汗出，服三剂乃解，若汗不出者，死病也。凡得时气病，至五六日而渴，欲饮水，饮不能多，不当与也，何者，以腹中热尚少，不能消之，便更与人作病也，至七八日大渴，欲饮水者，犹当依证而与之，与之常令不足，勿极意也，言能饮一斗，与五升，若饮而腹满，小便不利，若喘若嘔，不可与之也，忽然大汗出，是为自愈也。凡得病反能饮水，此为欲愈之病，其不晓病者，但闻病饮水自愈，小渴者乃强与饮之，因成其祸，不可以复数也。时气病饮水，能消不能消，当与勿强与，有次第。凡得病厥脉动数，服汤药更迟，脉浮大减小，初躁后静，此皆愈证也。凡治温病，可刺五十九穴，又身之穴三百六十有五，三十六穴，灸之有害，七十九穴，刺之为灾，并中髓也。引用内经，五十九刺之法，治温中窍。凡脉四损三日死，平人四息，病人脉一至，名曰四损，脉五损，一日死，平人五息，病人脉一至，名曰五损，脉六损，一时死，平人六息，病人脉一至，名曰六损，脉盛身寒，得之伤寒，脉虚身热，得之伤暑，脉阳阴俱盛，大汗出不解者死，脉阴阳俱虚，热不止者死，脉至乍疏乍数者死，脉至如转索者其日死，讖言妄语，身微热，脉浮大，手足温者生，逆冷脉沉细者，不过一日死矣，此以前是伤寒热病证候也。引损脉入伤寒大谬，按仲景遵内经热病之旨，作伤寒论，明以内经为例，叔和可无序也，即欲附赘引内经原文发明切要，以便后学足矣，其插入异气，蔓衍繁文，诚何心哉，岂以仲景所无，炼石足补天缺耶，则自勒一家言，另纬其后，听人之从违可耳，乃造不经之说，混乱经常

，至经常大义，不掣一语，以此网罗英贤，悉入彀中，其授受之途，盖已千年长夜矣，有志跻仲景之堂者，能无大剖叔和之藩也哉。

论春温大意并辨叔和四变之妄

喻昌曰，春温之证，内经云，冬伤于寒，春必病温，又云，冬不藏精，春必病温，此论温起之大原也，伤寒论云，太阳病发热而渴，不恶寒者为温病，若发汗已，身灼热者，名曰风温，风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出，若被下者，小便不利，直视失溲若被火者，微发黄色，剧则如惊痫时瘈瘲，若火熏之，一逆尚引日，再逆促命期，此论温成之大势也，仲景以冬不藏精之温，名曰风温，其脉阴阳俱浮，正谓少阴肾与太阳膀胱，一脏一腑，同时病发，所以其脉俱浮也，发汗后，身反灼热，自汗出，身重多眠睡，鼻息必鼾，语言难出，一一尽显少阴本证，则不可复从太阳为治，况脉浮自汗，更加汗之，医杀之也，所以风温证，断不可汗，即或误下误火，亦经气伤而阴精尽，皆为医促其亡，而一逆再逆，促命期矣，于此见东海西海，心同理同，先圣后圣，其揆一也，后人不察，惜其有论无方，讷知森森治法，全具于太阳少阴诸经乎，晋王叔和不究仲景精微之蕴，栽风种电，为不根之谈，妄立温症、风温、温毒、温疫四变，不思时发时止为症，症非外感之正病也，春木主风而气温，风温即是温证之本名也，久病不解，其热邪炽盛，是为温毒，亦病中之病也，至温疫则另加一气，乃温气而兼瘟气，又非温证之常矣，今且先辨温症，温症正冬不藏精之候，但其感邪本轻，故止成症耳，黄帝问温症舍于何藏，歧伯对曰，温症得之冬中于风，寒气藏于骨髓之中，至春则阳气大发，邪气不能自出，因遇大暑，骨髓数烁，肌肉消，腠理发泄，或有所用力，邪气与汗皆出，此病藏于肾，其气先从内出之于外也，如是者，阴虚而阳盛则热矣，衰则气复反入，入则阳虚，阳虚则寒矣，故先热而后寒曰温症，此可见温症为冬不藏精，故寒邪得以入肾，又可见温症遇温，尚不易发，必大暑大汗始发之也，叔和反以重感于寒立说，岂其不读内经乎，抑何不思之甚耶，今且再辨风温，春月时令本温，且值风木用事，风温二字，自不得分之两，凡病温者，悉为风温，即如初春，地气未升，无湿温之可言也，天气微寒，无热温之可言也，时令和煦，无温疫之可言也，其所以主病之故，全系于风，试观仲景于冬月正病，以寒统之，则春月正病，定当以风统之矣，夫风无定体，在八方则从八方，在四时则从四时，春之风温，夏之风热，秋之风凉，冬之风寒，自然之道也，叔和因仲景论温条中，重掣风温，故谓另是一病，不知仲景于温证中特出手眼，致其叮咛，见冬不藏精之人，两肾间先已习习风生，得外风相召而病发，必全具少阴之证，故于温字上加一风字，以别太阳之温耳，叔和妄拟重感重变，乃至后人作赋云，风温湿温兮，发正汗则危恶难医，又云，因知风温汗不休，当用汗防己，隔靴搔痒，于本来之面目安在哉，今且再辨温毒，夫温证中之有温毒，一如伤寒证中之有阳毒阴毒也，伤寒不以寒毒另为一证，则温病何得以温毒更立一名耶，况温毒复有阴阳之辨，太阳温证，病久不解，结成阳毒，少阴温证，病久不解，结成阴毒，叔和不知风温为阴邪，故但指温毒为阳毒，以致后人袭用黑膏紫雪，阴毒当之，惨于锋刃，其阶厉亦至今未

已耳，其温疫一证，另辨致详。

详论温疫以破大惑

喻昌曰，圣王御世，春无愆阳，夏无伏阴，秋无凄风，冬无苦雨，乃至民无夭扎，物无疵疠，太和之气，弥满乾坤，安有所谓温疫哉，然而周礼雩以逐疫，方相氏掌之，则温疫之由来，古有之矣，乡人雩，孔子朝服而致其诚敬，盖以装演巨像为雩神，不过彷彿其形，圣人以正气充塞其间，俾疫气潜消，乃位育之实功耳，古人元旦汲清泉，以饮芳香之药，上巳采兰草，以袪芳香之气，重溲秽也，后汉张仲景着伤寒论，欲明冬寒春温夏秋暑热之正，自不能并入疫病以混常法，然至理已毕具于脉法中，叔和不为细绎，乃谓重感于寒，变为温疫，又谓春时应暖而复大寒，夏时应大热而复大凉，秋时应凉而反大热，冬时应寒而反大温，此非其时而有其气，是以一岁之中，长幼之病，多相似者，此则时行之气也，又谓冬温之毒，与伤寒大异，冬温复有先后，更相重沓，亦有轻重，为治不同，又谓从春分节后，至秋分节前，天有暴寒者，皆为时行寒疫也，盖以春夏秋为寒疫，冬月为温疫，所以又云三月四月，或有暴寒，其时阳气尚弱，为寒所折，病热犹轻，五月六月，阳气已盛，为寒所折，病热则重，七月八月，阳气已衰，为寒所折，病热亦微，后人奉此而广其义，谓春感清邪在肝，夏感寒邪在心，秋感热邪在肺，冬感温邪在肾，埏簸递奏，举世若狂矣，嗟嗟，疫邪之来，果寒折阳气，乘其所胜，而直入精神魂魄之藏，人无啾类久矣，更有谓疫邪无形象声臭，定时定方可言，是以一岁之中，长幼莫不病此，至病伤寒者，百无一二，治法非疏里则表不透，非战汗则病不解，愈募愈远，究竟所指之疫，仍为伤寒伤温伤暑热之正病，疏里则下早可知，战汗则失表可知，祇足自呈败阙耳，夫四时不正之气，感之者因而致病，初不名疫也，因病致死，病气尸气，混合不正之气，期为疫矣，以故鸡瘟死鸡，猪瘟死猪，牛马瘟死牛马，推之于人何独不然，所以饥馑兵凶之际，疫病盛行，大率春夏之交为甚，盖温暑热湿之气交结互蒸，人在其中，无隙可避，病者当之，魄汗淋漓，一人病气，足充一室，况于连床并榻，沿门阖境，共酿之气，益以出户尸虫，载道腐壤，燔柴掩席，委壑投崖，种种恶秽，上溷苍天清静之气，下败水土物产之气，人受之者，亲上亲下，病从其类，有必然之势，如世俗所称大头瘟者，头面腮颐，肿如瓜瓠者是也，所称虾蟆瘟者，喉痹失音，颈筋胀大者是也，所称瓜瓢瘟者，胸高起肋起，呕汁如血者是也，所称疙瘩瘟者，通身红肿，发块如瘤者是也，所称绞肠瘟者，腹鸣干呕，水泄不通者是也，所称软脚瘟者，便清泄白，足重难移者是也，小儿痘疮尤多，以上疫证，不明治法，咸委之劫运，良可伤悼，大率瘟疫痘疹，古昔无传，不得圣言折衷，是以坠落叔和坑塹，曾不若俗见摸索病状，反可顾名思义也，昌幸微窥仲景一班，其平脉篇中云，寸口脉阴阳俱紧者，法当清邪中于上焦，浊邪中于下焦，清邪中上，名曰洁也，浊邪中下，名曰浑也，阴中于邪，名曰栗也，凡二百六十九字，阐发奥理，全非伤寒中所有事，乃论疫邪从入之门，变病之总，所谓赤文绿字，开天辟地之宝符，人自不识耳，篇中大意，谓人之鼻气通于天，故阳中雾露之邪者为清邪，从鼻息而上入于阳，入则发热头痛项强颈挛，正与俗称大头瘟虾?瘟之说

符也，人之口气通于地，故阴中水土之邪者，为饮食浊味，从口舌而下入于阴，入则其人必先内栗，足膝逆冷，便溺妄出，清便下重，脐筑湫痛，正与俗称绞肠瘟软脚瘟之说符也，然从鼻从口所入之邪，必先注中焦，以次分布上下，故中焦受邪，因而不治，中焦不治，则胃中为浊，营卫不通，血凝不流，其酿变即现中焦，俗称瓜瓢瘟疙痞瘟等证，则又阳毒痈脓，阴毒遍身青紫之类也，三焦定位之邪也，若三焦邪溷为一，内外不通，藏气熏蒸，上焦怫郁，则口烂食断，卫气前通者，因热作使，游行经络藏府，则为痈脓，营气前通者，因召客邪嚏出，声喑咽塞，热壅不行，则下血如豚肝，然以营卫渐通，故非危候，若上焦之阳，下焦之阴，两不相接，则脾气之中，难以独运，斯五液注下，下焦不阖，而命难全矣，伤寒之邪，先行身之背，次行身之前，次行身之侧，繇外廓而入，温疫之邪，则直行中道，流布三焦，上焦为清阳，故清邪从之上入，下焦为浊阴，故浊邪从之下入，中焦为阴阳交界，凡清浊之邪，必从此区分，甚者三焦相溷，上行极而下，下行极而上，故声喑咽塞，日烂食断者，亦复下血加豚肝，非定中上不及下，中下不及上也，伤寒邪中外廓，故一表即散，疫邪行在中道，故表之不散，伤寒邪入胃府，则腹满便坚，故可攻下，疫邪在三焦，散漫不收，下之复合，此与治伤寒表里诸法，有何干涉，奈何千年愤愤，试折中以圣言，从前迷谬，宁不涣然冰释哉，治法未病前，预饮芳香正气药，则邪不能入，此为上也，邪既入急以逐秽为第一义，上焦如雾，升而逐之，兼以解毒，中焦如沤，疏而逐之，兼以解毒，下焦如渌，决而逐之，兼以解毒，营卫既通，乘势追拔，勿使潜滋，详订诸方，载春温方后。有问春夏秋蒸气成疫，岂冬温独非疫耶，余曰冬月过温，肾气不藏，威而成病，正与不藏精之春温无异，计此时有春无冬，三气即得交蒸成疫，然遇朔风骤发，则蒸气化乌有矣，是以东南冬月患正伤寒者少，患冬瘟及痘疮者最多，西北则秋冬春，皆患正伤寒，殊无瘟疫痘愈之患矣，此何以故，西北土高地燥，即春夏气难上升，何况冬月之凝沍，东南土地卑湿，为雾露之区，蛇龙之窟，其温热之气，得风以播之，尚有可耐，设旦暮无风，水中之鱼，衣中之虱，且为飞扬，况于人乎，蒸气中原杂诸秽，益以病气死气，无分老少，触本即同一病状矣，此时朔风了不可得，故其气转积转暴，虽有熏风，但能送热，不能解凉，盛世所谓解愠阜财者，在兵荒反有注邪布秽之事矣，叔和以夏应大热，而反大寒为疫，讵知大寒正疫气消弭之候乎，故疫邪炽盛，惟北方始能消受，诗恶谮人，思欲投畀有北，以熄其燄，析义精矣，乡绅万吉人，营葬五雷惊蛇之地，触动土瘟，壮者病疫，少者病痘，一夕暴死五人，余令于营北掘井二丈，投猪首馒首蒸饭，促引土气下收，旋封其井，即得安全无损，此余偶试杨会之秘，非心得也，范文正公守饶，冬温吏请祷雪，公取薄冰置座，嘿坐良久，瑞雪满空，顷深三尺，蠹贼疫鬼，何地潜踪耶，可见先儒退藏于密，借凝冰为影草，已摄大地于清冷之渊矣，讵非法王手眼乎。

卷一

论太阳经伤寒证治大意

王叔和当日编次仲景伤寒论，以辨痉湿喝脉证为第一，以辨太阳病脉证为第二，谓痉湿喝虽太阳经之见证，然宜应别论，故列之篇首，此等处最不妥当，岂有别论反在正论之前者，况既应别论，即当明言所指，而故虚悬其篇，此叔和不究心之弊也，至于太阳经中，一概混编合病并病，温病坏病，过经不解病，以及少阳诸病，如理芩丝，不清其脉，寸寸补接，所以不适于用，徒令观者叹息，此更叔和不究心之弊也，宋林亿成无己辈，以脉法及伤寒例居前，次痉湿喝，次太阳病，分上中下三篇，其意以桂枝证麻黄证汇上篇，大青龙证，及汗后下后诸证，汇中篇结胸及痞证，汇下篇，究竟上篇混中下，下篇混上中，不能清也，更可笑者，下篇结胸例中，凡系结字，一概收入，如阳微结，阴微结，脉代结之类，悉与结胸同汇，尤可笑者，上篇第六条伤寒大义未及什一，何所见即汇温病，中篇下篇太阳本证，未及什七，何所见即汇少阳证，及合病并病，过经不解诸病，如此割裂原文，后人纵思研究，无门可入矣，夫足太阳膀胱，病主表也，而表有营卫之不同，病有风寒之各异，风则伤卫，寒则伤营，风寒兼受，则营卫两伤，三者之病各分疆界，仲景立桂枝汤麻黄汤大青龙汤，鼎足大纲三法，分治三证，风伤卫则用桂枝汤，寒伤营则用麻黄汤，风寒两伤营卫，则用大青龙汤，用之得当，风寒立时解散，不劳余力矣，乃有病在卫而治营，病在营而治卫，病在营卫，而治其一遗其一，与夫病已去营卫而复汗，病未去营卫而误下，以致经传错乱，展转不已，源头一差，末流百出，于是更出种种节目，辅三法而行，正如八卦之有六十四卦，八阵之有六十四阵，分统于乾坤，震巽坎离艮兑，天地风云龙虎鸟蛇之下，始得井井不紊，仲景参五错综，以尽病之变态，其统于桂枝麻黄青龙三法，夫复何疑，第文辞奥约，义例互陈，虽颖敏之士，读之不解其意，实由当时编次，潦草糊涂，不察来意，仲景一手一目，现为一手一目，悠悠忽忽，沿习至今，昌不得已而僭为尚论，太阳经中，仍分三篇，以风伤卫为上篇，寒伤营为中篇，风寒两伤营卫为下篇，一一以肤浅之语，括大义于前，明奥旨于后，其温病合病等名，逐段清出，另立篇目，俾读者了无疑惑于心，庶随所施而恰当矣。

太阳经上篇〔凡风伤卫之证，列于此篇，法五十三条〕

太阳经受病之初，有定脉定证一法。（一）太阳之为病，脉浮头项强痛而恶寒。〔原文〕先挈太阳病之总脉总证，统中风伤寒为言也，太阳膀胱经，乃六经之首，主皮肤而统营卫，所以为受病之始。太阳受病，有风寒不同，宜辨阴阳而定愈日。〔通计五法〕（二）病有发热恶寒者，发于阳也，无热恶寒者，发于阴也，发于阳者七日愈，发于阴者六日愈，以阳数七，阴数六也。〔原文〕风为阳，卫亦阳，故病起于阳，寒为阴，营亦阴，故病起于阴，无热热寒，指寒邪初受，未郁为热而言也，少顷郁勃于营间，则仍发热矣，太阳中篇第一条云，或已发热，或未发热，正互

明其义也，病发于阳，其愈宜速，乃六日传经已尽，必至七日方愈者，阳数七，主进故也，病发于阴，其愈宜迟，乃至六日经尽即愈者，阴数六，主退故也，得病之始，各从阴阳之类而起，得病之终，各从阴阳之类而愈，此道之所以本乎自然，而人身与天地同撰也。（三）太阳病，头痛，至七日已上自愈者，以行其经尽故也，若欲再作经者，针足阳明，使经不传则愈。〔原文〕七日而云已上者，该六日而言也，六日传至厥阴，六经尽矣，至七日当再传太阳，病若自愈，则邪已去尽，不再传矣，设不愈，则七日再传太阳，八日再传阳明，故针足阳明以竭其邪，乃得不传也，在他经则不然，盖阳明中土万物所归，无所复传之地，邪易解散故耳，然必针以竭其邪，始得归并阳明不犯他界也，旧谓夺其传路而遏之，则经经皆可遏矣，何独取阳明也哉。（四）太阳病欲解时，从巳至未上。〔原文〕凡病欲解之时，必从其经气之王，太阳者盛阳也，故从巳午未之王时而病解。（五）欲自解者，必当先烦，乃有汗而解，何以知之，脉浮故知汗出解也。〔原文〕天地郁蒸而雨作，人身烦闷而汗作，气机之动也，气机一动，其脉必与其证相应，故脉浮而邪还于表，俟得有汗，而外邪尽从外解，设脉不以浮应，则不能作汗，其烦即为内入之候，又在言外矣。已上四条，先挈太阳经，始病终愈风寒之总法。

太阳受病风寒不同，先辨中风定脉定证一法。（六）太阳病，发热汗出恶风脉缓者，名为中风。〔原文〕既有第一条脉浮头项强痛恶寒之总证，更加发热汗出恶风脉缓，则其病乃是触冒于风所致，即名中风，中字兴伤字无别，即谓伤风亦可，风性属阳，从卫而入，以卫为阳气所行之道，从其类也。此一条，又中风病之总称，已后凡言中风病三字，而发热汗出恶风脉缓，即括在内。

中风病主用桂枝汤解肌大纲一法（七）太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者热自发，阴弱者汗自出，啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。〔原文〕阳浮阴弱，与下文卫强营弱同义，阳浮者阳邪入卫，脉必外浮，阳性本热，风又善行，所以发热快捷，不待闭郁自发也，阴弱者营无邪助，比卫不足，脉必内弱，阴弱不能内守，阳强不能外固，所以致汗直易，不待覆盖自出也，啬啬恶寒，内气馁也，淅淅恶风，外体疏也，虽寒与风并举，义重恶风，恶风未有不恶寒者，所以中篇伤寒证中，亦互云恶风，又见恶寒未有不恶风者，后人相传，谓伤风恶风，伤寒恶寒，苟简辨证，误人多矣，翕翕发热，乃气蒸湿润之热，比伤寒之干热不同，息鸣者阳邪上壅也，干呕者阳邪上逆也，故取用桂枝汤解散肌表之阳邪，而与发汗驱出阴寒之法，迥乎角立也。

服已，须臾歠热稀粥一升余，以助药力，温覆令一时许，遍身絜絜，微似有汗者益佳，不可令如水淋漓，病必不除，若一服汗出病差，停后服不必尽剂，若不汗重服依前法，又不汗，后服小促，使其间半日许，令三服尽，若病重者，一昼一夜服，周时观之，服一剂尽，病证犹在者，更作服，若汗不出者，乃服至二三剂，禁生冷粘滑肉面五辛酒酪臭恶等物。桂枝气味俱薄，服过片顷，其力即尽，所以能解肌者，妙用全在歠稀热粥，以助药力，谷气内充，则邪不能入，而热歠以继药之后，则

邪不能留，法中之法若此，世传方书，无此四字，辄失初意，更有肌肤已透微似之汗，盖覆强逼，致令大汗淋漓者，总繇不识解肌为何义耳。按卫行脉外，风伤卫之证，皆伤其外，外者肌肤也，故但取解肌以散外，不取发汗以内动血脉，更不取攻下以内动藏府，所以服桂枝时，要使周身皦皦然，似乎有汗者，无非欲其皮间毛窍暂开而邪散也，然恐药力易过，又藉热稀粥以助其暖，如此一时之久，肌窍不致速闭，则外受之邪，尽从外解，允为合法矣，不识此意者，汗时非失之太过，即失之不及，太过则邪未入，而先扰其营，甚则汗不止而亡阳，不及则邪欲出而早闭其门，必至病不除而生变，仲景言之谆谆，后人转加忽略，兹特详发其义。

桂枝汤，有禁用三法（八）桂枝本为解肌，若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与也，当须识此，勿令误也。〔原文〕已见寒伤营之脉证，即不可误用风伤卫之治法，用之则寒邪漫无出路，留连肉腠，貽患无穷，故为首禁。（九）凡服桂枝汤吐者，其后必吐脓血也。〔原文〕桂枝辛甘，本胃所爱，服之反吐，其人湿热素盛可知矣，湿热素盛，更服桂枝，则两热相合，满而不行，势必上逆而吐，吐逆则其热愈淫，溢于上焦，蒸为败浊，故必吐脓血，此一大禁也，其误服未至于吐者，上焦清气未伤，热虽渐消亦蹈险矣。（十）酒客病不可与桂枝，得汤则呕，以酒客不喜甘故也。〔原文〕

酒为湿热之最，故即于上条文意，重引酒客以示戒，呕吐乃互词，勿泥。按辛甘发散为阳，内经之旨也，仲景遵之制方，重申辛甘之戒，可谓虑周千变矣，如酒客平素湿与热，搏结胸中，纔挟外邪，必增满逆，所以辛甘之法，遇此辈即不可用，辛甘不可用，则用辛凉以彻其热，辛苦以消其满，自不待言矣，后人不察，偏诋桂枝为难用，即不遇酒客，无端变乱内经定法，可胜诛哉，葛根虽酒客所宜，然犯太阳经禁，又不可用。

汗后水气上逆有禁更汗增满一法（二）发汗后，水药不得入口为逆，若更发汗，必吐下不止。〔原文〕此一条，从来诸家错会，扯入桂枝四禁，谓已用桂枝致逆，若更用桂枝，则其变愈大，粗疏极矣，盖为逆是言水逆，未尝说到其变愈大为凶逆也，且原文不云更与桂枝，而云更发汗者，见水药俱不得入，则中满已极，更发汗以动其满，凡是表药，皆可令吐下不止，不独是桂枝当禁，所以仲景于太阳水逆之证，全不用表药，惟用五苓散以导水，服后随溉热汤以取汗，正与此条，互相发明也，设只单禁桂枝，将麻黄葛根紫胡等类，在所不禁，而设用以致吐下不止，恬不知为犯禁矣，噫，斯道之不明，小者且然，况其大乎。

中风病主用桂枝汤解肌和营衞七法（三）太阳病，头痛发热汗出恶风者，桂枝汤主之。〔原文〕头痛见第一条，发热汗出恶风见第六条，重互其文，以致叮咛，辨证用法，首宜识此也。（一三）太阳病，外证未解，脉浮弱者，当以汗解，宜桂枝汤。〔原文〕浮弱即阳浮阴弱之谓，外证未解，脉见浮弱，即日久必当以汗解，然汗解当遵用桂枝汤之法，见不可误行发汗之法也，至于不可误下，更不待言矣。（一四）太阳病，发热汗出者，此为营弱卫强，故使汗出，欲救邪风者，宜桂枝汤主之

。〔原文〕卫得邪助而强营无邪助，故为弱也，即前阳浮阴弱之义，而重挈明之耳。须知营弱与血虚无涉邪风，即风邪勿啗看。（一五）病人藏无他病，时发汗自汗出而不愈者，此为卫气不和也，先其时发汗则愈，宜桂枝汤主之。〔原文〕藏无他病四字，隐括人身宿病，即动气不可发汗亦在内，见里无病而但表中风邪，乃有汗出不愈者，必是卫气不和也，设入于营，则里已近灾，未可宴然称无病矣，时发热者，有时发热，有时不热也，故先于未发热时，主用解肌之法，邪自不留也。（一六）病尝自汗出者，此为营气和，营气和者，外不谐，以卫气不共营气和谐故尔，以营行脉中，卫行脉外，复发其汗，营卫和则愈，宜桂枝汤。〔原文〕此明中风病，所以卫受邪风，营反出汗之理，见营气本和，但卫强不与营和，复发其汗，俾风邪从肌窍外出，斯卫不强而与营和，中酒发狂，酒去其人帖然矣，营受寒邪，不与卫和，宜麻黄汤亦然。（一七）太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者，先刺风池风府，却与桂枝汤则愈。〔原文〕中风之证，凡未传变者，当从解肌，舍解肌无别法也，然服桂枝汤以解肌，而反加热闷者，乃服药时不如法也，其法维何，即欢稀热粥以助药力，不使其不及，但取周身絜絜，微似有汗，不使其太过之谓也，此云服汤反烦者，必微似汗，亦未得肌窍未开，徒用药力引动风邪，漫无出路，势必内入而生烦也，刺风池、风府，以泻风热之暴甚，后风不继，庶前风可熄，更与桂枝汤，引之外出，则愈矣，可见解肌当如法也，因服桂枝生烦，竖此妙义，不可不讲，故特详其意，俾用药者知所当务焉。（一八）风家表解而不了了者，十二日愈。〔原文〕风家表解，已用桂枝汤之互词也，用桂枝汤表解，已胜其任矣，而不了了者，风为阳邪，卫为阳气，风邪虽去，而阳气之扰攘，未得遽宁，即欲治之，无可治也，七日不愈，俟十二日，则余邪尽出，正气复理，必自愈矣，见当静养以需，不可喜功生事也。已上七条，曲尽用桂枝汤妙义，一条辨用桂枝之证，二条辨用桂枝之脉，三条辨卫强营弱，宜用桂枝两和营卫，四条辨卫气不和，宜在未发热前用桂枝和卫，五条辨营气不和，宜仍用桂枝和卫，六条辨阳邪炽盛，服桂枝转烦者，先刺风穴，再行桂枝，七条辨用桂枝表已解，宜俟勿药，似此深切着明，可惜从前混编，兹特挈出。

不解肌成误汗病邪入里用五苓两解表里二法（一九）中风发热，六七日不解而烦，有表里证，渴欲饮水，水入则吐者，名曰水逆，五苓散主之，多服暖水汗出愈。〔原文〕伤风证原有汗，以其有汗也，延至日久不行解肌之法，汗出虽多，徒伤津液，表终不解，转增烦渴，邪入于府，饮水则吐者名曰水逆，乃热邪挟积饮上逆，以故外水格而不入也，服五苓散后，频溉热汤，得汗则表里俱解，盖表者阳也，里之属府者亦阳也，所以一举两得也，然亦以未经误治，邪不内陷，故易为力耳。膀胱为津淮之府，用五苓通调水道，则火热自化，而津液得全矣。（二十）太阳病发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈，若脉浮，小便不利，微热消渴者，与五苓散主之。〔原文〕不行解肌，反行发汗，致津液内耗，烦躁不眠，求救于水，若水入不解，脉转单浮，则无他变，而邪还于表矣，脉浮本当用桂枝，何以变用五苓耶，盖热邪得水，虽不全解，势必衰其太半，所以邪既还表，其热亦微，兼以小便不利，证成消渴，则府热全具，故不从单解而

从两解也，凡饮水多而小便少者，谓之消渴，里热炽盛，何可复用桂枝之热，故导湿滋干清热，惟五苓有全功耳。

不解肌而误发大汗，其变逆有救亡阳漏风二法。（三）太阳病发汗，汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身瞤动，振振欲擗地者，真武汤主之。〔原文〕此本为误服大青龙汤，因而致变者立法，然阳虚之人，纔发其汗，便出不止，即用麻黄火劫等法，多有见此证者，所以仲景于桂枝汤中垂戒，不可令加水淋漓，益见解肌中，且有逼汗亡阳之事矣，太阳下篇，大青龙证中垂戒云，若脉微弱，汗出恶风者，不可服，服之则厥逆，筋惕肉瞤，正与此段互发，振振欲擗地五字，形容亡阳之状如绘，诸家竟不加细绎，妄取诗经注，擗拊心貌为解，噫，是何言欤，仲景论中心下悸，欲得人按，与夫叉手自冒心间，且与拊心之义不协，何得妄指擗地为拊心耶，盖擗者辟也，避也，汗出过多，卫气解散，其人似乎全无外廓，故振振然四顾彷徨，无可置身，思欲辟地而避处其内也，阴证似阳者欲坐井中，避热就冷也，汗多亡阳者，欲入土中，避虚就实也，试观婴孩出汗过多，神虚畏怯，尝合面偎入母怀者，岂非振振欲擗地之一验乎，从来皆以为惊风误治，实繇未透伤寒证中之大关耳。（三）太阳病发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。〔原文〕大发其汗，致阳气不能卫外为固，而汗漏不止，即如水流漓之互词也，恶风者腠理大开，为风所袭也，小便难者，津液外泄而不下渗，兼以卫气外脱，而膀胱之化不行也，四肢微急，难以屈伸者，筋脉无津液以养，兼以风入而增其劲也，此阳气与阴津两亡，更加外风复入，与前条亡阳一证，微细有别，故用桂枝加附子，以固表驱风而复阳敛液也。

不解肌而以火劫汗伤阴致变四法一法辨阴未尽亡、一法辨邪所繇解、一法不得汗反躁必圉血、一法辨脉微而数者不可灸。（二三）太阳病中风，以火劫发汗，邪风被火热，血气流溢，失其常度，两阳相熏灼，其身发黄，阳盛则欲衄，阴虚则小便难，阴阳俱虚竭，身体则枯燥，但头汗出，剂颈而还，腹满而喘，口干咽烂，或不大便，久则譫语，甚者至哕，手足躁扰，捻衣摸床，小便利者，其人可治。〔原文〕风，阳也，火，亦阳也，邪风更被火热助之，则血气沸腾，所以失其常度，热势弥漫，所以蒸身为黄，然阳邪盛于阳位者，尚或可从衄解，可从汗解，至于阳邪，深入阴分，势必劫尽精津，所以剂颈以下，不能得汗，口干咽烂，肺焦喘促，身体枯燥，小便难，大便秘，手足扰动，譫妄哕逆，乃是一团邪火内炽，真阴顷刻立尽之象，有非药力所能胜者，必其人小便尚利，阴未尽伤，始得以行驱阳救阴之治也，噫，亦危矣。仲景以小便利一端，辨真阴之亡与未亡最细，盖水出高原，小便利则津液不枯，肺气不逆可知也，肾以膀胱为府，小便利则膀胱之气化行，肾水不枯可知也。按此证阳邪挟火，扰乱阴分而亡其阴，与前二条亡阳证，天渊悬绝，观阳盛欲衄身体枯燥等语，明是失汗所致，失汗则阳必内入，何反外亡耶，注家泥阴阳俱虚竭一语，遂谓小便利者，阴未甚虚，则阳犹可回，是认可治为回其阳，大失经旨，不知此证，急驱其阳，以存阴气之一线，尚恐不得，况可回阳以更劫其阴乎，且头汗乃阳邪上壅，不下通于阴，所以剂颈以下不能得汗，设见衄血，则邪从衄解，

头间且无汗矣，设有汗则邪从汗解，又不衄矣，后条火邪深入必圉血一证，亦谓身体枯燥而不得汗者，必致圉血，设有汗更不圉血矣，读古人书全要会意，岂有得汗而加衄血圉血之理哉，又岂有遍身无汗，而头汗为亡阳之理哉。（二四）太阳病，二日反躁，反熨其背而大汗出，大热入胃，胃中水竭，烦躁必发谵语，十余日振栗自下利者，此为欲解也，故其汗从腰已下不得汗，欲小便不得，反呕欲失溲，足下恶风，大便鞭，小便当数而反不数，及多大便，已头卓然而痛，其人足心必热，穀气下流故也。〔原文〕此段文义隐奥，从来注释不得其解，谨明之以畅尚论之怀，盖火邪入胃中，十余日不解，忽振栗自下利者，火邪从大肠下奔，其候本为欲解，然而不解者，以从腰已下不得汗，邪虽下走，终不外走，故不解也，上条从颈已下不得汗，其势重，此从腰已下不得汗，其势较轻，足下恶风，见阳邪但在下也，小便不得，见阳邪闭拒阴窍也，与不得汗正同，所以大便亦鞭，益见前之下利，为火势急奔，火势衰减，则仍鞭也，反呕者，邪欲从上越也，欲失溲者，邪欲从前阴出也，皆余邪欲散之征也，胃火既减，小便当数复不数，则津液可回，及至津之下润，则久积之大便必尽出矣，大便出多，则小便之当数者始数矣，肠胃之间，邪热既散而不持，则腰已下之得汗并可知矣，得汗则阴分之阳邪，尽从外解，然后身半以下之阴气得上，而反头痛，身半以上之阳气得下，而反足心热，欲愈之状，尚类病状，火邪助虐，为何如哉。（二五）太阳病以火熏之，其人必躁，到经不解，必圉血，名为火邪。〔原文〕火邪入胃，胃中水液多者，必奔迫下利，其渐解悉如上条矣，若胃中津液素乏之人，复受火邪，则漫无可御，必加躁扰不宁，由是深入血室而圉血也，盖阳邪不从汗解，得以袭入阴中，动其阴血，倘阳邪不尽，其圉血必无止期，故申之曰名为火邪，示人以治火邪而不治其血也。（二六）微数之脉，慎不可灸，因火为邪，则为烦逆，追虚逐实，血散脉中，火气虽微，内攻有力，焦骨伤筋，血难复也。〔原文〕脉微而数，阴虚多热之征也，此而灸之，则虚者益虚，热者益热，不至伤残不止矣，凡病皆然，不独伤寒宜戒也，针灸家亦识此义否。

不解肌而用烧针取汗，寒入核起，灸秩止变一法（二七）烧针令其汗，针处被寒核起而赤者，必发奔豚，气从少腹上冲心者，灸其核上各一壮，与桂枝加桂汤更加桂。〔原文〕奔豚者肾邪也，肾邪一动，势必自少腹上逆而冲心，状若豕突，以北方亥位属猪故也，北方肾邪，惟桂能伐之，所以用桂三倍，加入桂枝汤中，外解风邪，内泄阴气也，尝即此例推之，凡发表误入寒药，服后反加壮热，肌肤起赤块，畏寒腹痛，气逆而喘者，或汗时盖覆未周，被风寒复侵，红肿喘逆，其证同者，用此法良验，一妇病外感，服表药后，忽面若赭朱，散发叫喘，双手上扬，余知其腹作奔豚也，用此方而顷之即定。

不解肌而用吐药，虽得汗内伤脾胃，名为小逆二法。（二八）太阳病，当恶寒发热，今自汗出，不恶寒发热，关上脉细数者，以医吐之过也，一二日吐之者，腹中饥口不能食，三四日吐之者，不喜糜粥，欲食冷食，朝食暮吐，以医吐之所致，此为小逆。〔原文〕解肌之法，解散肌表风邪，全不伤动脾胃，乃天然不易之法也，若舍此而妄用吐法，吐中亦有发散之义，故不恶寒发热，一二日病在太阳，吐之则腹

中饥，口不能食，三四日病在阳明，吐之则不喜糜粥，欲食冷食，皆胃气受伤之故也，然且朝食暮吐，脾中之真阳亦伤，而不能消谷，是则外感虽除，脾胃内伤，卒未易复，故为小逆也。（二九）太阳病吐之，但太阳病当恶寒，今反不恶寒不欲近衣，此为吐之内烦也。〔原文〕此以吐而伤胃中之阴，较上条两伤脾胃之阴阳者稍轻，故内烦不欲近衣，虽显虚热之证，此关上脉细数，已成虚热之脉者，亦自不同，然以吐而伤其津液，虽幸病不致逆，医者能无过乎，可见用吐法时，亦当相人之津液矣，

中风肌未解不可下，宜用桂枝汤解外一法。（三十）太阳病，外证未解者，不可下也，下之为逆，欲解外者，宜桂枝汤主之。〔原文〕下之为逆，即指结胸等证而言，欲解外者，必无出桂枝一法，叮咛无已之辞也，外邪未解，下必为逆，然则欲下未下之时，亟解其肌，俾下之而不为逆也，不亦可乎。

中风肌未解误汗下，无他变者，仍当用桂枝汤一法。（三一）太阳病，先发汗不解而复下之，脉浮者不愈，浮为在外而反下之，故令不愈，今脉浮故知在外，当须解外则愈，宜桂枝汤主之。〔原文〕

见已下其脉仍浮，证未增变者，仍当亟解其外也。

不解肌反误下邪，不服者于前下药内更加桂枝一法。（三二）太阳病下之，其气上冲者，可与桂枝汤，方用前法，若不上冲者，不可与之。〔原文〕误下而阳邪下陷，然无他变，但仍上冲阳位，则可从表里两解之法，故以桂枝汤，加于前所误用下药之内，则表邪外出，里邪内出，即用桂枝大黄汤之互词也，若不上冲，则表里两解之法，漫无取义，其不可与明矣。

不解肌反误下心痞，用桂枝加温补药两解表里一法。（三三）太阳病，外证未除，而数下之，遂挟热而利，利下不止，心下痞鞭，表里不解者，桂枝人参汤主之。〔原文〕误下则致里虚，里虚则外热乘之，变而为利，不止者，里虚不守也，痞鞭者，正虚邪实，中成滞碍，痞塞而坚满也，以表未除，故用桂枝以解之，以里适虚，故用理中以和之，此方即理中加桂枝，而易其名，亦治虚痞下利之圣法也。

不解肌反误下邪入阳明，变用太阳两解一法。（三四）太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止，脉促者，表未解也，喘而汗出者，葛根黄连黄芩汤主之。〔原文〕太阳病原无里证，但当用桂枝解外，若当用不用，而反下之，利遂不止，则热邪之在太阳者，未传阳明之经，已入阳明之府，所以其脉促急，其汗外越，其气上奔则喘，下奔则泄，故舍桂枝而用葛根，专主阳明之表，加芩连以清里热，则不治喘而喘自止，不治利而利自止，又太阳两解表里之变法也。

不解肌反误下，宜辨阳实阳虚加减桂枝汤一法。（三五）太阳病下之后，脉促胸满者，桂枝去芍药汤主之，若微恶寒者，去芍药方中加附子汤主之。〔原文〕误下脉

促，与上条同，以无下利不止，汗出等证，但见胸满，则阳邪仍盛于阳位，几与结胸同变，然满而不痛，且诸证未具，胸未结也，故取用桂枝之芳甘，以亟散太阳之邪，其去芍药之意，酸收二字，不足尽之，以误下故不敢用，恐其复领阳邪下入腹中也，设微见恶寒，则阳虚已着，而非阳邪上盛之比，去芍药方中即当加附子以回其阳，是虽不言汗出，然由此条之微恶寒，合上条观之，则脉促胸满，喘而汗出之内，原伏有虚阳欲脱之机，故仲景于此条，特以微恶寒三字发其义，可见阳虚则恶寒矣，又可见汗不出之恶寒，即非阳虚矣，伤寒证中，多有下后魄汗不止，而酿亡阳之变者，必于此等处恭合，以求神髓，庶几可进于道耳。

不解肌反误下阳邪作喘，有用桂枝加行气药一法。（三六）太阳病，下之微喘者，表未解故也，桂枝加厚朴杏仁汤主之，喘家作枝汤，加厚朴杏子仁。〔原文〕凡下后利不止，而加上气喘急者，乃是上争下夺之象，危候也，但骤病之人，中气足供上下之用，邪尽而喘与利自止，若中气素馁，加以上下交征，立尽之数矣，此证不云下利，但云微喘表未解，则是表邪因误下上逆与虚证不同，故仍用桂枝以解表，加厚朴杏仁以利下其气，亦微里之意也。此诀风邪误下作喘治法之大要，其寒邪误下作喘，当用麻黄石膏，即此可推，故中篇不复赘也。

不解肌反误下有凭脉定变一法（三七）太阳病下之，其脉促，不结胸者，此为欲解也，脉浮者必结胸也，脉紧者必咽痛，脉弦者必两拘急，脉细数者头痛未止，脉沉紧者必欲呕，脉沉滑者挟热利，脉浮者必下血。〔原文〕脉促为阳邪上盛，反不结聚于胸，则阳邪未陷，可勃勃从表出矣，故为欲解也，脉浮者必结胸，即指促脉而申之，见脉促而加之以浮，邪气弥漫于阳位，故必结胸也，浮字贯下四句，见浮而促必结胸，浮而紧必咽痛，浮而弦必两胁拘急，浮而细数必头痛未止，皆太阳本病之脉，故主病亦在太阳之本位，设脉见沉紧，则阳邪已入阴分，但入而未深，仍欲上冲作呕，其无结胸咽痛等证，从可知矣，祇因论中，省用一个促字，三个浮字，后之读者遂眩，谓紧为下焦，属在少阴，惑之甚矣，观本文下句，即指出沉紧者，必欲呕一语，正见前紧字，指浮紧言也，沉紧方是阳邪入阴，上逆作呕，岂有浮紧咽痛，反为少阴寒邪上冲之理，明明太阳误下之脉证，何缘插入少阴，爰乱后人耶，至于滑脉居浮沉之间，亦与紧脉同推，故沉滑则阳邪入阴，而主下利，浮滑则阳邪正在荣分，扰动其血，而主下血也，夫太阳误下之脉，主病皆在阳在表，即有沉紧沉滑之殊，亦不得以里阴名之，仲景辨析之精，詎可杂以赘疣哉。

中风病不解热结膀胱下血有宜先表后里一法。（三八）太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈，其外不解者尚未可攻，当先解外，外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃仁承气汤。〔原文〕邪热搏血，结于膀胱，膀胱者，太阳寒水之经也，水得热邪，必沸腾而上侮心火，故其人如狂，见心虽未狂，有似乎狂也，血自下者，邪热不留故愈，若少腹急结，则膀胱之血，蓄而不行，先解外乃可攻，其攻法亦自不同，必用桃仁增入承气，以达血所，仍加桂枝，分解外邪，正恐余邪少有未解，其血得以留恋不下耳。桃仁承气汤中，用桂枝解外，与大柴胡汤中，用

柴胡解外相仿，益见太阳随经之热，非桂枝不解耳。

中风病不解，热瘀下焦，蓄血明辨脉证用抵当汤二法（三九）太阳病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在下焦，少腹当鞕满，小便自利者，下血乃愈，所以然者，以太阳随经，瘀热在里故也，抵当汤主之。〔原文〕此条之证较前条更重，且六七日表证仍在，曷为不先解其外耶，又曷为攻药中，不兼加桂枝耶，以脉微而沉，反不结胸，知邪不在上焦，而在下焦也，若少腹鞕满，小便自利，则其人之发狂者，为血蓄下焦无疑矣，故下其血自愈，然蓄血而至于发狂，则热势攻心，桃仁承气，不足以动其血，桂枝不足以散其邪，非用单刀直入之将，必不能斩关取胜，故名其汤为抵当，抵者至也，乃至当不易之良法也，奈何圣人以为至当，愚人以为非常，讵知邪结于胸，则用陷胸以涤饮，邪结少腹，则用抵当以逐血，设非此一法，少腹中所结之血，既不附气而行，更有何药可破其坚垒哉，所以一峻攻，斯血去而邪不留，并无藉桂枝分解之力耳，噫，非优入圣域之大贤，乌足以论此哉。（四十）太阳病，身黄，脉沉结，少腹鞕，小便不利者，为无血也，小便自利，其人如狂者，血证谛也，抵当汤主之。〔原文〕此一条，乃法中之法也，见血证为重证，抵当为重药，恐后人辨认不清，不当用而误用，与夫当用而不敢用，故重申其义，言身黄，脉沉结，少腹满，三者本为下焦蓄血之证，然只现此，尚与黄相邻，必如前条之其人如狂，小便自利，则血证无疑，而舍抵当一法，别无他药可代之矣。小便不利，何以见其非血证耶，盖小便不利，乃热瘀膀胱，无形之气病为发黄之候也，小便自利，则膀胱之气化行，然后少腹满者，允为有形之蓄血矣，庸工不能辨证，实于此等处未着眼耳。

中风病以小便利否定里证一法（四一）太阳病小便利者，以饮水多，必心下悸，小便少者，必苦里急也。〔原文〕小便清利，本为邪不在里，若因饮水过多，致小便之利，则水未入腹，先与邪争，必主心下悸也，小便少者，即小便短赤，里证已具之意，但本文云，必苦里急，明是谓饮水多而小便少者，邪热足以消水，故直指为里证已急也，以饮水多三字贯下，其旨跃然。

中风病汗吐下后，小便不利，宜俟津回自愈一法。（四一）大下之后，复发汗，小便不利者，亡津液故也，勿治之，得小便利，必自愈，凡病若发汗，若吐，若下，若亡血，亡津液，阴阳自和者，必自愈。〔原文〕泉之竭矣，不云自中，古今通弊，医事中之操霸术者，其人已亡津液，复强责其小便，究令膀胱之气化不行，转增满鞕胀喘者甚多，故宜以不治治之，俟其津液回，小便利，必自愈也，于此见汗下恰当，津液不伤，为措于不倾，藏于不竭之良图矣。

中风病，下后复汗，因虚致冒，先汗解后议下一法。（四三）太阳病，下之而不愈，因复发汗，以此表里俱虚，其人因致冒，冒家汗出自愈，所以然者，汗出表和故也，得里未和，然后下之。〔原文〕冒者神识不清，似有物蒙蔽其外也，所以必须得汗，俾外邪先从外彻，然后辨其二便之和否，再一分解其邪也，然而表里俱虚之

证，其两解之法，宜轻而且活，所以说汗出自愈，未尝指定服药也，又说得里未和，然后下之，但示其意，并不出方，后人熟察其遵，内经虚者，责之之义乎，若论用药，表无过桂枝，里无过大柴五苓矣。

中风病，表里已虚，余邪未解，辨脉用治回异初病一法。（四四）太阳病未解，脉阴阳俱停，必先振栗，汗出而解，但阳脉微者，先汗出而解，但阴脉微者，下之而解，若欲下之，宜调胃承气汤主之。〔原文〕病久而外邪不解，不过是入阳入阴之二途，既阴阳两停，初无偏胜，可以解矣，犹必先振栗，始得汗出而解，虚可知也，其有不为振汗，邪无出机者，辨脉用法，要与初病不同，盖初病皆邪气胜则实之脉，病后皆正气夺则虚之脉，所以最虚之处，便是容邪之处，故阳脉微者，邪乘其阳，汗之而解，阴脉微者，邪乘其阴，下之而解，必须透此一关，始得用药与邪相当，邪去则正自复，不补虚而自补耳，至于虚者责之之意，前条已露一斑，此云若欲下之，宜调胃承气汤，意更轻活，其无取于大汗大下，具在言外矣。

中风病，呕利痞满，表解可攻，与攻胃实迥异一法。（四五）太阳中风，下利呕逆，表解者乃可攻之，其人漐漐汗出，发作有时头痛，心下痞鞭，满引胁下痛，干呕短气，汗出不恶寒者，此表解里未和也，十枣汤主之。〔原文〕此证与结胸颇同，但结胸者，邪结于胸其位高，此，在心下及胁，其位卑，然必表解乃可攻之，亦与攻结胸之戒不殊也，其人漐漐汗出，发作有时，而非昼夜俱笃，即此便是表解之征，虽有头痛，心下痞鞭，满引胁下痛，干呕短气，诸证乃邪结之本证，不得以表证名之，若待本证尽除，后乃攻之，不坐误时日乎，故复申其义，见汗出不恶寒，便是表解可攻之候，虑何深耶，盖外邪挟饮，两相搏结，设外邪不解，何缘而得汗出津津乎，攻药取十枣汤者，正与结胸之陷汤相仿，因伤寒门中，种种下法，多为胃实而设，胃实者，邪热烁干津液，肠胃俱结，不得不用苦寒以荡涤之，今证在胸胁，而不在胃，则胃中津液，未经热耗，而荡涤胸胃之药，无所取矣，故取蠲饮逐水于胸胁之间，以为下法也。

中风病，本痰饮热误下有结胸及协热利之变一法。（四六）太阳病二三日，不能卧，但欲起，心下必结，脉微弱者，此本有寒分也，反下之，若利止，必作结胸，未止者，四日复下之，此作协热利也。〔原文〕二三日不能卧，但欲起，阳邪炽盛，逼处心胸，扰乱不宁，所以知其心下必结，然但显欲结之象，尚未至于结也，若其人脉微弱者，此平日素有痰饮，稍于心膈之分，适与外邪相召，外邪方炽，其不可下明矣，反下之，若利止，则邪势乘虚，欲结者愈益上结，利未止，因复下之，俾阳邪不复上结，亦将差就错因势利导之法，但热邪从表解极易，从里解极难，协热下利，热不尽，其利漫无止期，亦危道也，合上条外邪搏饮之证，反复提诲，深切着明，从来疑是阙文，可为叹息。

中风病，误下热邪内陷而成结胸六法。一法论结胸及痞之源、一法论脉证所以结胸之故、一法论结胸兼涉阳明、一法论结胸似涉柔痙、一法论脉浮大下之死、一法论

证加烦躁不下亦死。（四七）病发于阳而反下之，热入因作结胸，病发于阴而反下之，因作痞，所以成结胸者，以下之太早故也。〔原文〕风为阳邪，病发于中风，阳邪未从外解，而反下之，其热势乘虚陷入，必鞭结于胸上，寒为阴邪，病发于伤寒，阴未从外解，而反下之，其热势乘虚陷入必痞塞于心间，二证皆由下早，皆是热入，省文以见意也，太早则邪方炽盛，既未外解，又未传经，此而下之，其变安得不大耶。（四八）太阳病，脉浮而动数，浮则为风，数则为热，动则为痛，数则为虚，头痛发热，微盗汗出，而反恶寒者，表未解也，医反下之，动数变迟，膈内拒痛胃中空虚，客气动膈，短气躁烦，心中懊憹，阳气内陷，心下因鞭，则为结胸，大陷胸汤主之，若不结胸，但头汗出，余无汗，剂颈而还，小便不利，身必发黄也。〔原文〕中风病见浮动数之三脉，主风主热主痛，更主虚，虚故邪持日久，头痛发热恶寒，表终不解，医不知其邪持太阳，未传他经，反误下之，于是动数之脉变迟，而在表之证变结胸矣，动数变迟，三十六字，形容结胸之状殆尽，盖动数为欲传之脉，而变迟则力绵势缓而不能传，且有结而难开之象，膈中之气，与外入之邪，两相格(鬪)，故为拒痛，胃中水谷所生之精悍，因误下而致空虚，则不能藉之以冲开外邪，反为外邪冲动其膈，于是正气往返邪逼之界，觉短气不足以息，更躁烦有加，于是神明不安方寸之地，觉剥肤近灾，无端而生懊憹，凡此皆阳邪内陷所致，阳本亲上，故据高位，而心下鞭痛，为结胸也，非化工之笔，安能点缀病情若此哉。（四九）太阳病，重发汗而复下之，不大便五六日，舌上燥而渴，日晡所小有潮热，从心上至少腹，鞭满而痛不可近者，大陷胸汤主之。〔原文〕不大便，燥渴，日晡潮热，少腹鞭满，证与阳明颇同，但小有潮热，则不似阳明大热，从心上至少腹，手不可近，则阳明又不似此大痛，因是辨其为太阳结胸，兼阳明内实也，缘误汗，复误下，重伤津液，不大便而躁渴潮热，虽太阳阳明，亦属下证，但太阳痰饮内结，必用陷胸汤，由胸胁以及胃肠荡涤始无余，若但下肠胃结热，反遗胸上痰饮，则非法矣，其析义之精，为何如哉。（五十）结胸者，项亦强，加柔瘕状，下之则和，宜大陷胸丸。〔原文〕结胸而至颈项亦强，证愈笃矣，盖胸间邪结紧实，项势常昂，有似柔瘕之状，然瘕病身手俱张，此但项强，原非瘕也，借此以验胸邪，十分紧逼耳，胸邪紧逼，以大陷胸汤下之，恐过而不留，即以大陷胸丸下之，又恐滞而不行，故煮而连滓服之，然后与邪相当，而可施战胜攻取之略，观方中用大黄芒硝甘遂，可谓峻矣，乃更加葶苈杏仁以射肺邪，而上行其急，煮时又倍加白蜜以留恋而润导之，而下行其缓，必识此意，始得用法之妙。（五一）结胸证其脉浮大者，不可下，下之则死。〔原文〕胸既结矣，本当下以开其结，然脉浮大，则表邪未尽，下之是令其结而又结也，所以主死，此见一病不堪再误也。（五二）结胸证具，烦躁者亦死。〔原文〕亦字承上，见结胸证全具，更加烦躁，即不下亦主死也，曷为主死耶，盖邪结于胸，虽藉药力以开之，而所以载药力上行者，胃气也，胃气充溢于津液之内，汗之津液一伤，下之津液再伤，至热邪搏饮结于当膈，而津液又急奔以应上，正有不尽不已之势，烦躁者津液已竭，胃气垂绝之征也，坚敌在前，营中士卒，化为乌有，能无败乎，此陷胸诸法，见机于蚤，兢兢以涤饮为先务，饮涤则津液自安，如寇退而百姓复为良民也，噫，微矣。

不解肌，误汗下成痞，复误烧针合色脉以定死生一法。（五三）太阳病，医发汗，遂发热恶寒，因复下之，心下痞，表里俱虚，阴阳气并竭，无阳则阴独，复加烧针，因胸烦面色青黄，肤润者难治，今色微黄，手足温者易愈。〔原文〕凡表里差误，证变危笃，有阴已亡而阳邪尚不尽者，有阳邪尽而阳气亦随亡者，有外邪将尽未尽，而阴阳未致全亏者，此可愈不可愈，所繇分也，大率心下痞，与胸间结，虽有上下之分，究竟皆是阳气所治之位，观无阳则阴独一语，正见所以成痞之故，虽曰阴阳气并竭，实繇心下无阳，故阴独痞塞也，无阳阴独，蚤已括伤寒误下成痞大义，安得草率读过，无阳亦与亡阳有别，无阳不过阳气不治，复加烧针，以逼劫其阴阳，乃成危候，其用药逼劫，即可同推。中风误下结胸，伤寒误下成痞者，症之常也，然中风误下，间有痞证，伤寒误下，间有结胸证，不可不明，故次此条于结胸证后，至太阳中篇，亦次结胸于痞证后，以求合作者之圆神也。

太阳经中篇〔凡寒伤营之证列于此篇法五十八条〕

按上篇风伤卫之证，用桂枝汤解肌者，乃是不欲发汗以扰动其营也，不扰其营，但治其卫，尝有不及之弊，不及则邪不尽去，势必传入于里，故篇中两解表里之法居多，此篇寒伤营之证，用麻黄汤发汗者，乃亟驱其邪，尽从表出，不使停留之法，尝有太过之弊，太过则未免因邪伤正，而虚候易生，设有余邪不尽者，多未敢再汗，但可和其营卫，或俟其津回，自然得汗，故两解表里之法差少，其误下之证，亦不比上篇之阳邪多变，但发汗之后，其人津液已虚，更加误下，则津液重虚，所以或邪少虚多而伤其阳，或邪盛热炽而伤其阴，源同流异，各造其偏，以故治法亦错出不一，必先会大意，然后一展卷而了然于心目也。

辨寒伤营有定脉定证总称伤寒一法。（一）太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒体重呕逆，脉阴阳俱紧者，名曰伤寒。〔原文〕发热恶寒体重呕逆，脉阴阳俱紧，凡是伤寒病，必具此五者，故以为总称，或未发热者，寒邪初入，尚未郁而为热，顷之即热矣，多有服表药后，反增发热者，病必易解，盖热郁未久，药即领邪外出，无里证故也，仲景恐见恶寒体重呕逆，又未发热，认为直中阴经之证，操刃杀人，蚤于辨证之先，揭此一语，虑何周耶。

辨伤寒证用麻黄汤大纲一法（二）太阳病，头痛发热，身疼腰痛，骨节疼痛，恶风无汗而喘者，麻黄汤主之。〔原文〕上条已言伤寒之脉证矣，此复以头痛发热身疼腰痛骨节疼痛，恶风无汗而喘，互发其义，盖恶寒未有不恶风者，头身腰节疼痛，即体重之应，无汗而喘，亦即呕逆，脉阴阳俱紧之应也，汗乃血之液，血为营，营强则腠理闭密，虽热，汗不出也，麻黄发汗散邪，其力最猛，故以桂枝监之，甘草和之，而用杏仁润下以止喘逆，然亦但取微似汗，不须歠热稀粥，正如馭六马执辔惟谨，恒虞其泛轶耳。

辨伤寒传经不传经一法（三）伤寒一日，太阳受之，脉若静者为不传，颇欲吐，若

躁烦脉数急者，为传也，伤寒二三日，阳明少阳证不见者，为不传也。〔原文〕脉静者邪在本经，且不能遍，故不传经，颇欲吐，外邪内搏，身烦脉数，寒邪变热，必传经也，二三日阳明少阳证不见，即误治，亦止留连于太阳耳。

辨伤寒欲传不传，心悸而烦，宜用建中一法。（四）伤寒二三日，心中悸而烦者，小建中汤主之，呕家不可用建中汤，以甜故也。〔原文〕欲传未传之证，其人内实，差可无虑，若阳气内虚而心悸，阴气内虚而心烦，将来邪与虚搏，必至危困，建立其中气，则邪不易入，即入亦足以御之也。

辨寒伤营之证，当汗不汗，反行针灸致变二法。（五）太阳伤寒者，加温针，必惊也。〔原文〕温针欲以攻寒，孰知针用火温，营血得之反增其热，营气通于心，引热邪以内逼神明，必致惊惶而神乱也。（六）脉浮宜以汗解，用火灸之，邪无从出，因火而盛，病往接以下必重而痹，名火逆也。〔原文〕外邪挟火势上炎，必不下通阴分，故重而痹也。

辨脉浮及数宜麻黄汤发汗一法。（七）脉浮者病在表，可发汗，宜麻黄汤，脉浮而数者可发汗，宜麻黄汤。〔原文〕伤寒之脉，阴阳俱紧，其脉但浮，及浮数而不兼紧，似可不用麻黄汤，然寒既入营，舍麻黄汤定法，别无他药可代，故重申其意，见脉紧固当用麻黄汤，而脉浮不紧者，乘其邪方在表，当用麻黄汤托出其邪，不使得入，即脉浮数而不紧者，乘其势正欲传，当用麻黄汤击其半渡，而驱之使出，参看中风证，脉浮宜用桂枝汤，可见天然一定之法，不因邪势之浅深，辄可变易也。

服麻黄汤得汗后，察脉辨证有次第不同三法。一法汗解后，复感复烦，脉浮数者，宜更药解散、一法脉浮数而烦加渴者，宜两解表里、一法具两解证，不渴者用药宜里少表多。（八）伤寒发汗，解半日许复烦，脉数者，可更发汗，宜桂枝汤。〔原文〕发汗后，病解半日许复烦，脉复浮数，明系汗后表疏松，邪风袭入所致，即不可再用麻黄汤，宜更变发汗之法，改用桂枝可耳，用桂枝者，一以邪重犯卫，一以营虚不能复任麻黄也。（九）发汗已，脉浮数烦渴者，五苓散主之。〔原文〕脉浮数而烦，与上同也，加之以渴，则津液为热所耗，而内躁，里证具矣，津液内耗，即非细故，宜用四苓以滋其内，而加桂以解其外，比上更用桂枝之法，又大不同者，以无复感故也，然既云两解表里之邪热，则五苓散中，朮用苍，桂用枝，从可推矣。

按五苓散两解表里之法，风伤卫寒伤营俱用之。（十）伤寒汗出而渴者，五苓散主之，不渴者茯苓甘草汤主之。〔原文〕伤寒以无汗故烦，汗出则不烦可知矣，但汗出而渴则上条五苓两解表里之法，在所必用，若汗出而并不渴，则里证本轻，故用桂枝汤中三，五苓汤中之一，少示三表一里之意，名曰茯苓甘草汤，以消息病情，而分解微邪，如璋判圭合，允为实符。

辨脉浮紧浮数尺脉，反迟反微不可发汗二法。一法脉浮紧，身疼痛，宜以汗解，但尺迟则不可汗、一法脉浮数，即误下仍当发汗，但尺微则不可汗。（二）脉浮紧者，法当身疼痛，宜以汗解之，假令尺中迟者，不可发汗，何以知之，然以营气不足，血少故也。〔原文〕脉浮而紧，遍身疼痛，乃伤寒正病，亟当发汗，以驱逐外邪者也，设其人元气素薄，尺中脉迟，则城郭不完，兵甲不坚，米粟不多，根本先欲动摇，尚可背城借一乎，此所以必先建中而后发汗也。（三）脉浮数者，法当汗出而愈，若下之身重心悸者，不可发汗，当自汗出乃解，所以然者，尺中脉微，此里虚，须表里实，津液自和，便自汗出愈。〔原文〕脉浮数者，法当从乎汗解，故有更药发汗，及两解表里之法，设经误下，而身重心悸，纵脉仍浮数，亦不可复发其汗，但宜静调，俟其汗自出乃解耳，所以然者，以尺脉微，里阴素虚故也，必须津液自和，即为表里俱实，便自汗出而愈，此亦先建中而后发汗之变法，要知仲景云，尺脉微者不可发汗，又云尺微者，不可下无非相人津液之奥旨，所以误下之脉，虽浮数不改亟宜发汗者，亦必审谛其尺脉，不当率意径情，有如此矣。

凡用发汗药宜审病人有无宿疾，不可径汗六法。（一三）咽喉干燥者，不可发汗。

〔原文〕咽中干燥，其人平日津液素亏可知，故不可发汗以重夺其津液也，叔和重集不可发汗篇，有咽中闭塞，不可发汗，发汗则吐血，气欲绝，手足厥冷，欲得蜷卧，不能自温一条，与此似同而实大异，此戒发汗似夺阳明之津液，彼戒发汗以夺少阴之血也，又咽中闭塞不可下一条，亦指少阴立说，成注俱以咽门为胃之系混释，则谬矣。（一四）淋家不可发汗，发汗则便血。〔原文〕小便淋者，膀胱为热所闭，气化不行也，更发其汗，则膀胱愈扰，而血从小便出矣。（一五）疮家虽身疼痛，不可发汗，汗出则痊。〔原文〕身疼痛，为寒伤营之证，本当发汗，然疮疡之人，肌表素虚，营血暗耗，更发其汗，则外风袭虚，内血不荣，必至颈项强，身手张而成痊，痊亦膀胱之病也。（一六）衄家不可发汗，汗出必额上陷，脉紧急，目直视不能眴，不得眠。〔原文〕目得血而能视，汗为血液，衄血之人，清阳之气素伤，更发其汗，则额上必陷，乃上焦枯竭之应也，诸脉者皆属于目，筋脉紧急，则目上瞪而不能合，目不合则不得眠也，伤寒发烦，目瞑者必衄，宜用麻黄汤发汗，此言素惯衄血之人，戒发汗以虚其虚，宜两谛之也。（一七）亡血家不可发汗，汗发则寒栗而振。〔原文〕亡血即亡阴也，亡阴发汗，本当生热，乃反寒栗而振者何耶，盖阴亡则阳气孤而无偶，纔一发汗，其阳必从汗尽越，所以寒栗有加，阴阳两竭也。（一八）汗家重发汗，必恍惚心乱，小便已阴疼，与禹余粮丸。〔原文〕心主血，汗者心之液，平素多汗，更发其汗，则心脏之血伤，而心神恍惚，小肠之腑血亦伤，而便已阴疼，禹余粮丸，原方阙，然生心血，通水道，可意会也。

服麻黄汤汗后病不解，有恶寒恶热不同治一法。（一九）发汗病不解，反恶寒者虚故也，芍药甘草附子汤主之，发汗后恶寒者，虚故也，不恶寒但恶热者实也，当和胃气，与调胃承气汤。〔原文〕恶寒者，汗出营卫新虚，故用法以收阴固阳，而和其营卫，不恶寒者，汗出表气未虚，反加恶热，则津干胃实可知，故用法以泄实而和中，然曰与，似大有酌量，其不当径行攻下，以重虚津液，从可识矣。

服麻黄汤汗后身痛，脉迟者宜行补散一法。（二十）发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加芍药生姜各一两，人参三两，新加汤主之。〔原文〕伤寒发汗后，身反疼痛者，乃阳气暴虚，寒邪不能尽出所致，若脉见沉迟，更无疑矣，脉沉迟者，六部皆然，与尺迟大异，尺迟乃素虚，此为发汗新虚，故于桂枝方中，倍加芍药生姜各一两以去邪，用人参三两以辅正，名曰新加汤者，明非桂枝汤中之旧法也。门人问相传仲景全方，止得一百一十二道，因有新加一汤，故名为一百一十三方，其说然欤，答曰，此后人之呓语也，仲景意中，明明桂枝汤，不欲与人参并用，以桂枝能解肌表之邪，人参反固肌表之邪故也，然在误汗误下以后，表里参错，正气虚微，余邪不解，则有不得不并用之证，如上篇太阳病，外证未除而数下之，遂协热而利下痞鞭，表里不解，用桂枝理中汤，乃革去理中之名，但曰桂枝人参汤者，即此意也，人参尚主半表，故曰新加理中，则全不主表，故革其名，凡此皆仲景精微之蕴也，然桂枝人参汤中，去芍药者，以误下而邪入于阴，芍药主阴，不能散阳邪也，桂枝新加汤中倍芍药者，以误汗而阳虚邪凑，恐阳孤无偶，用芍药以和之，俾不至散乱也，故用法必识立法之意，斯用之各当矣。

服麻黄汤后不可误用桂枝及饮水灌水过多一法。（三）发汗后，不可更行桂枝汤，汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤主之，发汗后，饮水多者必喘，以水灌之亦喘。〔原文〕误用桂枝固卫，寒不得泄，气逆变喘，本当用大青龙汤，此于汤中除去桂枝姜枣者，以已经一误不可再误，馭药之严也，然有大热者，恐兼里证，若无大热，其为表邪实盛可知，故变青龙之制，为麻杏甘石，乃为的对也，饮水多者，内有大热，则能消之，汗后里证未具，内无大热，故饮水多者，水气上逆必为喘也，以水灌其外，冷气侵肤，与内邪相搏，亦主喘也，即形寒饮冷伤肺之意，但伤肺乃积渐所致，此不过偶伤耳，治法要不出麻杏甘石之外，见内饮水多，外行水灌，皆足以敛邪闭汗，不独误行桂枝汤为然矣。

本麻黄汤证，误下表邪未尽气逆变喘一法。（二三）下后不可更行桂枝汤，若汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤。〔原文〕易桂枝以石膏，少变麻黄之法，以治误汗而喘当矣，乃误下而喘，亦以桂枝为戒，而不越此方者何耶，盖太阳中风，与太阳伤寒，一从桂枝，一从麻黄，分途异治，繇中风之误下而喘者，用厚朴杏仁加入桂枝汤中观之，则伤寒之误下而喘者，用石膏加入麻黄汤中，乃天造地设，两不移易之定法，仲景所以谆谆告戒者，正恐人以伤寒已得汗之证，认为伤风有汗而误用桂枝，故特出误汗误下两条，示以同归麻黄一治之要，益见营卫分途，而成法不可混施矣。

服麻黄汤后有阳气暴虚叉手冒心二法。一法心下悸欲得按、一法耳聋无闻。（二三）发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸欲得按者，桂枝甘草汤主之。〔原文〕发汗过多，阳气虚衰，阳本受气于胸中，胸中阳气不足，故叉手冒心，不说到阴血上，方用桂枝甘草，固表缓中，亦未说到养血上，方注谓汗多则血伤，血伤则心虚，反置阳虚不理，所以迂阔而远于事情也。（二四）未持脉时，病人叉手自冒心，师因

教试令咳，而不咳者，此必两耳聋无闻也，所以然者，以重发汗，虚故如此。〔原文〕此示人推测阳虚之一端也，阳虚耳聋，宜亟固其阳，与少阳传经邪盛之耳聋迥别矣。

服麻黄汤后，有阳气暴虚阴邪上逆脐下悸腹胀满二法。一法欲作奔豚，预伐其邪、一法行气补虚，以除其满。（二五）发汗后，其人脐下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。〔原文〕汗本心之液，发汗后，脐下悸者，心气虚而肾气发动也，肾邪欲上陵心，故脐下先悸，取用茯苓桂枝，直趋肾界，预伐其邪，所谓上兵伐谋也。（二六）发汗后，腹胀满者，厚朴生姜甘草半夏人参汤主之。〔原文〕吐后腹胀，与下后腹胀，多为实，以邪气乘虚入里为实也，若发汗后，外已解而腹胀满，知非里实之证，繇脾胃气虚津液搏结，阴气内动，壅而为满也，故以益胃和脾，降气涤饮为治也。

服麻黄汗后，不繇误下津干饮结胃困变痞一法。（二七）伤寒汗出解之后，胃中不和，心下痞鞭，干噫食臭，胁下有水气，腹中雷鸣下利者，生姜泻心汤主之。〔原文〕汗后外邪虽解，然必胃气安和，始得脱然无恙，以胃主津液故也，津液因邪入而内结，因发汗而外亡，两伤告匮，其人心下必痞鞭，以伏饮搏聚，胃气不足以开之也，胃病故干噫食臭，食入而噎馊酸也，胃病故胁下有水气，水入而旁渗胁肋也，胃中水谷不行，腹中必雷鸣，而搏结有声，下利而清浊不分也，虽不由误下，而且成痞，设误下，其痞结又当何似耶，上篇论结胸及痞之源，云胃中空虚，此云胃中不和互意，以其未经误下而致空虚，但言不和，然不和已足成痞，胃气所关之巨，固若此哉。

误下成痞，用泻心汤诸方次第不同四法。一法误下后再误下，客热虚痞，用甘草泻心汤、一法误下后，复发汗，恶寒，先解表，后用大黄黄连泻心汤、一法阴气热邪作痞，用大黄黄连泻心汤，阴气乘阳虚作痞，用附子泻心汤、一法心下满而不痛者，用半夏泻心汤。（二八）伤寒中风，医反下之，其人下利日数十行，谷不化，腹中雷鸣，心下痞鞭而满，干呕心烦，不得安，医见心下痞，谓病不尽，复下之，其痞益甚，此非结热，但以胃中虚，客气上逆，故便鞭也，甘草泻心汤主之。〔原文〕此条痞证，伤寒与中风互言，大意具见，下利完谷，腹鸣呕烦，皆误下而胃中空虚之互词也，设不知此义，以为结热而复下之，其痞必益甚，故重以胃中虚，客气上逆，昭揭病因，方用甘草泻心汤者，即生姜泻心汤，除生姜人参不用，而倍甘草干姜也，客邪乘虚结于心下，本当用人参，以误而再误，其痞已极，人参仁柔，无刚决之力，故不用也，生姜辛温，最宜用者，然以气薄主散，恐其领津液上升，客邪从之犯上，故倍用干姜代之，以开痞，而用甘草为君，坐镇中州，庶心下与腹中渐致大宁耳，今人但知以生姜代干姜之僭，孰知以干姜代生姜之散哉，但知甘草能增满，孰知甘草能去满哉。（二九）伤寒大下后，复发汗心下痞，恶寒者，表未解也，不可攻痞，当先解表，表解乃可攻痞，解表宜桂枝汤，攻痞宜大黄黄连泻心汤。〔原文〕大下之后复发汗，先里后表，颠倒差误，究竟已陷之邪，痞结心下，证

兼恶寒，表邪不为汗衰，即不可更攻其痞，当用桂枝解肌之法，先解其外，外解已后，乃以大黄黄连泻心汤，攻去其心下之痞也。（三十）脉浮而紧而复下之，紧反入里，则作痞，按之自濡，但气痞耳，心下痞，按之濡，其脉关上浮者，大黄黄连泻心汤主之，心下痞而复恶寒汗出者，附子泻心汤主之。〔原文〕伤寒脉浮而紧，即不可下，误下而紧反入里，则寒邪转入转深矣，故作痞，外邪与内饮搏结，故心下满鞭，若按之自濡而不满鞭，则证不挟饮，其所挟饮者，乃身中之阴气上逆，而痞聚于心下也，阴气上逆，惟苦寒可泻之，上条大黄黄连泻心之法，即为定药，若恶寒汗出，前方必加上附子，以救阳虚，盖痞者干往居内，坤往居外，所以宜切阴盛阳微之虑，今恶寒汗出，其事着矣，故三黄汤内，另煎附子汁和服以各行其事，而共成倾否之功，即一泻心方中，其法度森森若此。（三一）伤寒五六日，呕而发热者，柴胡汤证具，而以他药下之，柴胡证仍在者，复与柴胡汤，此虽已下之不为逆，必蒸蒸而振，却发热汗出而解，若心下满而鞭痛者，此为结胸也，大陷胸汤主之，但满而不痛者，此为痞，柴胡汤不中与之，宜半夏泻心汤。〔原文〕半段当节入少阳篇中，因有半夏泻心汤之法，不便分析，故录全文。

上篇论结胸有阳明之兼证矣，此复论结胸及痞，有少阳之兼证，见五六日呕而发热，为少阳之本证，然太阳未罢，亦间有之，所以阳明致戒云，呕多虽有阳明证，不可攻，以呕属太阳故也，且发热而非往来之寒热，尤难辨识，果系少阳证，则太阳证将罢，不似阳明之不可攻，若系太阳，迁延未罢，误下即成痞结，其为逆更大矣，方用半夏泻心汤者，即生姜泻心汤，去生姜而君半夏也，去生姜者，恶其辛散，引津液上奔也，君半夏者，泻心诸方，原用以涤饮，此因证起于呕，故推之为主君耳。

服泻心汤，痞不解烦渴，小便不利，用五苓两解表里一法。（三二）本以下之，故心下痞，与泻心汤痞不解，其人渴而口躁烦，小便不利者，五苓散主之。〔原文〕泻心诸方，开结荡热益虚，可谓具备，乃服之而痞不解，更加渴而口躁烦，小便不利者，前第八条五苓两解表里之法，正当主用，盖其功擅润津滋躁，导饮荡热，所以亦得为消痞满之良治也。

服泻心汤，后复误下利不止，宜治下焦一法。（三二）伤寒服汤药，下利不止，心下痞鞭，服泻心汤已，复以他药下之，利不止，医以理中与之，利益甚，理中者理中焦，此利在下焦，赤石脂禹余粮汤主之，复利不止者，当利其小便。〔原文〕汤药者，荡涤肠胃之药，即下药也，误下而下利不止，心下痞鞭，服泻心汤为合法矣，乃复以他药下之，他药则皆荡涤下焦之药，与心下之痞，全不相涉，纵痞鞭微除，而关闸尽撤，利无休止，反取危困，用理中以开痞止利，原不为过，其利益甚者，明是以邻国为壑，徒重其奔迫也，故用赤石脂禹余粮，固下焦之脱，而重修其关闸，倘更不止，复通支河水道，以杀急奔之势，庶水谷分而下利自止耳。

痞证汗出，呕吐下利，用大柴胡汤两解表里一法。（三四）伤寒发热，汗出不解，

心中痞鞭，呕吐而下利者，大柴胡汤主之。〔原文〕外邪不解，转入于里，心下痞鞭，呕吐下利，攻之则碍表，不攻则里证已迫，计惟主大柴胡一汤，合表里而两解之耳。

汗吐下解后，余邪挟饮作痞，用旋覆代赭石汤一法。（三五）伤寒发汗，若吐苦下解后，心下痞鞭，噫气不除者，旋复代赭石汤主之。〔原文〕此亦伏饮为逆，但因胃气亏损，故用法以养正，而兼散余邪，大意重在噫气不除上，既心下痞鞭，更加噫气不除，则胃气上逆，全不下行，有升无降，所谓弦绝者其声嘶，土败者其声啾也，故用代赭领人参下行，以镇安其逆气，微加散邪涤饮，而痞自开耳。

病人素有痞连脐胁更加痛，引阴筋名为脏结一法。（三六）病胁下素有痞，连在脐傍，痛引少腹入阴筋者，此名脏结死，脏结无阳证，不往来寒热，其人反静，舌上胎滑者，不可攻也。〔原文〕伤寒有脏结之证，乃阴邪结于阴也，若加痛引少腹入阴筋，则悖乱极矣，故主死也，无阳证者无表证也，不往来寒热者，无半表半里之证也，其人反静者，并无里证也，既无表里之证，而舌上仍有胎滑，此为何故，则以丹田有热，胸中有寒耳，夫丹田阴也，反有热，胸中阳也，反有寒，则是其病不在表里，而在上下，上下之邪，相悖而不相入，所以不可攻也。按病人，素有动气在当脐上下左右，则不可发汗，素有痞气在胁下连脐傍，则不可攻下，医工不细询，病家不明告，因而贻误者多矣，甚有明知故犯者，其操术可胜诛哉。脏结之所以不可攻者，从来置之不讲，以为仲景未尝明言，后人无从知之，不知仲景言之甚明，人第不参讨耳，夫所谓不可攻者，乃垂戒之辞，正欲人详审其攻之之次第也，试思脏已结矣，匪攻而结胡繇开耶，前篇谓其外不解者，尚未可攻，又谓下利呕逆不可攻，又谓表解乃可攻痞，言之已悉，于此特出一诀，谓脏结无阳证，不往来寒热，其人反静，则证不在六经之表里，而在下焦上焦之两途，欲知其候，但观舌上有胎滑与否，有之则外感之阳热，挟痞气而反在下，素痞之阴寒，挟热势而反在上，此与里证已具，表证未除者，相去不远，但其阴阳悖逆，格拒而不入，证转凶危耳，岂结胸者膈内拒痛，而脏结者腹内不拒痛耶，此而攻之，是速其痛引阴经而死也，不攻则病不除，攻之则死，所以以攻为戒，是则调其阴阳，使之相入，而胎滑既退，然后攻之，则热邪外散，寒气内消，其脏结将自愈矣，此持危扶颠之真手眼也。凡腹内痛之证，得药而痛愈急者，要当识此。

设问借结胸以明脏结之脉证一法。（三七）问曰，病有结胸，有脏结，其状何如，答曰，按之痛，寸脉浮，关脉沉，名曰结胸也，何谓脏结，答曰，如结胸状，饮食如故，时时下利，寸脉浮，关脉小细沉紧，名曰脏结，舌上白胎滑者难治。〔原文〕脏结一证，最难辨识，复设问答，借结胸以详其脉证，而明外邪炽盛者为难治，结胸者阳邪结于阳也，脏结者阴邪结于阴也，然胸位高，脏位卑，其脉之寸浮关沉，两俱无异，乃脏结之关脉，更加小细紧者，以关脉居上下二焦之界，外邪繇此下结，积气繇此上干，实往来之要冲，所以病在下而脉反困于中也，此证全以外受之邪定轻重，若舌上有白胎滑，则所感深重，其互结之势方炽，单窗体里，及两解表

里之法，俱不可用，所以难治，然温中散邪，俾阴气渐下而内消，客邪渐上而外散，两相开解，则良工之为其所难乎。

伤寒下早亦成结胸之证四法一法辨大结胸，用大陷胸汤。一法辨小结胸，用小陷胸汤。一法辨热结在里，与结胸异。一法辨邪热在表，心下支结，单治其表。

太阳结胸证有少阳，附本篇第三十一条后。（三八）伤寒六七日，结胸热实，脉沉紧，心下痛，按之石鞕者大陷胸汤主之。〔原文〕伤寒误下，虽成痞，亦时有结胸之候，痞者十之八九，结胸者十之一二也，故次伤寒结胸于痞证之后，此条热实二字，形容结胸之状甚明，见邪热填实于胸间，不散漫也，上条言寸脉浮，关脉沉，此言脉沉紧更明，盖紧脉有浮沉之别，浮紧主伤寒无汗，沉紧主伤寒结胸，与中风之阳邪结胸迥殊，此所以不言浮也，精矣精矣。（三九）小结胸病，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷胸汤主之。〔原文〕小结胸病，正在心下，则不似大结胸之高在心上也，按之则痛，此手不可近则较轻也，而脉之浮又浅于沉，滑又缓于紧，可见其人外邪陷入原微，但痰饮素盛，挟热邪而内结，所以脉见浮滑也，黄连半夏括萎实，药味虽平，而泄热散结，亦是突围而入，所以名为小陷胸汤也。（四十）伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者，与大柴胡汤，但结胸无大热者，此为水结在胸胁也，但头微汗出者，大陷胸汤主之。〔原文〕治结胸之证，取用陷胸之法者，以外邪挟内饮搏结胸间，未全入于里也，若十余日热结在里，则是无形之邪热蕴结，必不定在胸上，加以往来寒热，仍兼半表，当用大柴胡汤，以两解表里之热邪，于陷胸之义无取矣，无大热，与上文热实互意，内陷之邪，但结胸间，而表里之热，反不炽盛，是为水饮结在胸胁，其人头有微汗，乃邪结在高，而阳气不能下达之明征，此则主用大陷胸汤，允为的对也，仲景辨证明彻若此，后人反谓结胸之外，复有水结胸一证，又谓下文支结，乃支饮结聚，亦另是一证，可笑极矣。（四一）伤寒六七日，发热微恶寒，肢节烦疼，微呕心下支结，外证未去者，柴胡桂枝汤主之，〔原文〕妙哉仲景之文，此一条，又足纬上三条而明其意，心下支结者，邪结于心下之偏旁不正中也，比小结胸之正在心下，又较轻矣，伤寒至六七日，宜经传已遍，乃发热微恶寒，肢节烦疼微呕，其邪尚在三阳之界，未入于里，虽心下支结，而外证未除，即不可用大陷胸汤，以大陷胸汤，主里而不主表也，亦不可用小陷胸汤，以小陷胸汤主饮而不主表也，夫支结之邪，其在外者方盛，其陷入者原少，故但合用柴胡桂枝和解二法，以治其表，表邪去而支节自开矣，后人谓支结，乃支饮结于心下，梦语喃喃，吾不识支饮为何物也。

辨下后胸满烦惊身重困笃一法。（四二）伤寒八九日，下之，胸满烦惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。〔原文〕此伏饮素稍为变之最巨者，盖积饮之人，津液素结，原不足以充灌周身，及遇外感，一切汗吐下定法，漫难轻试，其误下之变，更有进于结胸者，似此一证，八九日过经乃下之，可谓慎矣，孰知外邪未尽，乘虚而陷，积饮挟之，填满胸中，胸中既满，则膈中之气，不能四布而使道绝，使道绝则君主孤危，所以心惊而神乱也，烦与谵语本属胃

，此则兼心，小便不利，本属津液内竭，此亦兼小肠火燔，一身尽重不可转侧者，又神明内乱，治节不行，百骸无主之明征也，夫邪方在表里，其患已及神明，于此而补天浴日，宁复寻常表里所办，故用人参茯苓之补，以益心虚，丹铅之重，以镇心惊，龙骨牡蛎之涩，以为载神之舟楫，一方而批郤导窾，全收安内攘外之功，后人不察，谓是总三阳而和之之法，岂其然哉。按伤寒虽云传足不传手，其实原无界限，此证手少阴心主，为邪所逼，神明内乱，因致譫语无伦，较他证譫语之属胃实者，相去悬绝，若复以治足经之法治之，必无幸矣，方中药止九味，用入心药五种，不以为复，且用阳明药三种，不以为猛，盖都城震动，势必悉力入援，非孤注可图侥幸也，至于痰饮搏膈，最为剥床者，但用半夏一味，表邪内袭，首发难端者，但从太少之例，用桂枝柴胡二味，阳邪入阴，最宜急驱者，但用大黄一味，是则治伤寒吃紧之处，咸落第二义，止从治心诸药之后，一案共结其局，此等手眼，登凡近可识耶。

病久脉代结心动悸，宜补胃生津兼散邪一法。（四三）伤寒脉代结，心动悸者，炙甘草汤主之，一名复脉汤，脉按之来缓，而时一止复来者，名曰结，又脉来动而中止，更来小数，中有还者反动，名曰结阴也，脉来动而中止不能自还，因而复动，名曰代阴也，得此脉者必难治。〔原文〕伤寒病而至脉结代，心动悸，真阴已亡，微邪搏聚者，欲散不散，故立炙甘草汤，补胃生津润躁，以复其脉，少加桂枝以和营卫，少加清酒以助药力，内充胃气，外达肌表，不驱邪而邪自无可容矣。后段本为结代二脉下脚注，后人不解，疑为阙文，但以虚多实少混说，殊不知脉者气血之先，仲景于津液内亡之脉，名之为结阴代阴，又名无阳，原有至理，何得懵然不识，聊为四言俚句，以明其义，胃藏津液，水谷之海，内充脏腑，外灌形骸，津多脉盛，津少脉衰，津结病至，津竭祸来，脉见微弱，宜先建中，汗则津越，下则津空，津耗脉和，不可妄攻，小便渐减，大便自通，阳明内实，急下救焚，少缓须臾，津液无存，阳明似实，少用调承，驱热存津，此法若神，肾中真阳，阴精所栽，胃中真阳，津液所胎，津枯精盛，洌泉可溉，阴精衰薄，瓶罄罍衰，何谓结阴，无阳脉阖，何谓代阴，无阳脉夺，经揭无阳，津液所括，较彼亡阳，天地悬阔。

误下下利不止，身疼痛，宜先救里后救表一法。（四四）伤寒医下之，续得下利清谷不止，身疼痛者，急当救里，后身疼痛，清便自调者，急当救表，救里宜四逆汤，救表宜桂枝汤。〔原文〕下利清谷者，脾中之阳气微，而饮食不能腐化也，身体疼痛者，在里之阴邪盛，而筋脉为其阻滞也，阳微阴盛，凶危立至，当救其在里之微阳，俾利与痛而俱止，救后小便清，大便调，则在里之阳已复，而身痛不止，明是表邪未尽，营卫不和所致，又当急救其表，俾外邪仍从外解，而表里之辨，始为明且尽耳，救里与攻里天渊，若攻里必须先表后里，必无倒行逆施之法，惟在里之阴寒极盛，恐阳气暴脱，不得不急救其里，俟里证少定，仍救其表，初不敢以一时之权宜，更一定之正法也，厥阴篇下利腹胀，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表，曰先温，曰乃攻，形容不得已之次第，足互此意。

辨误下引邪内入用栀子汤取吐三法。一法下后烦满不安，用栀子厚朴汤、一法误用丸药大下身热微烦，用栀子干姜汤、一法大下后，身热心中结痛用栀子豉汤。（四五）伤寒下后，心烦腹满，卧起不安者，栀子厚朴汤主之。〔原文〕满而不烦，即里证已具之实满，烦而不满，即表证未罢之虚烦，合而有之，且卧起不安，明是邪凑胸表腹里之间，无可奈何之象，故取栀子以快涌其邪，而合厚朴枳实，以泄腹中之满，亦表里两解之法也。（四六）伤寒以丸药大下之，身热不去微烦者，栀子干姜汤主之。〔原文〕丸药大下，徒伤其中，而不能荡涤其邪，故栀子合干姜用之，亦温中散邪之法也。（四七）伤寒五六日，大下之后，身热不去，心中结痛者，未欲解也，栀子豉汤主之，发汗若下之，而烦热胸中窒者，栀子豉汤主之，发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者必反复颠倒，心中懊憹者，栀子豉汤主之，若少气者，栀子甘草豉汤主之，若呕者，栀子生姜豉汤主之，凡用栀子汤，病人粪微溏，不可与服之。〔原文〕香豉主寒热恶毒，烦躁满闷，下后身热不去，心中结痛，则表邪昭著，与前条之微烦不同，故以栀子合香豉，解散余邪，又主表而不主里之法也，然此栀豉一法，诸凡汗下后，证显实烦虚烦之不同，要皆可用，以其胸中窒塞，即名实烦，窒此心中结痛，则较轻也，以其身外热除，心中不窒，止是虚热内壅，即名虚烦，虚烦不得眠，亦即卧起不安之互词，反复颠倒，心中懊憹，热邪逼处，无法可除，故用栀豉汤，以涌其余热，乃因汗吐下后，胸中阳气不足，最虚之处，便是容邪之处，正宜因其高而越之耳，若虑津液内竭，正气暴虚，余邪不尽，则仲景原有炙甘草汤一法，宁敢妄涌，以犯虚虚之戒耶，执一而妄注，祇令作者之意尽失，可恼可恼。粪微溏，则大腑易动，服此汤不能上涌，反为下泄矣，缘内经有先泄而后生他病者，治其本，必先调之，后乃治其他病，故此示戒。

辨下后，复发汗之脉证及昼夜静躁二法。（四八）下之后，复发汗，必振寒，脉微细，所以然者，以内外俱虚故也。〔原文〕治伤寒，有先汗后下之次第，原不得已之法，设下之后，外邪不尽，复不得已而发其汗，其人身必振寒，脉必微细，邪虽去而内外俱虚，所伤滋大矣，良工于汗下之际，已不可无集木临谷之惧，现以误治致虚，更可再误，而犯虚虚之戒乎，注以振寒属误汗，脉微细属误下，且牵入亡阳亡阴蔓语，殊失仲景叮咛之意。（四九）下之后，复发汗，昼日烦躁，不得眠，夜而安静，不呕不渴，无表证，脉沉微，身无大热者，干姜附子汤主之。〔原文〕上条但言振寒及微细之脉，未定所主之病，以虚证不一也，然振寒脉微细，阳虚之故，已露一斑，设昼日烦躁不得眠，其为虚阳扰乱可知矣，其人夜反安静，不呕不渴，则虚阳扰乱，不兼外邪可知矣，乃复以脉沉微，身无大热，重加辨别者，仲景意中，恐新邪乘虚暗袭耳，外无邪袭，则烦躁为亡阳之候，而干姜附子在所必用矣，即此而推，其人日中安静，夜多烦躁，则阳不病，而阴病可知矣，然阴病乃伤寒后之本证，自有阳邪入阴，及阴气内亏，津液未复之条，故不复互言之也。

辨吐下后复汗身为振摇动惕久成痿废二法一法胸高头眩脉沉紧加误汗动经，宜亟通津液、一法饮搏胸胁，经脉动惕久成痿废。（五十）伤寒若吐若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者，茯苓桂枝白朮甘草汤

主之。〔原文〕心下逆满，气上冲胸，寒邪搏饮，塞涌于膈，所以起则头眩，脉见沉紧，明系饮中留结外邪，若但发汗以强解其外，外虽解而津液尽竭，反足伤动经脉，有身为振摇之患矣，盖人身经脉，赖津液以滋养，吐下而津液一伤，更发其汗，津液再伤，坐令经脉失养，身为振摇，贻害深矣，所以遇此等证，必一方之中，涤饮与散邪并施，乃克有济，太阳第三篇中，用小青龙汤，全是此意，但彼证风寒两受，不得不重在表，此证外邪已散，止存饮中之邪，故以桂枝加入制饮药内，俾饮中之邪尽散，津液得以四布，而滋养其经脉，千百年来孰解其批却导窾之微旨乎。（五一）伤寒吐下后，发汗，虚烦，脉甚微，八九日，心下痞硬，胁下痛，气上冲咽喉，眩冒，经脉动惕者久而成痿。〔原文〕此即上条之证，而明其增重者，必致废也，曰虚烦，曰脉甚微，则津液内亡，求上条之脉沉紧为不可得矣，曰心下痞硬，曰胁下痛，较上条之心下逆满更甚矣，曰气上冲咽喉，较上条之冲胸更高矣，外证痰饮搏结有加，而脉反甚微，不与病情相协，为日既久，则四属失其滋养，此后非不有饮食渐生之津液，然久不共经脉同行，其旁渗他溢与饮同事可知，其不能复荣经脉可知，所以竟成痿也。按汗下吐三法差误，阴阳并竭，变证蜂起，加心悸头眩，身瞤动，面色青黄，四肢难以屈伸等证，本篇言之不一，皆是教人对证急治，不可因循以贻祸患，如此一证，心下痞硬，太阳之邪，挟饮上逆也，胁下痛，少阳之邪，挟饮上逆也，逆而不已，上冲咽喉，逆而不已，过颈项而上冲头目，因而眩冒有加，则不但身为振摇，其颈项间，且阳虚而阴凑之矣，阴气剂颈，反不得还，乃至上入高巅，则头愈重而益振摇矣，夫人身之筋脉，全赖元气与津液为充养，元气以动而渐消，津液以结而不布，上盛下虚，两足必先痿废，此仲景茯苓杜枝白朮甘草汤，于心下逆满，气上冲胸之日，早已用力乎。

辨伤寒热瘀小便反利为蓄血用抵当丸一法。（五二）伤寒有热，少腹满，应小便不利，今反利者，为有血也，当下之，不可余药，宜抵当丸。〔原文〕伤寒蓄血，较中风蓄血，更为凝滞，故变上篇之抵当汤为丸，煮而连滓服之，与结胸项强似柔痙，用大陷胸丸同意，盖汤者荡也，阳邪入阴，一荡涤之，即散丸者缓也，阴邪入阴，恐荡涤之而不尽，故缓而攻之，所以求功于必胜也，其曰不可余药者，即本汤不变为丸，不可得矣。

辨伤寒风湿相搏，身体烦疼脉证二法。（五三）伤寒八九日，风湿相搏，身体烦疼，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩者，与桂枝附子汤主之，若其人大便鞭，小便自利者，去桂枝加白朮汤主之。〔原文〕风木湿土，虽天运六气中之二气，然而湿土实地之气也，经云，地气之中人也，下先受之，其与风相搏结，止是流入关节，身疼极重，而无头疼，及呕渴等证，故虽浸淫于周身躯壳，自难犯高巅脏腑之界耳，不呕者，上无表邪也，不渴者，内非热炽也，加以脉浮虚而涩，则为风湿搏于躯壳无疑，故用桂枝附子，疾驰经络水道，以迅扫而分竭之也。（五四）风湿相搏，骨节烦疼，掣痛，不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。〔原文〕此条复互上条之意，而辨其证之较重者，痛不可近，汗出短气，恶风不欲去衣，小便不利，或身微肿，正相搏之最剧处，

故于前方加白朮，以理脾而下渗其湿，减姜枣之和中，以外泄其风，要皆藉附子之大力者，负之而走耳。

辨伤寒发黄有寒湿相搏四法。（五五）伤寒发汗已，身目为黄，所以然者，以寒湿在里不解故也，以为不可下也，于寒湿中求之。〔原文〕伤寒发汗已，热邪解矣，何繇反蒸身目为黄，所以然者，寒湿搏聚，适在躯壳之里，故尔发黄也，里者在内之通称，非谓寒湿深入在里，盖身目正属躯壳，与脏腑无关也，于寒湿中求之，即下文三法也。（五六）伤寒瘀热在里，身必发黄，麻黄连翘赤小豆汤主之。〔原文〕伤寒之邪，得湿而不行，所以热瘀身中而发黄，故用外解之法，设泥里字，岂有邪在里而反治其表之理哉。（五七）伤寒七八日，身黄加橘子色，小便不利，腹微满者，茵陈蒿汤主之。〔原文〕黄色鲜明，其为三阳之热邪无疑，小便不利，腹微满，乃湿家之本证，不得因此指为伤寒之里证也，方中用大黄者，取佐茵陈栀子，建驱湿除热之功，以利小便，非用下也。（五八）伤寒身黄发热者，栀子蘘皮汤主之。〔原文〕热已发出于外，自与内瘀不同，正当随热势清解其黄，俾不留于肌表间也，前条热瘀，故用麻黄，此条发热，反不用麻黄者，盖寒湿之证，难于得热，热则其势外出，而不内入矣，所谓于寒湿中求之，不尽泥伤寒定法，此非一征欤。用三法以驱伤寒发黄，于寒湿中求之，能事毕矣，设不知此，妄行攻下，其邪乘虚陷入阳明中土，日与水谷相蒸，身目之黄，有加无已，渐至沉锢不返者多矣，此仲景所为叮咛不可下之意乎。同一湿也，与风相搏则为掣痛，与寒相结则发黄，是俱太阳表邪，故戒不可下，叔和不察，将寒湿编入阳明之末，未免与不可下之旨相悖，今悉归太阳，求不违先圣矩矱云。

太阳经下篇

凡风寒两伤营卫之证列于此篇，法二十四条。按上篇太阳中风，乃卫病而营不病之证，中篇太阳伤寒，乃营病而卫不病之证，然天气之风寒每相因，人身之营卫非两截，病则俱病者恒多，迨俱病则邪势孔炽，其人必增烦躁，非发汗不解，故仲景取用青龙之法，乃内经阳之汗以天地之雨名之之义也，但青龙为神物，最难驾驭，必审其人无少阴脉证，乃可用之，以少阴亦主烦躁故也，因是更立真武一汤，以救青龙之误投，白虎一汤，以匡青龙之不逮，神方毕用，所谓神乎其神者矣，有志精义入神之学者，请自兹篇证入。

用大青龙汤详辨脉辞大纲二法。（一）太阳中风，脉浮紧，发热恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁者，大青龙汤主之，若脉微弱，汗出恶风者，不可服，服之则厥逆，筋惕肉瞤，此为逆也，以真武汤救之。〔原文〕天地郁蒸，得雨则和，人身烦躁，得汗则解，大青龙汤证，为太阳无汗而设，与麻黄汤证何异，因有烦躁一证兼见，则非此法不解，盖风为烦，寒为躁，故用之发汗，以解其烦躁也，究竟本方原于无汗者，取微似汗，若有汗者之烦躁，全非郁蒸之比，其不藉汗解甚明，加以恶风脉微弱，则是少阴亡阳之证，若脉浮弱，汗出恶风而不烦躁，即是太阳中风之证，皆与

此汤不相涉也，误服此汤，宁不致厥逆惕瞤，而速其阳之亡耶，仲景不能必用法者，尽如其法，更立真武一汤，以救其误，学者能识其郑重之意，即百用不至一误矣，特为剖析疑义，相与明之。按解肌兼发汗，而取义于青龙者，龙升而云兴，云兴而雨降，郁热顿除，烦躁乃解，匪龙之为灵，何以得此乎，观仲景制方之意，本是桂枝麻黄二汤合用，但因芍药酸收，为兴龙致雨所不宜，故易以石膏之辛甘大寒，辛以散风，甘以散寒，寒以胜热，一药而三善俱备，且能助青龙升腾之势，所以为至当至神之法也，然而去芍药之酸收，增石膏之辛散，外攻之力，猛而难制，在寒多风少，及风寒两停之证，则用当而通神，其有风无寒之证，及微弱之脉，若不知辨而概用之，有厥逆惕瞤而亡阳耳，此疏庸之辈，所为望而畏之乎，诂知仲景于风多寒少之证，而见微邪之脉，有用桂枝二越婢一之法，桂枝全方，不去芍药，取用其二，全是不欲发汗之意，复改麻黄一汤，为越婢一者，略用麻黄石膏一物，示微发于不发之中耳，夫婢，女子之卑者也，女子因以顺为正，况于婢则惟所指使，更无专擅矣，以大青龙之升腾变化，不可驾驭之物，约略用之，乃至性同女婢之卑柔，此仲景通天手眼也，只一方中，忽焉去芍药，为大青龙而升天兴云雨，忽焉存芍药，为小青龙而蟠泥润江海，忽焉用桂枝二越婢一，而细雨湿泥沙，精义入神之道，比仙经较着矣，后人不窥作者之藩，安望其能用之也哉。再按误服大青龙汤，厥逆筋惕肉瞤者，既有亡阳之逆矣，亡阳帅当用四逆汤以回阳，乃置而不用，更推重真武一汤以救之者，其义何居，盖真武乃北方司水之神，龙惟藉水乃能变化，而水者真武之所司也，设真武不与之以水，青龙之不能奋然升天可知矣，故方中用茯苓白朮芍药附子，行水收阴，醒脾崇土之功，多于回阳，名之曰真武汤，乃收拾分驰离绝之阴阳，互镇于少阴北方之位，其所收拾者，全在收拾其水，使龙潜而不能见也，设有一毫水气上逆，龙即得遂其升腾变化，纵独用附子干姜以回阳，其如魄汗不止何哉，厥后晋旌阳祖师，以仙术斩蛟，捕至蛟龙遁迹之所，戒其家勿蓄勺水，乃至从砚中水逸去，可见水怪，原有尺水丈波之能，向非真武坐镇北方，天壤间久为龙蛇之窟矣，即此推之，人身阳根于阴，其亡阳之证，乃少阴肾中之真阳飞越耳，真阳飞越，亟须静摄归根，阳既归根阴必翕然从之，阴从则水不逆矣，阴从则阳不孤矣，岂更能飞越乎，故舍天人一致之理，以谭医者，非真至也。后贤用附子为末，以止阴躁，名曰霹雳散，药虽善，而名则可笑，夫阴躁正厥惕瞤之候，而霹雳又青龙行雨之符，以是名方，其违圣悖理，可胜道哉。（二）伤寒脉浮缓，身不疼，但重，乍有轻时，无少阴证者，大青龙汤发之。〔原文〕前条太阳中风四字，括上篇而言，此条伤寒二字，括中篇而言，风寒之脉证错见，则桂枝汤与麻黄汤，为不可用，不待言矣，故二条反复互明大青龙汤，允为风寒两兼，的对之药也，无少阴证，成注谓不久厥吐利，无少阴里证，梦语喃喃，误人最大，仲景原文，但重乍有轻时六字，蚤已挈明，言但身重，而无少阴之欲寐，其为寒因可审，况乍有轻时，不似少阴之昼夜俱重，又兼风因可审，所以敢恣行无忌，力驱其在表之风寒，若脉微弱，身重欲寐，则内顾少阴，且不遑矣，敢发之乎。细玩二条文意，伤风脉本微缓，反见浮紧，伤寒脉本浮紧，反见微缓，是为伤风见寒，伤寒见风，两无疑矣，既无可疑，又当辨无少阴证相杂，则用青龙，万举万当矣，故脉见浮弱，即不可用大青龙汤，以少阴病脉必微细也，方注泥弱字，牵入中风之脉，阳浮阴弱为解，

大失仲景叮咛垂戒之意，不思中风之脉，以及误汗等证，太阳上篇已悉，此处但归重分别少阴，以太阳膀胱经，与少阴肾经，合为表里，膀胱邪胜肾切震邻，其在阴精素虚之人，表邪不俟传经，蚤从膀胱之府，袭入肾藏者有之，现两感夹阴等证，临病尤当细察，设少阴不亏，表邪安能飞渡，而见身重欲寐等证耶，故有少阴证者，不得已而行表散，自有温经散邪，两相绾照之法，岂可径用青龙之猛，立铲孤阳之根乎，仲景竖此一义，用法之妙，已竭尽无余，后人颠倒无传妄行注释，致令察脉辨证之际，懵然不识要妙，祇觉仲景之堂，无阶可升，其治虚劳发热，骨蒸多汗，每轻用升柴，恣行表散，遵依东垣升阳散火，乃至百不救一，今与英贤商榷仲景法，岂非民生之一幸欤。

青龙项中脉见浮紧日久致衄用麻黄汤次第三法（三）太阳病，脉浮紧无汗，发热身疼痛，八九日不解，表证仍在，此当发其汗，服药已微除，其人发烦热，目瞑，剧者必衄，衄乃解，所以然者，阳气主重故也，麻黄汤主之。〔原文〕此风多寒少之证，服药已微除，则药不胜病可知，发烦者热蒸而郁烦也，目瞑者，热转营血肝气不治也，剧则热甚于经，必迫血妄行而为衄，衄则热随血散而解也，阳气重者，风属阳而入卫，气为寒所持故重也，所以虽得衄解，仍主麻黄汤以发其未尽之沉滞，而大变乎中风之例也。（四）太阳病，脉浮紧，发热身无汗，自衄者愈。〔原文〕此即前条风多寒少之证，但无身疼痛，则寒证较轻，又无发烦目瞑，则阳气亦不重，自衄即愈，比前衄乃解亦易安，所以既衄，则不更主麻黄汤也。（五）伤寒脉浮紧，不发汗因致衄者，麻黄汤主之。〔原文〕此寒多风少之证也，寒多不发汗，所以致衄，既衄则风邪得解，所以惟用麻黄汤，以发其未散之寒，而但从伤寒之例也。

青龙项中状如疟表里虚禁汗吐下用各半汤一法（六）太阳病，得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，其人不呕，清便欲自可，一日二三度发，脉微缓者，为欲愈也，脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更发汗，更下更吐也，面色反有热色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤。〔原文〕此亦风多寒少之证，以其风虽外薄，为寒所持，而不能散，所以面显怫郁之热色，宜总风寒而两解之也。

青龙项中脉微弱为无阳用桂枝二越婢一汤一法（七）太阳病，发热恶寒，热多寒少，脉微弱者，此无阳也，不可更汗，宜桂枝二越婢一汤。〔原文〕此亦风多寒少之证，无阳二字，仲景言之不一，后人不解，皆置为阙疑，不知乃亡津液之通称也，故以不可更汗为戒，然非汗则风寒终不解，惟取桂枝之二以治风，越婢之一以治寒，乃为合法，越婢者石膏之辛凉也，胃得之则热化津生，以此兼解其寒，柔缓之性，比女婢犹为过之，可用之无恐矣。

青龙项中汗出不解用桂枝二麻黄一汤一法（八）服桂枝汤，大汗出，脉洪大者，与桂枝汤如前法，若形如疟，日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。〔原文〕此

亦风多寒少之证，服桂枝汤，治风而遗其寒，汗反大出，脉反洪大，似乎风邪再袭，故重以杜枝汤探之，若果风邪之故，立解矣，若形如疟，日再发，则邪本欲散，又且浅而易散，其所以不散者，终为微寒所持，故略兼治寒，而汗出必解也。

青龙项中辨表里用桂枝汤单解风邪一法（九）伤寒不大便六七日，头痛有热者，与承气汤，其小便清者，知不在里，仍在表也，当须发汗，若头痛者必衄，宜桂枝汤。〔原文〕六七日不大便，明系里热，况有热以证之，更可无疑，故虽头痛，可用承气下之，若小便清者，邪未入里，即不可下，仍当发汗以散表邪，然头疼有热，多是风邪上壅，势必致衄，若兼寒邪，则必如第二类之身疼痛目瞑，何以但头痛，而无身目之证耶，故惟用桂枝汤，以解风邪，与用麻黄汤之法各别也。

青龙项中风寒挟饮微结桂枝合五苓加减一法（十）服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热无汗，心下满，微痛，小便不利者，桂枝汤去桂，加茯苓白朮汤主之。〔原文〕服桂枝汤，治风而遗其寒，所以不解而证变，设更下之，则邪势乘虚入里益误矣，在表之风寒未除，而在里之水饮上逆，故变五苓两解表里之法，而用茯苓白朮为主治，去桂枝者，以已误不可复用也，然桂枝虽不可用，其部下诸属，皆所必需，倘并不用芍药以收阴，甘草姜枣以益虚而和脾胃，其何以定误汗误下之变耶，故更一主将，而一军用命，甚矣，仲景立方之神也。

青龙项中火迫亡阳用桂枝汤加减救逆一法（一一）伤寒脉浮，医以火迫劫之，亡阳必惊狂，起卧不安者，桂枝去芍药，加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤主之。〔原文〕此条文义甚明，后人不识作者之意，虽有良法而不能用，兹特阐之篇首，误服大青龙汤，厥逆筋惕肉瞤而亡阳者，乃汗多所致，故用真武汤救之，此以火迫劫而亡阳者，乃方寸元阳之神，被火迫劫而飞腾散乱，故惊狂起卧不安，有如此者，少缓须臾，驷马莫追，神丹莫挽矣，故用此汤救之，桂枝汤中除去芍药，人皆不知其故，或谓恶其酸收，非也，夫神散正欲其收，何为见恶耶，设不宜于芍药之酸，又何宜于龙骨牡蛎之潜耶，学者于此等处，当猛下一参，透此一关，胜读方书千卷，盖阳神散乱当求之于阳，桂枝汤阳药也，然必去芍药之阴重，始得疾趋以达于阳位，既达阳位矣，其神之惊狂者漫难安定，更加蜀漆为之主统，则神可赖以攸宁矣，缘蜀漆之性最急，丹溪谓其能飞补是也，更加龙骨牡蛎有形之骨属，为之舟楫，以载神而返其宅，亦以重而镇怯，潜以固脱之外行，其妙用如是，而后天君复辟，聿迫晋重耳越勾践返国之良图矣，仲景制方，岂易识哉。

青龙项中火逆烦躁用桂枝甘草龙骨牡蛎汤一法（三）火逆下之，因烧针烦躁者，桂枝甘草龙骨牡蛎汤主之。〔原文〕此证误而又误，虽无惊狂等变，然烦躁，则外邪未尽之候，亦真阳欲亡之机，故但用桂枝以解其外，龙骨牡蛎以安其内，不用蜀漆者，以元神未至飞越，无取急追，以滋扰也。

青龙项中误用桂枝治风遗寒治表遗里救变一法（一三）伤寒脉浮，自汗出，小便数

心烦，微恶寒，脚挛急，反与桂枝汤，欲攻其表，此误也，得之便厥，咽中干烦躁吐逆者，作甘草干姜汤与之以复其阳，若厥愈足温者，更作芍药甘草汤与之，其脚即伸，若胃气不和，谵语者，少与调胃承气汤，若重发汗，复加烧针者，四逆汤主之。〔原文〕此段辨证用法，最精最详，从前不得其解，今特明之，脉浮自汗，固是在表之风邪，而小便数，心烦，则邪又在里，加以微恶寒，则在里为寒邪，更加脚挛急，则寒邪颇重矣，乃用桂枝独治其表，则阳愈虚，阴愈无制，故得之便厥也，桂枝且误，麻黄更可知矣，大青龙更可知矣，阴寒内凝，总无攻表之理也，甘草干姜汤复其阳者，即所以散其寒也，厥愈足温，不但不必治寒，且虑前之辛热有伤其阴，而足挛转辘，故随用芍药甘草，以和阴而伸其脚，设胃气不和而谵语，则胃中津液，亦为辛热所耗，故少与调胃承气汤，以和胃而止其谵，多与则为下，而非和矣，若不知此证之不可汗，而重发其汗，复加烧针，则阳之虚者必造于亡，阴之无制者必至犯上无等，此则用四逆汤以回其阳，尚恐不胜，况可兼阴为治乎。问曰，证象阳旦，按法治之，而增剧厥逆，咽中干，两胫拘急而谵语，师言夜半手足当温，两脚当伸，后如师言，何以知此，答曰，寸口脉浮而大，浮则为风，大则为虚，风则生微热，虚则两胫挛，病证象桂枝，因加附子参其间，增桂令汗出，附子温经，亡阳故也，厥逆咽中干烦躁，阳明内结，谵语烦乱，更饮甘草干姜汤，夜半阳气还，两足当热，胫尚微拘急，重与芍药甘草汤，尔乃胫伸，以承气汤微溲，则止其谵语，故知病可愈。〔原文〕附答门人问辞，求正四方道契。门人问曰，证象阳旦，成注谓是桂枝之别名，方注谓阳以风言，旦，晓也，似中风分晓，以本营中风，故设难详申其义，一主药，一主证，二家未知孰是，答曰，主药则既名桂枝云，何别名阳旦，是必一百一十三方，方方皆有别名然后可，主证则既是中风，复云不啻中风，果为何证，且训旦为晓，尤为牵强不通，二家于此等大关系处，尚且昏昏，后学安得不面墙耶，夫仲景之圆机活法，妙在阳旦阴旦二汤，阳旦者天日晴暖，以及春夏温热之称也，阴旦者，风雨晦冥，以及秋冬凉寒之称也，只一桂枝汤，遇时令温热，则加黄芩，名阳旦汤，遇时令凉寒则加芍药，名阴旦汤，后世失传，纷纷谓桂枝不宜于春夏者，皆繇不识此义耳，即如此证，既象阳旦，又云按法用之，即是按用桂枝加黄芩之法也，所以病人得之，便厥，明明误在黄芩助其阴寒，若单服桂枝汤，何至是耶，故仲景即行阴旦之法，以救其失，观增桂令汗出一语，岂不昭昭耶，阴旦不足，更加附子温经，即咽中干阳明内结谵语烦乱，浑不为意，且重饮甘草干姜汤，以俟夜半阳回足热，后果如其言，岂非先有所试乎，惟黄芩入口而便厥，未几即以桂附干姜尾其后，固知其厥必不久，所以可断云夜半手足当温，况咽干谵语热证相错，其非重阴沍寒可知，故俟得足温，即便以和阴为务，何其审哉，今与二三同调，抵掌谭仲景，当年治病机宜，愧无旨酒，满浮大白耳。

青龙项中汗下后烦躁将欲亡阳宜补虚回阳一法（一四）发汗若下之，病仍不解，烦躁者，茯苓四逆汤主之。〔原文〕烦躁者大青龙汤证，然脉弱汗出恶风者，误服之，则厥逆筋惕肉瞤，首条已谆谆致戒矣，此条复申其辨，见汗下不解，转增烦躁，则真阳有欲亡之机，而风寒之邪，在所不计，当用茯苓人参干姜附子，温补兼行，以安和其欲越之阳，俾虚热自退，烦躁自止，乃为合法，若因烦躁，更加散邪则立

毙矣，夫不汗出之烦躁，与发汗后才烦躁，毫厘千里，不汗出之烦躁，不辨脉而误投大青龙，尚有亡阳之变，是则发汗后之烦躁，即不误在药，已误在汗矣，此仲景所为见微知着，仿真武之例，更加人参之补，以嘿杜其危哉，下后烦躁，较未下之烦躁亦殊。

青龙项中风寒兼见寒热两壅宜分解阴阳一法（一五）伤寒胸中有热，胃中有邪气，腹中痛，欲呕吐者，黄连汤主之。〔原文〕胸中有热，风邪在上也，胃中有邪气，寒邪在中也，腹中痛，阳邪欲下而不得下也，欲呕吐，阴邪欲上而不得上也，此所以知其热邪中上，寒邪中下，阴阳各不相入，失其升降之恒，故用黄连汤，以分理阴阳而和解之也，尝因此法而推及脏结之证，舌上有胎者，又为寒反在上，热反在下，阴阳悖逆，既成危候，仲景但戒以不可攻，未言治法，然非先之以和解，将立视其死乎，学者请于黄连汤着眼。〔详见太阳中篇脏结条〕

青龙项中辨脉证之纵横而刺其经穴二法（一六）伤寒腹满谵语，寸口脉浮而紧，此肝乘脾也，名曰纵，刺期门。〔原文。期门二穴在不容两傍各去同身寸之一寸五分肝之募也。〕肝木乘脾土，名曰纵，其证腹满谵语，其脉寸口浮而紧，寸口即气口，脾胃脉之所主也，浮而且紧，即弦脉也，肝木过盛，所以脾胃之土受制也。（一七）伤寒发热，濇濇恶寒，大渴欲饮水，其腹必满，自汗出小便利，其府欲解，此肝乘肺也，名曰横，刺期门。〔原文〕肝脉乘肺金，名曰横，发热，濇濇恶寒者，太阳之本证也，大渴饮水者，木盛则热炽，而求水以润之也，木得水助，其势益横反侮所不胜，而上乘乎肺，水势泛溢，其腹必满，然肺金素无他病者，必能暗为运布，或自汗而水得外渗，或小便利而水得下行，其病欲解也，亦繇但腹满而不谵语，故易解耳。直贯上下曰纵，眠旦两旁曰横，木本克土，而乘乎土，其事直，故为纵，木受制于金，而反乘金，其事不直，故曰横，直则难愈，不直则易安，理之常也，然纵横之证不同，而同刺期门穴者，以贼土侮金，皆繇木盛，腹满谵语，证涉危疑，故急以泻木为主治也。

用小青龙汤外散风寒内涤水饮二法（一八）伤寒表不解，心下有水气，干呕发热，而咳，或渴或利或噎，或小便利，少腹满，或喘者，小青龙汤主之。〔原文〕风寒不解，心下有水气，水即饮也，水寒相搏，必伤其肺，或为多证者，人身所积之饮，或上或下或中，或热或冷，各不相同，而肺同为总司，但有一二证见，即水逆之应也，于散风寒涤水饮药中，加五味子之酸，以收肺气之逆，干姜之辛，以泻肺气之满，名曰小青龙汤，盖取其翻披逐浪以归江海，不欲其兴云升天而为淫雨之意也，后人谓小青龙汤为发汗之轻剂，毋乃昧其旨乎。（一九）伤寒心下有水气，咳而微喘，发热不渴，服汤已，渴者此寒去欲解也，小青龙汤主之。〔原文〕风寒挟水饮上逆，津液不下行，故不渴，渴则可知津液不逆，为寒去欲解之征也，寒去欲解，仍用小青龙汤，与上篇脉见单浮，用桂枝汤，中篇脉见单浮，用麻黄汤同意，大率以轻剂助其欲解之势耳。按桂枝麻黄汤无大小，而青龙汤有大小者，以桂枝麻黄之变法多，大青龙之变法，不过于麻桂二汤内施其化裁，或增或去，或饶或减，

其中神化，莫可端倪，又立小青龙一法，散邪之功，兼乎涤饮，取义山泽，小龙养成头角，乘雷雨而翻江搅海，直奔龙门之意，用以代大青龙，而擅江河行水之力，立法诚大备也，因经叔和之编次，漫无统纪，昌于分篇之际，特以大青龙为纲，于中桂麻诸法，悉统于青龙项下，拟为龙背龙接龙腹，然后以小青龙尾之，或飞或潜，可弭可伏，用大用小，曲畅无遗，居然仲景通天手眼，驭龙心法矣，更复顾名思义，清其血脉，于青龙尾后方缀白虎，为之对待，俾观者知神用无方，爽然有会，表章之余，聊资启发云。或问青龙自为一队，即白虎且剔出另峙其后，然则脉证之纵横，何与青龙事耶，答曰，此等奥义，惟作者知之，伤寒多有忽然自汗，突尔亡阳之候，虽不用青龙之药，蚤已犯青龙之逆者矣，况腹满则阴盛可知，讖语则阳虚可虑，仲景特挈纵横以名之者，岂无说耶，盖屈蠖者，龙之所以伏也，纵横者龙之所以飞也，纵横之脉证不同，刺穴同用期门，期门乃肝木所主，东方青龙之位也，刺其穴者，正所以制龙本而预弭亡阳之变耳，故一青龙方中，张大其施，则升行而为霖雨，狭小其制，则鼓浪而奔江海，驯其性能，则踰越奴婢之卑柔，刺其经穴，则销弭灵幻于寂若，仲景于其奋髯升天，万难把捉之时，尚以真武一法，坐镇北方之水，俾地气不上，天气不下，所谓其雨其雨，杲杲日出，龙之既升于天者，且不得不复返于渊，况未及升腾，可驯可抚，顾无法以制伏之耶，此余所为有会于纵横之义也，傥不其然，匪但无与青龙之事，亦并无与伤寒之事矣，昔有善画龙者，举笔凝思，而青天忽生风雨，吾不知仲景制方之时，其为龙乎，其为仲景乎，必有倏焉雷雨满盈，倏焉密云不雨，倏焉波浪奔腾，倏焉天日开朗，以应其生心之经纶者，神哉，青龙等方，即拟为九天龙经可矣。娄东胡贞臣先生，昌所谓贤士大夫也，夙苦痰饮为恙，夏月地气上升，痰即内动，设小有外感，膈间痰即不行，两三日瘥后，当膺尚结小瘕，无医不询，无方不考，乃至梦寐恳求大士救疗，因尔闻疾思苦，深入三摩地位，荐分治病手眼，今且仁智兼成矣，昌昔谓膀胱之气化大行，地气不升，则天气常朗，其偶受外感，则仲景之小青龙一方，与大士水月光中大圆镜智无以异也，盖无形之感，挟有形之痰，互为胶漆，其当胸窟宅，适在太阳经位，惟于麻桂方中，倍加半夏五味，以涤饮而收阴，加干姜细辛，以散结而分邪，合而用之，令药力适在痰邪绾结之处，攻击片时，则无形之感，从肌肤出，有形之痰，从水道出，顷刻分解无余，而膺胸空旷，不复丛生小瘕矣，若泥麻桂甘温，减去不用，则不成其为龙矣，将恃何物为翻波鼓浪之具乎。

变青龙汤经制改用白虎汤权宜五法（二十）服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者，白虎加人参汤主之。〔原文〕大汗出，则津液外亡，大烦渴，则躁热内极，脉转洪大，则凶变将起，青龙汤为不对矣，计惟白虎汤，可两解表里之热，加人参可润躁止渴也。（三）伤寒脉浮滑，此表有热里有寒，白虎汤主之。〔原文〕伤寒之脉，阴阳俱紧，此云浮滑，则兼风可知，滑为里热，浮滑则表亦热矣，里有寒者，伤寒传入于里，更增里热，但因起于寒，故推本而曰里有寒，实则表里俱为热极也。（一三）伤寒脉浮，发热无汗，其表不解者，不可与白虎汤，渴欲饮水，无表证者，白虎加人参汤主之。〔原文〕白虎汤但能解热，不能解表，必恶寒头身疼痛之表证皆除，但热渴而求救于水者，方可与之。（二三）伤寒无大热，口躁渴心

烦，背微恶寒者，白虎加人参汤主之。〔原文〕表里热极，躁渴心烦，全无恶寒，头疼身痛，诸表证者，固当行白虎矣，若脉浮滑，背微恶寒，此为表热少，里热多之证，仍可与之，盖以脉滑明系里热，而背为至阴之地，虽表退尙有余寒，不当牵泥也，设脉但浮而不滑，证兼头疼身痛，则虽表里俱热，而在表之邪浑未退，白虎汤即不可用，以白虎辛凉不能解表故也。此条辨证最细，脉滑而带浮，浑身无大热，又不恶寒，但背间微觉恶寒，是表邪已将罢，其人口躁渴心烦，是里热已大炽，更不可姑待，而当急为清解，恐迟则热深津竭，无救于事矣。门人问用白虎则表热不解，用青龙则里热转增，试拟议于二者之间，不识当用何法，答曰，惟于大青龙汤中，倍增石膏，少减麻桂，或见寒多风少，则用麻杏甘石汤，亦倍增石膏，少减麻黄，斯固圆机，然亦即可为定法矣。（二四）伤寒病，若吐若下后，七八日不解，热结在里，表里俱热，时时恶风大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者，白虎加人参汤主之。〔原文〕玩此条表证，比前较重，何以亦用白虎耶，本文热结在里，表里俱热二句，已自酌量，惟热结在里，所以表热不除，况加大渴饮水，安得不以清里为急耶，白虎五证，得隶青龙后者，以风寒俱有故也。寒与风皆伤，宜从辛甘发散矣，而表与里又俱热，则温热为不可用，欲并风塞表里之热而俱解之，不其难乎，故立白虎汤一法，以辅青龙之不逮，其药乃石膏知母，辛凉之二物也，辛者西方金也，凉者秋令也，酷热之时，欲求金风荐爽，万不可得，计惟虎啸则山谷间习习风生，风生则热解耳，所以取辛凉二物，偶而成方，以象白虎之阴也，夫青龙变化莫测，方无定体，故各用制伏之法，若白虎则地兽之灵，得风从而其威愈震，亦不易制伏之物，况里热已极，津液垂亡，元气所存无几，而领西方之肃杀，以入胃中，能无虑乎，于是以甘草之甘缓，和其猛性，而入米同煎，以助胃中水谷之气，虚者更加人参，以助胃中天真之气，乃可用之而无患，制法早具于一方之内矣，世传孙思邈有降龙伏虎之能，岂非以仲景之心法为道法耶。夫以石膏一物之微，入甘温队中则为青龙，从清凉同气，则为白虎，惟文武圣神之哲，乃能用之恰当，此龙虎所为庆风云之会也，设在表之风寒未除，当用青龙，而反用白虎，设在里之热渴已逼，当用白虎而反用青龙，则用者之误，竟与倒行逆施者同类，宁不败乃事乎，伤心哉，千古兴亡之际，同一医辙矣。

卷二

尚论阳明经证治大意

伤寒之证，无如太阳一经，风寒参错，表里差殊，难于辨认，昌分三篇，先列鄙语以引其端，后随仲景原文，阐其立言精意，俾业医者，得其门而入，庶足以窥其富美也，而阳明一经之病，治之尤难，盖胃为水谷之海，五脏六腑之大源，多气多血之冲，乃吉凶死生所攸关，仲景着论精详，后人读之愤愤，今僭为尚论，请得而要言之也，夫阳明者胃也，阳明以胃实为正，胃实则皆下证也，然阳明之邪，其来路则繇太阳，凡阳明证见八九，而太阳证有一二未罢，即从太阳而不从阳明，可汗而不可下也，其去路则趋少阳，凡阳明证纵见八九，而少阳证略见一二，即从少阳而不从阳明，可汗而不可下也，其去路趋少阳，凡阳明证纵见八九，而少阳证略见一二，即从少阳而不从阳明，汗下两不可用也，惟风寒之邪，已离太阳，未接少阳，恰好在阳明界内之时，用药亟为攻下，则涣然冰释，而不再传他经，津液元气，两无亏损，何快如之，此等机会，间不容发，庸愚无识，妄守颞门，必俟七日传经已尽，方敢言下，纵不危殆，而津液元气，所丧滋多矣，况太阳一经，早有十余日不解者，若不辨经而但计日，其误下仍在太阳，至阳明二三日内，即显下证，反以计日，当面错过，及阳明已趋少阳，又以计日妄行攻下，乃至少阳复转阳明，更全不识其证，以至热邪在胃，烁尽津液，轻者重而重者死矣，所关顾不巨耶，谨将阳明之证，亦比太阳之例，分为三篇，俾观者了无疑惑，斯临病不致差误耳。

阳明经上篇〔凡外邪初入阳明地界，未离太阳，净尽者谓之太阳，阳明列于此篇〕

太阳与阳明两经各半，谓之合病，两经连串，谓之并病，另自名篇于三阳经后，不在此例，此乃邪入阳明，而太阳将尽未尽之证也。（一）阳明病，脉迟汗出多，微恶寒者，表未解也，可发汗，宜桂枝汤方。〔原文〕（二）阳明病，脉浮无汗而喘者，发汗则愈，宜麻黄汤。〔原文〕仲景此二条之文，前条云风未解，后条即不云寒未解者，互文也，前条云，宜发汗，后条云，发汗则愈者，亦互文也，盖外邪初入阳明，用桂枝汤解肌，则风邪仍从卫分出矣，用麻黄汤发汗，则寒邪仍从营分出矣，营分之邪，深于卫分，且从外出而愈，则卫分更不待言矣，论中每用互文处，其妙义大率若此。（三）阳明病，能食者为中风，不能食者为中寒。〔原文〕风则伤卫，寒则伤营，一定之理，是则足三阳经，太阳行身之背，阳明行身之前，少阳行身之侧，皆可言营卫受邪，何仲景于阳明经，但以能食不能食分风寒，而不以营卫分风寒耶，盖营卫交会于中焦，论其分出之名，则营为水穀之精气，卫为水穀之悍气，论其同出之源，混然一气，何繇分其孰为营孰为卫哉，惟风为阳，阳能消谷，故能食，寒为阴，阴不能消穀，故不能食，以此而辨风寒之邪，庶几确然有据耳，仲景析义之精若此，如习焉不察者何。（四）脉阳微而汗出少者，为自和也，汗出多者为太过，阳脉实因发其汗出多者，亦为太过，太过为阳绝于里，亡津液，大便因鞣也。〔原文〕阳微者，中风之脉，阳微缓也，阳实者伤寒之脉，阳紧实也，

阳绝即亡津液之互辞，仲景每于亡津液者，悉名无阳，本文阳绝于里亡津液，大便因鞭甚明，注家认作汗多而阳亡于外，大谬。伤寒发太阳膀胱经之汗，即当顾虑阳气，以膀胱主气化故也，发阳明胃经之汗，即当顾虑阴津以胃中藏津液故也，所以阳明多有热越之证，稍胃中津液，随热而尽越于外，汗出不止耳，然则阳明证，不论中风伤寒，脉微脉实，汗出少而邪将自解，汗出多则阴津易致竭绝，业医者可不谨持其柄，而用重剂发汗以劫人之津液耶，观仲景于太阳发汗之重剂，以青龙名之，可见亢旱得之，则为甘霖，若淫雨用之，则沉灶产蛙，伤禾害稼，有载胥及溺已耳，此阳明所以有桂枝麻黄汤证，而无大青龙汤证也，噫，微矣哉。（五）问曰，阳明病，外证云何，答曰，身热汗自出，不恶寒，反恶热也。〔原文〕以此辨阳明中风之外证，正兼太阳也。（六）问曰，何缘得阳明病，答曰，太阳病，苦发汗，若下，若利小便，此亡津液，胃中干燥，因转属阳明，不更衣，内实大便难者，此名阳明也。〔原文〕以此辨阳明中风之里证。此属正阳阳明可卜当置中篇以全文不便分割读者识之可也。（七）问曰，病有一日得之，不发热而恶寒者，何也，答曰，虽得之一日，恶寒将自罢，即自汗出而恶热也。〔原文〕以此辨阳明伤寒之外证，正兼太阳也。（八）问曰，恶寒何故自罢，答曰，阳明居中土也，万物所归，无所复传，始虽恶寒，二日自止，此为阳明病也。〔原文〕以此辨阳明伤寒之里证，此属正阳阳明可下已上八条，见仲景于太阳传入阳明之证，其辨认之法，即少变太阳之定例矣，盖太阳有营卫之两路，风则伤卫，寒则伤营，而阳明则营卫难以辨别，辨之全藉于脉与证，风邪之脉，传至阳明，则缓去而迟在，寒邪之脉，传至阳明，则紧去而浮在，风邪之脉，轻高而上前者，风邪本微，殊无内向之意，虽汗出少而不为过也，寒邪之脉，已至于实，则将去太阳，而成可下之证，故发其汗太多，反为过也，如此辨别，读者犹不心花开朗耶，至其辨证，则以能食不能食为谛，盖阳邪能化穀，阴邪不能化谷之义也，又设四问以辨风寒之在表在里，而定汗下之权衡，何其明且尽耶，繇是推之，病已传经，而太阳邪有未尽，其用桂枝麻黄二汤，即当狭小其制，不可使太过明矣，太阳邪已尽，其用承气诸汤，即当竭蹶从事，不可使不及又明矣。问经言一脉，分为二病，谓营卫不同也，是则十二经脉中，以营卫之故，分为二十四病矣，乃仲景于阳明一经，独以能食不能食分营卫，至于少阳以后，更不申营卫之辨，其义何居，答曰，明哉问也，道之原也，叔和以后诸贤，俱有未彻，果识各经皆有营卫，曷为将仲景少阳经之文，编入太阳经中乎，后人更添蛇足，谓邪至阳明，则已过营卫，无复可言，果尔，则邪至少阳与三阴，其过营卫不更远乎，灵枢谓营卫起于中焦，卫气起于下焦，而行至中焦，是则中焦胃中，正是营卫所起之源，混于未分，而外入之风寒，自难辨别也，至于少阳以下诸经，内经明有一脉分为二病之旨，仲景可以不赘，况始先中卫，其传经必不转中于营，始先中营，其传经必不转中于卫，然则能食为中风，不能食为中寒，自可繇阳明而类推三阴各经矣，此等处须细心体会，略一卤莽，谬迷多矣。（九）本太阳病初得时发其汗，汗先出不彻，因转居阳明也。〔原文〕发其汗，兼解肌发汗二义，汗出不彻，则未得如法，故邪不服而转入阳明也。若汗多微发热恶寒者，外不解也，其热不潮，未可与承气汤，若腹大满不通者，可与小承气汤，微和胃气，勿令大泄下。〔节文〕全文见阳明中篇表未解而腹大满，则里亦急，故用小承气汤。（十）

太阳病，若吐若下，若发汗，微烦，小便数，大便因鞕者，与小承气汤和之愈。〔原文〕微烦，小便数，大便因鞕者，皆是邪入里之机，故用小承气汤和之，是变不可下之例，然曰和则与用下之意不同矣。（一一）伤寒吐后，腹胀满者，与调胃承气汤。〔原文〕吐后而腹胀满，则邪不在胸，其为里实可知，然但胀满而不痛，自不宜用急下之法，少与调胃承气可耳，此亦和法，非下法也，观正阳阳明篇中，腹满不减，灭不足言，如是之急者，止言当下，自可类推。（一二）阳明病，心下鞕满者，不可攻之，攻之利，遂不止者死，利止者愈。〔原文〕心下鞕满，邪聚阳明之膈，正兼太阳也，故不可攻，攻之利不止，则邪气未尽，真气先脱，故主死也，利止则邪去而与气犹存，故自愈也。（一三）伤寒呕多，即有阳明证，不可攻之。

〔原文〕呕属太阳，呕多则太阳未除，纵有阳明诸症，在所不计，故戒攻下。（一四）食穀欲呕者，属阳明也，吴茱萸汤主之，得汤反剧者，属上焦也。〔原文〕此条复辨呕有太阳，亦有阳明，本自不同，若食谷欲呕，则属胃寒，与太阳之恶寒呕逆，原为热证者相远，正恐误以寒药治寒呕也，然服吴茱萸汤转剧者，仍属太阳热邪，而非胃寒明矣。（一五）阳明中风，口苦咽干，腹满微喘，发热恶寒，脉浮而紧，若下之则腹满，小便难也。〔原文〕此条阳明中风俱该伤寒而言，俱太阳未除之候，但以腹满一端，知为热入阳明，然终与大实大满不同，若误下则外邪乘虚内陷，而腹愈满矣，小便难者，亡津液也。（一六）阳明病，脉浮而紧，咽燥口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒，反恶热，身重，若发汗则躁，心愠愠，反讞语，若加烧针，必怵惕烦躁不得眠，若下之，则胃中空虚，客气动膈，心中懊懊，舌上胎者，栀子豉汤主之，苦渴欲饮水，口干舌燥者，白虎加人参汤主之，若脉浮发热，渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之。〔原文〕发热以上与前条同，而汗出不恶寒，反恶热，身重，四端则皆阳明之见证，所以汗下烧针，俱不可用，而舌上胎，则膈热甚，故涌以栀子豉，而彻去其膈热，则治太阳而无碍阳明矣，若前证更加口干舌燥，则宜用白虎汤以解热生津，更加小便不利，则用猪苓汤，导热滋干。（一七）阳明病，汗出多而渴者，不可与猪苓汤，以汗多胃中躁，猪苓汤复利其小便故也。〔原文〕太阳证中，有用五苓散，两解表里一法矣，而太阳入阳明证中，复有猪苓汤导热滋干一法，然汗出多而渴者不可服，盖阳明胃经主津液者也，津液充则不渴，津液少则渴矣，故热邪传入阳明，必先耗其津液，加以汗多而夺之于外，复利其小便而夺之于下，则津液有立亡而已，故示戒也。（一八）太阳病，寸缓关浮尺弱，其人发热汗出，复恶寒，不呕，但心下痞者，此以医下之也，若其不下者，病人不恶寒而渴者，此转属阳明也，小便数者，大便必鞕，不更衣十日无所苦也，渴欲饮水者，少少与之，但以法救之，欲渴者宜五苓散。〔原文〕寸缓关浮尺弱，发热汗出复恶寒，纯是太阳未罢之证也，设非误下，何得心下痞结耶，如不误下，则心下亦不痞，而太阳证必渐传经，乃至不恶寒而渴，邪入阳明审矣，然阳明津液既偏渗于小便，则大肠失其润，而大便之鞕与肠中热结，自是不同，所以旬日不更衣，亦无苦也，以法救之，救其津液也，与水及用五苓即其法也。五苓利水者也，其能止渴而救津液者，何也，盖胃中之邪热，既随小水而渗下，则利其小水，而邪热自消矣，邪热消则津回而渴止，大便且自行矣，正内经通因通用之法也，前段汗出多而渴者，不宜用猪苓汤，重驱津液，此段仍有汗仍渴，但汗出不至于多，而渴亦

因热炽，其津液方在欲耗未耗之界，故与水而用五苓为合法也，今世之用五苓者，但知水穀偏注于大肠，用之利水而止泄，至于津液偏渗于小便，用之消热而回津者，则罕，故详及之。（一九）阳明病，脉浮而紧者，必潮热发作有时，但浮者必盗汗出。〔原文〕阳明脉之浮紧，即太阳寒伤营之脉也，单浮即太阳风伤卫之脉也，但传至阳明，仲景不欲以营卫辨证，而姑变其文耳，至于太阳证有未罢，各条虽悉，尚恐未明，再举潮热及盗汗，阳明之必至者辨之，确然无疑矣，从前批注，皆是断章取义，而不会其大意，不知脉紧与潮热，脉浮与盗汗，非的对之证也，不过藉以辨阳明八九太阳一二之候耳，至谓浮为阳盛，阳盛则阴虚，阴虚则盗汗出，节外生枝，几于说梦矣。（二十）阳明中风，脉弦浮大而短，气腹都满，胁下及心痛，久按之气不通，鼻干不得汗，嗜卧，一身及面目悉黄，小便难，有潮热，时时哕，耳前后踵，刺之小差，外不解，病过十日，脉续浮者，与小柴胡汤，脉但浮无余证者，与麻黄汤，若不尿腹满加哕者不治。〔原文〕此条阳明中风之证居七八，而中寒之证亦居二三，观本文不得汗，及用麻黄汤，其义自见也，然此一证为阳明第一重证，何以知之，太阳证既未罢，而少阳证亦兼见，是阳明所主之位，前后皆邪，而本经之弥漫流连，更不待言矣，盖阳明脉本大，兼以少阳之弦，太阳之浮，则阳明之大，正未易衰也，腹满鼻干嗜卧，一身面目悉黄，潮热，阳明之证既尽见，兼以少阳之胁痛，太阳之膀胱不利，乃至时时哕，耳前后肿，则阳明之诸证，正未易除也，所以病过十日，外证不解，必审其脉证，或可引阳明之邪，从少阳出，则用小柴胡汤，或可引阳明之邪，从太阳出，则用麻黄汤，方合法，若不尿，腹满加哕，则真气垂尽，更无力可送其邪，故知药不能治也。（三）阳明病，脉迟，食难用饱，饱则微烦，头眩，必小便难，此欲作穀疸，虽下之腹满如故，所以然者，脉迟故也。〔原文〕脉迟则表证将除，似乎可下，然得食而微烦，仍是外邪助其内热也，热蒸食而上攻，故头眩，小便必难者，湿热上攻，水道必不顺也，欲作谷疸者，水谷之湿，得热蒸而四沲，遍身发黄，势所必至，下之腹满如故，病既未除，其脉之迟者愈益难复，故以为戒，注谓下之则外邪内陷，殊不切要，盖腹满已是邪陷，宁俟下之始陷耶，所以然者，脉迟则胃不实，徒下其糟粕，不惟无益，而反害之耳，然则脉复其常，然后膀胱之气化行，湿热自除，穀疸自退，又不言可知矣。（二二）阳明病，若中寒不能食，小便不利，手足濇然汗出，此欲作固瘕，必大便初鞭后溏，所以然者，以胃中冷水穀不别故也。〔原文〕注谓固为坚固，瘕为积聚，大谬，盖大便初鞭后溏，因成瘕泄，瘤泄溏泄，久而不止，则曰固瘕也。（二三）阳明病，初欲食，小便反不利，大便自调，其人骨节疼，翕然如有热状，奄然发狂，濇然汗出而解者，此水不胜谷气，与汗共并，脉紧则愈。〔原文〕此段文义本明，注谓得汗，则外邪尽解，脉紧且愈，全非本文来意，观上二条，一以小便而成谷疸，是湿热絛胃上攻胸脑，则头眩而身发黄，一以小便不利而成固瘕，是湿热絛胃下渗大肠，则手足汗出而成溏泄，此条小便反不利，本当成谷疸及瘕泄之证，况其人骨节疼，湿胜也，翕然如有热状，热胜也，湿热交胜，乃忽然发狂，濇然汗出而解者，何以得此哉，此是胃气有权，能驱阳明之水与热，故水热不能胜，与汗共并而出也，脉紧则愈，言不迟也，脉紧疾则胃气强盛，所以肌肉开而濇然大汗，若脉迟则胃中虚冷，偏渗之水，不能透而为汗，即手足多汗，而周身之湿与热，又未能共

并而出，此胃强能食，脉健之人，所以得病易愈耶。（二四）阳明病，不能食，攻其热必哕，所以然者，胃中虚冷故也，以其人本虚，故攻其热必哕。〔原文〕攻热，谓寒下之药也。（二五）脉浮而迟，表热里寒，下利清穀者，四逆汤主之，若胃气虚冷，不能食者，饮水则哕。〔原文〕表热里寒，法当先救其里，太阳经中，下利不止，身疼痛者，已用四逆汤不为过，其在阳明之表热，不当牵制，更可知矣，此病比前一条虚寒更甚，故不但攻其热必哕，即饮以水而亦哕矣。前云能食者为中风，不能食者为中寒矣，此上五条，一云食难用饱，一云欲食，似乎指中风为言，一云中寒不能食，及后二条之不能食，又明指中寒为言，所以后人拘执其说，而误为注释也，不知此五条，重举风寒证中之能食不能食，辨胃气之强弱，非辨外邪也，故五证中，惟水不胜穀气，脉紧则愈一证，为胃气胜，其四条俱是脉迟胃冷，反为水热所胜之证，夫伤寒之证，皆热证也，而其人胃中虚冷者，又未可一例而推，盖胃既虚冷，则水谷混然无别，热邪传入，必不能遽变为实也，胃不实则不可下，而热邪既入，转蒸水穀之气，蕴崇为病，即下之而水热不去，徒令胃气垂绝而作哕耳，仲景一一挈出，而于后条下利清穀一证，主之以四逆汤，则前条之较轻者，宜主之以温胃，更不待言，惟合五条而总会其立言之意，始不至于传讹耳。门人问泯然汗出而病解，乃手足泯然汗出者，反作固瘕，何手足不宜于汗耶，答曰，前代之业医者，皆极大聪明学问之人，故仲景书为中人以上，举一隅能以三隅反者设也，胃气虚寒之人，外邪入之，必转增其热，胃热故膀胱亦热，气化不行，小便因之不利，小便不利，而尽注于大肠则为洞泄，即末条之下利清谷者是也，小便不利，乘胃热而渗于脾，则四肢先见色黄，乃至遍身发黄，而成谷疸者是也，今手足泯然得汗，则脾中之湿热行，而色黄谷疸之患可免，但汗从手足而出，水热之气，未得遍泄于周身，不过少分大肠奔迫之势，故不为洞泄而为瘕泄耳，无病之人，小便行，尚渍为他病，况伤寒证极赤热之小便，停蓄不行，能无此三种之变耶，一溯其源，而轻重自分矣。（二六）阳明病，但头眩不恶寒，故能食而咳，其人必咽痛，若不效者咽不痛。〔原文〕此胃热挟风邪，而上攻之证也。（二七）阳明病，法多汗，反无汗，其身如虫行皮中状者，此以久虚故也。〔原文〕此胃热挟寒邪，而郁于肌肤之证也，言久虚者，明所以不能透出于肌表之故也，非谓当用补也。（二八）阳明病，反无汗，而小便利，二三日呕而效，手足厥者，必苦头痛，若不效不呕，手足不厥者，头不痛。〔原文〕阳明证，本不头痛，若无汗呕咳，手足厥者，得之寒因而邪热深也，然小便利，则邪热不在内而在外，不在下而在上，故知必苦头痛也，苦不效不呕不厥，而小便利者，邪热必顺水道而出，岂有逆袭巅顶之理哉。（二九）阳明病，下之，其外有热，手足温不结胸，心中懊憹，饥不能食，但头汗出者，栀子豉汤主之。〔原文〕下之而外有热，心中懊憹，饥不能食，几成结胸矣，然手足温，则阳气未至伤陷，不结胸，则外邪原属轻微，若其人头汗出者，亦是膈中郁热上蒸所致，宜因其高而扬之，用栀子豉汤以彻其热，则阳得下通于阴，而周身泯然汗解，并可知矣。止二条皆湿热上攻之证。（三十）阳明病，口躁，但欲漱水，不欲咽，此必衄。〔原文〕口中干燥与渴异，漱水不欲咽，知不渴也，阳明气血俱多，以漱水不欲咽，知邪入血分，阳明之脉起于鼻，故知得血热而妄行，必衄鼻而出也。（三一）脉浮发热，口干鼻燥，能食者则衄。〔原文〕脉浮发热，口干鼻

躁，阳明邪热炽矣，能食为风邪，风性上行，所以衄也。（三二）阳明病，发热汗出者，此为热越，不能发黄也，但头汗出，身无汗，剂颈而还，小便不利，渴饮水浆者，此为瘀热在里，身必发黄也，茵陈蒿汤主之。〔原文〕（三三）阳明病，面合赤色，不可攻之，必发热色黄，小便不利也。〔原文〕（三四）阳明病，无汗，小便不利，心中懊憹者，身必发黄。〔原文〕（三五）阳明病，被火额上微汗出，小便不利者，必发黄。〔原文〕合四条观之，阳明病，湿停热郁而烦渴有加，势必发黄，然汗出，热从外越，则黄可免，小便多热从下泄则黄可免，若误攻之，其热邪愈陷，津液愈伤，而汗与小便，愈不可得矣，误火之则热邪愈炽，津液上奔，额虽微汗，而周身之汗与小便愈不可得矣，发黄之变，安能免乎，发黄与前谷疸，本同一证，但彼因脉迟胃冷而得，则与固瘕及哕同源，而与此异派。（三六）阳明病，下血谵语者，此为热入血室，但头汗出者刺期门，随其实而泻之，濇然汗出则愈。〔原文〕妇人病伤寒，经水适来适断，则邪热乘之，而入于血室，谵语如见鬼状，当刺期门，乃男子阳明经病，下血而谵语者，亦为热入血室，亦刺期门。详后少阳篇末。（三七）阳明证，其人喜忘者，必有蓄血，所以然者，本有久瘀血，故令喜忘，屎虽鞭，大便反易，其色必黑，宜抵当汤主之。〔原文〕太阳经热结膀胱之证，轻者如狂，重者发狂，如狂者血自下，但用桃核桂枝，加入承气汤，因势利导，血去则愈，发狂者血不下，须用抵当汤，亟下其血乃愈，详太阳上篇，此条阳明喜忘之证，本差减于如狂，乃用药反循发狂之例者何耶，盖太阳少血，阳明多血，阳明之血一结，则较太阳更为难动，所以宜用抵当汤峻攻之法耳，但太阳云主之，则确乎不易，此云宜用，则证有轻重不等，在于临时酌量矣。（三八）病人无表里证，发热七八日，虽脉浮数者可下之，假令已下脉数不解，合热则消谷善饥，至六七日不大便者，有瘀血也，宜抵当汤，若脉数不解，而下利不止，必协热而便脓血也。〔原文〕虽云无表里证，然发热脉浮数，表证尚在也，其所以可下者，以七八日为时既久，而发热脉数，则胃中热炽，津液尽亡，势不得不用下法，如大柴胡汤之类是也，若下后脉数不解，可知果胃中热炽，其候当消谷善饥，然谷食既多，则大便必多，乃至六七日，竟不大便，其证非气结而为血结明矣，所以亦宜于抵当汤也，若脉数不解而下利不止，注谓用抵当汤下之，数仍不解，大谬，此乃对，假令已下，脉数不解五句之文，见已下脉数不解反六七日不大便，则宜抵当以下其血，若已下脉数不解，而下利不止，则不宜抵当之峻，但当消悉以清其血分热邪，若血分热邪不除，必协热而便脓血矣。合三条总是热入血室，故随下血与不下血，而异治也，然要知阳明尚兼太阳，则不但胃中热炽，而膀胱随经之热，亦未尽解，此所以宜于抵当汤乎。（三九）病人烦热，汗出则解，又如疟状，日晡所发热者，属阳明也，脉实者宜下之，脉浮虚者宜发汗，下之与大承气汤，发汗宜桂枝汤。〔原文〕病人得汗后烦热解，太阳经之邪，将尽未尽，其人复加疟状，日晡时发热，则邪入阳明审矣，盖日晡者申酉时，乃阳明之王时也，发热即潮热，乃阳明之本候也，然虽已入阳明，尚恐未离太阳，故必重辨其脉，脉实者，方为正阳阳明宜下之，若脉浮虚者，仍是阳明而兼太阳，更宜汗而不宜下矣，发汗宜桂枝汤，宜字最妙，见前既得汗而烦热解，此番只宜用桂枝，和营卫，以尽阳明兼带之邪，断不可误用麻黄汤矣。

阳明经中篇〔凡外邪已离太阳，未接少阳，谓之正阳阳明列于此篇〕

凡外感之邪，全入阳明所辖地界，已离太阳，未接少阳，此际当用下法，确无疑矣，然其邪复有在经在府之不同，在经者与太少为邻，仍是传经之邪，在府者则入于胃而不传经，但在经者之用下，常恐胃有未实，篇中无限消息迟徊，若在府则胃已大实，惟有急下以存津液而已。（一）阳明之为病，胃家实是也。〔原文〕以胃家实，揭正阳阳明之总，见邪到本经，遂入胃而成胃实之证也，不然阳明病，其胃不实者多矣，于义安取乎。（二）伤寒三日，阳明脉大。〔原文〕伤寒一日太阳，二日阳明，三日少阳，乃传经之次第，其实不以日拘也，此云三日阳明脉大，正见二日之阳明，传自太阳，必兼乎浮紧浮缓，未定是正阳阳明也，若正阳阳明，气血俱多，其脉必大，而与太阳别矣，言外见三日，证兼少阳，则其脉必大而弦，又不得为正阳阳明也，噫，微矣哉。（三）伤寒发热无汗，呕不能食，而反汗出濇濇然者，是转属阳明也。〔原文〕（四）伤寒转系阳明者，其人濇濇然微汗出也。〔原文〕濇濇者，肌肉开而微汗不干之貌，发汗无汗，呕不能食，皆伤寒之证也，伤寒无汗，何以反濇濇汗出耶，可见证已转属正阳阳明矣，既濇然汗出，则热除呕止可知矣。（五）太阳病，三日发汗不解，蒸蒸发热者属胃也，调胃承气汤主之。〔原文〕蒸蒸者，热势自内腾达于外，如蒸炊然，胃实之验也，其热蒸蒸，势必其汗濇濇矣，妙哉形容乎，惟热在胃，故用承气以调其胃，胃调则病涣然除矣。（六）阳明病，本自汗出，医更重发汗，病已差，尚微烦不了了者，此大便必鞭故也，以亡津液，胃中干燥，故令大便鞭，当问其小便日几行，若本小便日三四行，今日再行，故知大便不久出，今为小便数少，以津液当还入胃中，故知不久必大便也。〔原文〕（七）阳明病，自汗出，若发汗，小便自利者，此为津液内竭，虽鞭不可攻之，当须自欲大便，宜蜜煎导而通之，若土瓜根，及与猪胆汁，皆可为导。〔原文〕（八）阳明病，脉迟，虽汗出不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘，有潮热者，此外欲解，可攻里也，手足濇然而汗出者，此大便已鞭也，大承气汤主之，若汗多微发热恶寒者，外未解也，其热不潮，未可与承气汤，若腹大满不通者，可与小承气汤，微和胃气，勿令大泄下。〔原文，后半节入阳明上篇〕脉迟汗出，不恶寒，身重，短气，腹满喘，潮热，八者乃阳明之外邪欲解，可以攻里，而不为大误之候也，然曰欲解，曰可攻，不过用小承气，及调胃承气之法耳，必手足濇然汗出，方可验胃实便鞭，外邪尽解，而当从大承气急下之法也，申酉戌间独热，余时不热者，为潮热，若汗多微发热恶寒，是阳明证尚兼太阳，纵腹大满胃终不实，只可微和胃气，以从权而已。（九）病人不大便五六日，绕脐痛，烦躁，发作有时者，此有燥屎，故使不大便也。〔原文〕（十）大下后六七日不大便，烦不解，腹满痛者，此有燥屎也，所以然者，本有宿食故也，宜大承气汤。〔原文〕（一一）病人小便不利，大便乍难乍易，时有微热，喘冒不能卧者，有燥屎也，宜大承气汤。〔原文〕（一二）阳明病，潮热，大便微鞭者，可与大承气汤，不鞭者不可与之，若不大便六七日，恐有燥屎，欲知之法，少与小承气汤，汤入腹中转失气者，此有燥屎，乃可攻之，若不转失气，此但初头鞭，后必溏，不可攻之，攻之必胀满，不能食也，欲饮水者，与水则哕，其后发热者，必大便鞭而少也，以小承气汤和之，不转失

气者，慎不可攻也。〔原文〕转失气者屁出也，腹中之气，得攻药不为转动，则属虚寒，所以误攻而证变胀满，不能食及嘔也，攻后重复发热，又是胃热，至此方炽，大便因可得鞭，但为时未久，必少耳，仍以小承气汤和之，若腹中气仍不转，则不但用大承气大差，即用小承气亦小差矣。（一三）阳明病，下之心中懊憹而烦，胃中有躁屎者可攻，腹微满，初头鞭后必溏，不可攻之，若有躁屎者，宜大承气汤。〔原文〕以小承气汤试其可下，而用大承气汤下之矣，设下后心中懊憹，而烦，又属热重药轻，当再进大承气以协济前药，亟驱热邪，则闷烦自解也，一云胃中有躁屎者，一云若有躁屎者，俱指试其转失气，及绕脐痛，腹满痛，小便不利，烦躁时有微热，喘冒不能卧，七证言也。（一四）得病二三日脉弱，无太阳柴胡证，烦躁心下鞭，至四五日，虽能食，以小承气汤，少少与微和之，令小安，至六日与承气汤一升，若不大便六七日，小便少者虽不能食，但初头鞭，后必溏，未定成鞭，攻之必溏，须小便利，屎定鞭，乃可攻之，宜大承气汤。〔原文〕无太阳少阳之证，则烦躁心下鞭，属正阳阳明之可下无疑矣，乃其人脉弱，虽是能食，亦止可少用小承气，微和胃气，和之而当，必觉小安，俟隔日再以小承气稍稍多进，总因脉弱故尔迟徊也，至六七日竟不大便，似乎胃实，乃小便复少，正恐胃弱，而膀胱气化之源窒，转渗大肠，初鞭后溏耳，所以小便利，屎定鞭，乃可攻之。此段之虽能食，虽不能食，全与辨风寒无涉，另有二义，见虽能食者，不可以为胃强而轻下也，虽不能食者，不可以为胃中有躁屎而轻下也，后九条云，譫语有潮热，反不能食者胃中必有躁屎五六枚，与其互发，前后注释俱差。（一五）阳明病，不吐不下，心烦者可与调胃承气汤。〔原文〕胃气及津液，既不繇吐下而伤，则心烦明系胃中热炽，故可与调胃承气，以安胃气而全津液也。合九条，总是以外证之解与不解，气之转与不转，脐腹之痛与不痛，脉之弱与不弱，汗出之多与不多，小便之利与不利，邪热之炽与不炽，津液之干与不干，而辨腹中之躁屎多与不多，溏与不溏，以消悉微下之法，故惟手足濇然汗出，大便已鞭者，主之以大承气汤，其他诸证，一则曰宜用导法，再则曰不可攻之，再则曰宜小承气汤，再则曰少与小承气汤，再则曰明日更与一升，再则曰宜大承气汤，全是商量治法，听人临时斟酌，以祈无误，所以不用主之二字，此等处关系安危最大，盖热邪入胃，不以寒药治之，则胃伤，然寒药本以救胃也，不及则药不胜邪，太过则药反伤正，况乎不胜其邪，势必尽伤其正，又未必尽去其邪，此仲景所为淳复于二者之间耶。（一六）阳明病，譫语发潮热，脉滑而疾者，大承气汤主之，因与承气汤一升，腹中转失气者，更服一升，若不转失气，勿更与之，明日不大便，脉反微涩者，里虚也，为难治，不可更与承气汤也。〔原文〕譫语而发潮热，阳明之下证审矣，更兼其脉疾滑，复与脉弱者不伦，故主之以小承气汤，一定之法也，然尚未知其里证若何，必转失气，方可再服，若服后不转失气，并不大便，脉反微而且涩，又是里气虚寒之证，盖阳明居于中土，其表虚表实，来自太阳，至此已明，其里虚里实，茫然未卜，故用法不可令虚者益虚，有如此之郑重也。（一七）夫实则譫语，虚则郑声，郑声重语也。〔原文〕郑声者郑重之声，正气不足，声出重浊也，亦辨里实里虚之一端也。（一八）直视譫语，喘满者死，下利者亦死。〔原文〕此条当会意读，谓譫语之人，直视者死，喘满者死，下利者死，其义始明，盖譫语者心火亢极也，加以直视，则肾水垂绝，

火心愈无制，故主死也，喘满者邪聚阳位而上争，正不胜邪，气从上脱，故主死也，下利者邪聚阴位而下夺，正不胜邪，气从下脱，故主死也。（一九）发汗多，着重发汗者，亡其阳，讞语脉短者死，脉自和者不死。〔原文〕注拟此为太阳经脱简，不知太阳无讞语之例必日久而兼阳明少阳，方有讞语，故此言太阳经得病时，发汗过多，及传阳明时，重发其汗，亡阳而讞语之一证也，亡阳之人，所存者阴气耳，故神魂无主，而妄见妄闻，与热邪乘心之候不同，况汗多则大邪必从汗解，止虑阳神飞越难返，故脉短则阴阳不附，脉和则阴阳未离，其生死但从脉定耳，其脉既短，安问药之长哉。。门人问亡阳而讞语，四逆汤可用乎，答曰，仲景不言方，而子欲言之，曷不详之仲景耶，盖亡阳固必回其阳，然邪传阳明，胃热之炽否，津液之竭否，里证之实否，俱不可知，设不辨悉，回其阳，先竭其阴，竟何益哉，此仲景不言药，乃其所以圣也，然得子此问，而仲景之妙议愈彰矣。（二十）阳明病，其人多汗，以津液外出，胃中躁，大便必鞭，鞭则讞语，小承气汤主之，若一服讞语止，更莫复服。〔原文〕此条举讞语之因汗多津越者为言。（二一）伤寒四五日，脉沉而喘满，沉为在里，而反发其汗，津液越出，大便为难，表虚里实，久则讞语。〔原文〕此举讞语因误汗而致者，其曰里实，亦即上文胃中躁，大便必鞭之互辞，其不出方者，亦即上文小承气汤之互意也。（二二）伤寒若吐若下后不解，不大便五六日，上至十余日，日晡所发潮热，不恶寒，独语印见鬼状，若剧者发则不识人，循衣摸床，惕而不安，微喘直视，脉弦者生，涩者死，微者但发热讞语者，大承气汤主之，若一服利，止后服。〔原文〕此条举讞语之势重者为言，而势重之中复分二等，剧者生死，仍凭乎脉，微者则主以大承气汤，比上条之小承气更进矣，前于13语脉短者死，此云脉弦者生，前云讞语脉滑疾者，用小承气，此云脉涩者死，更互一字而大意跃然。（二三）汗出讞语者，以有躁屎在胃中，此为风也，须下之，过经乃可下之，下之若早，语言必乱，以表虚里实故也，下之则愈，宜大承气汤。〔原文〕此条之文，似浅而实深，仲景惧人不解，已自为脚注，不识后人何故茫然，胃有躁屎，本当用下，以讞语而兼汗出，知其风邪在胸，必俟过经下之，始不增扰，所以然者，风性善行数变，下之若早，徒引之走空窍，乱神明耳，然胃有躁屎，下之不为大误，其小误止在未辨证兼乎风，若此者必再一大下，庶大肠空而风邪得以并出，故自愈，此通因通用之法，亦将差就错之法也。（二四）阳明病，讞语有潮热，反不能食者，胃中必有躁屎五六枚也，若能食者但鞭耳，宜大承气汤。〔原文〕有躁屎，则肠胃热结，故不能食，若能食，则肠胃未结，故但鞭耳，前条云，其后发热者，必大便鞭而少也，此云但鞭耳，不更言其少，乃于胃中有躁屎者，言其五六枚之多，亦互举以辨微细之意，不可忽也，俱宜大承气汤者，已结者开其结，未结者涤其热，不令更结，同一讞语潮热，故同一治，至于药制之大小，必有分矣。合力条观之，既云实则讞语矣，乃其用治，迟徊审谛，始以和法为攻法，俟服药后，重辨脉证，不敢径情急攻，，即攻之，又一服利止后服，何其郑重耶，可见所谓实者，乃邪气实也，邪气实，正气未有不虚，况津液为邪所耗，而至于讞语，方寸几于无主，其虚为何如哉，邪实不可不下，正虚不可大下，斟酌于邪正之间，以权宜而善其治，良工苦心，要当三复于圣言矣。（二五）阳明病，发热汗多者，急下之，宜大承气汤。〔原文〕胃中止一津液，汗多则津液外渗，加以发

热，则津液尽随热势，蒸蒸腾达于外，更无他法可止其汗，惟有急下一法，引热势从大肠而出，庶津液不致尽越于外耳，前条云，发汗不解，蒸蒸发热者，属胃也，调胃承气汤主之，可见调胃之义，乃和缓其胃中之热，以存津液也，此证发热而至于汗多，明是始先未行调胃所致，故宜急下，无取缓调。（二六）发汗不解，腹满痛者，急下之，宜大承气汤。〔原文〕腹满不减，减不足言，当下之，宜大承气汤。〔原文〕发汗不解，而反腹中满痛，则邪不在表而在里，亦惟有急下一法，庶满痛去而病自解也，减不足言四字，形容腹满如绘，见满至十分，即减去一二分，不足杀其势也，此所以纵有外邪未解，而当下无疑耳。（二七）伤寒六七日，目中不了了，睛不和，无表里证，大便难，身微热者，此为实也，急下之，宜大承气汤。〔原文〕此一条，辨证最微细，大便难，则非久秘，里证不急也，身微热，则非大热，表证不急也，故曰无表里证，只可因是而验其热邪在中耳，热邪在中，亦不为急，但其人目中不了了，睛不和则急矣，以阳明之脉络于目，络中之邪且盛，则在经之盛更可知，故惟有急下之而已。按少阴经，有急下三法，以救肾水，一本经水竭，一木邪涌水，一土邪凌水，而阳明经，亦有急下三法，以救津液，一汗多津越于外，一腹满津结于内，一睛目不慧，津枯于中，合两经下法以观病情生理，恍觉身在冰壶，腹饮上池矣。（二八）阳明病欲解时，从申至戌上。〔原文〕（二九）脉浮而芤，浮为阳，芤为阴，浮芤相搏，胃气生热，其阳则绝。〔原文〕其阳则绝，即无阳之互辞，谓津液内亡也，当下不下，故至此耳。（三十）跌阳脉浮而濡，浮则胃气强，濡则小便数，浮濡相搏，大便则难，其脾为约，麻仁丸主之。〔原文〕脾约之证，在太阳阳明，已当用麻仁丸润下，失此不用，延至正阳阳明，胃中津液，瓮干杯罄，下无及矣，然则浮濡之脉，转为浮芤，不可类推乎，详见本卷末答门人脾约问。

阳明经下篇

凡外邪已趋，少阳未离阳明，谓之少阳，阳明列于此篇。凡属正阳阳明之证，病已入于胃腑，故下之则愈，其有胃不实，而下证不具者，病仍在经，在经之邪不解，必随经而传少阳，口苦咽干，目眩耳聋，胸胁满痛之证，必兼见一二，故谓之少阳阳明，其实乃是阳明少阳也。少阳主半表半里，阳明证中，纔兼少阳，即表里皆不可攻，故例中止用和法。少阳阳明合病，另有颡条，附三阳经后。（一）阳明病，发潮热，大便溏，小便自可，胸胁满不去者，小柴胡汤主之。〔原文〕潮热本阳明胃实之候，苦大便溏，小便自可，则胃全不实，更加胸胁满不去，则证已传入少阳矣，纔兼少阳，即有汗下二禁，惟小柴胡汤一方，合表里中而总和之，乃少阳一经之正法，故阳明少阳，亦取用之无别法也。（二）阳明病，胁下硬满，不大便而呕，舌上白胎者，可与小柴胡汤，上焦得通，津液得下，胃气因和，身濈然而汗出解也。〔原文〕不但大便溏，为胃未实，即使不大便，而见胁下硬满，呕与舌胎之证，则少阳为多，亦当从小柴胡汤，分解阴阳，则上下通和，濈然汗出，而胎呕胁满之外证，一时俱解矣，既云津液得下，则大便自行亦可知矣，此一和而表里俱彻，所以为贵也。上焦得通，津液得下，八字，关系病机最切，风寒之邪，协津液而上

聚于膈中，为喘为呕为水逆，为结胸，常十居六七，是风寒不解，则津液必不得下，倘误行发散，不惟津液不下，且转增上逆之势，愈无退息之期矣，此所以和之于中而上焦反通也，至于杂病项中，加痰火哮喘咳嗽癰痈等证，又皆火势熏蒸，日久顽痰，胶结经隧，所以火不内熄，则津液必不能下灌灵根，而精华尽化为败浊耳，夫人之得以长享者，惟赖后天水谷之气，生其津液，津液结则病，津液竭则死矣，故治病而不知救人之津液者，真庸工也。论太阳阳明少阳阳明原有可下之证。（三）问曰，病有太阳阳明，有正阳阳明，有少阳阳明，何谓也，答曰，太阳阳明者，脾约是也，正阳阳明者，胃家实是也，少阳阳明者，发汗利小便已，胃中燥烦实，大便难是也。〔原文〕

注谓脾约，乃太阳之邪，径趋入胃而成胃实，贻误千古，详后答门人问脾约论。

附少阳转阳明二证此与阳明兼带少阳之证殊，故另揭出。

○少阳阳明者，发汗利小便已，胃中燥烦实，大便难是也。阳明原文病已传到少阳经，而去阳明经远矣，乃从少阳经治法，发汗利小便已，其人方饑胃中燥烦实，大便难者，是少阳重转阳明，而成可下之一证也。○服柴胡汤已，渴者，属阳明也，以法治之。〔少阳原文〕此条亦互工作之意，解见少阳

附太阴转阳明一证 ○伤寒脉浮而缓，手足自温者，是为系在太阴，太阴者身当发黄，若小便自利者，不能发黄，至七八日大便鞭者，为阳明病也。〔太阴原文〕脉浮而缓，本为表证，然无发热恶寒外候，而手足自温者，是邪已去表而入里，其脉之浮缓，又是邪在太阴以脾脉主缓故也，邪入太阴，势必蒸湿为黄，若小便自利，则湿仁而发黄之患可免，但脾湿既行，胃益干燥，胃燥则大便必鞭，因复转为阳明内实而成可下之证也。

附少阴转阳明一证

○少阴病，六七日，腹胀不大便者，急下之，宜大承气汤。〔少阴原文〕少阴之证，自利者最多，虚寒则下利消穀，滑脱则下利脓血，故多用温法，此以六七日不大便，而腹胀，可见热邪转归阳明，而为胃实之证，所以宜于急下也。

附厥阴转阳明之证 ○下利谵语者，有躁屎也，宜小承气汤。〔厥阴原文〕下利则热不结，胃不实，何得谵语耶，此必邪返于胃，内有躁屎，故虽下利而结者自若也，半利半结，所以不宜大承气，而宜于小承气，微动其结耳。

附答客难大意客有熟仲景之书者，难昌曰，所分阳明三篇，将仲景阳明证中七十四条，收尽无遗，大开后人眼目，可谓智矣，祇是过矜其智，而掩昔贤之长，鄙见微有不满耳，昌曰，余何敢哉，客曰，王叔和当日编次阳明一经，首列问有太阳阳明，有正阳阳明，有少阳阳明者，何也，仲景答曰，太阳阳明者，脾约是也，正阳阳明者，胃家实是也，少阳阳明者，发汗利小便已，胃中燥，大便难，是在，圣言煌煌，子既遵其例，何反后其文耶，昌曰，三段揭首，叔和已误，曷可再误，昌分三

篇，不从兹起见也，三篇举以统括七十余条之义，若叔和所列，不过是绝无仅有之一证，以冠篇首，则阳明一经之大旨尽矣，此无难辨者，盖当日之问，乃问三阳经中可下之证，所以答云，太阳阳明之可下者，除是脾约，少阳阳明之可下者，除是发汗利小便已，胃中躁，大便难，舍此二证，则太阳少阳，必有一定之下法矣，今分三篇，以明太少二阳之不可下，乃以可下之条，混引其端，昌之所不敢出也，，又况少阳阳明，所谓发汗利小便已，胃中躁，大便难者，乃是病邪已去阳明，全入少阳，及发汗利小便后，少阳证亦尽罢，其邪不入三阴，重复转到阳明，所以名为少阳阳明，与始先病在阳明，略兼少阳一二者，有何干涉哉，客始为之心折。

附答门人奇问门人问治伤寒之法，轨则虽多，必有精一之理，可以贯彻终始者，请吾师试举一言以蔽之，可乎，余曰，伤寒之变，千蹊万径，如之何其可以一言括耶，门人曰，如痘疹秘诀，谓起先开盘时，要有根脚，有根脚则浆成，及至灌脓时，要无根脚，，无根脚则毒化，此亦片言居要者，吾师曷不仿而言之，余笑曰，若是则姑拟一言以答子之奇问，亦无难者，凡治伤寒之诀，起先惟恐传经，传经则变生，其后惟恐不传经，不传经则势笃，此二语不识可括其义否，门人踌躇曰，起先惟恐传经，慙矣，其后惟恐不传经之说，大奇且大创，未之前闻也，余曰，仲景言之再四，但子辈双眸未炯，见同未见耳，何奇创之有耶，仲景云，阳明居中，土也，万物所归，无所复传，盖阳明之脉，行身之前，邪入其经，则有前经后经相传之次第，而阳明之府，乃中州之胃，为水谷之海，脏腑经脉之总司，邪入其中，则无复传次之可言，所以惟有以下一法，夺其土，而邪自不留耳，此仲景于阳明经内特挈不传之妙理也，又云阳明中风，脉弦浮大而短气，腹都满，胁下及心痛，久按之气不通，鼻干不得汗，嗜卧，一身及面目悉黄，小便难，有潮热，时时哕，耳前后肿，刺之小差，外不解，病经十日，脉续浮者，与小柴胡汤，脉但浮无余证者，与麻黄汤，若不尿，腹满加哕者不治，此一段至理，千古无人看出，总不识其所言者何事，讵知脉弦浮大而气反短，连腹都满者，邪不传也，胁下及心痛，乃至久按之气不通者，邪不传也，鼻干不得汗，嗜卧，表里俱困，乃至一身及面目，悉蒸为黄者，邪不传也，小便难，有潮热，时时哕者，胃热炽盛，上下道穷，邪不传也，耳前后肿，刺之小差者，内邪不传，乃至外挾，其血亦不散，但其肿小差也，外不解过经十日，留连极矣，所谓万物所归，无所复传者，原为美事，孰知病邪归之而不传，反成加此之危候耶，要之阳明之邪，来自太阳，去自少阳，所以脉续浮者，与小柴胡汤，推其邪使速往少阳去路也，脉但浮无余证者，与麻黄汤，推其邪使速还太阳来路也，若不尿腹满，则胃邪内壅，不下行矣，而更加哕，则胃气将竭，愈上逆矣，再有何法可以驱其邪而使之传哉，又云太阳病，十日已去，脉浮细而嗜卧者，外已解也，设胸满胁痛者，与小柴胡汤，脉但浮者与麻黄汤，见脉浮细而嗜卧，邪已尽传于外而解散者，方可无虑，设胸满胁痛，则当与小柴胡汤，推立速往少阳而出，设脉但浮无余证，则当与麻黄汤，推之速往太阳而出，是皆惟恐其邪之不传，暗伏危机也，必识此意，然后始识仲景用药之故，不然，岂有十余日后而无故张皇，反用麻黄汤之理哉，凡此皆因太少二阳，与阳明连贯，故用表法，所谓从外入者驱而出之于外也，复有表里阴阳之间，正已虚而邪不尽，无可速传之候，仲景用法

，悉从外邪不能传出起见，如太阳病未解，脉阴阳俱停，必先振栗汗出而解，设不振慄，则邪不能传之于表，而无从得汗可知也，然既云阴阳两停，其传表传里，未可预定，所以惟阳脉微者，方是邪不能传表，当从汗之而解，惟阴脉微者，方是邪不能传里，当从下之而解，此其故甚可思也，若非邪住不传之候，则阳脉微者，当补其阳，阴脉微者，当补其阴矣，岂有反汗之而伤其阳，下之而伤其阴之理哉，又如太阳病，过经十余日，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡汤服之，本当蒸蒸而振，却发热汗出而解矣，乃反加呕不止，心下急，郁郁微烦者，此邪因屡下而入里已深，非一柴胡汤可以尽提之，传出于表，必再与大柴胡汤，分提表里之邪，阳邪传阳，阴邪传阴，一举而分解之，始为合法，不然，岂有呕急郁烦，表证转增，反行兼解其里之理哉，又如伤寒五六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便鞭，脉细者，此为阳微结，乃是说阳分之邪，微微结聚，不能传出于表里，故本文即继之曰，必有表复有里也，其旨甚明也，末云可与小柴胡汤，设不了了者，得屎而解，即前证过经十余日，用大小柴胡，分提使传之法也，乃知舍此，更无可使其传矣，又如发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者必反复颠倒，心中懊憹，此邪退正虚，而余邪阻滞不能传散，以致无可奈何也，此时将汗之乎，下之乎，和之乎，温之乎，仲景巧用栀子鼓汤，涌载其余邪于上，俾一吐而尽传无余，设非此一法，从高而越，有殆而已矣，又如云，食谷则哕，不能食，攻其热则哕，欲饮水者，与水则哕，不能食者，与水则哕，何其言之不一耶，皆是为胃气虚寒，余邪不能传散者，致其叮咛也，更有穀疸一证，邪热在胃不能传出，反蒸食而发黄，固瘕一证，胃气虚寒，水停不行，反渗大肠而瘕泄，此三证者，仲景但言证而不言治，学者倘不透此一关，果何从而施治耶，是则邪之传与不传，所关如此甚巨，乃治伤寒家，初不量邪势之浅深，胃气之厚薄，而贸贸以从事也，实繇先圣法则，未经昔贤阐释，后学漫无入路耳，夫足太阳膀胱，足阳明胃，足少阳胆，皆府也，何必独归阳明，始不传耶，盖膀胱主出，胃主纳，胆不主出纳，所以惟阳明胃，为藏纳之地，具载物之体，传经之邪，必归阳明，始能消之，若夫胃土告困，不能消邪，则在府之邪，漫无出路，久之必渐积于本经，其脉必仍转为浮，所以仲景云脉续浮者，与柴胡汤，此中复有奥义，其义维何，即必有表复有里之说也，故用柴胡汤，提出少阳，俾循经次而传太阴少阴厥阴以尽其邪，乃始得以无患耳，若但浮无余证，则是有表无里，只用麻黄汤提出太阳，其邪立解，不劳余力矣，得仲景之神者，目击道存，即如天以四时成岁，中土各旺于季月之末，然后木庇其根，火收其焰，金销其肃，水藏其澜，便非传之中土，则木火金水不相连贯，何以化机盈眸不息乎，人之饮食入胃，清气升而浊气降，波滓不留者，其妙惟在于传，设一日不传，则积滞而不能化矣，至于仙家摘簇五行，东三南二木火相恋归于中土，西四北一金水相亲归于中土，其妙更在于不传，设传则流散而不能造矣，然则中土之传与不传，足尽天人之蕴，又何疑于医事哉，门人爽然曰，似此剔出伤寒神髓以立言，数之可千，推之可万，恍疑身陟天汉星津，炯炯光芒，流射肺腑矣，请名之曰伐髓迪光论。门人问脾约一证，胃强脾弱脾不为胃行其津液，如儒夫甘受悍妻之约束，宁不为家之索乎，余曰，何以见之，曰仲景云，趺阳脉浮而涩，浮则胃气强，涩则小便数，浮涩相搏，大便为难，其脾为约，麻仁丸主之，以是知胃强脾弱也，

余曰脾弱即当补矣，何为麻仁丸中，反用大黄枳实厚朴乎，子辈曰聆师说，而腹笥从前相仍之陋，甚非所望也，仲景说胃强，原未说脾弱，况其所谓胃强者，正是因脾之强而强，盖约者省约也，脾气过强，将三五日胃中所受之谷，省约为一二弹丸而出，全是脾土过躁，致令肠胃中之津液日渐干枯，所以大便为难也，设脾气弱，即当便泄矣，岂有反难之理乎，相传谓脾弱，不能约束胃中之水，何以反能约束胃中之谷耶，在阳明例中，凡宜攻下者，惟恐邪未入胃，大便弗鞭，又恐初鞭后溏，不可妄攻，若欲攻之，先与小承气，试其转失气，方可攻，皆是虑夫脾气之弱，故尔踌躇也，若夫脾约之证，在太阳已即当下矣，更何待阳明耶，子辈传会前人，以脾约为脾弱，将指吴起之杀妻者，为懦夫乎，有悖圣言矣。门人又问曰，今乃知脾约之解矣，触类而推，太阳阳明之脾约，与少阳阳明之胃中躁烦实，大便难者，同是一证，此其所以俱可攻下耶，余曰，是未可言触类也，困难之曰，邪热自太阳而阳明而少阳，为日既久，烁其津液，大便固当难矣，其在太阳方病之始，邪未入胃，何得津液即便消耗，而大肠躁结耶，且太阳表邪未尽，又何不俟传经，即亟亟润下，而自犯太阳之禁耶，门人不能对，因诲之曰，脾约一证，乃是未病外感之先，其人素惯脾约三五日一次大便者，及至感受风寒，即邪未入胃，而胃已先实，所以邪至阳明，不患胃之不实，但患无津液以奉其邪，立至枯槁耳，仲景大变太阳禁下之例，而另立麻仁丸一法以润下之，不比一时暂结者，可用汤药荡涤之耳，此义从前瞢瞢凡遇素成脾约之人，亦必俟经尽方下，百无一生矣，故因子问而畅发之。

附问难门人大意暇日门人聚谭仲景制方之妙，主伯亚旅，天然一定，因问曰，仲景于太阳经中，有兼带阳明经者，其风伤卫，则桂枝汤中加葛根，其寒伤营，则麻黄汤中加葛根，有兼带少阳经者，其风伤卫，则桂枝汤中加柴胡，其寒伤营，则麻黄汤中加柴胡，合并之病亦然，是则阳明经以葛根为主药，少阳经以柴胡为主药矣，乃少阳经颛用小柴胡汤，而阳明一经，全不用葛根汤者何耶，门人不能对，因诲之曰，此有二义，太阳而略兼阳明，则以方来之阳明为重，故加葛根，阳明而尚兼太阳，则以未罢之太阳为重，故不用葛根，且阳明主肌肉者也，而用葛根大开其肌肉，则津液尽从外泄，恐胃愈躁而阴立亡，故不用者，所以存津液耳，本经前条有云，阳脉实，因发其汗出多者，亦为太过，太过为阳绝于里，亡津液，大便因鞭也，是阳脉实者，且不可过汗，其阳脉微者，又当何如耶，仲景所以阳明诸证，全不用葛根之意，益彰彰矣，小儿布痘，见点之时，第一戒用葛根，用之则肌窍尽开，一齐拥出，昔贤云，见点之后，忌用升麻汤，以升麻汤中有葛根耳，后人误谓见点后，忌用升麻，至于葛根反恣用无忌，只遗一汤字，而葛根等兔脱，升麻等雉罹，儿命遭枉，等恒河沙数矣，因与治伤寒，滥用葛根劫人津液者，并举示戒焉。

卷三

尚论篇少阳经证治大意

仲景少阳经之原文，叔和大半编入太阳经中，昌殊不得其解，岂以太阳行身之背，少阳行身之侧，其营卫显然易辨，非如阳明与三阴之属脏腑者，营卫难窥，故将少阳之文，汇入太阳耶，此等处窃不敢仍叔和之旧，盖六经各有专司者，乃引少阳之文，与三阳合病并病经过不解，及坏病诸条，悉入太阳篇中，适足以乱太阳之正也，在太阳一经之病，已倍他经，辨之倍难，而无端蔓引混收，此后人所为多歧亡羊乎，兹将治少阳之法，悉归本篇，其合病、并病，坏病，痰病，另隶于三阳经后，庶太阳之脉清，而少阳之脉亦清耳。

少阳证用小柴胡汤和解加减一法（一）伤寒五六日，中风往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬或心下悸，小便不利，或不渴，身有微热，或欬者，小柴胡汤主之，伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具，若胸中烦而不呕，去半夏人参加枳实芍药，苦渴者，去半夏，加人参栝蒌根，若腹中痛，去黄芩加芍药，若胁下痞硬，去大枣加牡蛎，若心下悸小便不利者，去黄芩加茯苓，若不渴外有微热者，去人参加桂枝，温覆取微似汗愈，若欬者，去人参大枣生姜，加五味子干姜。〔原文〕 躯壳之表阳也，躯壳之里阴也，少阳主半表半里之间，其邪入而并于阴则寒，出而并于阳则热，往来寒热，无常期也，风寒之外邪，挟身中有形之痰饮，结聚于少阳之本位，所以胸胁苦满也，胸胁既满，胃中之水穀亦不消，所以默默不欲食，即昏昏之意，非静默也，心烦者，邪在胸胁，逼处心间也，或呕不呕，或渴不渴，诸多见证，各随人之气体，不尽同也，然总以小柴胡之和法为主治，而各随见证以加减之耳。

少阳病有辨证一法（二）少阳之为病，口苦咽干目眩也。〔原文〕 口苦咽干者，热聚于胆也，目眩者，木盛生风而旋晕也。

少阳病有汗吐下三禁二法（三）伤寒脉弦细，头痛发热者属少阳，少阳不可发汗，发汗则譫语，此属胃，胃和则愈，胃不和则烦而悸。〔原文〕 少阳伤寒禁发汗，少阳中风禁吐下，二义互举，其旨益严，盖伤寒之头痛发热，宜于发汗者，尚不可汗，则伤风之不可汗，更不待言矣。脉弦细者，邪欲入里，其在胃之津液，必为热耗，重复发汗，而驱其津液外出，安得不譫语乎，胃和者，邪散而津回也，不和者，津枯而饮结，所以烦而悸也。（四）少阳中风，两耳无所闻，目赤，胸中满而烦者，不可吐下，吐下则悸而惊。〔原文〕 风热上壅则耳无闻，目赤，无形风热，与有质痰饮搏结，则胸满而烦，此但从和解中行分竭法可也，若误汗下，则胸中正气大伤，而邪得以逼乱神明，此时即为城下之盟，所丧不滋多乎。

辨少阳经病有欲解不解四法（五）伤寒三日，三阳为尽，三阴当受邪，其人反能食

不呕，此为三阴不受邪也。〔原文〕能食不呕，与胃和则愈之义互发。（六）伤寒三日，少阳脉小者，欲已也。〔原文〕

脉不弦大，邪微欲解之先征也。（七）少阳病，欲解时，从寅至辰上。〔原文〕受病之经，正气虚衰，每藉力于时令之王，此趋三避五，所繇来乎。（八）伤寒六七日，无大热，其人躁烦者，此为阳去入阴故也。〔原文〕阳去入阴，则邪势得以留连，转致危困者多矣，有治伤寒之责者，线索在手，于邪在阳经之日，亟从外夺不亦善乎。

少阳证具将欲入里而太阳阳明小有未罢但用小柴胡汤一法（九）伤寒四五日，身热，恶风，头项强，胁下满，手足温而渴者，小柴胡汤主之。〔原文〕身热恶风，太阳证也，头项强，太阳兼阳明证也，胁下满，少阳证也，本当从三阳合并病之例，而用表法，但其手足温而加渴，外邪辐凑于少阳，而向里之机已着，倘更用辛甘发散之法，是重增其热，而大耗其津也，故从小柴胡之和法，则阳邪自罢，而阴津不伤，一举而两得矣，此用小柴胡汤，当从加减法，不呕而渴者，去半夏加栝蒌根为是。

少阳证，脉弦濇加腹痛，先用建中，后用小柴胡一法。（十）伤寒阳脉濇，阴脉弦，法当腹中急痛者，先用小建中汤，不差者，与小柴胡汤主之。〔原文〕阳脉濇，阴脉弦，浑似在里之阴寒，所以法当腹中急痛，故以小建中之缓，而和其急，腹痛止，而脉不弦濇矣，若不差，则弦为少阳之本脉，而濇乃汗出不彻，腹痛乃邪欲传太阴也，则用小柴胡汤以和阴阳，为的当无疑矣。

少阳论具已经汗下而太阳未罢胸有微结者宜用柴胡桂枝干姜一法（一一）伤寒五六日，已发汗而复下之，胸胁满，微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热，心烦者，此为未解也，柴胡桂枝干姜汤主之。〔原文〕少阳证尚兼太阳，所以误下而胸间微结也，太阳中篇结胸条内，头微汗出，用大陷胸汤，以其热结在里，故从下夺之法也，此头汗出而胸微结，用柴胡桂枝干姜汤，以里证未具，故从和解之法也，小柴胡方中，减半夏人参，而加桂枝以行太阳，加干姜以散气满，栝蒌根以滋干，牡蛎以栗结，一一皆从本例也。

少阳证小柴胡汤加渴者宜救津液一法（三）服柴胡汤已，渴者，属阳明也，以法治之。〔原文〕风寒之邪，从阳明而转少阳，起先不渴，里证未具，及服小柴胡汤已，重加口渴，则邪还阳明，而当调胃以存津液矣，然不曰攻下，而曰以法治之，意味无穷，盖少阳之寒热往来，间有渴证，倘少阳未罢，而恣言攻下，不自犯少阳之禁乎，故见少阳重转阳明之证，但云以法治之，其法维何，即发汗利小便已，胃中躁烦实，大便难之说也，若未利其小便，则有猪苓五苓之法，若津液热炽，又有人参白虎之法，仲景圆机活泼，人存政举未易言矣。

少阳证具误下而证尚未变者仍用小柴胡汤二法（一三）凡柴胡汤病证而下之，若柴

胡证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。〔原文〕（一四）伤寒五六日，呕而发热者，柴胡汤证具而以他药下之，柴胡证仍在者，复与柴胡汤，此虽已下之，不为逆，必蒸蒸而振，却发热汗出而解若心下满而鞭痛者，此为结胸也，大陷胸汤主之，但满而不痛者此为痞，柴胡汤不中与之，宜半夏泻心汤。〔原文〕二条互发，前略后详，误下虽谁未变，然正气先虚，故服柴胡汤，必蒸蒸而振，始得发热汗出，而邪从表解也，若误下而成结胸与痞，则邪尚在太阳，而柴胡非所宜矣，结胸及痞太阳经令有颡条。

重以汗下为逆不为逆申上文而广其义（一五）本发汗而复下之，此为逆也，若先发汗，治不为逆，本先下之，而反汗之，此为逆也，若先下之，治不为逆。〔原文〕少阳虽有汗下二禁，然而当汗当下，正自不同，本当发汗而反下之，则为逆，若先汗后下，则不为逆，本当下之，而反发汗，则为逆，若先下后汗，则不为逆，全在辨其表里差多差少之间矣。

少阳病有疑似少阴者当细辨脉证用药一法（一六）伤寒五六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便鞭，脉细者，此为阳微结，必有表复有里也，脉沉亦在里也，汗出为阳微，假令纯阴结，不得复有外证，悉入在里，此为半在里半在外也，脉虽沉紧，不得为少阴病，所以然者，阴不得有汗，今头汗出，故知非少阴也，可与小柴胡汤，设不了了者，得屎而解。〔原文〕阳微结者，阳邪微结，未尽散也，注作阳气衰微，故邪气结聚，大差，果尔则头汗出为亡阳之证，非半表半里之证矣，果尔则阴结，又是阴气衰微矣，玩本文假令纯阴结等语，谓阳邪若不微结，纯是阴邪内结，则不得复有外证，其义甚明，得屎而解，即取大柴胡为和法之意也。

用汗吐下后有辨脉证而识其必愈一法（一七）凡病若发汗，若吐若下，若亡津液，阴阳自和者，必自愈。〔原文〕汗吐下三法，难于恰当，若误用之，则病未去，而胃中之津液已先亡，凡见此者，诊视其脉与证，阴阳自和，则津液复生，必自愈也。

辨妇人伤寒传少阳有热入血室之证四法（一八）妇人中风，发热恶寒，经水适来，得之七八日，热除而脉迟身凉，胸胁下满，如结胸状，谵语者，此为热入血室也，当刺期门，随其实而泻之。〔原文〕（一九）妇人中风，七八日续得寒热，发作有时，经水适断者，此为热入血室，其血必结，故使如疟状，发作有时，小柴胡汤主之。〔原文〕（二十）妇人伤寒发热，经水适来昼日明了，暮则谵语，如见鬼状者，此为热入血室，无犯胃气及上二焦，必自愈。〔原文〕（二一）血弱气尽腠理开，邪气因入，与正气相搏结于胁下，正邪分争，往来寒热，休作有时，默默不欲饮食，脏腑相连，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之。〔原文〕四条皆互文见意也，一云经水适来，一云经水适断，一云七八日热除，而脉迟身凉，一云七八日续得寒热，发作有时，一云胸胁下满，一云邪气因入，与正气相搏结于胁下

，一云如结胸状，一云邪高痛下，一云譫语，一云昼日明了，暮则譫语，如有鬼状，一云如疟状，一云往来寒热，休作有时，一云刺期门，一云用小柴胡汤，一云母犯胃气及上二焦，皆互文以明大义，而自为脚注也，学者试因此而紬释全书，思过半矣。如结胸状四字，仲景尚恐形容不尽，重以脏腑相连，邪高痛下之语，畅发病情，盖血室者冲脉也，下居腹内，厥阴肝之所主也，而少阳之胆与肝相连，腑邪在上，脏邪在下，胃口逼处二邪之界，所以默默不欲饮食而但喜呕耳，期门者肝之募也，随其实而泻之，泻肝之实也，又刺期门之脚注也，小柴胡汤，治少阳之正法也，母犯胃气及上二焦，则舍期门，小柴胡更无他法矣，必自愈，见腑邪可用小柴胡汤，而脏邪必俟经水再行，其邪热乃随血去，又非药之所能胜耳。〔少阳止此〕

重编合病并病坏病痰病附三阳经后，其过经不解，附三阴经后。右证叔和俱编入太阳经中，不知何意，或谓伤寒只分六经，合太阳一经，别无可入诸项也，然则霍乱证，及阴阳易等证，曷不尽入太阳耶，况乎既重六经，则少阳亦六经之一，曷不为重耶，兹一一清出，以六经等六国，以合并诸病等附庸，俾业伤寒者，一展玩而了然于心目耳。

合病合病者，两经之证，各见一半，如日月之合朔，如王者之合圭璧，界限中分，不偏多偏少之谓也。（一）太阳病，项背强，几几反汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。〔原文〕（二）太阳病，项背强，几几无汗恶风者，葛根汤主之。〔原文〕二条以有汗无汗，定伤风伤寒之别，盖太阳初交，阳明未至，两经各半，故仲景原文，不用合病二字，然虽不名合病，其实乃合病之初证也，几几者，颈不舒也，颈属阳明，既于太阳风伤卫证中，纔见阳明一证，即于桂枝汤内，加葛根一药，太阳寒伤营证中，纔见阳明一证，即于麻黄汤内加葛根一药，此大匠天然一不易之谷率也，然第二条，不用麻黄全方加葛根，反用桂枝全方加麻黄葛根者，则并其巧而传之矣，见寒邪既欲传于阳明，则胸间之喘必自止，自可不用杏仁，况颈项背，俱是阳位，易于得汗之处，设以麻黄本汤加葛根，大发其汗，将毋项背强，几几者，变为经脉振摇动惕乎，此仲景之所为精义入神也。桂枝汤，麻黄汤，分主太阳之表，葛根汤，总主阳明之表，小柴胡汤，总主少阳之表，三阳经合并受病，即随表邪见证多寡定方，丝丝入扣。（三）太阳与阳明合病，不下利，俱呕者，葛根加半夏汤主之。〔原文〕（四）太阳与阳明合病者，必自下利，葛根汤主之。〔原文〕二条又以下利不下利，辨别合病主风主寒之不同也，风者阳也，阳性上行，故合阳明胃中之水饮而上逆，寒者阴也，阴性下行，故合阳明胃中之水谷而下奔，然上逆则必加半夏入葛根汤，以涤饮止呕，苦下利，则但用葛根汤，以解两经之邪，不治利而利自止耳，葛根汤即第一条桂枝汤加葛根，不用麻黄者是也。（五）太阳与阳明合病，喘而胸满者，不可下麻黄汤主之。〔原文〕两经合病，当合用两经之药，何得偏用麻黄汤耶，此见仲景析义之精，盖太阳邪在胸，阳明邪在胃，两邪相合，必上攻其肺，所以喘而胸满，麻黄杏仁，治肺气喘逆之颞药，用之恰当，正所谓内举不避亲也，何偏之有。（六）太阳与少阳合病，自下利者，与黄芩汤，若呕者，黄芩加半夏生姜汤。〔原文〕太阳阳明，合病下利，表证为多，阳明少阳，合病下利，里

证为多，太阳少阳，合病下利，半表半里之证为多，故用黄芩甘草芍药大枣为和法也。（七）阳明少阳合病，必下利，其脉不负者，顺也，负者，失也，互相克贼，名为负也，脉滑而数者，有宿食也，当下之，宜大承气汤。〔原文〕土木之邪，交动，则水穀不停而急奔，故下利可必也，阳明脉大，少阳脉弦，两无相负，乃为顺候，然两经合病，阳明气衰，则弦脉独见，少阳胜而阳明负矣，下之固是通因通用之法，而土受克贼之邪，势必藉大力之药，急从下夺，乃为解围之善着，然亦必其脉滑而且数，有宿食者，始为当下无疑也，设脉不滑数而迟软，方虑土败垂亡，尚敢下之乎。按太阳与阳明合病，阳明与少阳合病，俱半兼阳明，所以胃中之水穀不安，而必自下利，其有不下利者，亦必水饮上越而呕，与少阳一经之证，干呕者大不同也，或利或呕，胃中之真气，与津液俱伤，所以亟须散邪以安其胃，更虑少阳胜而阳明负，即当急下以救阳明，其取用大承气汤，正迅扫外邪，而承领元气之义也，设稍牵泥，则脉之滑数必转为迟软，下之无及矣，微哉危哉。（八）三阳合病，脉浮大上关上，但欲眠睡，目合则汗。（九）三阳合病，腹满身重，难以转侧，口不仁而面垢，譫语遗尿，发汗则譫语，下之则额上生汗，手足逆冷，若自汗者，白虎汤主之。〔原文〕三阳合病，互合之，表里俱伤，故其脉浮大，其证欲眠，而目合则汗，中州之扰乱可知矣，此时发汗则偏于阳，而阳明之津液倍竭，故譫语益甚，将成无阳之证也，下之则偏于阴，而真阳以无偶而益孤，故手足逆冷，而额上生汗，将成亡阳之证也，既不宜于汗下，惟有白虎一汤，主解热而不碍表里，在所急用，然非自汗出，则表犹未解，尚未可用，此证夏月最多，当与痄湿喝篇参看。按三阳经之受外邪，太阳头疼腰脊痛，阳明目痛，鼻干不眠，少阳寒热往来，口苦呕渴，各有专司，合病者，即兼司三阳二阳之证也，仲景但以合之一字括其义，而归重在下利与呕喘胸满之内证，盖以邪既相合，其人腹内，必有相合之征验故也，后人于此等处，漫不加察，是以不知合病为何病耳，再按少阳篇第九条云，伤寒六七日发热微恶寒，支节烦疼微呕，心下支结，外证未去者，柴胡桂枝汤主之一条，其证全是太阳与少阳合并之病，但内无下利，其呕复微，即不谓之合病，心下支结，又与心下痞鞭，时如结胸者不同，即不谓之并病，乃知并合之病，重在内有合并之征验，非昌之臆说矣。后人谓三阳合病，宜从中治此等议论，似得仲景表邪未散，用小柴胡汤，里热已极，用白虎汤之旨，然未可向痴人说梦也，设泥此则仲景所用麻黄汤，大承气汤之妙法，万不敢从矣，噫，吾安得尽辟快捷方式为周行也哉。

并病并病者，两经之证，连串为一，如贯索然，即兼并之义也，并则不论多寡，一经见三五证，一经见一二证，即可言并病也，然太阳证多，阳明少阳证少，如秦之并六国者乃病之常，若阳明少阳证多，太阳证少，则太阳必将自罢，又不得拟之为六国并秦矣。（一）二阳并病，太阳初得病时，发其汗，汗先出不彻，因转属阳明，续自微汗出，不恶寒，若太阳病证不罢者，不可下，下之为逆，如此可小发汗，设面色缘缘正赤者，阳气怫郁在表，当解之熏之，若发汗不彻，不足言阳气怫郁不得越，当汗不汗，其人躁烦，不知痛处，乍在腹中，乍在四肢，按之不可得，其人短气，但坐以汗出不彻故也，更发汗则愈，何以知汗出不彻，以脉濇故知也。〔原文〕（二）二阳并病，太阳证罢，但发潮热，手足濇濇汗出，大便难而譫语者，下

之则愈，宜大承气汤。〔原文〕按二阳并病二条，皆是太阳与阳明并也，上条证初入阳明，而太阳仍未罢，宜小汗，此条证已入阳明，而太阳亦随罢，宜大下，所以宜小汗大下之故，昌言之已悉，可以无赘，但上条之文，从前未有注释，兹特明之，太阳初得寒伤营之病，以麻黄发其汗，汗出而邪去，病不传矣，因汗出不彻，故传阳明，续自微汗出，不恶寒，阳明热炽，似乎当用下法，以太阳之邪未彻，故下之为逆，谓其必成结胸等证也，如此者，可小发汗，然后下之，设面色缘缘正赤者，寒邪深重，阳气怫郁在表，必始先未用麻黄汤，或已用麻黄汤而未得汗，所以重当解之熏之，又非小发汗所以胜矣，若是发汗不彻，不足言阳气怫郁不得越也，毕竟当汗不汗，其人躁烦，不知痛处，乍在腹中，乍在四肢，按之不可得，方是阳气不得越耳，短气者，因汗而气伤也，脉濇者，因汗而血伤也，汗虽未彻，其已得汗可知，其不怫郁又可知，所以宜更他药以小发其汗，更字读平声，与太阳中篇伤寒汗解半日许复烦，脉浮数者，可更发汗互发，然则彼更桂枝汤，此更桂枝加葛根汤，并可推矣。（三）太阳与少阳并病，头项强痛，或眩冒，时如结胸，心下痞鞭者，当刺大椎第一间肺俞肝俞，慎不可发汗，发汗则谵语，脉弦，五六日谵语，不止当刺期门。〔原文〕少阳之脉，络胸胁间并入太阳之邪，则与结胸证似是而实非也，肝与胆合，刺肝俞所以泻胆也，膀胱不与肺合，然肺主气，刺肺俞以通其气，斯膀胱之气化行，而邪自不能留矣，发汗则谵语与合病木盛克土之意同，注谓木盛则生心火，节外生枝，反失正意，脉弦亦即合病，内少阳胜而阳明负之互词，此所以刺期门，随木邪之实而泻之也，仲景通身手眼，后人只泥于一手一目可乎。（四）太阳少阳并病，心下痞，颈项强而眩者，当刺大椎肺俞，肝俞，慎勿下之。〔原文〕重申不可下之禁，与上条不可汗互发。（五）太阳少阳并病，而反下之，成结胸心下痞，下利不止，水浆不下，其人心烦。〔原文〕误下之变，乃至结胸下利，上下交征，而阳明之居中者水浆不入，心烦待毙，伤寒顾可易言哉。并病即不误用汗下，已如结胸心下痞鞭矣，况加误下乎，此比太阳一经，误下之结胸，殆有甚焉，其人心烦，似不了之语，然仲景太阳经，谓结胸证悉具，烦躁者亦死，意者此谓其人心烦者死乎。

坏病坏病者，已汗已吐已下，已温针，病犹不解，治法多端，无一定可拟，故名之为坏病也，坏病与过经不解大异，过经不解者，连三阴经俱已传过，故其治但在表里，差多差少，宜先宜后之间，若坏病则病在三阳未入于阴，故其治但在阳经，其证有结胸下利，眩冒振惕惊悸，谵妄呕啰躁烦之不同，其脉有弦促细数，紧滑沉微，涩弱结代之不同，故必辨其脉证，犯何逆，然后得以法而治其逆也。（一）太阳病三日，已发汗，若吐若下若温针，仍不解者，此为坏病，桂枝不中与也，观其脉证，知犯何逆，随证治之。〔原文〕相传伤寒过经日久，二三十日不瘥者，谓之坏病，遂与过经不解之病无辨，此古今大误也，仲景止说病三日，即五六日亦未说到，且此条止说太阳病，连少阳亦未说到，故谓桂枝偏表之法，不可用，观下条太阳转入少阳之坏证，有柴胡证罢四字，可见此为桂枝证罢，故不可复用也，设桂枝证仍在，即不得谓之坏病，与少阳篇内柴胡证仍在者，此虽已下之不为逆，复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却发热汗出而解之文，又互相绾照也，岂有桂枝柴胡之证，尚未

罢，而得指为坏病之理哉，故必细察其脉为何脉，证为何证，从前所误，今犯何逆，然后随其证而治之，始为当耳。（二）本太阳病不解，转入少阳者，胁下鞭满干呕，不能食，往来寒热，尚未吐下，脉沉紧者，与小柴胡汤，若已吐下，发汗温针譫语，柴胡证罢，此为坏病，知犯何逆，以法治之。〔原文〕按上条太阳经之坏病也，此条少阳经之坏病也，两条文意互发，其旨甚明，叔和分汇，致滋疑惑，兹合而观之，乃知上条云桂枝汤不中与，则其所犯，要不离于太阳一经之误吐误下，误发汗误烧针之诸逆也，此条云，柴胡汤不中与，则其所犯，要不离于少阳一经之误吐误下，误发汗误烧针之诸逆也，后人拟议何逆四治，见为创获，繇兹观之，真吃语矣。

痰病慨自伤寒失传，后人乃以食积虚烦痰饮脚气，牵合为类伤寒四证，此等名目一出，凡习伤寒之家，苟简粗疏，已自不识要妙，况复加冬温、温病、寒疫、热病、湿温、风温、霍乱、痉、内痈、畜血，为类伤寒十四证，头上安头，愈求愈失，兹欲直溯渊源，不得不尽辟歧派，盖仲景于春夏秋三时之病，既以冬月之伤寒统之，则十四证亦皆伤寒中之所有也，若倭之局外，漫不加察，至临证模糊，其何以应无穷之变哉，昌于春夏病中，逐段拈出，兹于三阳经后，特立痰病一门，凡痰饮素积之人，有挟外感而动者，有不繇外感而自动者，仲景分别甚明，挟外感之邪，搏结胸胁，三阳篇中，已致详矣，此但举不繇外感之痰病，昭揭其旨，俾学者辨证以施治焉耳。（一）病如桂枝证，头不痛，项不强，寸脉微浮，胸中痞鞭，气上冲咽喉，不得息者，此为胸有寒也，当吐之，宜瓜蒂散，诸亡血虚家不可与。〔原文〕寒者痰也，痰饮内动，身必有汗，加以发热恶寒，全似中风，但头不痛，项不强，此非外入之风，乃内蕴之痰，窒塞胸间，宜用瓜蒂散，以涌出其痰也。（二）病人有寒，复发汗，胃中冷，必吐蚘。〔原文〕寒亦痰也，此即上条之互文，上条辨非桂枝之证，此条辨不可发汗，盖痰从内动，无外感与俱，误发其汗，必至迷塞经络，留连不返，故示戒也，设兼外感，如三阳证中诸条，则无形之感，挟有形之痰，结于一处，非汗则外邪必不解，即强吐之，其痰饮亦必不出，所以小青龙一法，卓擅奇功耳，此言有痰无感，误发其汗，重亡津液，即大损阳气，其人胃冷而吐蚘有必至也。（三）病人手足厥冷，脉乍紧者，邪结在胸中，心中满而烦，饥不能食者，病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散。〔原文〕手足厥冷，与厥阴之热深厥深相似，其脉乍紧，则有时不紧，殊不似矣，可见痰结在胸，故满烦而不能食，亦宜瓜蒂为吐法也。合三条，总见痰证可吐不可汗，合食积虚烦脚气四证论之，勿指为类伤寒，但指为不可发汗，则其理甚精，盖食积胸中，阳气不布，更发汗则阳气外越，一团阴气用事，愈成危候，虚烦则胃中津液已竭，更发汗则津液尽矣，脚气即地气之湿邪，从足先受者，正湿家不可发汗之义耳，奈何舍正路而趋曲径耶。门人问曰，吾师于三阳证中，挈出合病、并病、坏病、痰病之条，可谓暗室一灯，炯然达旦矣，但不识阳明何以无坏病耶，答曰，阳明之误治最多，其脉证固当辨别，但不得以坏病名之也，盖阳明原有可汗可下之条，汗下原不为大逆，且误在汗，当不误在下矣，误在下，当不误在汗矣，即使汗下烧针屡误，其病亦止在胃中，原有定法可施，与坏证无定法之例，微有不协，此坏病所以不入阳明耳。门人又问曰，救阳明误治

之定法，可得闻乎，答曰，仲景云，阳明病，脉浮而紧，咽躁口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒，反恶热，身重，若发汗则躁，心愤愤，反讞语，若加烧针，必怵惕烦躁，不得眠，若下之则胃中空虚，客气动膈，心中懊憹，舌上胎者，栀子豉汤主之，观其误汗误烧针之变，烦躁怵惕，讞语不眠，止是邪在胃中，扰其津液，与亡阳之证不同也，观其误下之变，客气动膈，心中懊憹，止是热邪上膈，心逼不安，与结胸之证不同也，故遵内经高者越之之旨，以栀子豉汤涌出其邪耳，此非无定中之定法乎。

卷四

尚论太阴经证治大意

仲景伤寒论，六经中，惟太阴经文止九条，方止二道，后人致惜其非全书，昌紬绎其所以约略之意，言中风，即不言伤寒，言桂枝，即不言麻黄，言当温者，则曰宜四逆辈，全是引伸触类之妙，可见治法总不出三阳外，但消其风寒之原，以定发汗解肌，更于腹之或满或痛间，辨其虚实，以定当下当温而已，了无余义矣，自非深入阃奥者，孰能会其为全书也哉。

太阴经全篇〔法九条〕

（一）太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛，若下之，必胸下结鞕。〔原文〕腹满自利，太阴之本证也，吐而食不下，则邪迫于上，利甚而腹痛，则邪迫于下，上下交乱，胃中空虚，此但可行温散，设不知而误下之，其在下之邪可去，而在上之邪陷矣，故胸中结鞕，与结胸之变颇同，胃中津液上结，胸中阳气不布，卒难开也。（二）太阴中风，四肢烦疼，阳微阴涩而长者为微愈。〔原文〕四肢烦疼者，脾主四肢，亦风淫末疾之验也，阳脉微，阴脉涩，则风邪已去，而显不足之象，但脉见不足，正恐元气已漓，暗伏危机，故必微涩之中，更察其脉之长而不短，知元气未漓，其病为自愈也，注不审来意，谓濇为血凝气滞大谬，岂有血凝气滞，反为欲愈之理耶。（三）太阴病脉浮者，可发汗，宜桂枝汤。〔原文〕太阴脉，尺寸俱沉细，今脉浮，则邪还于表可知矣，故仍用桂枝解肌之法也。太阳经中，以浮缓为中风，浮紧为伤寒，故此不重复，但揭一浮字，其义即全该，风邪用桂枝汤，其脉之浮缓，不待言矣，然则寒邪之脉浮紧，其当用麻黄汤，更不待言矣，况少阳篇中云，设胸满胁痛者，与小柴胡汤，脉但浮者，与麻黄汤，早已挈明用麻黄汤之义，故于太阴证中，但以桂枝互之，乃弥全现全彰也，不然，同一浮脉，何所见而少阳当用麻黄，太阴当用桂枝也哉。（四）自利不渴者，属太阴，以其藏有寒故也，当温之宜服四逆辈。〔原文〕注谓自利不渴，湿邪也，故用四逆辈以燠土燥湿，此老生腐谭，非切要也，仲景大意，以自利不渴者，属太阴，以自利而渴者属少阴，分经辨证，所关甚巨，盖太阴湿土，热邪入而蒸动其湿，则湿有余，故不渴而多发黄，少阴属肾水，热邪入而消耗其水，则显不足，故口渴而多烦躁，若不全篇体会，徒博注释之名，其精微之蕴，不能阐发者多矣。（五）伤寒脉浮而缓，手足自温者，系在太阴，太阴当发身黄，若小便自利者，不能发黄，至七八日虽暴烦，下利日十余行，必自止，以脾家实，秽腐当去故也。〔原文〕太阴脉本缓，故浮缓虽类太阳中风，然手足自温，则不似太阳之发热，并不似少阴厥阴之四逆与厥，所以系在太阴，允为恰当也，太阴脉见浮缓，其湿热交盛，势必蒸身为黄，若小便自利者，湿热从水道暗泄，不能发黄也，前阳明篇中，不能发黄，以上语句皆同，但彼以胃实而便鞕，其证复转阳明，此以脾实而下秽腐，其证正属太阴耳，至七八日暴烦，下利日十余行，其证又与少阴无别，而利尽秽腐当自止，则不似少阴

之烦躁有加，下利漫无止期也，况少阴之烦而下利，手足反温，脉紧反去者，仍为欲愈之候，若不辨晰，而误以四逆之法治之，几何不反增危困耶，虽阳明与太阴，脏腑相连，其便鞭与下利，自有阳分阴分之别，注家归重于脾，谓脾为胃行津液则如此，不为胃行津液则如彼，似是而非，全失仲景三阴互发之旨。（六）本太阳病，医反下之，因而腹满时痛者，属太阴也，桂枝加芍药汤主之。〔原文〕太阳病之误下，其变皆在胸胁以上，此之误下而腹满时痛，无胸胁等证，则其邪已入阴位，所以属在太阴也，仍用桂枝解肌之法，以升举阳邪，但倍芍药以收太阴之逆气，本方不增一药，斯为神耳。（七）大实痛者，桂枝加大黄汤主之。〔原文〕大质大满，宜从急下，然阳分之邪，初陷太阴未可峻攻，但于桂枝汤中少加大黄，七表三里以分杀其邪可也。（八）太阴为病，脉弱，其人续自便利，设当行大黄芍药者，宜减之，以其人胃气弱易动故也。〔原文〕此段叮咛，与阳明篇中互发，阳明曰不转失气，曰先鞭后溏，曰未定成鞭，皆是恐伤太阴脾气，此太阳证，而脉弱便利，减用大黄芍药又是恐伤阳明胃气也。（九）太阴病，欲解时，从亥至丑上。

尚论少阴经证治大意

传经热邪，先伤经中之阴，甚者邪未除而阴已竭，独是传入少阴，其急下之证，反十之三，急温之证，反十之七而宜温之中，复有次第不同，毫厘千里，粗工不解，必于会犯房劳之证，始克用温，及遇一切当温之证，反不能用，詎知未病先劳其肾水者，不可因是遂认为当温也，必其人肾中之真阳素亏，复因汗吐下扰之，外出而不能内返，势必藉温药以回其阳，方可得生，所以伤寒门中，亡阳之证最多，即在太阳，已有种种危候，至传少阴，其辨证之际，仲景多少迟徊顾惜，不得不从正治之法，清热夺邪，以存阴为先务也，今以从权温经之法，疏为前篇，正治存阴之法，疏为后篇，俾业医者免临歧之惑云。

少阴经前篇〔凡本经宜温之证，悉列此篇〕

（一）少阴病，始得之，反发热脉沉者，麻黄附子细辛汤主之。〔原文〕脉沉为在里，证见少阴，不当复有外热，若发热者，乃是少阴之表邪，即当行表散之法者也，但三阴之表法，与三阳迥异，三阴必以温经之药为表，而少阴尤为紧关，故麻黄与附子合用，俾外邪出而真阳不出，纔是少阴表法之正也。（二）少阴病，得之一二日，口中和，其背恶寒者当灸之，附子汤主之。〔原文〕得之一二日，即上条始得之之互文，口中和者，不渴不躁，全无里热，其背恶寒，则阳微阴盛之机，已露一斑，故灸之以火，助阳而消阴，主之以附子汤，温经而散寒也。（三）少阴病，得之二三日，麻黄附子甘草汤，微发汗，以二三日无里证，故微发汗也。〔原文〕不吐利烦躁呕渴，为无里证，既无里证，病尚在表可知，故以甘草易细辛，而微发汗，又温散之缓法也。（四）少阴病，欲吐不吐，心烦，但欲寐，五六日自利而渴者，属少阴也，虚故引水自救，若小便色白者，少阴病形悉具，小便白者，以下焦虚有寒，不能制水，故令色白也。〔原文〕欲吐不吐心烦，肾气上逆之征也，自利

而渴，加以口躁舌干，引水自救，似乎传经热病之形悉具，然肾热则水道黄赤，若小便色白，又非肾热证，乃下焦虚寒，不能制水，仍当从事温法，不可误认为热，而轻用寒下也。（五）病人脉阴阳俱紧，反汗出者，亡阳也，此属少阴，法当咽痛而复吐利。〔原文〕阴阳俱紧，伤寒之脉也，伤寒无汗，反汗出者无阳以固护其外，所以邪不出而汗先出也，少阴之邪不出，则咽痛吐利，一一显少阴之本证，即当用少阴温经散邪之法，不言可知矣。（六）少阴病，脉微不可发汗，亡阳故也，阳已虚，尺脉弱濇者，复不可下之。〔原文〕亡阳不可发汗，与上条互发，亡与无同，无阳则其邪为阴邪，阴邪本宜下，然其人肠已虚，尺脉弱濇者，复不可下，其当亟行温法，又可见矣。（七）少阴病下利，若利自止，恶寒而蜷卧，手足温者可治。〔原文〕恶寒蜷卧，证本虚寒，利止手足温，则阳气未亏，其阴寒亦易散，故可用温法也。（八）少阴病，恶寒而蜷，时自烦，欲去衣被者可治。〔原文〕自烦欲去衣被，真阳扰乱不宁，然尚未至出亡在外，故可用温法也。（九）少阴病脉紧，至七八日自下利，脉暴微，手足反温，脉紧反去者，为欲解也，虽烦下利必自愈。

〔原文〕三条互见，此则邪解阳回，可勿药自愈之证，即紧去入安之互词也。（十）少阴病，身体痛，手足寒，骨节痛，脉沉者，附子汤主之。〔原文〕身体痛，手足寒，骨节痛，脉沉，皆寒邪入少阴之本证，即当用附子汤，行温经散寒之定法也。（一一）少阴病，吐利，手足厥冷，烦躁欲死者，吴茱萸汤主之。〔原文〕吐利厥冷，而至于烦躁欲死，肾中之阴气上逆，将成危候，故用吴茱萸以下其逆气，而用人参姜枣以厚土，则阴气不复上干，此之温经兼用温中矣。（三）少阴病，下利，白通汤主之。〔原文〕下利无阳证者，纯阴之象，恐阴盛而隔绝其阳，故用白通汤，以通其阳，而消其阴也。（一三）少阴病，下利脉微者，与白通汤，利不止，厥逆无脉，干呕烦者，白通加猪胆汁汤主之，服汤脉暴出者死，微续者生。〔原文〕与白通汤，反至厥逆无脉，干呕而烦，此非药之不胜病也，以无乡导之力，宜其不入耳，故复加人尿猪胆汁之阴，以引阳药深入，然脉暴出者死，微续者生，亦微矣哉，故上条纔见下利，早用白通图功于未着，真良法也。（一四）少阴病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重，疼痛，自下利者，此为有水气，其人或欬，或小便利，或下利，或呕者，真武汤主之。〔原文〕阴寒内持，湿胜而水不行，因而内渗外薄，甚至水谷不分，或欬或利，泛滥无所不至，非赖真武坐镇北方之水，宁有底哉，太阳篇中，厥逆筋惕肉瞤而亡阳者，用真武汤之法，已表明之矣，兹少阴之水湿上逆，仍用真武一法以镇摄之，可见太阳膀胱，与少阴肾，一藏一府，同居北方寒水之位，府邪为阳邪，藉用麻桂为青龙，藏邪为阴邪，藉用附子为真武，得此二汤，以涤痰导水，消阴摄阳，其神功妙济，真有不可思议者矣。

（一五）少阴病，下利清穀，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面赤色，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止脉不出者，通脉四逆汤主之，其脉即出者愈。〔原文〕下利里寒，种种危殆，其外反热，其面反赤，其身反不恶寒，而手足厥逆，脉微欲绝，明系群阴隔阳于外，不能内返也，故仿白通之法，加葱入四逆汤中，以入阴迎阳，而复其脉也，前条云，脉暴出者死，此条云脉即出者愈，其辨最细，盖暴出则脉已离根，即出则阳已返舍，繇其外反发热，反不恶寒，真阳尚在躯壳，然必通其脉而脉即出，始为休征，设脉出艰迟，其阳已随热势外散，又主死

矣。（一六）少阴病，脉沉者，急温之，宜四逆汤。〔原文〕外邪入少阴，宜与肾气两相搏击，乃脉见沉而不鼓，即内经所谓肾脉独沉之义，其人阳气衰微可知，故当即温之以助其阳也。（一七）少阴病，饮食入口即吐，心下温温欲吐，复不能吐，始得之，手足寒脉弦迟者，此胸中实不可下也，当吐之，若膈上有寒饮干呕者，不可吐也，急温之，宜四逆汤。〔原文〕饮食入口即吐，犹曰胃中不能纳穀也，若不饮食之时，复欲吐而不能吐，明系阴邪上逆矣，此等处必加细察，若始得之，便手足寒而脉弦迟，即非传经热邪，其为阴邪上逆无疑，当从事乎温经之法也，若胸中实者，是为阳邪在胸而不在腹，即不可用下，而当吐以提之也，然必果系阳邪，方可用吐，设膈上有寒饮干呕，即是阴邪用事，吐必转增其逆，计惟有急温一法，可助阳而胜阴矣。（一八）少阴病，下利，脉微涩，呕而汗出，必数更衣，反少者，当温其上，灸之。〔原文〕下利而脉见阳微阴涩，为真阴真阳两伤之候矣，呕者，阴邪上逆也，汗出者阳虚不能外固，阴弱不能内守也，数更衣反少者，阳虚则气下坠，阴弱则勤弩责也，是证阳虚，本当用温，然阴弱，复不宜于温，一药之中既欲救阳，又欲护阴，漫难区别，故于顶之上，百会穴中灸之，以温其上而升其阳，庶阳不致下陷，以逼迫其阴，然后阴得安静不扰，而下利自止耳，此证设用药以温其下，必逼迫转加，下利不止，而阴立亡，故不用温药，但用灸法，有如此之回护也。前条用吴茱萸汤，兼温其中，此条用灸法，独温其上，妙义天开，令人舞蹈。

（一九）少阴病吐利，手足不逆冷，反发热者，不死，脉不至者，灸少阴七壮。〔原文〕既吐且利，手足逆冷者，其常也，若反发热，则阳气似非衰惫，然正恐真阳越出躯壳之外，故反发热耳，设脉不至，则当急温无疑，但温药必至伤阴，故于少阴本穴，用灸法以引其阳内返，斯脉至而吐利亦将自止矣，前条皆恶寒之证，灸后用附子汤者，阴寒内凝，定非一灸所能胜，此条手足反热，止是阴内阳外，故但灸本经以招之内入，不必更用温药也，丝丝入扣。（二十）少阴病，恶寒身蜷而利，手足逆冷者不治。〔原文〕阴盛无阳，即用四逆等法，回阳气于无何有之乡，其不能回者多矣，故曰不治。（二一）少阴病，吐利烦躁，四逆者死。〔原文〕上吐下利，因至烦躁，则阴阳扰乱，而竭绝可虞，更加四肢逆冷，是中州之土，先败，上下交征，中气立断，故主死也，使早用温中之法，宁至此乎。（二二）少阴病，下利止而头眩，时时自冒者死。〔原文〕下利既止，其人似可得生，乃头眩时时自冒者，复为死候，盖人身阴阳相为依附者也，阴亡于下，则诸阳之上聚于头者，纷然而动，所以头眩时时自冒，阳脱于上，而主死也，可见阳回利止则生，阴尽利止则死矣。（二三）少阴病，四逆恶寒而身蜷，脉不至，不烦而躁者死。〔原文〕四逆恶寒身蜷，更加脉不至，阳已去矣，阳去故不烦，然尚可施种种回阳之法，若其人复加躁扰，则阴亦垂绝，即欲回阳，而基址已坏，不能回也。（二四）少阴病，六七日，息高者死。〔原文〕诸阳主气，息高则真气上并于胸中，本实先拨，而不能复归于气海，故主死也，六七日三字，辨证最细，见六七日经传少阴而息高，与二三日太阳作喘之表证迥殊也。（二五）少阴病，脉微沉细，但欲卧，汗出不烦自欲吐，至五六日自利，复躁烦不得卧寐者死。〔原文〕脉微沉细，但欲卧，少阴之本证也，汗出不烦，则阳证悉罢，而当顾虑其阴矣，乃于中兼带欲吐一证，欲吐，明系阴邪上逆，正当急温之时，失此不图，至五六日，自利有加，复烦躁不得卧寐，

非外邪至此转增，正少阴胃中之真阳扰乱，顷刻奔散，即温之亦无及，故主死也。

少阴经后篇〔凡少阴传经，热邪正治之法，悉列此篇〕

（一）少阴之为病脉微细，但欲寐也。〔原文〕阳脉滑大，阴脉微细，外邪传入少阴，其脉心微细，而与三阳之滑大迥殊，卫气行阳，则寤，行阴则寐，邪入少阴，则气行于阴，不行于阳，故但欲寐也，此少阴之总脉总证也。（二）少阴病，脉细沉数，病为在里，不可发汗。〔原文〕沉细之中，加中以数，正热邪入里之征，热邪入里，即不可发汗，发汗则动其经气，而有夺血亡阳之变，故示戒也。（三）少阴病，欬而下利譫语者，被火气劫故也，小便必难，以强责少阴汗也。〔原文〕少阴之脉，从足入腹，上循喉咙，萦绕舌根，故多咽痛之证，其支别出肺，故间有咳证，今以火气强劫其汗，则热邪挟火力上攻，必为欬，以肺金恶火故也，下攻必为利，以火势逼迫而走空窍故也，内攻必譫语，以火势燔炳而乱神识故也，小便必难者，见三证皆妨小便，盖肺为火热所伤，则膀胱气化不行，大肠奔迫无度，则水谷并趋一路，心胞燔灼不已，则小肠枯涸必至耳，少阴可强责其汗乎。（四）少阴中风，阳微阴浮者为欲愈。〔原文〕风邪传入少阴，仍见阳浮阴弱之脉，则其势方炽，必阳脉反微，阴脉反浮，乃为欲愈，盖阳微则外邪不复内入，阴浮则内邪尽从外出，故欲愈也，少阴伤寒之愈脉，自可类推。（五）少阴病，欲解时，从子至寅上。〔原文〕各经皆解于所王之时，而少阴独解于阳生之时，阳进则阴退，阳长则阴消，正所谓阴得阳则解也，即是推之，而少阴所主在真阳不可识乎。（六）少阴病，八九日，一身手足尽热者，以热在膀胱，必便血也。〔原文〕少阴病难于得热，热则阴病见阳，故前篇谓手足，不逆冷反发热者不死，然病至八九日，阴邪内解之时，反一身手足尽热，则少阴必无此候，当是藏邪传府，肾移热于膀胱之证也，以膀胱主表，一身及手足正躯壳之表，故尔尽热也，膀胱之血为少阴之热所逼，其出必趋二阴之窍，以阴主降故也，（七）少阴病，但厥无汗，而强发之，必动其血，未知从何道出，或从口鼻，或从耳目，是名下厥上竭，为难治。〔原文〕强发少阴汗，而动其血，势必逆行而上出阳窍，以诸发汗药，皆阳经药也，或口鼻，或耳目，较前证血从阴窍出者，则倍甚矣，下厥者，少阴居下，不得汗而热深也，上竭者，少阴之血，尽从上而越竭也，少阴本少血，且从上逆，故为难治，然则上条不言难治者，岂非以膀胱多血，且从便出为顺乎。（八）少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧，黄连阿胶汤主之。〔原文〕心烦不得卧，而无燥证，则与真阳发动迥别，盖真阳发动，必先阴气四布，为呕，为下利，为四逆，乃致烦而且躁，魄汗不止耳，今但心烦不卧，而无呕利四逆等证，是其烦为阳烦，乃真阴为邪热煎熬，如日中纤云，顷刻消散，安能霾蔽青天也哉，故以解热生阴为主治，始克有济，少缓则无及矣。（九）少阴病，二三日，至四五日，腹痛，小便不利，下利不止，便脓血者，桃花汤主之。〔原文〕腹痛，小便不利，少阴热邪也，而下利不止，便脓血则下焦滑脱矣，滑脱即不可用寒药，故取干姜石脂之辛涩，以散邪固脱，而加糯米之甘，以益中虚，盖治下必先治中，中气不下坠，则滑脱无源而自止也，注家见用干姜，谓是寒邪伤胃，欠清，盖热邪挟少阴之气，填塞胃中，故用干姜之辛以散

之，若混指寒邪为热邪，宁不貽误后人耶。（十）少阴病，下利，便脓血者，桃花汤主之，少阴病，便脓血者可刺。〔原文〕证兼下利，便脓血，则用桃花汤，若不下利，而但便脓血，则可刺经穴以散其热，即上文之互意也。（一一）少阴病，下利，咽痛，胸满心烦者，猪肤汤主之。〔原文〕下利咽痛，胸满心烦，少阴热邪充斥，上下中间，无所不到，寒下之药不可用矣，又立猪肤汤一法，以润少阴之躁，与用黑驴皮之意颇同，若以为燔猪皮外毛根薄肤，则签劣无力，且与熬香之说不符，但用外皮，去其中层之肥白为是，此药大不可忽，阳微者用附子温经，阴竭者，用猪肤润燥，温经润燥中同具散邪之义，比而观之，思过半矣。（三）少阴病，二三日，咽痛者，可与甘草汤，不差者与桔梗汤。〔原文〕邪热客于少阴，故咽痛，用甘草汤者，和缓其势也，用桔梗汤者，开提其邪也，此在二三日，他证未具，故可用之，若五六日，则少阴之下利呕逆，诸证峰起，此法又未可用矣。（一三）少阴病，咽中痛，半夏散及汤主之，少阴病，咽中伤，生疮，不能语言，声不出者，苦酒汤主之。〔原文〕热邪挟痰攻咽，当用半夏涤饮，桂枝散邪，若剧者咽伤生疮，音声不出，桂枝之热，既不可用，而阴邪上结，复与寒下不宜，故用半夏鸡子，以涤饮润咽，更有藉于苦酒之消肿敛疮，以胜阴热也。（一四）少阴病，四逆，其人或欬或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，四逆散主之。〔原文〕传经热邪，至于手足四逆，最当辨悉，若见欬利种种之证，其为热证无疑矣，然虽四逆而不至于厥，其热未深，故主此方为和解，亦如少阳经之用小柴胡汤，为一定之法矣，读者详之。（一五）少阴病，下利六七日，欬而呕渴，心烦不得眠者，猪苓汤主之。〔原文〕下利六七日，本热去寒起之时，其人尚兼欬渴心烦不眠等证，则是热邪搏结水饮，以故羁留不去，用猪苓汤以利水润躁，不治利而利自止也。（一六）少阴病，得之二三日，口燥咽干者，急下之，宜大承气汤。〔原文〕得病二三日，即口燥咽干则肾水之不足上供可知，延至五六日始下，必枯槁难回矣，故宜急下以救肾水也。（一七）少阴病，自利清水，色纯青，心下必痛，口干燥者，急下之，宜大承气汤。〔原文〕热邪传入少阴，逼迫津水，注为自利，质清而无渣滓相杂，色青而无黄赤相间，可见阳邪暴虐之极，反与阴邪无异，但阳邪传自上焦，其人心下必痛，口必干燥、设系阴邪，必心下满而不痛，口中和而不躁，必无此枯槁之象，故宜急下以救其阴也。（一八）少阴病，六七日，腹胀不大便者，急下之，宜大承气汤。〔原文〕六七日，腹胀不大便，则胃土过实，肾水不足以上供，有立尽之势，又非少阴负趺阳反为顺候之比，此时下之已迟，安得不急。（一九）少阴负趺阳者，为顺也。〔此条叔和编入厥阴，今移附少阴〕少阴水也，趺阳土也，诸病恶土克水，而少阴伤寒见证，惟恐土不能制水，其水反得以泛滥，水一泛滥，则呕吐下利，无所不至，究令中州土败，而真阳外越，神丹莫救矣，故予其权于土，则平成可几，予其权于水，则昏垫立至，此脉法中消息，病情之奥旨也。按少阴，水藏也，水居北方，原自坎止，惟挟外邪而动，则波翻浪涌，横流逆射，无所不到，为呕为欬，为下利，为四肢沉重，仲景不顾外邪，惟以真武一法，坐镇北方之水，水不横溢，则诸证自止，而人之命根赖以攸固，命根者何，即父母构精时一点真阳，伏藏于肾水之中者是也，水中火发，所以其证虽阴，其人反烦躁多汗，而似阳，仲景每用干姜附子白通之法，以收摄其阳，初不虑夫外感，盖阳出则腠理大开，

外感先出，所以一回阳而了无余义也，若用寒凉以助水，则真阳不返，而命根斯断矣，其有肾水衰薄，邪入不能横溢，转而内挟真阳，蕴崇为患，外显心烦舌躁，咽痛不眠等证，即不敢擅用汗下诸法，以重伤其阴，但用黄连阿胶汤，苦酒汤猪苓汤猪肤汤四逆散之类，以分解其热，而润泽其枯，于中虽有急下三证，反无当下一证，所以前方俱用重剂润下，一日三服，始胜其任，设热邪不能尽解，传入厥阴，则热深者其厥亦深，而咽痛者转为喉痹，呕欬者转吐痈脓，下利者转便脓血，甚者发热厥逆，躁不得卧，仍是肾气先绝而死也，必识此意，然后知仲景温经散邪之法，与清热润燥之法，微细曲折，与九转还丹不异，后人窥见一斑者，遇阴邪便亟温，遇阳邪便亟下，其卤莽灭裂，尚不可胜言，况于聋瞶之辈乎，兹分前后二篇，畅发其义，有知我者，谅不以我为僭也。

尚论厥阴经证治大意

厥阴虽两经交尽之名，然厥者逆也，肾居极下，逆行而上，以传于肝，故名曰厥阴也，邪传厥阴，其热深矣，热深多发厥，厥证皆属于阳，以阳与阴不相承接，因致厥也，厥后发热，阳邪出表则易愈，厥多热少，则病进，热多厥少则病退，所以仲景杂用三阳经治法，即讖语之当下者，但用小承气汤，微和胃气，他证皆不用下，正欲其热多而邪从外出耳，然厥证多兼下利，则阳热变为阴寒者，十居其七，盖木盛则胃土受克，水穀奔迫，胃阳发露，能食则为除中，木盛则肾水暗亏，汲取无休，肾阳发露，面赤则为戴阳，絳是阳微则厥愈甚，阳绝则厥不返矣，所以温之灸之，以回其阳，仍不出少阴之成法也，但厥而下利，阴阳之辨甚微，不便分为二篇，故发其奥于篇首，俾读者先会其意云。

厥阴经全篇 [法四十七条]

（一）厥阴之为病，消渴气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蚘，下之利不止。〔原文〕消渴者，饮水多而小便少也，厥阴属木，厥阴邪甚，则肾水为之消，肾消则引水以自救，故消而且渴，其渴不为水止也，气上撞心，心中疼热者，肝气通于心也，饥不能食者，木邪横肆，胃土受制也，食则吐蚘者，胃中饥，蚘嗅食则出也，下之利不止者，邪属厥阴，下则徒虚阳明，阳明确，木益乘其所胜也，此条文义，形容厥阴经之病情最着，盖子盛则母虚，故肾水消而生渴，母盛则子实，故气撞心而疼热，然足经之邪，终与手经有别，虽仰关而攻，究不能入心之郛廓也，至胃则受俯凌之势，无可逃避，食则吐而下则利不止矣，亦絳邪自阳明传入，胃气早空，故易动耳。（二）厥阴中风，脉微浮为欲愈，不浮为未愈。〔原文〕厥阴之脉，微缓不浮，中风病传厥阴，脉转微浮，则邪还于表而为欲愈。（三）厥阴病，欲解时，从丑至卯上。〔原文〕丑寅卯，厥阴风木之王时，故病解。（四）厥阴病，欲饮水者，少少与之愈。〔原文〕（五）诸四逆厥者不可下之，虚家亦然，凡厥者阴阳气不相顺接，便为厥，厥者手足逆冷者是也。〔原文〕厥即四逆之极，阴阳既不相顺接，下则必至于脱绝也。厥阴证，仲景总不欲下，无非欲邪还于表，而阴

从阳解也，此但举最不可下之二端，以严其戒耳。手之三阴，与手之三阳，相接于手，足之三阴，与足之三阳，相接于足，阴主寒，阳主热，故阳气内陷，不与阴气相顺接，则手足厥冷也，然四肢属脾，脾为阴，与胃之阳不相顺接，亦主逆冷，所以厥证虽传经热邪，复有不尽然者，最难消息。（六）伤寒脉迟，六七日，而反与黄芩汤彻其热，脉迟为寒，今与黄芩汤，复除其热，腹中应冷，当不能食，今反能食，此名除中，必死。〔原文〕脉迟为寒，寒则胃中之阳气已薄，不可更用寒药矣，腹中即胃中，胃暖乃能纳食，今胃冷而反能食，则是胃气发露无余，其阳亦必渐去而不能久存，故为必死，除者去也，与除夕之义同，又除者授也，与授鞶带之义同。（七）伤寒始发热六日，厥反九日而利，凡厥利者，当不能食，今反能食者，恐为除中，食以索饼，不发热者，知胃气尚在必愈，恐暴热来出而复去也，后三日脉之，其热续在者，期之旦日夜半愈，所以然者，本发热六日，厥反九日，复发热三日，并前六日，亦为九日，兴厥相应，故期之旦日夜半愈，后三日脉之而脉数，其热不罢者，此为热气有余，必发痈脓也。〔原文〕少阴经中内藏真阳，最患四逆，故云吐利手足不逆冷，反发热者不死，厥阴经中，内无真阳，不患其厥，但患不能发热，与夫热少厥多耳，论中恐暴热来出而复去，后三日脉之，其热尚在，形容厥证重热之意，匠心满志，读者不可草草，然得热与厥相应，尤无后患，若热气有余，病势虽退，其后必发痈脓，以厥阴主血，热与血久持不散，必至壅败也。（八）伤寒先厥，后发热，而利者，必自止，见厥复利，伤寒先厥，后发热，下利必自止，而反汗出咽中痛者，其喉为痹，发热无汗，而利必自止，若不止，必便脓血，便脓血者其喉不痹。〔原文〕先厥后热，下利止，其病为欲愈矣，乃反汗出咽中痛，是热邪有余，上攻咽喉，挟湿痰而为痹也，然既发热，即无汗而邪亦外出，所以利必自止，若不止则无汗，明系邪不外出，仍在于里，必主便脓血也，便脓血者其喉不痹，见热邪在里，即不复在表，在下即不复在上也。（九）伤寒一二日，至四五日，厥者必发热，前热者后必厥，厥深者热亦深，厥微者热亦微，厥应下之，而反发汗者，必口伤烂赤。〔原文〕前云诸四逆厥者，不可下矣，此云厥应下之者，其辨甚微，盖先四逆而后厥，与先发热而后厥者，其来迥异，故彼云不可下，而此云应下也，以其热深厥深，当用苦寒之药，清解其在里之热，即名为下，如下利譫语，但用小承气汤止耳，从未闻有峻下之法也，若不用苦寒，反用辛甘发汗，宁不引热势上攻乎，口伤烂赤，与喉痹互意。（十）伤寒病，厥五日，热亦五日，设六日当复厥，不厥者自愈，厥终不过五日，以热五日，故知自愈。〔原文〕厥终不过五日，即上句之脚注，见热与厥相应，阴阳一胜一复，恰恰相当，故可勿药自愈。

（一一）伤寒脉微而厥，至七八日肤冷，其人躁无暂安时者，此为藏厥非蚘厥也，蚘厥者，其人当吐蚘，今病者静而复时烦者，此为藏寒，蚘上入其膈，故烦，须臾复止，得食而呕又烦者，蚘闻食臭出，其人当自吐蚘，蚘厥者，乌梅圆主之，又主久利。〔原文〕此条微旨，千百年来，全无识者，昌于篇首总括大意，挈出肾阳胃阳二端，原有所自，藏厥者，正指肾而言在，蚘厥者，正指胃而言也，曰脉微而厥，则阳气衰微可知，然未定其为藏厥蚘厥也，惟肤冷而躁无暂安，乃为藏厥，藏厥用四逆，及灸法，其厥不回者主死，若蚘厥则时烦时止，未为死候，但因此而驯至胃中无阳，则死也，乌梅圆中，酸苦辛温互用，以安蚘温胃益虚，久利而便脓血，

亦主此者，能解阴阳错杂之邪故也。（一二）伤寒热少厥微指头寒，默默不欲食，烦躁数日，小便利，色白者，此热除也，欲得食，其病为愈，若厥而呕，胸胁烦满者，其后必便血。〔原文〕热少厥微，指头微寒，其候原不重，然默默不欲食，烦躁数日，胃中津液伤而坐困矣，若小便利，色白，则胃热暗除，故欲得食，若厥而呕，胸胁满不去，则邪聚中焦，其后阴邪必走下窍而便血，以厥阴主血也。（一三）伤寒发热四日，厥反三日，复热四日，厥少热多，其病当愈，四日至七日热不除者，必便脓血，伤寒厥四日，热反三日，复厥五日，其病为进，寒多热少，阳气退，故为进也。〔原文〕以阴阳进退之义互举，其旨跃然。（一四）伤寒六七日，脉微，手足厥冷，烦躁，灸厥阴，厥不还者死。〔原文〕脉微而厥，更加烦躁，则是阳微阴盛，用灸法以通其阳，而阳不回则死也。（一五）伤寒发热，下利厥逆，躁不得卧者死。〔原文〕（一六）伤寒发热，下利至甚，厥不止者死。〔原文〕厥证但发热则不死，以发热则邪出于表，而里证自除，下利自止也，若反下利厥逆，烦躁有加，则其发热，又为阳气外散之候，阴阳两绝，亦主死也。（一七）发热而厥七日，下利者，为难治。〔原文〕厥利与热，不两存之势也，发热而厥七日，是热者自热，厥利者自厥利，双方其偏，漫无相协之期，故虽未现烦躁等证，而已为难治，盖治其热，则愈厥愈利，治其厥利，则愈热，不至阴阳两绝不止矣。（一八）伤寒六七日不利，便发热而利，其人汗出不止者死，有阴无阳故也。〔原文〕六七日不利，忽发热而利，浑是外阳内阴之象，此中伏有亡阳危机，所以仲景蚤为回护，用温用灸，以安其阳，若俟汗出不止，乃始图之，则无及矣，可见邪乱厥阴，其死生全关乎少阴也，不然，厥阴之热深厥深，何反谓之有阴无阳哉。（一九）病者手足厥冷，言我不结胸，小腹满，按之痛者，此冷结在膀胱关元也。〔原文〕阳邪必结于阳，阴邪必结于阴，故手足逆冷，腹满按之痛者，邪不上结于胸，其非阳邪可知，其为阴邪下结可知，则其当用温用灸，更可知矣，关元在脐下三寸，为极阴之位也。（二十）伤寒五六日，不结胸，腹濡脉虚，复厥者不可下，此为亡血，下之死。〔原文濡音软〕伤寒五六日，邪入厥阴，其热深矣，乃阳邪不上结于胸，阴邪不下结于腹，其脉虚而复厥，则非热深当下之比，繇其阴血索亏，若误下之，以重亡其阴，必主死也，此厥阴所以无大下之法，而血虚之人，尤以下为大戒矣。（二一）手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之，若其人内有久寒者，宜当归四逆，加吴茱萸生姜汤主之。〔原文〕前条之脉虚，此条之脉细，互见其义，虚细总为无血，不但不可用下，并不可用温，盖脉之虚细，本是阳气衰微，然阴血更为不足，故药中宜用归芍以济其阴，不宜用姜附以劫其阴也，即其人素有久寒者，但增吴茱萸生姜观之，是则干姜附子，宁不在所禁乎，比而推之，妙义天开矣。（二二）大汗出，热不去，内拘急，四肢疼，又下利厥逆而恶寒者，四逆汤主之。〔原文〕大汗出而热反不去，正恐阳气越出躯壳之外，若内拘急，四肢疼更加下利，厥逆恶寒，则在里纯是阴寒，宜急用四逆汤以回其阳，而阴邪自散耳。（二三）大汗若大下利，而厥冷者，四逆汤主之。〔原文〕此证较上条无外热相错，其为阴寒易明，然既云大汗大下利，则津液亦亡，但此条不得不以救阳为急，俟阳同尚可徐救其阴，所以不当牵制也。（二四）伤寒脉促，手足厥逆者，可灸之。〔原文〕伤寒脉促，则阳气局蹐可知，更加手足厥逆，其阳必为阴所格拒而不能返，故宜灸以通其阳

也。（二五）伤寒脉滑而厥者，里有热也，白虎汤主之。〔原文〕滑为阳脉，其里热炽盛可知，故宜行白虎汤以解其热，与三阳之治不殊也。（二六）病人手足厥冷，脉乍紧者，邪结在胸中，心下满而烦，饥不能食者，病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散。〔原文〕手足厥冷疑似阴邪，其脉有时乍紧，则是阳邪而见阳脉也，阳邪必结于阳，所以邪结在胸中，心下烦满，饥不能食也，此与太阳之结胸迥殊，其脉乍紧，其邪亦必乍结，故用瓜蒂散，涌载其邪而出，斯阳邪仍从阳解耳。（二七）伤寒厥而心下悸者，宜先治水，当用茯苓甘草汤，却治其厥，不尔水渍入胃，必作利也。〔原文〕太阳篇中，饮水多者，心下必悸，故此厥而心悸者，明系饮水所致，所以乘其水未渍胃，先用茯苓甘草汤治水，以清下利之源，后乃治厥，庶不致厥与利相因耳。（二八）伤寒六七日，大下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不至，咽喉不利，唾脓血，泄利不止者，为难治，麻黄升麻汤主之。〔原文〕此表里错杂之邪，最为难治，然非死证也，大下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，则阳气陷入阴中，下部脉不至，则阴气亦复衰竭，咽喉不利唾脓血，又因大下伤其津液，而成肺痿，金匱曰，肺痿得之，被快药下利重亡津液者是也，泄利不止，未是下焦虚脱，但因阳气下陷所致，故必升举药中兼调肝肺，乃克有济，此麻黄升麻所以名汤，而谓汗出愈也。按寸脉沉而迟，明是阳去入阴之故，非阳气衰微可拟，故虽手足厥逆，下部脉不至，泄利不止，其不得为纯阴无阳可知，况咽喉不利，唾脓血，又阳邪搏阴上逆之征验，所以仲景特于阴中，提出其阳，得汗出，而错杂之邪尽解也。（二九）伤寒四五日，腹中痛，若转气下趋少腹者，此欲自利也。〔原文〕腹中痛，多属虚寒，与腹中实满不同，若更转气下趋少腹，则必因腹寒而致下利，眼明见此，自当图功于未着矣。（三十）伤寒本自寒下，医复吐下之，寒格更逆吐下，若食入口即吐，干姜黄连黄芩人参汤主之。〔原文〕本自寒下，是其人之平素胃寒下利也，较上条之转气下趋少腹者，更为已然之事矣，所以纔病伤寒，即不可妄行吐下，与病人粪微溏，不可服栀子汤互意，粪微溏而用栀子，则易涌易泄，本自寒下而施吐下，则吐下更逆，其理甚明，注家不会其意，寒格者，因误施吐下之寒药，致成格拒也，若食入口即吐，格拒极矣，故用干姜人参以温补其胃，用黄芩黄连之苦，以下逆气，而解入里之热邪也。（三一）下利脉沉而迟，其人面少赤，身有微热，下利清穀者，必郁冒，汗出而解，病人必微厥，所以然者，其面戴阳下虚故也。〔原文〕下利脉沉迟，里寒也，面少赤，有微热，则仍兼外邪，必从汗解，但戴阳之证必见微厥，汗中大伏危机，其用法即迥异常法，下条正其法也。（三二）下利清穀，里寒外热，汗出而厥者，通脉四逆汤主之。〔原文〕上条辨证，此条用药，两相互发，然不但此也，少阴病，下利清谷，面色赤者，已用其法矣，要知通之正所以收之也，不然，岂有汗出而反加葱之理哉。（三三）下利手足厥冷，无脉者，灸之不温，若脉不还，反微喘者死。〔原文〕灸之不温，脉不还，已为死证，然或根柢未绝，亦未可知，设阳气随火气上逆，胸有微喘，则孤阳上脱而必死矣，与少阴病六七日息高者死，正同。（三四）下利后脉绝，手足厥冷，辟频率还，手足温者生，脉不还者死。〔原文〕厥利无脉，阳去而难于返矣，然左根本坚固者，生机尚存一线，经一周时，脉还手足复温则生，否则死矣，此即互上条用灸之意，所以不重赘灸法也，少阴下利，厥逆无脉，服白通汤，脉暴出者死，微续者生，厥阴下利

，厥逆脉绝，用灸法，晬频率还者生，不还者死，可见求阳气者，非泛然求之，无何有之乡也，根深宁极之中，必有几微可续，然后藉温灸为鸾胶耳。（三五）下利腹胀满，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表，温里宜四逆汤，攻表宜桂枝汤。〔原文〕此与太阳中篇，下利身疼，用先里后表之法大同，彼因误下而致下利，此因下利而致腹胀，总以温理为急者，见晬曰消之义也，身疼痛有里有表，必清便已调，其痛仍不减，方属于表，太阳条中已悉，故此不赘。（三六）下利清穀，不可攻表，汗出必胀满。〔原文〕此条重举下利清谷，不可攻表以示戒，正互明上条，所以必先温里，然后攻表之义也，见误攻其汗，则阳出而阴气弥塞，胸腹必至胀满而酿变耳。（三七）伤寒下利日十余行，脉反实者死。〔原文〕实为邪盛，邪盛必正脱也。（三八）下利有微热而渴，脉弱者令自愈，下利脉数而渴者令自愈，设不差，必清脓血，以有热故也，下利脉数，有微热，汗出令自愈，设复紧为未解。〔原文〕微热而渴，证已转阳，然正恐阳邪未尽也，若脉弱则阳邪已退可知，故不治自愈，脉数与微热互意，汗出与脉弱互意，脉紧则不弱矣，邪方炽盛，其不能得汗，又可知矣。（三九）下利寸脉反浮数，尺中自濇者，必圉脓血。〔原文〕清濇同义，脉见浮数，若是邪还于表，则尺脉自和，今尺中自濇，乃热邪搏结于阴分，虽寸口得阳脉，究竟阴邪必走下窍，而便脓血也。（四十）下利脉沉弦者，下重也，脉大者为未止，脉微弱数者，为欲自止，虽发热不死。〔原文〕下利而脉沉弦，主里意后重，成滞下之证，即所称痢证也，脉大者，即沉弦中之大，脉微弱数者，即沉弦中之微弱数也，脉微弱数，虽发热不死，则脉大身热者，其死可知矣。（四一）热利下重者，白头翁汤主之。〔原文〕热利下重，互上文，即伤寒转利之谓也。（四二）下利欲饮水者，以有热故也，白头翁汤主之。〔原文〕此从上条另申一义，见凡下利欲饮水者，与藏寒利而不渴自殊，乃热邪内耗津液，纵未显下重之候，亦当以前汤胜其热矣。（四三）下利谵语，以有躁屎也，宜小承气汤。〔原文〕此与阳明经谵语，胃中有躁屎正同，乃不用大承气，而用小承气者，以下利肠虚，兼之厥阴藏寒，所以但用小承气，微攻其胃，全无大下之条耳。（四四）下利后更烦，按之心下濡者，为虚烦也，宜栀子豉汤。〔原文〕已下利而更烦，似乎邪未尽解，然心下濡而不满则为虚烦，与阳明误下，胃虚膈热之证颇同，故俱用涌法也。（四五）呕而发热者，小柴胡汤主之。〔原文〕厥阴之邪上逆，而兼发热，乃肝胆藏府相连之证也，故用小柴胡汤，分解其阴藏阳府之呕热也。（四六）呕而脉弱，小便复利，身有微热，见厥者难治，四逆汤主之。〔原文〕呕而脉弱，小便利，里虚且寒，身有微热，证兼表里，其人见厥则阴阳互错，故为难治，然不难于外热，而难于内寒也，内寒则阳微阴盛，天日易霾，故当用四逆汤以回阳，而微热在所不计也，况干姜配附子，补中有发，微热得之自除耶。（四七）干呕吐涎沫者，吴茱萸汤主之，呕家有痈脓者，不可治呕，脓尽，自愈。〔原文〕厥阴之邪上逆，而干呕吐涎沫，可用吴茱萸汤以下其逆气，若阴邪上逆，结而为痈，溃出脓血，即不可复治其呕，正恐人误以吴茱萸汤治之耳，识此意者，用辛凉以开提其脓，亦何不可耶。按厥阴篇中，次第不一，有纯阳无阴之证，有纯阴无阳之证，有阴阳差多差少之证，有阳进欲愈，阴进未愈之证，有阴居八九，阳居一二之证，厥而发热，热深厥深，上攻而成喉痹，下攻而便脓血，此纯阳无阴之证也，脉微细欲绝，厥冷，灸之不温

， 恕寒大汗大利，躁不得卧，与夫冷结关元，此纯阴无阳之证也，厥三日，热亦三日，厥五日，热亦五日，手足厥冷，而邪热在胸，水热在胃，此阴阳差多差少之证也，渴欲饮水，饥欲得食，脉滑而数，手足自温，此阳进欲愈之证也，默默不欲食，寸脉虽浮数，尺脉自濡，呕吐涎沫，腹胀身疼，此阴进未愈之证也，下利清谷，里塞外热，呕而脉弱，小便复利，本自寒下，复误吐下，脉沉微厥，面反戴阳，此阳居八九，阴居一二之证也，大率阳脉阳证，当取用三阳经治法，阴脉阴证，当合用少阴经治法，厥阴病见阳为易愈，见阴为难痊，其表里错杂不分，又必先温其里，后攻其表，设见咽喉不利，欬唾脓血则温法不可用，仍宜先解其表矣，世医遇厥阴诸证，加涉大洋，茫无边际可测，是以动手即错，兹不厌烦复，阐其要旨，俾后学奉为指南云。再按厥阴经，原无下法，首条即先示戒云，下之利不止矣，盖厥阴多至下利，下利中复有死证，金匱云，五藏气绝于内，则下利不禁，此所以政戒不可下耶，中间虽有用小承气一法，因胃有躁屎，微攻其胃，非攻其肠也，虽有厥应下之一语，乃对发汗而言，谓厥阴内解其热，不应外发其汗耳，岂可泥应下二字，遂犯厥阴之大戒耶，自晋迄今，伤寒失传，遇阳明二三日内当下之证，及少阴二三日急下之证，总不能下，至厥阴六七日，不当下之时，反行下之，在热深厥深之阳证，下之已迟，万一侥幸，不过为焦头烂额之客，在亡血藏虚之人，下之百无一生矣，几千年来，孰任杀人之辜耶。

过经不解〔法四条附三阴经后〕

过经不解者，由七八日已后，至十三日已后，病过一候二候，犹不痊解也，然邪在身中日久，势必结聚于三阳，太阳为多，少阳次之，阳明又次之，及至三阴，则生死反掌，不若此之久持矣。辨〔原缺九字〕、阳用大小柴胡两解一法。（一）太阴病，过经十余日，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡汤，呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也，与大柴胡汤下之则愈。〔原文〕过经十余日，而不知太阳证有未罢，反二三下之，因而致变者多矣，后四五日，柴胡证仍，在未有他变，本当行大柴胡，两解表里，但其人之邪，屡因误下而深入，即非大柴胡下法所能服，故必先用小柴胡，提其邪出半表，然后乃用大柴胡，始合法也。〔辨遇经不解心下欲吐微烦微满用药宜审一法〕（二）太阳病，过经十余日，心下温温欲吐，而胸中痛，大便反溏，腹微满，郁郁微烦，先此时自极吐下者，与调胃承气汤，若不尔者，不可与，但欲呕，胸中痛微溏者，此非柴胡证，以呕故知极吐下也。

〔原文〕此条批注不得仲景叮咛之意，兹特明之，太阳病，过经十余日，心下温温欲吐而不吐，其人胸中痛，大便反溏，腹微满，郁郁微烦者，此有二辨，若曾经大吐大下者，邪从吐解，且已入里，可用调胃承气之法，若未极吐下，但欲呕不呕，胸中痛，微溏者，是痛非吐所伤，溏非下所致，调胃之法，不可用矣，岂但调胃不可用，即柴胡亦不可用，以邪尚在太阳高位，徒治阳明少阳而邪不服耳，解太阳之邪，仲景言之已悉，故此但示其意也，若其人能呕，则是为吐下所伤，而所主又不在太阳矣。〔过经证属可下误用圆药增利辨内实内虚二法〕（三）伤寒十三日，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利，此本柴胡证，下之而不得利，今反利者，知

医以圆药下之，非其治也，潮热者实也，先宜小柴胡以解外，后以柴胡加芒硝汤主之。〔原文〕胸胁满而呕，邪在少阳表里之间也，发潮热，里可攻也，微下利，便未鞭也，以大柴胡分解表邪，荡涤里热，则邪去而微利亦自止矣，若误用圆药，则徒引热邪内陷，而下利，表里俱不解也，故先用小柴胡分提以解外邪，后加芒硝以涤胃中之热也。（四）伤寒十三日不解，过经讞语者，以有热也，当以汤下之，若小便利者，大便当鞭，而反下利，脉调和者，知医以圆药下之，非其治也，若自下利者，脉当微厥，反和者，此为内实也，调胃承气汤主之。〔原文〕二条俱见微利之证，难辨其内虚内实，上条胸胁满而呕，邪凑少阳之表，故欲下之，必用柴胡汤为合法，若以他药下之，表邪内入，即是内虚，此条原无表证，虽圆药误下，其脉仍和，即为内实也。按仲景下法，屡以用圆药为戒，太阳之脾约，乃用麻仁圆，因其人平素津枯肠结，必俟邪入阳明，下之恐无救于津液，故虽邪在太阳，即用圆药之缓，下润其肠，俾外邪不因峻攻而内陷，乃批却导窍游刃空虚之妙也，此等处亦须互察。再按伤寒证，以七日为一候，其有二候三候不解者，病邪多在三阳经留恋，不但七日传之不尽，即十日十三日二十余日，尚有传之不尽者，若不辩证，徒屈指数经数候，汗下展转差误，正虚邪凑，愈久愈难为力，与内经至七日，太阳病衰，头痛少愈，八日阳明病衰，身热少歇，九日少阳病衰，耳聋微闻，十日太阴病衰，腹减加故，则思饮食，十一日少阴病衰，渴止舌润而嚏，十二日厥阴病衰，囊纵少腹微下，大气皆去，病人精神爽慧之恒期迥异矣，所以过经不解，当辨其邪在何经而取之，仲景云，太阴病头痛，至七日以上自愈者，以行其经尽故也，即内经七日太阳病衰，头痛少愈之旨也，可见太阳一经，有行之七日以上者矣，其欲作再经者针足阳明，使经不传则愈，以太阳既羁留多日，则阳明少阳，亦可羁留，过经漫无解期矣，所以早从阳明中土而夺之，使其不传，此捷法也，若谓六经传尽，复传太阳，必无是理，后人堕落成无且阱中耳，岂有厥少两阴交尽于里，复从皮毛外，再入太阳之事耶，请破此大惑。

差后劳复阴阳易病〔附三阴经后〕

（一）大病差后，劳复者，枳实栀子鼓汤主之，若有宿食者，加大黄如博棋子大五六枚。〔原文〕劳复者，乃起居作劳，复生余热之病，方注作女劳复大谬，女劳复者，自犯伤寒后之大戒，多死少生，岂有反用上涌下泄之理耶，太阳中篇，下后身热，或汗吐下后，虚烦无奈，用本汤之苦，以吐彻其邪，此非取吐法也，乃用苦以发其微汗，正内经火淫所胜，以苦发之之义，观方中用清浆水七升，空煮至四升，然后入药同煮，全是欲其水之热而趋下，不致上涌耳，所以又云覆令微似汗，精绝。（二）伤寒差已后，更发热者，小柴胡汤主之，脉浮者以汗解之，脉沉实者以下解之。〔原文〕差已后更发热，乃余热在内，以热召热也，然余热要当辨其何在，不可泛然施治，以虚其虚，如在半表半里，仍用小柴胡汤和解之法，如在表，则仍用汗法，如在里，则仍用下法，然汗下之法，即互上条汗用枳实栀子，微汗下用枳实栀子，加大黄微下也。（三）大病差后，从腰已下有水气者，牡蛎泽泻散主之。

〔原文〕腰以下有水气者，水渍为肿也，金匱曰，腰以下肿，当利小便，此定法矣

，乃大病后，脾土告困，不能摄水以致水气泛滥，用牡蛎泽泻散峻攻，何反不顾其虚耶，正因水势未犯身半以上，急驱其水，所全甚大，设用轻剂，则阴水必袭入阳界，驱之无及，城不没者三版，亦云幸矣，可见活人之专，迂疏辈必不能动中机宜，庸工遇大病后，悉行温补，自以为善，孰知其为鹵莽灭裂哉。（四）大病差后，喜唾久不了了者，胃上有寒，当以圆药温之，宜理中圆。〔原文〕身中津液，因冒寒凝结而成浊唾，久而不清，其人必消瘦索泽，故不用汤药荡涤，而用圆药缓图也，理中圆，乃区分阴阳，温补脾胃之善药，然仲景差后病，外邪已尽，纔用其方，在太阳邪炽之日，不得已合桂枝用之，即更其名曰桂枝人参汤，又云医以理中与之，利益甚，理中者理中焦，此利在下焦，非其治也，于此见用法之权衡矣。（五）伤寒解后，虚羸少气，气逆欲吐者，竹叶石膏汤主之。〔原文〕身中津液，为热邪所耗，余热不清，必致虚羸少气，难于康复，若更气逆欲吐，是余邪复挟津液滋扰故，用竹叶石膏汤，以益虚清热散逆气也。（六）病人脉已解，而日暮微烦，以病新差，人强与谷，脾胃气尚弱不能消谷，故令微烦，损谷则愈。〔原文〕脉已解者，阴阳和适，其无表里之邪可知也，日暮微烦者，日中卫气行阳，其不烦可知也，乃因脾胃气弱，不能消谷所致，损谷则脾胃渐趋于旺而自愈矣，注家牵扯日暮为阳明之王时，故以损谷为当小下，不知此论差后之证，非论六经转阳明之证也，日暮即内经日西而阳气已衰之意，所以不能消谷也，损谷当是减损谷食，以休养脾胃，不可引前条宿食例，轻用大黄重伤脾胃也。合六条观之，差后病，凡用汗下和温之法，但师其意，不泥其方，恐元气精津久耗，不能胜药耳，岂但不能胜药，抑且不能胜穀，故损谷则病愈，而用药当思减损，并可识矣，其腰已下有水气，峻攻其水，亦以病后体虚，膀胱气化不行，若不一朝迅扫，则久困之脾土，必不能堤防水逆，不至滔天不止，所以仲景云，少阴负趺阳者为顺，故急夺少阴之水，以解趺阳之围，夫岂寻常所能测识耶。（一）伤寒阴阳易之为病，其人身体重，少气，少腹理急，或引阴中拘挛，热上冲胸，头重不欲举，眼中生花，膝胫拘急者，烧裨散主之。〔原文〕阴阳易之病，注家不明言，乃致后人指为女劳复大谬，若然，则妇人病新差，与男子交，为男劳复乎，盖病伤寒之人，热毒藏于气血中者，渐从表里解散，惟热毒藏于精髓之中者，无繇发泄，故差后与不病之体交接，男病传不病之女，女病传不病之男，所以名为阴阳易，即交易之义也，其证眼中生花，身重拘急，少腹痛引阴筋，暴受阴毒，又非姜桂附子辛热所能驱，故烧裨裆为散，以其人平昔所出之败浊，同气相求，服之小便得利，阴头微肿，阴毒即从阴窍出耳。此条叔和汇于差后劳复之前，因起后人女劳复之疑，今移附劳复后，益见热病之为大病，差后贻毒他人，其恶而可畏，有如此也。尚论张仲景伤寒论凡八卷，前四卷详论六经证治，已尽伤寒之义矣，后四卷推广春月温病，夏秋暑湿热病，以及脉法诸方，聊与二三及门扬确千古，稿藏笥中，欲俟百年身尽名灭，然后梓行，以其刻意求明，今天下业医之子，从前师说，漫无着落，必反嫉为欺世盗名耳，不谓四方来学日众，手编不便抄录，姑将前四卷授梓，求正大方，傥坊间购刻全本，人书具在，宁致贻憾于续貂乎。

庚寅初夏喻昌识

尚论后篇

卷一

尚论春三月温证大意

仲景书详于治伤寒，略于治温，以法度俱错出于治伤寒中耳，后人未解义例，故春温一证，漫无成法可师，而况触胃寒邪之病少，感发温气之病多，寒病之伤人什之三，温病之伤人什之七，古今缺典，莫此为大，昌特会内经之旨，以畅发仲景不宜之奥，然僭窃无似矣，厥旨维何，内经云，冬伤于寒，春必病温，此一大例也，又云冬不藏精，春必病温，此一大例也，既冬伤于寒，又冬不藏精，至春月同时病发，此一大例也，举此三例，以论温证，而详其治，然后与三阳三阴之例，先后同符，盖冬伤于寒，邪藏肌肤，即邪中三阳之谓也，冬不藏精，邪入阴脏，即邪中三阴之谓也，阳分之邪浅而易疗，阴分之邪深而难愈，所以病温之人，有发表三五次，而外证不除者，攻里三五次，而内证不除者，源远流长，少减复剧，以为在表也，又似在里，以为在里也，又似在表，用温热则阴立亡，用寒凉则阳随绝，凡伤寒之种种危候，温证皆得有之，亦以正虚邪盛，不能胜其任耳，至于热证，尤为十中八九，缘真阴为热邪久耗，无以制亢阳，而燎原不熄也，以故病温之人，邪退而阴气犹存一线者，方可得生，然多骨瘦皮干，泽枯肉烁，经年善调，始复未病之体，实缘医者于此一证，茫然不识病之所在，用药不当，邪无从解，留连展转，莫必其命，昌之目击心伤者久之，兹特出手眼，以印正先人之法则，祈以永登斯人于寿域，后有作者，谅必不以为狂诞也。

温证上篇

谨将冬伤于寒春必病温定为一大例冬伤于寒，藏于肌肤，感春月之温气而始发，肌肤者，阳明胃经之所主也，阳明经中久郁之热，一旦发出，而外达于太阳，有略恶寒而即发热者，有大热而全不恶寒者，有表未除而里已先实者，有邪久住太阳一经者，有从阳明而外达于太阳者，有从太阳复传阳明，不传他经者，有自三阴传入胃腑者，有从太阳循经传三阴，如冬月伤寒之例者，大率太阳阳明二经，是邪所蟠据之地，在太阳则寒伤营之证，十不一见，在阳番明则谵语发斑，衄血畜血，发黄脾约等热证，每每兼见，而凡发表不远热之法，适以增温病之困阨耳，况于治太阳经之证，其法度不与冬月相同，盖春月风伤卫之证或有之，而寒伤营之证则无矣，且由阳明而达太阳者多，不尽由太阳而阳明少阳也，似此则温证之分经用法，比之伤寒大有不同，而世方屈指云某日某经，某日传经已尽，究竟于受病之经，不能摸索以求良治，所谓一盲而引众盲，相将入火坑也，冤哉生命，古今诚莫控制矣。按温热病，亦有先见表证，而后传里者，温热自内达外，热郁腠理，不得外泄，遂复还里，而成可攻之证，非如伤寒从表而始也，盖伤寒从表而始，故误攻而生变者多温证，未必从表始，故攻之亦不为大变，然郁热必从外泄为易，误攻而引邪深入，终非法也。按温热病表证间见，而里病为多，故少有不渴者，法当以治里为主，而解肌兼之，亦有治里而表自解者，其间有误攻里而致害者，乃春夏暴寒所中之疫证，

邪纯在表，未入于里故也，不可与温热病同论。

（一）太阳病发热而渴，不恶寒者为温病。〔原文〕 昌按温者，春令之气也，冬夏秋虽有气温之日，不加春令之正且久也，不恶寒三字内有奥义，盖时令至春，则为厥阴风木主事，而与太阳之寒水，不相涉矣，故经虽从太阳，而证则从春令而不恶寒也。再按温病，或有新中风寒者，或有表气虚不禁风寒者，卫虚则恶风，营虚则恶寒，又不可因是遂指为非温病也，然即有之，亦必微而不甚，除太阳一经，则必无之矣。

（二）形作〔似也〕伤寒，其脉不弦紧而弱，〔非伤寒矣〕，弱者必渴，被火者必谵语，弱者发热，〔所以渴也〕，脉浮解之，当汗出愈。〔原文〕 风性弱缓，故脉亦弱，弱者发热，即内经诸弱发热之义也，脉既浮，当以汗解之，使汗出而愈，取解肌不取发汗之意。按温热病，原无风伤卫寒伤营之例，原无取于桂枝麻黄二方也，表药中，即败毒散参苏饮等方，亦止可用于春气未热之时，若过时而发之，温病暑病，尚嫌药性之带温，况于桂麻之辛热乎，然仲景不言桂麻为不可用者，有二说焉，一者以剔出桂麻，则三阴绝无表药也，一者以桂麻用之不当，在冬月已屡致戒，春月更无可赘也，后之纷纷訾议桂麻之热者，未尝计及于冬不藏精之治耳，惟知春夏有不得不用也，谁知仲景立方之神哉。

（三）脉浮热甚，反灸之，此为实，实以虚治，因火而动，必咽躁吐血。〔原文〕 脉浮热甚，邪气胜也，邪气胜则实，反灸之，是实以虚治也，血随火灸，而妄逆在所必至矣，咽躁者火势上逼，枯涸之应耳，若是少阴见证，当不止此一端，故不入冬不藏精一例。

（四）病加桂枝证，〔似乎中风〕，头不痛，项不强，〔则太阳无外入之邪，而非中风〕，寸脉微浮，〔则邪自内出而不当过表〕，胸中痞鞭，〔痰涎塞隔〕，气上冲，咽喉不得息者，胸中有塞也，当吐之，宜瓜蒂散，病人有寒复发汗者，胃中冷必吐蚘。〔原文〕

昌按仲景不曰病似中风证，而曰病加桂枝证者，恐后人误以治温一例，混入太阳中风之例而滋扰，故更换其名也，吐法多用枳实汤，此用瓜蒂散者，取其吐顽痰而快膈，涌风涎而逐水也，有痰而误发汗，徒亡津液，胃中容虚，蚘失所养，故悖逆而上出也。

（五）病人手足厥冷，〔似涉厥阴〕，脉乍紧者，邪结在胸中，〔非厥阴也〕，心中满而烦，饥不能食者，病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散。〔原文〕

按此证乃痰邪自内而作，即四证类伤寒之疟证者也，仲景云，病人身大热，反欲得近衣者，热在皮肤，寒在骨髓也，〔表实里虚〕，身大寒，反不欲近衣者，寒在皮

肤，热在骨髓也，〔畏虚里实〕，此以互合之表里言，设合脏腑而统言之，则皆谓之表矣。

（六）病在阳，〔表未罢热未除〕，应以汗解之，反以冷水噀之，其热被却不得去，弥更益烦，肉上粟起，意欲饮水反不渴者，〔热邪为水寒所制〕，服文蛤散，〔咸寒利水〕，若不瘥者，与五苓散。寒实结胸，无热证者，〔两寒相搏〕，与三物小陷胸汤。白散亦可服。〔寒结重者，原文〕

按病在阳，则不兼阴可知，正合第一例也。

（七）病人脏无他病，〔里气和也〕，时发热，〔或然或不然〕，自汗出而不愈者，此胃气不和也，先其时，〔未发热之时〕，发汗则愈，宜桂枝汤主之。〔原文〕

（八）病常自汗出，〔无时不然〕，此为营气和，营气和者，外不谐，以卫气，不共营气，和谐故尔，以营行脉中，卫行脉外，复发其汗，营卫和则愈，宜桂枝汤。〔原文〕

按脏无他病，但卫气不和，亦阳病而阴不病之例也。再按春温之证，由肌肉而外达于皮肤，则太阳膀胱经之邪，传自阳明胃经，与冬月外受之风寒，始先便中太阳而伤其营卫者，迥乎不同，故此但言卫气，不与营和，其无太过可知也，既卫不与营和，当用麻黄，乃但用杜枝者，可见温证中发汗之法，皆用解肌，盖久郁之邪，一解肌则自散，若大汗而重伤伤津液，反变起矣，此先圣用法之大关也。

（九）病人脉数，数为热，当消谷引食，而反吐者，此以发汗令阳气微，膈气虚，脉乃数也，数为客热，不能消穀，以胃中虚冷，故吐也。〔原文〕昌按发汗而令阳微，误之甚也，阳微则胃中虚冷，而脉反数者，不过客热之微，温其胃而客热不留，斯脉不数矣。再按此但言胃中之阳微，与不藏精之真阳微弱者不同。

（十）病人烦热，〔太阳也〕，汗出则解，又如疟状，日晡所发热者，属阳明也，脉实者，〔阳明〕，宜下之，脉浮虚者，〔太阳〕宜发汗，下之，宜承气汤，若汗之宜桂枝汤。〔原文〕

（一一）微数之脉，慎不可灸，因火为邪，则为烦逆，追虚逐实，血散脉中，火气虽微，内攻有力，焦骨伤筋，血难复也。〔原文〕

昌按此一条垂戒，虽在温证项下，然不显为温证而设，所以不言证而但言脉也，脉见微数，则是阴虚而阳炽，重以火力追逐其血，有筋骨焦伤已耳，今世之灼艾者，不识亦辨脉之微数否耶，其为阴虚火胜之人，漫用灸法者何耶。

（一二）病人耳聋无闻者，以重发汗虚故也。〔原文〕

此与伤寒耳聋，为少阳邪盛者迥异，益见温证禁过汗也。

（一三）病人不大便，五六日绕脐痛烦躁发作有时者，此有躁屎，故使大便鞭也。〔原文〕

（一四）病人小便不利，大便乍难乍易，时有微热喘冒不能卧者，有躁屎也，宜大承气汤。〔原文〕

（一五）大下后六七日不大便，烦不解，腹满痛者，此有躁屎也，宜大承气汤。〔原文〕

昌按仲景治温证，凡用表法，皆用桂枝汤，以示微发于不发之意也，凡用下法，皆用大承气汤，以示急下无所疑之意也，不知者鲜不以为表在所轻，而里在所重，殊大不然，盖表里无可轩轻，所以然者，祇虑热邪久据阳明，胃中津液先伤，故当汗而惟恐过于汗，反重伤其津液，当下而惟恐不急于下，以亟存其津液也。

（一六）本发汗而复下之，此为逆也，若先发汗，治不为逆，本先下之而反汗之，此为逆也，若先下之，治不为逆。〔原文〕

观此则温证此伤寒太阳经之变证为差减，而汗下之次第，亦为不同矣。

（一七）凡病若发汗，若吐若下，若亡津液，阴阳和者，必自愈。〔原文〕

观此则病温之人，素无内伤，及不藏精之类者，为易愈也。春温上篇诸方〔伤寒论共二百九十七法，前四卷已我明三百六十七法，兹篇得三法〕

解肌法桂枝汤、桂枝加葛根汤、升麻葛根汤、葛根柴胡汤、葛根葱白汤、葛根黄连黄芩汤、〔附方〕人参败毒散、参苏饮、海藏大羌活汤。解肌后，病不去，反恶寒者，虚也。芍药甘草附子汤〔脉细身倦者方可服〕。解肌后，身疼痛脉沉者。桂枝加芍药人参新加汤。解肌后，汗出过多，心下悸欲得按者。桂枝甘草汤。脐下悸，欲作奔豚者。茯苓桂枝甘草大枣汤。解肌后，烦渴脉洪大。白虎加人参汤。解肌后，腹胀满。厚朴生姜人参汤。解肌后，不恶寒，但恶热者。调胃承气汤。解肌后，恶热无下证。知母石膏汤。解肌后，脉微数，小便不利微热烦渴。五苓散。解肌后，胃干，烦不得眠，欲饮水，少少与之。

吐法瓜蒂散、梔豉汤〔伤寒内着有颡论〕。清热诸方白虎汤、白虎加人参汤、白虎加苍朮汤、白虎加桂枝汤、玄参升麻汤、升麻梔子汤、竹叶石膏汤、竹叶汤。和解

诸方小柴胡汤、小柴胡加桂枝汤、小柴胡去半夏加人参瓜蒌汤、小柴胡去人参加五味子汤、小柴胡加芒硝汤。疏风诸方荆芥散、独活汤、金匱风引汤、续命汤减麻黄附子。分利诸方五苓散〔脉浮而大是表，其人发渴小便赤，却当下，用此。〕、猪苓汤〔汗多者不可与阳明，脉浮发热，渴欲饮水，小便不利者与之〕、天水散、辰砂天水散〔分利兼清镇〕、牡蛎泽泻散〔治腰以下有水气〕。开结诸方三物小陷胸汤、三物白散。

下法大承气汤、调胃承气汤、大柴胡汤〔脉浮大是表，其人心下痞却当下，若烦渴燥热，小便赤色，嘔不止，心下微烦者，俱常两解〕。下后，脉促胸满。桂枝去芍药汤。若微寒。去芍药加附子汤。误以丸药下之，身热不去，微烦。栀子干姜汤〔三汤取其温以散表〕。下后，利不止，脉促，表未解，喘而汗出者。葛根黄连黄芩汤〔取其凉以解表〕。下后，身热不去，心中结痛，未欲解者。栀子厚朴汤〔取其吐以散邪〕。下后，心中懊恼而烦，有躁屎者。大承气汤〔取其仍从下解〕。下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，下利脉不至，咽喉不利，吐脓血，泻利不止，为难治。麻黄升麻汤〔取解错杂之邪〕。下后，伤血脉涩。葶苈苦酒汤，〔取其壮阴大汗，使阳气微又大下，使阴气弱，其人亡血病恶寒后，乃发热无休止时，阴阳既虚气血俱弱，故其热不可止息。〕、葶苈栀子汤〔二方取其酸苦涌滑以助阴〕。解毒诸方黄连解毒汤、黄连汤、黄连阿胶汤、黄连泻心汤、黄连龙骨汤、黄芩犀角汤、黄连橘皮汤、黑膏。养血生津酸枣仁汤、芍药甘草汤、阿胶散、大青龙汤、炙甘草汤、五味子汤。补中黄耆建中汤、小建中汤、理中汤、温中汤、治中汤。凉血滋阴犀角地黄汤。搐鼻出水瓜蒂散。刺鼻出血干粟干箬叶。

温证中篇

谨将冬不藏精春必病温分为一大例人身至冬月，阳气潜藏于至阴之中，内经教人于此时若伏若匿，若已有得，重藏精也，苦伏者，若抱雏养蛰，不遑食息也，苦匿者，若逋逃隐避，不露踪迹也，苦已有得者，韬光铲采，绝无缺望也，此何如郑重耶，故谓冬不藏精，春必病温，见病所由来，为一定之理，必然之事，其辞甚决，盖以精动，则关开而气泄，冬月关开气泄，则寒风得入之矣，关屡开，气屡泄，则寒风屡入之矣，而肾主闭藏者，因是认贼作子，而贼亦无门可出，弥甚相安，及至春月，地气上升，肝木用事，肝主疏泄，木主风，加是吸引肾邪，勃勃内动，而劫其家宝矣，然邪入既深，不能遽出，但觉愤愤无奈，其发热也，全在骨髓之间，自觉极热，而扪之反不烙手，任行表散，汗出而邪不出，徒伤津液，以取危困，其候比之冬伤于寒一例，则倍重矣。按冬不藏精之例，乃内经之例，非仲景之例也，非仲景之例，言之未免为悖，然观仲景之论温证第一条，始不胜庆幸，而仲景已起发其端，昌可言之无罪矣，其曰发汗已，身灼热者，名曰风温，风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重多眠睡，鼻息必鼾，语言难出，若被下者，小便不利，直视失溲，若被火者，微发黄色，剧如惊痫状，时瘈瘲，若火熏之，一逆尚引日，再逆促命期

，此一段至理，千古若明若昧，未经剖晰，全不思既名温病，即是时行外感，何又汗之下之火之，俱为逆耶，盖热邪久蓄少阴肾中，精水既为素伤，重加汗下火劫阴之法，乃为逆耳，其自汗出身重多眠睡，鼻息鼾，语言难者，一一皆少阴之本证也，膀胱为肾之府，故少阴证具，若被下则膀胱之阴亦伤，而直视失溲者，肾精不上荣，肾气欲外夺也，若被火劫，则阴愈亏而邪愈无制，甚则如惊⁸²⁵⁹状，而时为瘈瘲也，一逆再逆，言汗下火之误，可一不可二，非汗而又下，而又汗之为再误也，由此观之，冬不藏精之温证，显然昭著矣，昌之比例以分其治，而仲景之道愈明矣，奚罪耶。再按仲景之论误下，有结胸及痞挟热⁸²⁵⁹脏寒不禁等证，从未说到小便不利，直视失溲，于此言之者，谓肾以膀胱为府，素不藏精之人，误下则膀胱益亏，以故小便不利，直视失溲，其变亦倍重于膀胱也，况于风邪内炽，津液干燥，大便虽通之未必通，徒令膀胱受累，而小便自遗，试观好色之人，多成癃淋，可类推矣，今之医者，亦讲于误下而绝膀胱之化源，立取危困之理耶。再按发汗已身灼热者，名曰风温，此语将冬不藏精之温证，形容殆尽，盖凡外感之邪，发汗已，则身热自退，乃风温之证，发汗已，身始灼热者，明明是先热在骨髓，发汗已，然后透出肌表也，至于风温二字，取义更微，与内经劳风之义颇同，劳风者，劳其肾而生风也，然则冬不藏精之人，诎非劳其肾而风先内炽欤，故纔一发汗，即带出自汗，身重多眠，鼻鼾语难，诸多肾经之证，设不发，则诸证尚隐伏，不尽透出也，夫肾中之风邪内炽，而以外感汗下，及火攻之法治之，宁不促其亡耶，后人不知风温为何病，反谓温证之外，更有风温湿温温毒温疫四证，观其言曰，重感于风，变为风温，则是外受之邪，与身重鼻鼾多眠少语之故，绝不相涉，可知是梦中说梦也，尚论及此，聊以自慊耳，客有难昌者曰，内经论冬伤于寒，寒毒藏于肌肤，感春月之温气始发，故名曰温病，未尝言寒毒感藏于骨髓，今谓冬不藏精者，寒邪藏于骨髓，或未尽然耶，昌应之曰，此正内经之言，非余之臆说也，黄帝问温症，舍于何脏，岐伯曰，温症得之冬中于风，寒气藏于骨髓之中，至春则阳气大发，邪气不能自出，因遇大暑，骨髓烁，肌肉消，腠理发泄，或有所用力，邪气与汗皆出，此病藏于肾，其气先从内出之于外也，如是者阴虚而阳盛则热矣，衰则邪气复反入，入则阳虚，虚则寒矣，故先热而后寒，名曰温症，由是观之，温症且然，而况于温病乎，客始唯唯。昌按热邪久伏肾中，其证与第一例自不相同，其发热也，皆从骨内郁蒸而出，皮间未热，而耳翰上下，已先热矣，始发之时，多兼微寒，不似第一例之全不恶寒，以少阴居北方寒水之位也，及至大热灼肌，多不恶渴，不似第一例之大渴，以热邪初动，而阴精尚足持之也，其后则不恶寒而恶渴，与第一例之证，浑无别矣，然虽无别，究竟表里不同，标本互异，始先用药深入肾中，领邪外出，则重者轻，而轻者即愈矣，奈何其义隐而不彰，即以叔和之明，未尝抽引其绪，为后人旁通一线，昌何人斯，顾敢恣谭无忌，然而远器三十余载，驱逐睡魔，昼夜不敢倒身，因是冥悟一班，即取仲景少阴伤寒之例，推演为治温之例，未尝以己意混入一字也，引例如左。

（一）少阴病始得之反发热脉者，麻黄附子细辛汤主之。〔原文〕

昌按脉沉，病在里也，而表反发热，则邪虽在表，而其根源实在里，在里之邪，欲其尽透于表，则非颞经之药不可故，取附子细辛以匡麻黄，为温经散邪，千古不易之正法，奈何后人全不知用，明明见脉沉身重，嗜卧倦语之证，即知为风温，又知为冬不藏精，尚且漫用三阳经之表药屡表不应，十中不能活一，复诿之伤寒偏死肾虚人，是则是矣，但不知果行温经散邪，而人死耶，抑未行温经散邪，而人死也噫，业伤寒者之托颞门，真是操刀之凶人，宁但为茺兰之童子已哉。

（二）少阴病，得之二三日，麻黄附子甘草汤微发汗，以二三日无里证，故微发汗也。〔原文〕

昌按麻黄主散邪，附子主温经，二者，皆大力之药也，前证发热脉沉，则表里俱急，惟恐二物不胜其任，更加细辛之辛温，取其为少阴引经之药，而又有辛散之能，以协赞二物，共建奇功也，云无里证，非是并脉沉嗜卧等证俱无也，但无吐利躁烦呕渴之证耳，似此则表里俱不见其急，而麻黄附子二物，尚恐其力之太过，故不用细辛以助之，而反用甘草以和之也，谨并制方之意，呕心相告，凡治冬不藏精之温证，始发二三日间，请决择于斯二方焉。

（三）病发热头疼，脉反沉，若不瘥，身体疼痛，当救其里，宜四逆汤。〔原文〕

昌按此一段文义，可得仲景治冬不藏精之奥旨，病发热头疼，证见于表矣，而脉反沉，则病又在里矣，两有可疑也，既发热头疼，势必先治其表，若不瘥，则治表无益矣，凡治表者皆治其阳也，阴病治阳，岂惟无益，将见阴中之真阳，因之外越，而身体反加疼痛，一团阴寒用事矣，此所以当用四逆汤，而急回其在经之阳也。再按若不瘥三字甚活，盖发热头疼，表之原不为误，但一切三阳经表药，俱不对证，惟麻黄附子细辛汤，与麻黄附子甘草汤二方，始为少阴经对证之表药，而又不肯必人之能用，所以不说误表，而但说若不瘥，正见表药中原有瘥法也。

（四）少阴病，脉沉细而数，其病在里，不可发狂。〔原文〕

按脉细而数，里热也，发汗则虚其表，且亡其津液，内热愈炽。

（五）少阴病脉微，不可发汗，亡阳故也，阳已虚，尺脉弱涩者，复不可下之。〔原文〕

昌按前段云，脉沉细数则为热，此云脉微则为虚，热而发汗，则阴易亡，虚而发汗，则阳易亡，故两戒之也，然则脉不微数者，一概禁汗，不为惩噎废食耶，况于不藏精之证，邪发之初，未必即见微数之脉，惟可用麻黄附子二方，而不知用，驯至脉微且数，则汗下温三法，皆不可行，而阴绝阳离，有立而待毙耳。

（六）少阴病，欬而下利，譫语者被火气劫故也，小便必难，以强责少阴汗也。〔原文〕

昌按少阴少血，强责其汗，是劫夺其血也，小便难者，源先竭也。再按少阴病，强汗则小便必难，误下则小便不利，直视失溲，可见肾以膀胱为府，脏病而府未有不病，脏伤则府先告绝也，伤寒证中云，直视譫语，循衣撮空，小便利者，其人可治，则是少阴之脏气，绝与不绝，全于小便之利与不利，窥其中藏，孰谓冽彼之下泉，非回枯泽槁之善物哉。

（七）少阴病，脉紧，至七八日，自下利，脉暴微，手足反温，脉紧反去者，为欲解也，虽烦下利，必自愈。〔原文〕

昌按邪在阴者，多自利，自利则邪气涌，正气而脱者多矣，其候必脉紧数，而四肢逆冷，今脉紧去而但微，则阴邪已散，手足温，则真阳未伤，虽有心烦下利之危意，而可直决为必愈，盖阴阳不相乖乱，则别无死法也，然非肾气素旺，受邪原轻者，不易得之数矣。再按此与邪在阳，脉数而热，得汗而脉和，身凉数去，为欲愈之意同，然阳病轻，而从汗解则易，阴病重，而从利解则难，所以仲景于阳邪内陷，下利不止之证，惟用逆流挽舟之法，挈里邪还之于表，则利不治而自止也，此段见阴邪从阴分解散，原属顺便，但少阴脏气，堪为主人送出客邪，尚恢乎有余地则善也，而不藏精者，日为床褥作主人，安望重关设险以待暴客乎。

（八）少阴病，八九日，一身手足尽热者，以热在膀胱，必便血也。〔原文〕

按膀胱为肾之府，肾邪传膀胱，则里热达表，故一身手足尽热也，太阳多血，为热所乱，则血出于二便，然比之少阴少血，误动其血，而从口鼻耳目出者，则天渊矣。再热邪虽从便血而解，经年调理，阴气难复，况既开血一窦，漫无止期，何如一身手足方热之顷，预识势所必至，而亟图之于早耶，夺膀胱热，用桂枝大黄入四苓散。

（九）少阴病，欲吐不吐，心烦但欲寐，五六日，自利而渴者，虚故引水自救，口燥舌干证具，小便色反白者，下焦虚，有寒也，勿认为热以致误。〔原文〕

此一段因仲景原文难解，昌会其意而言之也。按冬不藏精之证，此一段最肖，仲景早已欲人辨识之矣。

（十）病人脉，阴阳俱紧，反汗出者，亡〔无也〕，阳也，〔无妨以为之外护也〕，此用少阴，法当咽痛而复吐利。〔原文〕

按冬不藏精之证，此一段更肖，少阴为水脏，吐利者阴盛而水无制也。

春温中篇诸方〔兹篇得十二法〕 温经散邪一法

麻黄附子细辛汤、麻黄附子甘草汤〔二方之意前已论明〕。温经一法

附子汤。治得病一二日，口中和，背恶寒者。治身体痛，手足寒，骨节痛，脉沉者。附子温经散寒，人参补气回阳，芍药收阴，茯苓及朮，制水燠土。急温一法

四逆汤。治寒邪深入于里者。治膈上有寒饮干呕者。阴邪深入，则微阳必遭埋没，阴邪上干，则微阳必致飞腾，故宜急温，恐少迟则不及也。急温则无取于回护矣，然以甘草为君，以干姜附子为臣，正长驾远驭，俾不至于犯上无等，无回护中之回护也。通阳一法白通汤。治阴寒下利，葱白为君，干姜附子为臣，以在经之阴极盛，格拒其阳于外而不纳，故取用于葱白以通阳气，而使阴气自敛，见睨曰消之义也。白通加猪胆汁汤。治下利脉微，及厥逆无脉，干呕烦者，呼吸存亡之际，恐阳药不能直达，故加入尿猪胆汁之阴，以为向导，服汤脉暴出者死，微续者生。通脉四逆汤。治下利清谷，里虚外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面赤色，或腹痛，或干呕咽痛，或利止脉不出者，即前四逆汤，而倍干姜加葱白也。不恶寒，面色赤而外热者，加葱白以通阳气，腹中痛者，真阴不足，去葱加芍药，呕者加生姜。咽痛者，去芍药，少加桔梗。利止，脉不出者，阳气未复，去桔梗加人参。温胃一法吴茱萸汤。治吐利，手足厥冷，烦躁欲死者。桃花汤。治二三日，至四五日，腹痛，小便不利，下利不止，便脓血者。胃虚土寒，不能制水，而下焦滑脱，故用干姜粳米之辛甘，以佐赤石脂也。灼艾助阳一法一二日口中和背恶寒者，即宜服附子汤，并用灸法以助阳。吐利，手足不逆冷者，不死，脉不至者，灸少阴七壮。下利，脉微涩，呕而汗出，数更衣反少者，阳虚而气下坠，血少而勤弩责也，宜灸顶门之百会穴，以升举其阳也。温经镇水一法真武汤。治腹痛，小便不利，四肢沉重，疼痛，自下利者，或欬，或小便利，或呕者，真武北方司水之神也，阴邪炽盛，水泉泛溢，得真武，则可以镇摄而安其位也。和阴一法黄连阿胶汤。治心烦不寐者。少阴本欲寐，反心烦不寐，热甚而里不和也，芩连除热，鸡子黄阿胶少佐芍药以和血，而生不足之真阴也。急下一法大承气汤。治二三日，口燥咽干者，二三日病始发，便有肾水枯竭之象，不急下将何救耶。治自利清水，色纯青，心下痛，口干燥者，肾中之邪，搏水而变青，热之极也，心下痛者，水气上逆也，水气上逆而口反干燥，则枯涸有立至矣，故当急下。治六七日腹胀不大便者，腹胀不大便，胃实可知，水脏受病，加以土实，则水必竭，故当急下。清解一法四逆散。治四肢微逆，或欬或悸，或小便利，或腹中痛，或泄利下重者。四肢微冷，则热未深，故用柴胡解之，枳实泄之，甘草和之，而最要加芍药以收其阴也，欬者，加五味子干姜，并主下利，悸者，加桂枝，小便不利者，加茯苓，腹中痛者，加附子，泄利下重者，加薤白，煮汁煎散。分利一法

猪苓散。治下利不止，欬而呕渴，心烦，不得眠者，取其水谷分，则利自止，利止，则呕渴心烦，不待治而自愈，然不藏精，而膀胱之气不化者，又在所禁。

清咽一法 甘草汤、桔梗汤、半夏汤。治风挟痰热者，苦酒汤。治咽中生疮，话声不出者。

温证下篇

谨将冬伤于寒又兼冬不藏精春月同时病发定为一大例 昌按冬既伤于寒，冬又不藏精，至春月两邪同发，则冬伤于寒者，阳分受邪，太阳膀胱经主之，冬不藏精者，阴分受邪，少阴肾经主之，与两感伤寒证中，一日太阳受之，即与少阴俱病，则头痛口干烦满而渴之例，纤毫不差，但伤寒证自外，入内，转入转深，故三日传遍六经，温证，自内达外，既从太阳之户牖而出，势不能传遍他经，表里只在此二经者为恒也，若更挟外邪，从大肠少阴经中，二日传阳明太阴，三日传少阳厥阴，则脏腑之邪交炽，不俟六日即死矣，盖太阳少阴邪发之日，正已先伤，外邪复入，正气又伤，即与再传无异，脏腑之气几何，决无所供三传之理也，但既是温证，表里横发，重复感受外邪者，十中无一，所以温证两感之例，原有可生之理，昌冶金鉴一则，先以麻黄附子细辛汤汗之，次以附子泻心汤下之，两剂而愈，可见仲景法度，森森具列，在人之善用也，今人见热烦枯燥之证，而不敢用附子者，恶其以热助热也，熟知不藏精之人，肾中阳气不鼓，精液不得上升，故枯燥外见，纔用附子助阳，则阴气上交于阳位，如釜底加火，则釜中之气水上腾，而润泽有立至者，仲景方中，辄用附子一枚，今人一钱，亦不敢用，总由其识之未充耳，昌亦非偏重温也，以少阴经之汗下，与他经不同，如冶金鉴，先以温法及汗法一药同用，次以温法及下法一药同用，而收功反掌，盖舍二法别无他法也，设汗药中可不用温，下药中可不用温，是与治伤寒阳邪之法，全无差等矣，昌之分温证为三例者，道本自然，其不以牵强穿凿，取后世之批议也明矣。再按冬伤于寒，又不藏精，春月病发，全似半表半里之证，乃以半表半里药用之，病不除而反增，所以者何，此证乃太阳少阴，互为标本，与少阳之半表半里，绝不相涉也，然随经用药，个中之妙，难以言传，盖两经俱病，从太阳汗之，则动少阴之血，从少阴温之，则助太阴之邪，仲景且谓其两感于寒者，必不免于死，况经粗工之手，尚有活命之理耶，所云治有先后，发表攻里，本自不同，此十二字秘诀，乃两感传心之要，即治温万全之规，圣言煌煌，学者能参透此关，其治两感之温证，十全八九矣。

表热里寒者，脉虽沉而迟，手足微厥，下利清谷，此里寒也，所以阴证亦有发热者，此表解也，表寒里热者，脉必滑，身厥舌干，所以少阴恶寒而蜷，此表寒也，时时自烦，不欲厚衣，此里热也。 [原文]

按此段文义论温证，全以少阴肾与太阳膀胱分表里，昌所谓太阳与少阴，互为标本者，得此而为有据矣，其云所以阴证亦有发热者，此表解也，言当先从表解也，即麻黄附子细辛汤之例也，脉滑表寒也，身厥舌干里热也，恶寒而蜷，宜行温散，时时自烦，不欲厚衣，又宜凉解，用药如此繁难，正与两感证中，治有先后，发表攻里，本自不同之义互见，正欲学者之以三隅反也，又云，少阴病，恶寒而蜷，时自

烦，欲去衣被者可治，又云，手足温者可治，虽不出方，大段见阴阳不甚乖离，尚可调其偏以协于和之意，设恶寒而蜷，更加下利，手足逆冷，则无阳而偏于阴矣，更加脉不至，不烦而躁，则阳去而阴亦不存矣，所以用药全在临时较量，果其阴盛阳微，即以温为主，果其阳盛阴微，即以下为主，果其阴阳错杂，温下两有所碍，则参伍以调其偏胜为主也，当从表解之义，前已申明，然亦必邪势正炽，阴阳尚未全亏，方可温经散邪，若夫滋蔓难图，任行背水之阵，必无侥幸矣，此等处，皆是危疑关头，虽仲景之圣，不敢经出一方，以胶治法之圆机，所贵明理之彦，师其意而自为深造耳。

少阴中风，脉阳微阴浮者为欲愈。〔原文〕

观此一条，而认脉辨证之机，亦甚昭著矣，阳微阴浮为欲愈，则病发之时，阳盛阴紧可知也，阳盛则治先腑，阴紧则治先脏，又可知也，既盛且紧，则参之外证，以分缓急，又可知也，倘阳已微，而阴不浮者，更当治其阴，亦可知也，倘阴已浮，而阳不微者，更当治其阳，亦可知也，此昌之尚论，每于仲景言外，透出神髓，以自慊也。仲景用桂枝，以和营卫而解肌，此定例也，不但为太阳经中风之本药，即少阴经之宜汗者，亦取用之，其最妙处，在用芍药以益阴而和阳，太阳经之营卫，得芍药之酸收，则不为甘温之发散所逼，而安其位也，至若少阴则更为阴脏而少血，所以强逼少阴汗者，重则血从耳目口鼻出，而厥竭可虞，轻亦小便不利，而枯涸可待，用药自当比芍药之例，而倍加阴以益阳，昌每用桂枝，必加生地，以佐芍药之不逮，三十年来，功效历历可纪，盖得比例之法也，仲景于冬月太阳中风之证，而用桂枝为例，不为春月之病温者设也，春月病温用桂枝，势必佐之以辛凉，而不藏精之温，属在少阴，不得不用桂枝之温解之，以少阴本阴标寒，邪入其界，非温不散也，岂惟桂枝，甚则麻黄附子，在所必用，所贵倍加阴药以辅之，如芍药地黄，猪胆汁之类是也，今人未达此理，但知恶药性之温，概以羌活柴葛为表，则治太阳而遗少阴，屡表而病不除，究竟莫可奈何，而病者无幸矣，纷纷为仲景解嘲之说，然乎否耶。

谨定拟冬伤于寒冬不藏精之证名曰两感温证

按伤寒少阴证，乃从三阳经传入者，此证乃少阴与膀胱经，一脏一腑，自受之邪，故三阳传入之例，多不合，惟两感之例，一日太阳受之，即与少阴俱病，其例吻合，然仲景又不立治法，但曰，治有先后，发表攻里，本自不同，是则一药之中，决无兼治两经，笼统不清之法矣，而治有先后，于义何居，昌尝思之，传经之邪先表后里，直中之邪，但先其里，温证之邪，里重于表，两感之邪，表里不可预拟，惟先其偏重处，假如其人，阴水将竭，真阳发露，外见种种躁扰之证，加以再治太阳之邪，顷刻亡阳而死矣，是必先温其在经之阳，兼益其阴，以培阳之基，然后乃治其太阳之邪，犹为庶几也，此则与少阴宜温之例合也，又如其人，平素消瘦，兼以内郁之邪，灼其肾水，外现鼻煤舌黑，种种枯槁之象，加以再治太阳，顷刻亡阴而

死矣，是必急下以救将绝之水，水液即回，然后乃治太阳之邪，犹为庶几也，此则与少阴宜下之例合也，又如其人，邪发于太阳经者，极其势迫，太热恶寒，头疼如劈，腰脊颈项，强痛莫移，胸高气喘，种种危急，温之则发斑发狂，下之则结胸譫语，计惟有先从太阳经桂枝之法解之，解已，然后或温或下以去其在阴之邪也，此则当用太阳经之表例，而与其少阴可汗之例略同也，诎非先后攻发之可预拟者耶，但两感伤寒之攻里，单取攻下，原不兼温，而两感温证之里，亡阳之候颇多，不得不兼温与下而并拟之也，此又变例而从病情者也。按太阳少阴两感之温证，其例虽与两感伤寒，一日太阳与少阴俱病相合，其实比传经之邪，大有不同，盖伤寒之邪，三日传遍六经，故为必死之证，而温病乃内郁之邪，始终只在太阳少阴二经，不传他经者为多，是则非必死之证也，惟治之不善，乃必死耳，倘用汗下温法，先后不紊，则邪去而正未伤，其生固可必也，又有邪未去而正先亡，惟藉他经供其绝乏，久之本脏复荣，亦以得生者，总宜分别视也。按亡阳一证，在伤寒则误发太阳经汗，与误发少阴经汗者多见之，他经汗误则不然，可见两感之温证，为太阳少阴双受之邪，合温经散邪，而单用汗药者，其亡阳真在顷刻间耳，盖阳根于阴，深藏北方肾水之底，素不藏精之人，真阴既耗，则真阳之根，浅而易露，若不以温经之法，嘿护其根，而但用甘温发散之药，是以阳召阳，随感即赴，不待盖覆，而淋漓不止矣，可不惧哉。按亡阴一证，在伤寒则邪传阳明，当下而不下，致津液暗枯，邪传少阴，当下而又不下，致肾水暗枯，其亡也以渐，尚有急下一法可救，若在不藏精之温证，则肾水已竭之于先，而邪发之日，阴邪必从下走，势自下利奔迫，是下多尤足亡阴，而又绝无补法，可以生阴，金匱云，六腑气绝于外者，其人恶寒，五脏气绝于内者，则下利不禁，脏者阴也，阴气欲绝，诎非亡阴之别名乎。神哉仲景之书，既详不藏精之证，又出不藏精之治，特未显然挈示，后人不维其义耳，即如桂枝一汤，本为太阳中风设也，而汗下和温，已具于一方之内，至于温法，尤为独详，如加附子，加人参白朮干姜甘草，加桂心茯苓蜀漆红花等类，岂太阳表证中所宜有乎，惟病有不得不先温经，又不得不兼散邪者，故以诸多温经之法，隶于桂枝项下，一方而两擅其用，与麻黄附子细辛汤同意，凡遇冬不藏精之证，表里之邪交炽，阴阳之气素亏者，按法用之，裕如也。

春一温下篇诸方〔兹篇得十五法，连前共三十法，合前四卷共足三百九十七法。〕

桂枝领邪一法。桂枝加生地汤。清表温中一法。桂枝加人参汤。

清阳泻火一法。桂枝加大黄汤。脉浮先表一法。桂枝汤。先温后表一法。治下利清谷不止，身疼痛者。先用四逆汤，急救其里，救后清便自调，但身痛者，随用桂枝汤急救其表，此见下多，则阴邪亦从阴解，故温后但解其阳邪，不必兼阴为治。

温经止汗一法。桂枝加附子汤。

汗后恶寒一法，芍药甘草附子汤〔收阴固阳表虚〕。

下后恶寒一法。桂枝汤去芍药加附子〔阳虚〕。

汗后恶热一法。调胃承气汤〔胃中干实〕。

汗后里虚一法。桂枝新加汤〔汗后身疼痛，脉沉迟〕。汗后发悸二法。桂枝甘草汤〔治心下悸，欲得人按〕。茯苓桂枝甘草大枣汤〔治脐下悸〕。

汗后腹胀一法。厚朴生姜甘草半夏人参汤 昼夜静躁一法。汗下后表虚恶寒，里虚脉微细，日轻夜重者，以救阴为主，宜桂枝加红花汤。日重夜轻，身无大热者，以救阳为主，宜干姜附子汤。误汗变逆一法。本脉浮而证见汗出心烦，微寒脚挛之候，纔服桂枝汤，即便厥冷，咽干烦躁吐逆者，乃阳虚而阴独盛也，先与甘草干姜汤，以复其阳，俟厥愈足温，更与芍药甘草汤，行阴寒凝滞之血，以伸其脚，若阳虚阴盛，其变愈大者，但用四逆汤以温经回阳，而不兼阴为治也。

附辨温证合偶感之客邪以明理而辟谬 诸家方书，谓温证之外，复有四证，一曰，脉阴阳俱盛，重感于寒者，变为温疟，一曰，阳脉浮滑，阴脉濡弱者，更遇于风，变为风温，一曰，阳脉濡弱，阴脉实大者，更遇温热，变为温毒，一曰，阳脉濡弱，阴脉弦紧者，更遇温气，变为温疫，据其援脉以辨证，而为治温者推广其端，似乎新奇可喜，詎知辞不达意，徒足炫人，所以后人一得之长，迥不及于古人，此等处，关系病机最巨，昌不得不并明其理焉，盖春温夏热，秋凉冬寒，各主一气者，其常也，然天气不可以长拘，所以夏气亦有清凉之时，冬气亦有燠热之时，凡此皆谓之客气也，本温证而重感于寒，其病即兼冬气，而为温疟，本温证而重感于热，其病即兼夏气而为温毒，本温证而重感于时行不正之气，其病即兼不正之气而为温疫，原无所变也，乃谓某病忽变某病，不令人炫而且骇乎，又且长夏之湿气，春分后早已先动，最能与温气相合，而为湿温之证，何以四证内，反不并举，又且温疟一证，内经明说是冬月邪入骨髓，至春夏始发，何以妄说春月重感于寒，又且更遇于风，变为风温一证，头上安头，梦中说梦，尤为无识，盖春月厥阴风木主事，与时令之温，不得分之两，凡感而病者，皆为风温之病也，即如初春之时，地气尚未上升，无湿之可言也，天气尚微寒，无毒之可言也，时令正清和，无疫之可言也，而所以主病者，全系于风，倘除风温，另为一证，则所以病温之故，为何故耶，试观仲景于冬月之病，悉以伤寒之名统之，其感发之风寒，栗烈之寒气，总为一寒，则春月之风寒，风热，风湿，总为一风并可知也，夫风为定体者也，在八方则从八方，在四时则从四时，春之风温，夏之风热，秋之风凉，冬之风寒，此自然之事也，仲景于温证篇首，即特揭风温之名，以纲众目，其晰义之精为何如耶，显明道理，一经后入之手，便将风与温，分之为二，况于精微之奥乎，兹特辨之，以见治温之法，原为切近平易，而非有奇特也。温疟主治温疟病，脉尺寸俱盛，先热后寒者，宜小柴胡汤。先寒后热者，宜小柴胡加桂枝汤，但寒不热者宜柴胡加桂姜汤，但热不寒者，宜白虎加桂汤。有汗多烦渴，小便赤涩，素有瘴气，及不服水土，吐甚者，宜五苓散。温毒主治温毒为病最重，温毒必发斑，宜人参白虎汤。竹叶石膏汤。玄参升麻汤。黑膏〔清气，凉血。〕温疫主治。人参败毒散。温疫病阳脉濡弱，正虚也，阴脉弦紧，邪实也，正虚邪实，则一团外邪内炽，莫能解散，病固缠身为累，而目前不藏精之人，触其气者，染之尤易，所以发表药中，宜用人参，以领出其邪，寓意草中，论之已悉，兹不复赘。

卷二

尚论四时

冬天干始于甲，地支始于子，故尚论四时以冬为首，凡春夏秋三时之病，皆始于冬故也，先王以至日闭关，商旅不行，后不省方者，法天之闭藏，与民休息，俾无夭札也，然而高人踏雪空山，而内藏愈固，渔父垂钓寒江，而外邪不侵，以藏精为御寒，乃称真御寒矣，内经谓冬不藏精，春必病温，谆谆垂诫，后世红炉暖阁，醉而人房，反使孔窍尽开，内藏发露，以致外寒乘间窃入，所以伤寒一证，最凶最多，伸景于春夏秋三时之温热病，悉以伤寒统之者，盖以此也，吾人一日之劳，设不得夜寝，则来日必加困顿，农夫一岁之劳，设不为冬藏，则来年必至缺乏，况乎万物以春夏秋为昼，以冬为夜，至冬而归根伏气，莫不皆然，岂以人为万物之灵，而顾可贸贸然耶，特首揭之，且以动良士之瞿瞿也。

春天地之大德曰生，德流化溥，而人物生焉者也，春秋首揭春王正月，虽重王道，而天德人理，统括无余，春于时为仁，仁者人之心也，故生而勿杀，予而勿夺，赏而勿罚，心上先有一段太和之意，然后与和风甘雨，丽日芳时，百昌庶类，同其欣赏，一切乖戾之气，不驱自远，更何病之有哉，乃纵肆辈日饮食于天地之阳和，而不禁其暴戾恣睢之习，此其心先与凶恶为伍，凡八风之邪，四时之毒，咸得中之，及至病极无奈，乃始忍性以冀全生，究属勉强以冀而非自然，如石压草，逢春即芽，如木藏火，逢钻即出，惟廓然委顺，嗒然丧我者，病魔潜消，而精气渐长，犹为近之，故法天地之生以养生者，为知道也。风者，善行易入之物，为百病之长，大率风之伤人，先从皮毛而入，以次传入筋骨脏腑，内虚之人，与外风相召，如空谷之应响，大块之噫气，未动而已先觉，若星摇灯闪，可预征者，故体虚之人，避风如避箭石，偶不及避，当挣努以捍其外，热汤以溉其内，使皮毛间津津润透，则风邪随感即出，不为害矣，然外虽避风，而内食引风之物，其招致尤为不浅，善治风者，必权衡于风入之浅深，逐节推引而出，然亦须兼治痰，痰不堵塞窍隧，则风易出也，至于痰热积盛，有自内生风之候，则与外感之风，迥隔天渊，若以外感法治之，加羌防之属，则内愈虚，风愈炽，每至不起，与内伤病以外感药治，其误同也。

夏热者，天时之气也，暑者，日之毒也，湿者，地之气也，夏月时本热，加以地湿上腾，是以庶类莫不繁茂然而三气相合，感病之人为独多，百计避之不免，亦惟有藏精一法可恃耳，昌谓夏月藏精，则热邪不能侵，与冬月之藏精，而寒邪不能入者，无异也，故春夏秋三时之病，皆起于冬，而秋来二时之病，皆起于夏，夏月独宿，兢兢堤防，金水二脏，允为摄身之仪式矣，每见贵介髫龄之子，夏月出帷纳凉，暗中多开欲窦，以致热邪乘之，伤风咳嗽，渐成虚怯羸瘦等病者甚多，有贤父兄者，自宜防之于早矣。人之居卑隩，触山岚，冒雨暘，着汗衣，卧冰蕈，饮凉水，食瓜果，受内郁，皆能使湿土受伤，若以秋疟但为受暑，遗却太阴湿土受伤一半，至

冬月咳嗽，反以为受于湿，而以燥治之，不成千古一大误耶，夏月汗多真阳易散，津少真阴易消，为内伤诸病之始。

秋金继长夏湿土而生，其气清肃，天香遍野，地宝垂成，月华露湛，星朗渊澄，酷热之后，得此高秋荐赏，与严寒之后，而得阳春敷和，同为岁不可多得之日，盖金性刚，金令严，繁茂转而为萧疎矣，燠热转而为清冷矣，以故为时未几，而木萎草枯，水落石出，时愈冷则愈躁，以火令退气已久，金无所畏而得以自为也，故躁金之令，不可伤，伤之则水竭液干，筋急爪枯，肝木暗摧，去生滋远，故凡肝病之人，宜无扰无伐，以听木气之归藏，木气归藏，躁金即能萎其枝叶，而不能伤其根本，及秋金纔生冬水，早已庇木之根，以故木至春而复荣者，荣于冬月之胎养也，夫生中有杀，杀中有生，亦自然而然之理，人在气交之中，能随天地自然之运，而为节宜，则不但无病，而且难老，岂舍此而更有延年之术哉，若夫躁金自受之邪，为病最大，以夏火之克秋金为贼邪，故暑热湿之令，金独伤之，暑热湿之病，金独受之，古人于夏月，早以淡泊滋味，恶其湿热伤肺，且不欲浊滞碍清道也，然形寒饮冷，尤为伤肺，虽夏月之乘凉，亦不可过，况入秋已深，尚啖生冷，冒风露而无忌，宁不致肺之病耶，故夏三月所受之热，至秋欲其散，不欲其收，若以时今之收，兼收其热，则金不生水，而转增躁，安得不为筋脉短劲，浊渴枯损之导，为冬月欬嗽之根耶。

论治病必本于四时

飧泄病，既谓春伤于风，夏生飧泄矣，又曰长夏兼病洞泄寒中，又曰逆秋气者，冬必飧泄，其言错出无定，人不易会不知病名虽同，而其因风因湿因寒，则各不相同，故治病不本于四时，无能治也。

春伤于风夏生飧泄解春伤于风，夏生飧泄，从来解说不明，昌谓风邪伤人，必入空窍，惟肠胃为最，所飧之食，由胃入肠，胃空而风居之，少顷糟粕去，肠空而风亦居之，风既居于肠胃，则其导引之机，如顺风扬帆，不俟脾之运化，食入即出，以故飧已即泄也，不知者以为脾虚，完谷不化，用长夏洞泄寒中，及冬月飧泄之法，反以补脾刚躁之药，助风性之劲，有泄无已，每至束手无策，倘知从春令治之，仍以桂枝领风，从解肌而出，一二剂可愈也，识此意者，虽三时之伤于风者，亦可会而通之。

夏伤于暑长夏伤于湿秋必痎疟解自二月以至七月，地气动，则湿用事，自八月以至正月，地气静，则燥用事，所以春夏多病疟者，可知伤热伤暑，未有不伤湿者也，所以秋冬有欬嗽者，伤风伤寒，未有不兼伤燥者也。

秋伤于燥冬生欬嗽解秋月之金，生冬月之水，然金必寒，始能生水，水必冷，始不为痰，故冬月之欬嗽，必由于秋令之燥也，然而夏月化土之气，不先伤于肺，则秋

月何躁之有，昌故谓秋冬二时之病，皆始于夏，夏月藏精则热邪不能侵也，夫池沼之间，暑且不到，岂有内藏之泓然真水，而暑热之邪得伤其肺者哉，故火邪不能烁金，而金始冷也，金寒则气清而不上逆，水冷则质清而不成痰，更何欬嗽之有哉。

论内经四时主病之脱误

内经云，春伤于风，夏生飧泄，夏伤于暑，秋必痃疟，秋伤于湿，冬生欬嗽，冬伤于寒，春必病温，春冬二季，风寒之病，可无疑矣，其夏伤于暑，秋必痃疟一语，释云暑汗不出，至秋凉气相薄，而为寒热往来之疟，盖以经文，原有当暑汗不出者，秋风成疟之说，故引之而为注，不知于理欠通也，夫夏月之暑，合于长夏之湿，始为秋时之疟，所以疟证名曰脾寒，由伤于长夏之湿土为多，若谓专属伤暑，则人之深居静摄，未尝伤暑，秋亦病疟者，又谓何所伤耶，至秋伤于湿，冬生欬嗽一语，释云秋伤于湿，湿蒸为热，热者火也，至冬寒与热搏，当为欬嗽之证，则牵强不通之极矣，夫湿无定体者也，春夏曰风热之湿，秋冬曰凉寒之湿，惟夏月之暑热湿三气相合，始可名之为热，岂有至秋之凉，而反蒸为热之理，况乎湿者水类，所以水就湿也，躁者火类，所以火就躁也，指躁为湿，是指火为水矣，颠倒不已甚乎，今为正经文之脱简，增人一语曰，春伤于风，夏生飧泄，夏伤于暑，长夏伤于湿，秋必痃疟，秋伤于躁，冬必欬嗽，则六气配四时之旨，灿然中天矣，加长夏之湿，而秋病之源始清，易秋月为躁，而诸家指为热火之训，亦不谬，请再以素问之旨明之，素问云，天有春夏秋冬之四时，金木水火土之五行，以生长化收藏，而寒暑燥湿风火之六气，从兹而生焉，盖春属风木主生，夏属热火主长，长夏属湿土主化，秋属燥金主收，冬属寒水主藏，可见造物全赖湿土生化之一气，而木火金水，始得相生于不息，虽土无正位，四季之中，各分旺一十八日，然无长夏十八日之土，则相生之机息矣，故长夏之土，为生秋金之正土，春秋冬之分隶者，不得与之较量也，此义既明，则秋月躁金主收之义始明，而冬月之欬嗽，为伤秋金之躁，不为伤秋之湿也，亦自明矣，再观素问云，逆春气则伤肝木，不能生夏时之心火，至夏有寒变之病，逆夏气则伤心火，心火不能生长夏之脾土，脾土不能生秋时之肺金，至秋有痃疟之病，逆秋气则伤肺金，肺金不能生冬时之肾水，至冬有飧泄之病，逆冬气，则伤肾水，肾水不能生春时之肝木，至春有痿厥之病，是则三时之病，当更互言之，而秋之病疟未尝更也，其必以心火脾土并言，则长夏之伤于湿，诚为经文当日必有之言，而非昌之臆说也明矣。

论春秋冬各主一气夏月兼主三气之理原为天地自然之运

内经云，彼春之温，为夏之暑，彼秋之忿，为冬之怒，明乎温热寒凉，循序渐进，自然而然者，乃天运之常也，后之俗子，辄以风寒暑湿，分隶四时，此缘经文，脱误秋伤于躁一段，传习至今而不察耳，曷不曰，风寒暑躁犹为近耶，盖湿土无定位，寄旺于四季，各一十八日，风寒暑躁之内，不言湿而湿自在也，然亦但仿洛书五数，居中纵横各得之理以立言，若论天时自然之运，如环无端，岂有甫终一运，重

转土运十八日，五运而为八转者乎，此其道，惟以六气之配而始明，盖三百六十日，五分之各得七十二日，则为五运，六分分之各得六十日，则为六气，自小雪至大寒六十日，属太阳寒，水之气，自大寒至春分六十日属厥阴风木之气，自春分至小满六十日，属少阴君火之气，自小满至大暑六十日，属少阳相火之气，自大暑至秋分六十日，属太阴湿土之气，自秋分至小雪六十日，属阳明燥金之气，此则水木火土金相生，不息之义也，可见冬季大寒后十八日之土，即从太阳寒水之气为用，故能生厥阴之风木，而春季谷雨后天十八日之土，早已属少阴君火之所生，而不从风木为同类，又加仲夏少阳相火，重生其土，至长夏大暑后，其土之盛为始极，而为生金之正土矣，未立夏之前，气已从火，既立秋之后，气上从土，火土之气，共管一行八十日，分岁之半，昌所谓夏月三气相合，与冬春秋之各主一气，迥乎不同者，正以天时自然之运而知之也，岂故为牵强其说以欺人哉，但君相二火之分，即与湿土合司其化，所以夏月暑热中有湿，湿中有暑热，自春分至秋分，有极湿之时，有极热之时，又有湿热交蒸之时，虽云长夏建未之月，湿土主事，其实已行半年之久矣，夫春分后，土膏地溽，湿行半年，不谓之湿，直至秋后，土干地燥，反谓之湿，昔贤以讹传讹，其因仍苟简为不少矣，可无论欤。热湿暑三气，同于夏月见之，真所谓同气相求也，盖热而益之以暑，则热为甚酷，烁石流金，亦云仅矣，然但为干热已也，得阴凉尚可避之，若加以湿而与炎威相会，尽大地为蒸笼，础礫流膏，虬虱悉出衣表，无可避也，必俟金风动而暑始退，惟风动胜湿故也，三气相兼之义，益可见矣，夏日较他时独永，而南方离明之位，天星独密，造化活泼之妙，非圆机之圣人，曷足以知之。

论逆四时之病为自取其殃

四序之中，当温而温，当热而热，当凉而凉，当寒而寒，以生以长以化，以收以藏，四时极正之气，民物原无痼疹，乃有违天而召戾，不可救药者甚多，内经云，逆冬气则伤肾，奉生者少，逆春气则伤肝，奉长者少，逆夏气则伤心，奉收者少，逆秋气则伤肺，奉藏者少，其逆四季土旺之气则伤脾，奉化者少，言外自寓造物不与人忤，而人自逆之也，逆之之情，久而靡鞫，如暴戾忿恨之人，始焉但觉肝气有余，终岁扰乱，一旦不足，则尪羸无似，更有何气可奉他藏耶，所谓违天者不祥，人不可以不知也。四序之中，有与病相邻者，善保生者，宜默杜其机，如春气在头，头间之气，倍旺于他部，气旺则血充，血充则易至于溢出，故春病善鼽⁸⁷⁴⁸，其所损也多矣，内经云，上者下之，诚知春气之在头也，每日引而归诸丹田气海之内，且气机虽发扬，而吾心不可无萧瑟之应，不则微用苦降之药，以通其气，凡此皆所谓嘿杜其机者也，若俟鼽⁸⁷⁴⁸淋漓，尚不知其所来，则无具甚矣。〔鼽音求，鼻间窒塞也，⁸⁷⁴⁸音忸，鼻间出血也。〕

论四时制胜之道

素问云，风胜则动，热胜则肿，燥甚则干，寒胜则浮，湿胜则濡泻，可见凡人感受

四时偏胜之气而成病者，原各不同，感风气胜者，则体从之而动焉，如振掉摇动之类是也，感热气胜者，则体从而肿焉，凡痈肿之类是也，此与寒伤形，形伤肿之肿不同，与热伤气，气伤痛之意直互见，感躁气胜者，则体从之而干焉，如津液枯涸，皮毛躁煖之类是也，感寒气胜者，则体从之而浮焉，即所谓寒伤形，形伤肿者是也，感湿气胜者，则体从之而濡泻焉，脾恶湿喜燥，湿气太过，则土不胜水，而濡泻之病作也，六元正经，又谓甚则水闭跗肿，亦见土不胜水，则不能外输膀胱，而内则为水闭，及水气泛滥四肢，而外则为跗肿，所以较之濡泻为尤甚也，然而风与躁相邻，风躁又未有不热者也，湿不与躁为邻，其成为寒湿，或为热湿，则各随其体之积累所造焉，但春夏秋三时，俱属风躁热，惟冬时方属寒，则受病者之热湿多而寒湿少，又属可推矣。春属东方木，木太过以西方金制之，始得其平，故怒多则伤肝，惟悲始能胜怒，以肺金主悲也，风多则伤筋，惟燥始能胜风，以肺金性燥也，酸多则伤筋，惟辛始能胜酸，以肺金味辛也，夏属南方火，火太过以北方水制之，始得其平，故喜多则伤心，惟恐始能胜喜，以肾水主恐也，热多则伤气，惟寒始能胜热，以肾水性寒也，苦多则伤气，惟咸始能胜苦，以肾水惟咸也，长夏属中央土，土太过以东方木制之，则得其平，故思伤脾，惟怒胜思，肝主怒也，湿伤肉，惟风胜湿，木主风也，甘伤肉，惟酸胜甘，木味酸也，秋属西方金，金太过以南方火制之，则得其平，故忧伤肺，惟喜胜忧，心主喜也，躁伤皮毛，惟热胜躁，心主热也，辛伤皮毛，惟苦胜辛，火味苦也，冬属北方水，水太过，以中央土制之，则得其平，故恐伤肾，惟思胜恐，脾主思也，寒伤血，惟热胜寒，火胜水也，咸伤血，惟甘胜咸，土味甘也，夫四时一有太过，即以所胜制之，内而七情，外而六气五味，皆可用之，调其偏以协于和，可见道本自然而然，推之无穷无极，总不出其范围，虽有智者，莫加毫末也，后世识不及古，反舍正路不由者何耶。问形不足者，温之以气，精不足者，补之以味，此何解也，曰二语者药之权衡也，形充于血，阴之属也，阴不足者，本当益阴，然益阴而阴未能生，必温以气之阳而阴始生，以阳为阴之主也，精丽于气，阳之属也，精不足者，本当益阳，而阳未能生，必补以阴之味，而阳始生，以阴为阳之基也，二者皆药石之权宜，亦阴阳互根之妙理也。

真中合小儿论伤寒真中阴经人之阳气素弱，加以房室过损，腠理久疏，胃气久薄，泻利无度者，一旦感受风寒之邪，正加怯懦之夫，盗至全不争斗，开门任其深入，拱手以听命而已，所以其后全不发热者为多，盖发热则尚有争斗之象，邪不得直入无忌也，然岂是从天而下，大都从胃口而入，胃为五脏六腑之源，深入其中，可以径奔三阴而从其类，以故吐呕四逆唇青等候，亦从胃而先见也，失此不治，势必腹痛下利不止，渐至卷舌囊缩而死矣，有魄汗淋漓而死者，孤阳从外脱，亦风邪为多也，有全不透汗，浑身青紫而死者，微阳为阴所灭，亦寒邪深宽也，此证阴霾已极，以故一切猛烈之药，在所急用，不可一毫回互，设用药而加踌躇，转盼天崩地裂矣。

论真中风伤寒证，太阳经之中风者，乃风寒暑湿之风，自外而入者也，真中风之风，乃人身自有之风，平素蕴蓄，而一旦内出者也，素问云，阳之气，以天地之疾风

名之，可见真中风之病，乃人之数扰其阳所致，数扰其阳，惟房室一事为最，房室过勤，纵阴不走，而阳气则已动，动而不已，必渐积于空隙之所，而手微麻，足或微痹，舌或微蹇，风信已至，而扰其阳者方未已一旦乘虚横发，与大块噫气，林木振响，黄沙蔽天，白浪翻海者，初无少异矣，其人安得不卒倒乎，迨至卒倒，而世医方引风寒暑湿之风为治，一误再误，外风入而与内风交煽，任凭躯伟体坚，经年不能少减，而成废人者比比，甚有不旬日而告毙者矣，可胜叹哉。

论真中风大法风既自内而生，还须自内而熄，欲自内而熄，何物是熄风之药，养血乎，风亦与之俱养，补气乎，风亦与之俱补，实腠理乎，风亦与俱实，将何所取耶，养血补气，自不可少，而实腠理之药，断不可用，进而求之于法，然后不患于无药也，盖天地间之风，得两则熄，所以素问又曰，阳之汗，以天地之雨名之，以雨治风，不言治而治在其中，以故内风之人，腠理断不可实，实则汗不能出也，气血不可不补，虚则不足供汗之用也，要使元气足以拒风于腠理之间，务如大病捩后之人，饮汤则汗，食粥则汗，如此旬日，以听风之自熄，然后为当，其妙全在助阳而通血脉，不取驱风散邪为义，与荆防柴葛之经药，绝不相干，世传以羌防等药，发散一食顷者，此但可治偶感之风耳，以治内风，不去百分之一，岂有经年积累之风，而取办一药，且仅攻皮肤之理哉，中风病，多见于富贵之人，而贫贱绝少，贫贱之人，非无房室也，以其劳苦奔走，身中之气，时为蒸动，纔有微风，便从汗解，而富贵之人，身既安逸，内风已炽，尚图乘风纳凉，沐浴饮水，以解其热，致阳气愈遏不舒，加以浓酒厚味之热，挟郁阳而为顽痰，阻塞经络，一旦卒然而中，漫不知病所由来，古今成方虽多，辨证全不清切，盍观平人饮醇食824，积至无算，全不见其热者，阳气有权，嘿为运出耳，阳气遏郁无权，势必转蒸饮食之物为痰，痰与风相结，迨发之时，其体盛之人，病反加重，盖体盛则阳多，阳多则风与痰俱多也，孰知其风为本，而痰为标耶，孰知其阳气为本，而风痰为标耶，风痰为标，可汗可吐，而或者见其昏迷舌蹇，以为邪入心脏，用牛黄清心之类，驱风散痰，致阳气愈遏，而成不治甚多，夫阳遏在内之人，脏腑有如火烙，平素喜生冷，临病又投金石，覆辙相寻，明哲罔悟，亦独何耶，阳气为本，势必绝欲而不更扰其阳，病根始拔，然而阳气素动，习惯渐近自然，多不乐于赡养，风痰纔得少息，往往思及欲事，略一举动，复从本及末，蔓而难图矣，古今无人深论及此，惟善保生者，见体中痰多风炽，无俟病发，预欲绝欲可矣，甚哉，人于天地自然之气机，日用不知也，天时蒸动之时，欲求凉风而不可得，风气干燥之时，欲求微雨而不可得，是以多湿之人恶蒸动，多风之人恶干燥者，内邪感之而益动也，故湿病喜燥药而忌汗药，风病喜汗药而忌燥药，充其义以为调摄，则居四达之衢，而披襟向风，起呼吸即通帝座之想者，即治湿之良方也，处奥隩之室，而整冠振衣，凛天威不违咫尺之惧者，即治风之良方也，人苟知此，不诚可以却痰而延年耶。

辟小儿惊风论小儿初生，以及童幼，肌肉筋骨，藏府血脉，俱未充长，阴则不足，阳实有余，不比七尺之躯，阴阳交盛，惟阴不足，阳有余也，故身内易于生热，热盛则生痰生风生惊，亦所时有，彼当日若以四字立名，曰热痰风惊，则后人不炫，

乃以四字难呼，节去二字曰惊风，遂贻后人以多论，以其头摇手劲也，而曰抽掣，以其卒口噤，脚挛急，目邪心乱也，而曰搐搦，以其脊强背反也，而曰角弓反张，不知小儿之腠理未密，易于感冒风寒，凡寒中人，必先入太阳经，太阳经之脉，起于目内眦上额交巅入脑，还出别下项夹脊抵腰中，是以病则筋脉牵强，乃生出抽掣等不通各名，而用金石重药镇坠，以致外邪深入难痊，间有体坚证轻而愈者，遂以为奇方可传，误矣，又方书有云小儿八岁以前无伤寒，以助惊风之说，不思小儿不耐伤寒，初传太阳经，早已身强多汗，筋脉牵动，人事昏沉，势已极于本经，药又乱投，不能待于传经解散耳，岂为无伤寒乎，况小儿易于外感，易于发热，伤寒为更多耶，是即世所云惊风也，所以小儿伤寒要在三日内即愈为贵，若待其经尽而解，必不能矣，又刚痉无汗，柔痉有汗，小儿刚痉少柔痉多，人见其汗出不止，神昏不醒，遂名之曰，慢惊风证，而以参耆朮附药，闭其腠理，以致邪热不得外越，以为大害，所以凡治小儿之热，但当攻其出表，不当固其入内，仲景原有桂枝法，若舍而不用，从事东垣，内伤为治，又误矣，又新产妇人，去血过多，阴虚阳盛，故感冒与小儿无别，乃遂相传为产后惊风，尤可笑也，然小儿亦实有惊病，以小儿气怯神弱，凡卒遇怪异形声及骤然跌仆，皆生惊怖，其候面青粪青，多烦多哭，其神识昏迷，对面撞钟放铙，全然不闻，不此热邪塞窍也。

谨论小儿治法大纲小儿冬月，深居房帷，触犯寒邪者恒少，而知识未开，天癸未动，又无不藏精之事，然亦有温证三例可互推者，经云，水谷之气感，则害人六府，小儿或啖乳而传母热，或从饮食而中外邪，皆从阳明胃经先受，繇阳明而外达太阳，即与温证之第一例颇同，而平素脾气受伤者，邪气入胃，复乘其脾虚而客之，即与温证之第二例颇同，既阳明胃与太阴脾，相连之一脏一腑，交合为病，正伤寒两感证中，二日阳明，与太阴受之，则有腹满身热，不欲食，譫语之证，与温证之第三例，分经虽不同，而两感则颇同也，后人造为小儿八岁已前，无伤寒之说，不思小儿冬月登山入水者，尚有之，岂遂谓无寒可伤耶，即冬月不令受寒，岂遂谓无寒可伤耶，即冬月不令受寒，岂春月并不受时行外袭之气耶，其后又因无寒伤之说，凡一切外感，俱妄立惊风之名，擅用金石重坠，反领外邪深入，以成不痊之证，昌寓意草中，已略辨其端，但未详其治也，试观中风卒倒之人，邪中脾之大络，则昏迷不醒，然则邪炽太阴脾经，势必传于大络，其譫妄而不知人者，夫岂惊风之谓耶，祇有慢脾风一说，似乎近理，然不以外感之名统之，则用药茫无措手，兹特比入春温之例，庶推之以及四时，而治悉无忒，后之赤子可登春台，昌所以乞灵于越人，而大畅仲景之旨乎。

小儿温证第一例繇阳明而太阳，自内达外，皆是表证，但表法原取解肌而不取发汗，况于小儿肌肤嫩薄，腠理空虚，断无发汗之理，仲景于太阳之项背强，几几，反汗出恶风者，用桂枝加葛根汤，极得分经之妙，桂枝汤主太阳，葛根汤，主阳明，以类推之，太阳证多，阳明证少，则用桂枝汤加葛根，阳明证多，太阳证少，则用葛根汤加桂枝，圆机在乎临证，然颈项肩背，正二阳所辖之地，不明经络者，见其几几然，牵强不舒，加以目睛上窜，手足反张，诸多太阳见证，而惊风之名，自此

始矣，诂知仲景曰，身热足寒，头项强急，恶寒时头热面赤，目脉赤，独头面摇，卒口噤，背反张者，痉病也，发热无汗，反恶寒者，名刚痉，发热汗出，不恶寒者，名柔痉，又曰太阳病，发汗过多因致痉，可见不解肌而误发汗者，必有此变，又可见汗沾衣被，旋复内渗者，必有此变，当解肌而不当发汗之说，又显然矣，然则小儿之解肌，不更当从乎轻剂耶，小儿服桂枝，不必啜热稀粥，并不可急灌，逼其大汗也。凡小儿发热呕吐者，倘未布痘，即须审谛，不可误用温胃之药，里中一宗侯高年一子，恣啖不禁，每服香砂平胃散极效，一夕痘发作呕，误服前药，满头红筋错出，斑点密攒筋路，所谓瓜藤斑也，上饶某公一侄，病发作呕，乃父投以藿香正气散，一夕舌上生三黑疔，如尖粟形，舌下四黄疔，如牛奶形，盖痘邪正出，阻截其路，故生变若此，因述以垂诫。

解肌清热三法 桂枝加葛根汤、葛根汤、桂枝加栝蒌汤。攻里救胃一法 调胃承气汤。大承气汤。治痉病胸满，卧不着席，脚挛急，断齿者。昌变调胃误攻邪陷一法 桂枝加芍药汤。治下后腹满时痛者。

小儿温证第二例繇阳明而太阴，自表入里，仲景云，太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛，若下之，必胸中结鞅，可见脾气虚衰，不能为胃行津液，必致吐利兼见，此俗子借口慢惊之源也，诂知外感之邪入乘其虚，上吐下利者，即霍乱之意，正气既虚，儿因畏怯则有之，岂是心虚发惊，肝木生风之候耶，此等认证一差，用药不合，万无生理，盖脾经之证，自有脾经之颛药，况于属在外感，仍以散邪为先，所以误下，则心下结鞅，正谓邪虽已入太阴，而阳明未尽除者，恐有表证相碍也。

解肌之法 桂枝汤。脉浮者用之，太阴之脉，尺寸俱沉细，今见浮则邪还于表，仍用解肌之法，送出其邪为当也。四逆汤。自利不渴者用之，燠土燥湿。理中汤。浊气上干于胃，腹胀满者用之。桂枝加大黄汤。大实痛者用之，然芍药大黄，亦当倍灭，以小儿胃薄易动也。

小儿两感温证第三例胃与脾一腑一脏，表里双受，则在表者为阳邪，然既已入于胃，即当爱惜津液，即不得已而解肌清热，不可轻动其汗，所最难者，要在急温急下，审谛不差，盖胃实兼以脾实，则二火交炽，水谷之阴立尽，其口燥咽干鼻煤。〔阙〕

会讲刺热篇温论述上古经文一段 上堂师嘉言老人第一会语录上古医旨，其时首春，其证首温，先师祖僦贷季所传，先师岐伯地之者也，首引太阳之脉色荣观骨，荣未交，曰今且得汗，待时而已，与厥阴脉争见者，死期不过三日，其热病内连肾，少阳之脉色，荣颊前，热病也，荣未交，曰，今且得汗，待时而已，与少阴脉争见者死，凡十五句七十字，岐黄之庭，宗旨晓然，至后世则内经且阙，况上古乎，所以释者极悖理，吾徒会讲，首析其义焉，凡人有病，其色必征于面，而热病尤彰，内

经本篇，谓肝热病者，左颊先赤，心热病者，颜先赤，脾热病者，鼻先赤，肺热病者，右颊先赤，肾热病者，颐先赤，是五藏热病，色且先征矣，然五脏隐深，其色不宜外见，纔见微色，随刺俞穴，蚤泻其热，名曰治未病，待病治之迟矣，灵枢谓赤黑色，忽见天庭，大如拇指者，不病而卒死，剧则刺，非能挽矣，惟太阳经脉色，显而易见，初起热征于面，此时漫无凶咎，太阳脉色，荣饰于颧，乃久邪内伏，其春发温，必始太阳经脉，红赤热色，先见两颧，加以采饰，热之先征也，荣饰之色，止颧骨一处，不交他处，病之浅者也古经荣未交，曰今且得汗，待时而已，少需听其自解，此真诀也，大凡温病，热自内出，经气先虚，虽汗之多，未汗解，故云，今且得汗，待时而已，太阳经气虚者，必待午未正阳，杲日当空，群阴见睨，太阳经邪不留而尽出也，少阳经气虚者，必待寅卯初旭，出震继离，焕然一新，少阳经邪不留而尽出也，注谓肝病待甲乙解，心病待丙丁解，此五藏经文，与三阳经，全不相涉，至于与厥阴脉争见者死，咸谓外见太阳赤色，内应厥阴弦脉，此则如隔千山矣，秦汉以后，始分二十四脉，弦谓少阳可也，厥阴亦可也，大浮滑数，入阳弦可，沉濡弱微，入阴弦亦可也，弦脉阴阳两属，安得指为死脉，且三日之促耶，古义断不其然，上古理脉色而通神明，谓上帝之所贵也，先师之所传也，色以应日，脉以应月，常求其要，则其要也，色以应日者，举头见日，随处长安，晶光万道，人身之色，无幽不烛，同也，脉以应月者，千江有水千江月，地脉潜通，人身之脉，环会贯通，同也，脉荣颧骨，即色荣颧骨，纔一见之，表里两符，岂非日月合璧耶，如太阳颧骨，色脉同时解散，并不成温热病矣，病则色脉同时俱见矣，太阳荣颧骨，少阳荣颊前，厥阴荣颊后，少阴荣两颐，乃至十二经脉色，大络小络，随病彰灼，一疮一痤，色脉不相离也，道在下合五行休王，上副四时往来，何吾人自小之耶，所以太阳厥阴，阴阳同时，并交荣饰，此纔名为争见，若只面呈一部，岂争见乎，争见赤紫滞晦，传经势重，已为主死，争见青黑克贼，十死不救矣，盖太阳水而生厥阴木，则发荣滋长，光华毕达，固有善无恶也，厥阴木而孕太阳水，则子藏母腹，勾萌尽敛，亦嘿庇其根也，今外邪入而真藏逼见于面，夫是以死耳，其热病内连肾，身内百司庶职，惟肾独为政府，安则宅神根本，危则颠覆浊乱，生死出入，莫不繇之，太阴厥阴，祇禀其成，难干之矣，然不曰少阴而曰肾者，少阴传走经脉，肾则颧主内藏，经谓过在少阴，甚则入肾，同一义也，太阳厥阴争见主死，牵连肾气在内，以少阴为厥阴母，木势垂危，求救肾水，肾水足供，尚可母子两全，肾水源流并竭，不母子俱毙乎，可见神去则藏败，藏败则争见黎黑，岂脉色不由根心也哉，释谓木之生数三，故死期不过三日，以生数定死期，谬甚，果尔水数一，土数五，其死主一日五日耶，内经明为死阴之属，不过三日而死，胡以生数妄解乎，下文无期不满三日，反误古脱，增入五字骇观，总因死阴之属，不审其义，故擅复之耳，少阳之脉色也六字，亦擅增入，少阳之脉色，荣颊前，热病也，荣未交，曰今且得汗，待时而已，与少阴脉，争见者死，谓右颊前见赤色，未交他处，待汗自己，若两颐黑色，与少阳赤色，争见则死也，少阴经败甚，必入肾，肾藏发露，泉之竭矣，无阴以守之矣，少阳相火，少阴真火，上下交焚，顷刻俱为灰烬，诚劫灾也，传经势重，间有回天之手，至于肾内枯槁无救，颊颐紫黑，已见恶痕，缕缕不散，此独阳无阴，如大火聚，安得紫府丹台，授以太阴神水乎，吾徒同志

，浚洌彼之泉自固，庆古经之法传心，无负此番提命可矣。会讲素问评热论病文经一段上堂师嘉言老人第二会语录岐伯先师论温胜义微妙，今始深解之也，黄帝问曰，有病温者，汗出辄复热，而脉躁疾，不为汗衰，狂言不能食，病名为何，岐伯对曰，病名阴阳交，交者死也，帝曰，愿闻其说，岐伯曰，人所以汗出者，皆生于谷，谷生于精，今邪气交争骨肉而得汗者，是邪却而精胜也，精胜则当能食而不复热，复热者邪气也，汗者精气也，今汗出而辄复热者，是邪胜也，不能食者，精无俾也，病而留者，其寿可立而倾也，且夫热论曰，汗出而脉尚躁盛者死，今脉不与汗相应，此不胜其病也，其死明矣，狂言者是失志，失志者死，今见三死，不见一生，虽愈必死也，此段论温独创谷气之旨，穀气化为精，精气胜，乃为汗，身中之至宝至宝者也，穀气为疾病之总途，生死之分界，萃万理为一言，谁能外之，内经谓精者，身之本也，故藏于精者，春不病温，是则藏精之人，外邪不入，身如药树，百病不生矣，即不然者，冬藏已敌春温，积贮为命，主张蚤计在是，胡乃泥沙掷之耶，泥沙掷之，兹后则肾虚甚而温死矣，尺热甚而温死矣，穀气既馁，转输不给，关门闭而水谷难通，大事去矣，况肾虚尺热，外感传经而入三阴，热上加热，一呼脉三动，一吸脉三动而躁，准平人十二频率，更增四时，三日促为二朝，再促则脱而不续矣，所以狂言失志，脱精则死，以此故也，上古中古，两大圣神，如出一手，倒说竖说，变化生心，万理渊源，烂然生色，千代以后，乃至传为土苴，不谕不议，奈之何哉，吾徒七十有五，始知理障稍尽，矩则昭然，兹时不言，更待何年耶，岐伯先师问阴阳交，交者死，黄帝愿闻其说，岐伯但发穀气之妙，至阴阳交一言而终，不更再举，向者胸为疑府，今乃知谷气之旨既明，即阴阳交与不交，了然定矣，吾徒嚼舌多年，今转饶舌，而且细举之矣，上古营未交，证之轻者，营交阴，重且死者，中古冬伤于寒，春必病温，证半轻者，冬不藏精，肾虚尺热，苴且死者，圣神心印，妙义天开，变化错综，愈出愈奇，上古太阳（小肠膀胱）与厥阴（心肝）为偶，少阳兴少阴（心肾）为偶，而阳明太阴，虽不言之而其相偶，更定位也，中古太阳与少阴，一腑一脏独主其重，盖太阳主外，少阴主内，太阳司阳经之温，少阴司阴经之温，太阳交少阴，少阴交太阳，阴阳交而死矣，然掌上意珠，不叙其文，若隐若显，俟之后人，何乃竟成绝学耶，岐伯先师，妙翻千古变证，若相杵而实相成，贤智不识其旨，况庸人乎，谓二阳搏，其病温，死不治，不过十日死，乃阳经营未交之轻证，而举为死不治，必有其说，言二阳搏，虽未入阴，病温至极，必死不治，稍延不过十日死，较三日死阴之属，少饶其期耳，二阳者，手大肠，足胃，手经足经，并主阳明，金土燥刚，亢熯阴绝，胃穀肠津，水谷将绝，乃至肠胃如焚矣，纵延多日，究竟不得不死矣，至上古足阳明胃，足太阴脾，一阳一阴，虽不相错而相偶，然吾徒营未交，待时汗已，经气虚者，辰已经旺，汗乃尽解，必然之理也，门人有蓄疑义，脾胃以膜相连耳，脾胃营交相连，直是易易，所以上古故不言之也，予不然，伤寒传经，如胆藏肝叶，岂不直入相合，然必少阳胆，乃传太阴，再传少阴，乃传厥阴，遶经而走，不能直截合胆也，今阳明胃，乃传少阳胆，少阳始传，太阴遶经传次亦然，固知阳明太阴，交与不交，各分疆界矣，两颧颊后，营交相争，部位不远，颊前与颐，营交相争，部位不远，额中鼻准，营交相争，部位不远，必至营交不分，乃为死也，至于太阳少阴，阴阳正交，吾徒更深言

之，内经两感证，一日太阳少阴，二日阳明太阴，三日少阳厥阴，三日死，由是论之，温证微不相同矣，温证一日，太阳而交少阴，有十分交者，有五分之交者，有一二分交者，所以温证太阳少阴，本经与病相持，即十日半月，总为一日之期，不传二日三日之促，而骤死者，盖以谷气平时，觉不相同，营卫平时，觉不相等，病之精津不枯，谷气不尽，热势少衰，肌肤渐积，微汗两交，忽为两解，病医相成者多有之矣，半月一月，待毙无医，谷气不得不尽者，非天也人也，然医之手眼，审机决择，一日已前，图而又图，邀非幸邀，生机可待，此为超医，至一日已后，二日阳明太阴，三日少阳厥阴，谷气精血，传经立尽，尽则死矣，岐伯先师曰，病而留者，其寿可立而倾也，又曰今见三死，不见一生，虽愈必死也，然则阴阳交，交者死，予向以为一言而终，随病随死之候，几误一生，墙面惶汗，常栗然之矣，立志奇男子，冬至闭关，储蓄内富，岂非第一义乎。

会讲伤寒论中论温证一段上堂师嘉言老人第三会语录上古中古，首重温证，民生最赖之矣，周秦以降，如扁鹊越人，起家数辈，各树伟义，经纬裁成，后代宗匠，至于温证，绝不言之，由是论温，驳传驳失，乃至人去书存，几千百年，黯然无色矣，汉末张仲景，前圣后圣同符一揆，其着伤寒论，虽述实为创也，三百九十七法，一百一十三方，其功远绍轩岐，于中温证一法，划然天开，步步着实，绎伤寒家，成朱十余辈，义例多获，独温证从不知为何事，予步趋仲景先师，至老不辍，诸公会讲，大举温证以建当世赤帜，俾仲景寒灰火传，盖太阳病发热而渴，不恶寒者为温病，玩内经冬伤于寒，春必病温之说，知冬寒久郁，太阳经受，肌表营卫主之，与冬月骤病，发热恶寒，且不渴者，证则不同，故春月寒郁既久，发热而渴，不恶寒，自内出外矣，与上古营未交，待汗自解同义，其证不过十之一二耳，若发汗已身灼热者，名曰风温，风温证，少阴冬不藏精，与太阳病随时忽至，势则病之八九矣，风温兴风伤卫又不同，中风其脉浮弱，独主太阳，风温其脉尺寸俱浮，兼主太阳少阴，肾水本当沉也，风温载之，从太阳上入，根本拨而枝叶繁矣，春月木长势强，吸汲肾水，已为母虚，加以风温之病，俄顷少阳相火，厥阴风木，风火炽然，能无殆乎。故若发汗已四字，包括错误，见医未病之先，及得病之顷，须诊足太阳足少阴，一腑一脏，此千古独传妙诀也，诊之辨其有无伏气，有伏气者，冬寒太少二经，久伏身中，时当二月，其脉先见露矣，发则表热太阳，与里热少阴，将同用事，恣汗无忌，灼热反倍，是为风温，风温表里，俱见浮脉，其证自汗身重，肾水病也，多眠睡鼻息鼾，语言难，肾本病也，肾中之候，同时荐至，危且殆矣，古律垂戒云，风温治在少阴，不可发汗，发汗死者，医杀之也，诂意发热之初，不及脉理，轻易发汗，蚤已犯此大戒，生命可轻试手乎，既肾中风邪外出，以阳从阳，热无休止矣，被下者，小便不利，伤其膀胱气化，直视失溲，太阳藏府，同时绝矣，被火微发黄色，剧如惊8259，时瘈瘲，火热乱其神明，扰其筋脉也，伤寒燔针灼艾，仲景屡戒，至温证尤当戒之，被火微发黄色一段，乱其神明，扰其筋脉，重证莫重于此，稍轻误火，少阴脉系，咽喉干痛，乃至唾血，亦多死者，如之何，一逆发汗，已是引日待毙，再促，圣神莫挽矣，故治温病，吃紧在未发汗前，辨其脉证补救备至，防危可也，发汗已后，凶咎卒至，又何所措其手足哉，上古论温，荣交已

后，其病内连肾，中古论温，颞论谷气，肾中精胜，乃汗则生，肾中虚甚，更热则死，其旨至矣，尽矣，仲景先师，出其不尽之藏，论肾更视膀胱以纬之，小便伤膀胱气化，甚则直视失溲，谓太阳入络膀胱命门穴中者，藏精光照，两目直视，则光绝矣，瞳子高者，太阳不足，戴眼者，太阳已绝，太阳气绝者，其足不可屈伸，是则太阳之脉，其终也有五大证，戴眼，反折瘈瘲，色白绝汗，太阳关系，岂不最操其重哉，所以中风暴证，多绝膀胱，人不识者，故风温扼要膀胱，若肾藏将绝，宁不膀胱先绝乎，因是吾徒，尚论太阳春温受证，虽不类夫风温，然阳热势极，肾吸真阴上逆，地道不通，亦成太阳死证，盖由误发其汗，致少阴随之上入，大类内经风厥同也，内经巨阳主气，故先受邪，少阴与其为表里也，得热则从之，从之则厥也，泻阳补阴，是则能治风厥多不死者，然而中风风温风厥，太阳纔涉三风见证，总当回护阴之根底，勿使阴不内守，勿使阳不上厥，百凡封蛰不露，乃可需其正汗，风始熄也，必能若此，乃为泻阳补阴之妙，若阳邪狂逞，少水不能胜火，虚风洞然，果何为哉，谛思一方，其方苟非设诚通神，孰能定此，吾徒尚论温证于后四卷之一，内取裁其方，然未刻也，又十余年，诸公大举会讲温证，当为之刻之矣。阅末语，则老人之欲刻此书，以仁天下也久矣，具同心者其能已耶。

会讲温证自晋至今千年绝学一段上堂师嘉言老人第四会语录仲景先师，叔季天生圣人，其道加日月之明，无数之矣，叔和何如人也，以为得统而学圣人之徒，今且谭从前英贤，过信叔和之弊，叔和为晋太医令，一时医流，既以浅陋，更甚荒唐，如西晋崔文行所传解散温法，用桔梗细辛白朮乌头四味，后世奉为灵宝，更增附子，名老君神明散，更增茱萸，名务成子茱萸丸，托老君务成子售欺，妖妄极矣，后代朱肱活人书，具载其方，确信以为有见，时疫为寒疫，故用阴毒伤寒，所以久宗之耳，及以毒攻毒，受劫必死，朱肱复改圣散子，仍用附子，而表里香躁同之，东坡学士在黄州，见其随施辄效，载之集中，后世又以过信坡公，杀人多误，诎知坡公集中，朱肱已三改其方，始用败毒散，不用热药，厥功少减前罪，然虽改易其方，不识圣神心法，竟无益矣，朱肱论伤寒注释，颇合圣矩，但其论温，传派不清，违悖圣言，未可枚举，如仲景谓太阳病发热，不恶寒而渴者为温病，朱肱谓夏至以前，发热恶寒，头疼，身体痛，其脉浮紧者，温病也，仲景所言者，冬月感寒，至春始发之温病，朱肱所言者春月病温，重感于寒之变病，苟朱肱立百法以治正病，外立一法以治变病，于理甚融，乃千百年从未论温正病，所以其法其方，咸入室操戈也，叔和云，更遇温热，变为温毒，朱肱即云，初春发斑，欬嗽为温毒，吴绶谓伤寒坏证，更遇温热，变为温毒，乃以温毒为坏证，亦宗叔和序例，恢旧坏证而治之也，朱肱吴绶，埶簏迭奏于叔和之庭，正乎，邪乎，洁古伤寒名家，惑叔和变法，则亦不为正矣，赵嗣真谓仲景所云，重感异病，变为他病者，即索矩所谓二气三气，杂合为病也，朱肱谓仲景云冬温之毒，与伤寒大异，汪机谓仲景云，遇温气为温病，遇温热为温毒，不知仲景几会有是言哉，巢氏病源，宗序例四变，用崔文行解散法，庞安常亦然，治法初用摩膏火灸，二日法针，解散取汗，不解，三日复汗之，更不解，四日用藜蘆丸，微吐愈，不愈，改用瓜蒂散吐之，解尚未了了者，复一法针之，七日热已入胃，乃以鸡子汤下之，巢庞比匪极矣，后安常自撰微言，有和

解因时法，于春分夏至前后，一以和解为主，增一味减一味，即名一方，岂始崔文行蜂螫手耶，然只定不移，移则蹶矣，李思训亦用和解，海藏谓二公当宋全盛，其法明哲莫踰，然欲汗不敢，欲下不敢，迁延渺法，无可奈何矣，大率委置圣言，傅会多口，几千年来，祖孙父子，一派相承，盈庭聚讼，各逞其端而未已也，丹溪究心杂证，不事仲景，遇外感宗东垣补中益气，兼行解散，终非正法，况惑异气之说，决择不精，然既外感不习，独主杂证，何由登峰造极耶，东垣不解伤寒正治，盖一生精神在内伤也，乃从内经深入至理，发出冬温春温二义，真千百年之一人也，云冬伤于寒者冬行秋令也，当寒而温，火盛而水亏矣，水既已亏，则所胜妄行，土有余也，所生受病，金不定也，所不胜者侮之，火太过也，火土合德，湿热相助，故为温病，又云，春月木当发，生阳已外泄，孰为鼓舞，肾水内竭，孰为滋养，生化之源既竭，木何赖以生乎，身之所存者热也，时强木长，故为温病，此二则温证，从内经立说，入理深谭，不辟叔和，叔和自妄，盖时强木长，肾水不足供其吸取，故为温病，较叔和三月四月，不为寒折，病热犹轻，五月六月为寒所折，病热则重，盛夏寒折，倒见不成事理，东垣一则冬温妙义，一则春温妙义，几千年来独步悟入，伟哉伟哉，贤关首肯此老矣。

会讲温证正名辨脉之要一段上堂师嘉言老人第五会语录〔论湿温〕仲景先师祖素问热病作伤寒论，以伤寒皆为热病也，然于冬月正病，独详之矣，而春温夏热，则但述大意，比类一二，惟风温湿温二证，春司风温，夏司湿温，独主其重，千古不易也，前第三会，已论风温之戒矣，今举湿温言之，伤寒湿温，其人常伤于湿，因而中喝，湿热相薄，则发湿温，若两胫逆冷，腹满叉胸，头目痛，若妄言，治在足太阴，不可发汗，汗出必不能言，耳聋不知痛所在，身青面色变，名曰重喝，如此者，医杀之也，然风温二律，指为医杀，叔和当时凛斧钺，不敢干也，何乃插入重感异气，变出四证，诳惑后人，谓脉阴阳俱盛，重感于寒者，变为温疟，阳脉浮滑，阴脉濡弱，更遇于风，变为风温，阳脉洪数，阴脉实大，更遇温热，变为温毒，阳脉濡弱，阴脉弦紧，更遇温气，变为温疫，予既自任仲景之徒，当再折其妄，盖温疟风温，温毒温疫四变，总由不识仲景风温湿温二大证耳，风温为少阴证，微分太阳厥阴，即温疟亦该少阴统属，素问谓冬感于寒，藏之骨髓，遇大暑，内灼髓空而发温疟，此正理也，若重感于寒而变疟，无是事也，至于湿温一大证，从不言及，是则夏月竟无着落矣，詎知温湿包疫证在内，湿温至盛，长幼相似，则疫矣，疫亦暑湿之正法也，其外感发疟，证之轻者也，今脉反加重，而证变轻，何以得此耶，至温毒则证之重者，三阴更重，切出脉状洪数实大有之，其人元气实盛，可堪大汗大下，外邪立解，何至发为温毒乎，且阳毒若此，其阴毒又何脉耶，谓阳脉濡弱，阴脉弦紧，变为温疫，濡弱本名湿温，而弦紧乃伤寒定脉，一湿一寒，何从主之，叔和至夏暑为病最重，内经原无其说，杨上善云，轻者夏至前温病，甚者夏至后暑病，不知何见，予谓初春寒芽，或谓柔折可也，至盛夏时强木长，谓之疫寒，断不其然，第四会东垣老人，片言而折矣，盖春月风温，多死在三日，夏月湿温，多有可愈者，安得反重之耶，至于脉法微妙，显然易征，伤寒之脉，浮大而紧，中风之脉，浮缓而弱，春温浮而且弱，风温弗举，风温尺寸俱浮，风火洞然，中喝弦细扎

迟，暑伤其气，湿温沉弱濡缓，湿流其经，至于痲症，俱是脉合火土主之，脉之应病，步步着实，自然之理也，叔和左更遇，右更遇，左变为，右变为，饴喉结舌面厚三寸，韩氏微旨，本欲惩艾，而见齟齬，和解因时，听病自愈，政如用小柴胡汤，诚亦一法，第守此将三百九十六法，尽为赘庞，其可乎哉，风温湿温天大二证，乃风温之治，朱肱用五方，葳蕤汤，知母干葛汤，防己汤，括萎根汤，葛根龙胆汤，其风火相炽，顷刻危亡，全不知矣，至于湿温君火心太阴脾，从不识正法若何，但施邪术而已，真见则安在哉，吾徒品鹭温证，列眉如炬，诸公目击胜义，千里同风，是所望矣。

会讲论古今粹美同堂悦乐一条上堂师嘉言老人第六会语录人无古今，性有完缺，吾生所赋，一隙微明而已，然静里索照，觉无极太极以来，虽未生人，先具人理，人理者，天地之心也，向着阴病谕，少摹开辟一斑，而劫初上帝以为之君，其臣以为之教，创着上经中经下经三卷，中古辽邈，全书未睹，而岐伯先师，私淑先师祖，时举黄帝，相授一堂，内经以后，十不彻一，况古经论温哉，然上古荣未交前，及荣交后，生死燎然，但温旨莫能几及，绝世知识，明明见莫问，问莫究岂不世界空掷人理乎，吾徒神酣上古，志观玉京，绘为空中楼阁之想，步虚陟降，游焉息焉，自觉目光心朗，温证开先，即使拱壁以先驷马，不若晤言一室，求志千古矣，此吾徒一大畅也，岐伯先师论运气曰，尺寸交者死，阴阳交者死，各有其义，惟论温曰，阴阳交交者死也，一言而终，更不再举，吾徒何从得之，然溯上古前圣，徐觉荣交未交，两端，而生死定之也，仲景后圣，徐觉温与风温两端，而生死定之也，今始阴阳交，交者死，论温比类列眉，岐伯先师，从前大呼疾声，向不悟则不闻耳，悟则岂论岐伯先师，即吾徒交与未交，自炯两目，胃为肾关同一机轴，温证纔一见之，而意中已先觉矣，此吾徒一大畅在，先师仲景宫墙，吾徒步趋，垂老弥任，忽发未刊之旨，意谓冬寒春温夏热，分之三时，觉三大纲建鼎足焉，冬月太阳寒水，继以厥阴风木，则统伤寒中风两证，为一大纲，以伤寒该中风，天然不易也，春月厥阴风木，继以少阳相火，则出温证风温两证，为一大纲，以温病该风温，天然不易也，夏月少阴君火，继以太阴湿土，则出喝湿两证，为一大纲，以喝病该湿温，天然不易也，精微之蕴，声臭尽泯，叔和以后，歧路羊肠，蓁披鸟道，多少沉沦，天意未丧，乃至吾世履视昭然，此吾徒一大畅也，仲景先师以前无方，以后其方充栋，大率禁方失传，寝成邪僻，所以有晋温疫，疑鬼疑神，相沿未已，亦以后人莫得仲景之方耳，吾徒伤寒论方，取裁温证诸方，尚论篇末，刻后四卷之一载之，逐一发明其义，无方乃有定方，此吾徒一大畅也，晋唐宋元以后贤者，和解因时，铢铢两两无可奈何，犹可言也，不肖者荡检踰闲，妄行汗下，生命施手，不可言也，几千年来，独东垣老人二则，谭言微中，域外伟观，异时同调，此吾徒一大畅也，嗣后诸君精参，各出一则二则，竖义警切，蕴理新隲，应接不暇，吾徒一大畅大畅矣。

答杭州程云来伤寒十六问一问，凡阴病见阳脉者生，阳病见阴脉者死，而有曰，病人苦发热，身体疼，病人自卧，其脉沉而迟者，知其差也，曰沉曰迟，非阴脉乎，

岂亦有阳病见阴脉而愈耶。答，凡阴病见阳脉者生，阳病见阴脉者死，此二语乃伤寒脉法，吃紧大纲，至其比例详情，自非一端可尽，如厥阴中风脉，微浮为欲愈，不浮为未愈，是阴病我得阳脉也，如讖言妄语，脉沉细者死，脉短者死，脉濡者死，是阳病恶见阴脉也，又如太阳蓄血病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，下血乃愈，此亦阳脉见阴脉，仲景复推出可生之路，见六七日，太阳之表证仍在，自当现大浮数动滑之脉，设其人脉浮而沉，自当比动败变迟之条，而证成结胸，今乃反不结胸者，明是阳邪不结于太阳之经，而结于太阳之府也，膀胱之府，果真蓄血，势必发狂而成死证，计惟急下其血，庶结邪解而乃可愈耳，今人但疑抵当汤，为杀人之药，而孰知亟夺其血，正所以再生其人乎，又如厥阴下利，寸脉反浮数，此阴病得阳脉，本当愈者，设其人尺中自濡，则是阳邪陷入阴中，其浮数之脉，为血所持而不露也，然阳邪既陷入阴，寸脉不加浮数，则阳邪亦属有限，令寸脉反浮数，其在里之热，炽盛难除，更可类推，故知其必圉脓血，而成半死半生之证也，合两条论之，上条可愈之故，全在阴脉见，脉既转阴，阳邪原有限也，下条难愈之故，全在阳脉见，阳邪既从血下出，阳邪不尽，血必不止，万一血尽而阳邪未尽，能免脱阴而死乎，可见阴病阳病二语，特举其大纲，至微细听人自会耳，大纲云者，谓证属于阴，其脉反阳，必能鼓勇以却敌，证属于阳，其脉反阴，必难婴城以固守，故得濡弱弦微之脉者，其人气血精津，未病先亏，小病且难胜，况能胜传经之热病哉，尊问疑阳病见阴脉，亦有愈者，兹正大彻之关，但所引病人苦发热一段，此不过验病之法耳，谓病人苦发热身体疼，到诊脉时，其人安卧，则不见有发热身疼之苦矣，加以脉沉而迟，表邪又未入里，其从外解无疑，所以知其差耳。二问，从霜降以后，至春分以前，凡有触冒者，名曰伤寒，余时则非伤寒也，其有曰，立夏得洪大脉，是其本位，其人身体苦疼重者，须发其汗，非伤寒如何。答，冬月伤时令之寒，春月伤时令之温，夏秋伤时令之暑湿热，此四时之正病也，然夏秋亦有伤寒，冬春亦有伤暑伤湿，乃四时之客病，所谓异气也，此段叮咛，仲景特于湿家不可发汗之外，另竖一义，益以夏月得洪大脉，是心火之本脉，其人身体苦疼重，又似湿土之本病，恐后学误遵湿家不可发汗之条，故以此辨析之耳，见湿病虽夏月，脉必濡弱，不能洪大，且额上有汗，非如伤寒病腠理闭塞，即在夏月，亦必无汗之比也，又见洪大，既为夏月本脉，断无当暑汗不出，而身体疼重之理也，两相比照，则其疼重，仍系太阳经伤寒无疑，但在夏月受邪原微，见证亦稍轻，今人难辨，故于脉法中，析此大疑，以昭成法，可见不但冬春正病，有汗为伤寒，无汗为伤寒，即夏秋正病，有汗为伤暑伤湿，无汗仍为伤寒，参脉辨证了然明矣。三问，阳病从寅而解于戌，阴病从亥而解于寅，是阳得阳解，阴得阴解，而有曰阳病解于夜半，阴病解于日中，何也。答，阳得阳解，阴得阴解者，此从其经气之王也，如少阳王于寅卯辰，太阳王于巳午未，阳明王于申酉戌，太阴王于亥子丑，少阴王于子丑寅，厥阴壬于丑寅卯，是也，各经皆从其王，少阴独从其生者，少阴肾中，内藏真阳，子时一阳生，葭管灰飞，蚤已春回暘谷，丑时二阳，寅时三阳，阳进阴必退，阳长阴必消也，且天一生水，子水生地，即是王地，故少阴欲解独从之，也然三阳之解，从寅卯而始，三阴之解从寅卯而终，寅为生人之首，卯为天地之门户，亦阴阳加环之理也，但三阳之王时九，各不相袭，三阴之王时五，逐位

相连，可见阳行健，其道长，故不相及，阴行钝，其道促，故皆相蹶也，于此见仲景析义之精，以述为作矣，至阳病解于夜半，阴病解于日中者，内经之旨，取阳见阴，阴见阳，两相和协之义也，然而阴阳之和协与否，恶从知之，故阳病必于阳王之时，先现欲解之机，然后夜半而轻安也，阴病必于阴王之时，先现欲解之机，然后日中而轻安也，先圣后圣，宁非一揆也哉。四问，汗多则热愈，凡桂枝麻黄二汤，俱取微似有汗，不令汗多，汗少则便难，少则津液未竭，何为便难也。答，太阳病，非汗不解，然汗法中，每伏亡阳漏风，种种危候，所以服桂枝麻黄汤，但取微似汗，虑夫阳气素薄之人，得药而汗出不止也，至于阳明胃经，为津液之府，邪热内入，津液随即外越者最多，不但阳气虚，不可过汗，即阳气素实，亦不可过汗，所以阳明致戒云阳明实，因发其汗出多者，亦为太过，太过为阳绝于里，亡津液大便因鞭也，从前不解阳绝为何事，不知正指津液内竭而言，即无阳之互文也，所云汗多则热愈，汗少则便难，乃脉法后段，推原所以当下之故，谓服药得汗，腠理既开，两三日内，仍觉皤皤微汗，则邪服而热除，不传里矣，若汗纔得而腠理随闭，则热邪不服而传里，热既传里，津液必耗而便难，故宜攻下以存津液，观下文复云，脉迟尚未可攻，又戒其勿误攻，以重伤津液也，要知此三语，总顶属府者，不令洩数，而为阳明病下脚注耳。五问，太阳病，发热恶寒，热多寒少一节内云，脉微弱者，此无阳也，不可发汗，宜桂枝二越婢一汤，既曰无阳，不可发汗，方中桂枝麻黄石膏生姜，能不发汗耶。答，太阳病，风伤卫，则用桂枝汤解肌，寒伤营，则用麻黄汤发汗，风寒两伤营卫，而加烦躁，则用大青龙汤，峻发其汗，此定法也，于中复有最难用法一证，如太阳病，发热恶寒，热多寒少，谓风多寒少也，风多则麻黄汤为不可用，寒少则桂枝汤必不能去寒，加以脉见微弱，其人胃中复无津液，是汗之固万万不可，欲不汗其微寒终不外散，虽有桂枝二，麻黄一之法，施于此证，尚不中窍，何者桂枝二麻黄一，但可治热多寒少，而不可治脉微弱故耳，于是更改麻黄一，为越婢一，示微发于不发之中，越婢者，不过麻黄石膏二物，形容其发散之柔缓，较女婢尤为过之，正可胜微寒之任耳，所以然者，以石膏能解阳明之热，热解则津液复生，而不名无阳，适得天然妙合之法也，此仲景之精义乎。六问，伤寒心下有水气，欬而微喘，发热不渴，服汤已渴者，此寒去欲解也，小青龙汤主之，既寒去欲解，不用药可矣，必用小青龙汤，何也。答，伤寒心下有水气，欬而微喘，此水寒相搏，而伤其肺也，伤寒故发热，水停心下故不渴，内水与外寒，相得益彰矣，今服汤已而渴，明是表药之甘温，克胜其外袭之寒，所以知其证为欲解，然尚未解也，何以故，外寒为内水所持，开解最难，故必更用小青龙汤，逐其寒从外出，水从下出，斯一举而开解无余耳，倘不其然，纵外寒渐散，其水气之射肺中者，无缺62

由得解，所以热虽少止，喘仍不止，故用麻黄发肺邪，杏仁下肺气，甘草缓肺急，石膏清肺热，即以治足太阳膀胱经药，通治手太阴肺经，亦为天造地设之良法也，倘更误行桂枝，宁不壅塞肺气而吐衄脓乎，必识此意，然后不可更行桂枝之戒，愈觉深切着明耳。九问，血弱气尽一节，有藏府相连，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，高指表耶，下指胁耶。答，高不指表，下不指胁，要知此乃为妇人经水适来适

断之词，经水适断之后，宁非血气弱尽乎，因少阳热邪，尽入血室，逼其经血妄行，致成此证，盖少阳胆，藏于厥阴肝叶之内，藏府相连，与太阳阳明两阳，各为一区，却与少阴太阴相连者迥殊，所以太阳阳明之府邪，不能袭入于藏，而少阳之府邪，与藏相连，漫无界限，有热邪之在胁者，迫血妄行，必痛连腹中，见经血虽止，而腹痛犹不止耳，高指胁也，下指腹也，邪在两胁，已搏饮上逆，痛在腹中，又浊气上干，所以其证呕逆特甚，但不可因其痛在腹中，遂指为取阴见证，误用吴茱萸等汤治呕，桂枝大黄等汤治痛，仍用小柴胡汤，治其府不治其脏，乃为不误，此是吃紧叮咛，言外见藏府同治，必领府邪入藏，而成两感，水浆不入，形体不仁，有必至矣，仲景不能尽所欲言，但以小柴胡汤主之一语，砥柱狂澜也。十问，小柴胡汤法，去滓，复煎，必有其义。答，用小柴胡汤，必去滓，复煎，此仲景法中之法，原有奥义，盖少阳经用药有汗吐下三禁，故但取小柴胡汤以和之，然一药之中，柴胡欲出表，黄芩欲入里，半夏欲驱痰，纷纭而动，不和甚矣，故去滓，复煎，使其药性合而为一，漫无异同，俾其不至僨事耳，又和非和于表，亦非和于里，乃和于中也，是必煎至最熟，令药气并停胃中，少顷随胃气以敷布表里，而表里之邪，不觉潜消默夺，所以方中既用人参甘草，复加生姜大枣，不厌其复，全藉胃中天真之气为斡旋，所谓大力者负之而走耳，试即以仲景印仲景，三黄附子汤中，以其人阳邪入阴而热炽，非三黄不能除热，其人复真阳内微而阴盛，非附子不能回阳，然必各煎后，乃得以各行其事，而复煎以共行其事之义，不亦彰彰乎。十一问，太阳病，外证未解而复下之，协热而利，利下不止，心下痞鞭，表里不解者，桂枝人参汤主之，此理中加桂枝也，设遇此证，解表用桂枝可也，协热利而用理中，人所不敢，仲景神门，必有妙义者欤。答，太阳经表邪未解而误下，以致协热而利，心下痞鞭，设腹中利止，则里邪可从里解，乃利下不止，是里邪漫无解期也，设胸中结开，则表邪可从表解，乃心下痞鞭，是表邪漫无解期也，此际欲解表里之邪，全藉中气为敷布，夫既上下交征不已，中气且有立断之势，其能解邪开结乎，故舍桂枝人参汤一法，更无他法可用者，若以协热之故，更清其热，斯殆矣，愚每用此法，病者得药，腹中即响若雷奔，顷之痞鞭开，下利止，捷于反掌，可见握枢而运，真无为之上理矣。按泻心汤中，治痞鞭下利，用甘草干姜人参，各有其义，从未有用朮之法也，此因下利不止，恐其人五藏气绝于内，不得已而用朮，故不曰桂枝理中汤，而更其名曰桂枝人参汤，岂非谓表邪未尽，不可以用朮立法耶，后来陶节庵，制疏邪实表汤，以代桂枝汤，竟推重白朮为君主，坐令外感内伤，混同用药，此等微细关头，不可不辨。十二问，伤寒脉浮滑，此表有热，里有寒，白虎汤主之，寒字误耶，浮滑之脉，不应有寒也。答，脉滑为里热，浮滑则表亦热，所以仲景白虎汤证，又云热结在里，表里俱热，可为互证矣，寒字勿泥，即谓外感之寒入里，而生其在里之热亦可。十三问，阳明病，心下痞满者，不可攻之，阳明病，不吐不下，心烦者，与调胃承气汤，痞满似重于心烦，何心烦可下，而痞满不可下也。答，心下正胸膈之间，而兼太阳，故痞满为太阳阳明之候，不可攻之，攻之利遂不止者死，至于心烦一证，乃津液内耗，大率当调其胃，然尚有重伤津液之虑，若不由吐下所致，是津液未亏，反见心烦者，其为邪热灼胃审矣，当用调胃承气，夫复何疑，然曰与，亦似少少和胃，以安津液之法，非下法也。十四问，少阴病，得之二

三日，口燥咽干者，急下之，宜大承气汤，观急字似不宜缓，其证不过口干燥，而且病属少阴，少阴又不过二三日，非十余日之大满大实，有此神见，而使用承气耶。答，少阴病，得之纔二三日，即口燥咽干，其人肾水素竭可知，故宜急下以救肾水，少缓须臾，瓮干杯罄，救无及矣，所以阳明有急下三法，以救津液，少阴有急下三法，以救肾水，皆动关性命，所谓如救头燃，何商量等待之有耶，此与大满大实之条，天渊悬绝，所当辨之于蚤矣。十五问，脉濡而弱，弱反在关，濡反在巅，此一节有阙文否。答，叔和以濡弱微濇之脉，见为阳气与阴血两虚，分类于不可发汗，不可下，二篇之首，推其所以不可汗下之故，岂非以阳证阴脉乎，而阳证阴脉，大率归重在阳微一边，观下文云，阳微发汗，躁不得眠，又云阳微不可下，下之则心下痞鞭，差可睹矣，其中风汗出，而反躁烦一语，最为扼要，见无汗之躁烦，用大青龙汤不对，且有亡阳之变，况于有汗之燥烦，其亡阳直在转盼间，此即用真武汤，尚恐不及，奈何可更汗更下乎，本非阙文，但叔和未会仲景之意，类此不一而足，反觉重复缠扰，而今读者茫然耳。十六问，脉双弦而迟者，必心下鞭，脉大而紧者，阳中有阴，可下之也，宜大承气汤，设遇此证，果可下否。答，脉双弦而迟，谓左右皆然，乃阴寒内凝，所以心下必鞭，其脉其证，必因误下，邪未尽退，而反致其虚寒也，仲景金匱方论云，脉双弦者寒也，皆大下后虚脉，所以于结胸条论脉，谓太阳病，脉浮而动数，医反下之，动数变迟，一以误下而脉变双弦，一以误下而脉变迟，可互证也，结胸条以其人邪结在胸，不得已用大陷胸汤，涤去胸间之邪，则与用大承气汤，峻攻肠中之结者悬矣，然且谓脉浮大者，不可下，下之则死，是并陷胸汤亦不可用也，垂戒甚明也，双弦脉即欲用下，当仿用温药下之之例，今反谓宜大承气汤下之者，何耶，至于脉大而紧者，阳中有阴，明谓伤风有寒，属大青龙汤证，其不可下更明矣，两段之文迥不相蒙，叔和汇凑一处，指为可下之证，贻误千载，诚斯道之厄也，尊问不敢行其所疑，具过人之识矣，敬服。

卷三

尚论诸方大意

仲景一百一十三方，用本草九十一一种耳，仲景上溯神农本经药，三百六十五种，效用周天三百六十五度之数，应三才而合四时，妙义开天也，仲景取述神农本经药品，纔九十一一种，入伤寒论中，辅相裁成，有合六经之大纲者，有合六经之一目者，盖神农百病兼收，而仲景则由六经以例百病，所以于上古本经，取裁九十一一种，用之不尽，万世而后，星日炳然，圣之又圣者矣，梁陶隐君别录，倍之为七百三十种，迨唐本图经证类，宋嘉佑政和旁收编录，于是旁门快捷方式，各自成名者多矣，而仲景宫墙生色，间出英贤数十辈，尤为不孤，识大识小，总计一千七百四十六种，病虽百疾，药无纤漏，天下后世永赖焉，然一千七百四十六种，显现亿兆，如同一日昭式，乃至渐推渐广，观察尽矣，何独仲景九十一一种，贤哲挺生，莫识厥旨，昌也晚进无识，手集神农本经，窃以伤寒论中药品为主，其晋唐以后诸贤，发挥伤寒论全方有得者，亦一一录出，而昌亦少步尚论诸方之后，总欲门下好学，随证问药，一目燎然，无检书之苦难是慰耳。

太阳经风伤卫方辨中风证用桂枝汤解肌大纲总法桂枝汤方。桂枝〔三两去皮味辛热〕、芍药〔三两味苦酸微寒〕、甘草〔二两炙味甘平〕、生姜〔三两切味辛温〕、大枣〔十二枚味甘温〕，右五味咀，以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温服一升，服已，须臾歠热稀粥一升余，以助药力温覆令一时许，遍身(仅)(仅)，微似有汗者益佳，不可令如水淋漓，病必不除，若一服汗出病差，停后服，不必尽剂，若不汗更服，依前法，又不汗后服，小促役其间，半日许，令三服尽，若病重者，一日一夜服，周时观之，服一剂尽，病证犹在者，更作服，若汗不出者，乃服至二三剂，禁生冷粘滑肉面五辛酒酪臭恶等物。

太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者热自发，阴弱者汗自出，啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，宜桂枝汤。〔原文〕风之伤人也，头先受之，故令头痛，风在表则表实，故令发热，风为阳，气亦为阳，同类相从，则伤卫外之气，卫伤则无以固卫津液，故令汗出，其恶风者，卫气不能卫也，其脉缓者，卫气不能鼓也，上件皆太阳证，故曰太阳中风，桂枝辛甘，辛则能解肌，甘则能实表，内经曰，辛甘发散为阳，故用之以治风，然恐其走泄阴气，故用芍药之酸以收之，佐以生姜甘草大枣，此发散而兼和里之意，是方也，惟表邪乃可用之，若阳邪去表入里，里作燥渴，二便秘结，此宜承气之时也，而误用之则反矣，昌按承气之误，庸者固然，而工者误在微细，仲景谆切，不似此项，逐条本文，详玩始获。凡桂枝汤病证者，常自汗出，小便不数，手足温和，或手足指稍露之则微冷，覆之则温，浑身热微烦，而又憎寒，始可行之，若病者无汗，小便不数，既手足温和，或手足逆，身冷，不恶寒，反恶热，或饮酒后，慎不可行桂枝汤也，脉紧必无汗，有汗不可误作桂枝证，此脉与证，仲景说得甚明，后人看不透，所以不敢用此方，假今寸口脉微，名曰阳不足，阴气

上入阳也，则洒淅恶寒也，尺脉弱，名曰阴不足，阳气下陷入阴中，则发热也，此谓元气受病而然也，又曰，阳微则恶寒，阴微则发热，医既汗之，使阳气微，又大下之令阴气弱，此谓医所使也，大抵阴不足，阳往从之，故阳内陷而发热，阳不足阴往乘之，故阴上入阳中则恶寒，举此二端，明白易晓，何惮而不用桂枝汤哉。仲景治表虚制此汤，桂枝味辛热，发散助阳，体轻，本乎天者亲上，故桂枝为君，芍药甘草佐之，如阳脉濡，阴脉弦，腹中急痛，乃制小建中汤，以芍药为君，桂枝甘草佐之，一则治其表虚，一则治其里虚，故各有主用也。以桂枝易肉桂，治伤寒腹痛，神品药也，如夏中热，腹疼少加黄芩去桂，痛立止，桂于春夏二时为禁药。按经云，桂枝入咽，阳盛则毙，春夏发者，为禁药也，桂能动血，血热者为禁药也，木得桂而死，肝不足者，为禁药也。桂枝汤有禁用三法〔仲景本文并昌论〕汗后水气上逆有禁更汗增满一法〔本文并昌论〕中风病主用桂枝汤解肌和营卫七法〔本文并昌论〕。或问桂枝汤发字之义，曰一桂枝耳，或云发汗，或云当得汗解，或去当发汗，更发汗，宜桂枝汤者数方，是用桂枝发汗也，复云无汗，不得用桂枝，又曰汗家不得重发汗，又曰发汗过多者，都用桂枝甘草汤，是闭汗也，一药二用，如何说得，仲景发汗，举本草出汗之义，相通为一，答曰，本草云，桂味辛甘热，无毒固为百药之长，通血脉，止烦出汗者，是调血而汗自出也，仲景云，藏无他病，发热自汗者，此卫气不和也，又曰，自汗者为营气和，营气和，则外不谐，以卫气不与营气和谐也，营气和则愈，故皆用桂枝汤，调和营卫，营卫既和则汗自出矣，风邪由此而解，非桂枝能于腠理发出汗也，以其固闭营血，卫气自和，邪无容地而出矣，其实则闭汗孔也，昧者不解闭汗之意，凡是病者，俱用桂枝汤发汗，若与中风自汗者合，效如桴鼓，因见其取效而病愈，则曰此桂枝发出汗也，遂不问伤寒无汗者，亦与桂枝汤，误之甚矣，故仲景言无汗不得服桂枝，是闭汗孔也，又曰发汗多，叉手冒心心悸，欲得按者，用桂枝甘草汤，是亦闭汗孔也，又曰汗家不得重发汗，若桂枝汤发汗，是重发汗也，凡桂枝条下言发字，当认作出字，是汗自然出也，非若麻黄能开腠理，而发出汗也，本草出汗二字，上文有通血脉一句，是非三焦卫气皮毛中药，是为营血中药也，如是则出汗二字，当认作营卫和自然汗出，非桂开腠理，而发出汗也，故后人用桂治虚汗，读者当逆察其意，则可矣，噫，神农作于前，仲景述于后，前圣后圣，其揆一也。不解肌，或误汗，病邪入里，用五苓两解表里二法。一法水逆用之，多服暖水，汗出愈。一法脉浮，小便不利，微热，消渴者用之。五苓散方。猪苓〔十八铢去皮〕、茯苓〔十八铢〕、泽泻〔一两六铢〕、白朮〔十八铢〕、桂〔半两〕，右五味为散，以白饮和服。方寸匕，日三，多服暖水，汗出愈。不解肌，而误发大汗，其变逆，有救亡阳漏风二法。一法真武汤。一法桂枝加附子汤。真武汤方。此本少阴经之神方，并加减法，而太阳上篇，先录之，至太阳下篇，尤宜紧要。先同录此。茯苓〔三两〕、芍药〔三两〕、生姜〔三两切〕、白朮〔二两〕、附子〔一枚炮去皮破八片〕，右五味，以水八升，煮去三升，去滓，温服七合，日三服。桂枝加附子汤。于桂枝汤内加附子一枚，余依桂枝汤法。不解肌，而用烧针取汗，寒入核起，炙核止变一法。桂枝加桂汤更加桂。于桂枝汤方内，更加桂枝二两。中风肌未解，不可下，宜用桂枝汤，解外一法。桂枝汤。方见前。不解肌，反误下，邪不服者，于前下药内，更加桂枝汤一法。即桂枝大

黄汤之互词，因上冲阳位，故两解之也，不上冲者，不用此方。不解肌，反误下，心痞，用温补药，两解表里一法。桂枝人参汤。即理中加桂枝，而易其名也。桂枝〔四两去皮〕、甘草〔四两炙〕、白朮〔三两〕、人参〔三两〕、干姜〔三两〕，右五味，以水九升，先煎四味，取五升，内桂枝，更煮取三升，去滓，温服一升，日再服，夜一服。或问大柴胡，泻也，桂枝人参汤，补也，何为皆治下利，心下痞鞭，曰，此非里热，乃下之早，因作痞，里虚协热而利，表又不解，故与桂枝人参汤，和里解表，若夫伤寒发热，汗出不解，心下痞鞭，呕吐而下利者，表和而里病也，以心下痞鞭故为实，当以大柴胡下之，二者心下痞鞭虽同，而虚实之证有别，故用药有攻补之异，不解肌，反误下，邪入阳明，变用太阳，两解一法。万根黄连黄芩汤方，葛根〔半斤〕、黄连〔一两〕、黄芩〔三两〕、甘草〔二两炙〕，右四味，以水八升，先煮葛根，减二升，内诸药，煮取二升，去滓，分温再服。不解肌，反误下，宜辨阳实阳虚，加减桂枝汤一法。桂枝去芍药汤。下之后，脉促胸满，于桂枝汤内，去芍药一味，余依桂枝汤法。去芍药方中加附子汤。下之，微恶寒，于桂枝汤内去芍药，加附子一枚。不解肌，反误下，阳邪作喘，有用桂枝加行气药一法。桂枝加厚朴杏仁汤。于桂枝汤方内，加厚朴二两，杏仁五十个，余依桂枝汤法。中风病不解，热结膀胱，下血，有宜先表后里一法。桃核承气汤。外不解者，尚未可攻，宜桂枝汤，外解，已少腹急结，可用此攻。桃仁〔五十个去皮尖〕、桂枝〔二两〕、大黄〔四两〕、芒硝〔二两〕、甘草〔二两炙〕，右五味，以水五升，煮取二升半，去滓，内芒硝，更上火微沸，下火，方食，温服五合，日三服，当微利。中风病不解，热瘀蓄血，明辨脉证，用抵当汤二法。一法发狂蓄血重证。一法再辨脉证法中之法。抵当汤方。水蛭〔三十个熬〕、虻虫〔三十个，去翅足，熬〕、大黄〔三两〕、桃仁〔三十个，去皮尖〕，右四味为散，以水五升，煮取三升，去滓，温服一升，不下再服。中风病，下后复汗，因虚致冒，先汗解，后议下一法，遵内经，虚者实之之义，汗法下法，并出方，若论用药，表无过桂枝，里无过大柴五苓矣。中风病，表里已虚，余邪未解，辨脉用治，迥异初病一法。桂枝汤。阳脉微者用此。方见前。调胃承气汤。阴脉微者宜此。方见后。中风病，呕利痞满，表解可攻，与攻胃实迥异一法。十枣汤方。芫花〔熬〕、甘遂、大戟、大枣〔十枚劈〕，右上三味，等分，各别捣为散，以水一升半，先煮大枣，肥者十枚，取八合，去滓，内药末，强人服一钱匕，羸人服半钱，温服之，平日服，若下少病不除者，明日更服，加半钱，得快下，利后，糜粥自养。太阳中风，下利呕逆，表解者，乃可攻之，其人(仅)(仅)汗出，发作有时，头痛，心下痞鞭，满引胁下痛，干呕，短气，汗出，不恶寒，此表解，里未和也，十枣汤主之。〔(仅)音蛰〕。按大枣，纯得土之中气，兼感天之微阳以生，故味甘气平，又温，气味俱厚，阳也，入足太阴阳明经，经曰，里不足者，以甘补之，又曰，形不足者，温之以气，甘能补中，温能益气，甘温能补脾胃，故主治，安中补脾，补中益气，此方三药，皆峻利，故用肥枣十枚，盖戎衣一着，大发巨桥之意，所以题之曰十枣汤，表其用之重也。按神农本经云，芫花味苦寒，主伤寒温疟，下十二经水，破积聚，大坚症瘕，荡涤肠中留癖，饮食寒热邪气，利水道，仲景本方取用，正取此义，后人乃遂改芫花何也，即曰芫花，别录亦云，能消胸中痰水，五藏五水，然本经云，味辛温，全与芫

花不同，且亦并不云主伤寒温症等证也，权移通用，殊非仲景立方本旨，不可不辨。仲景伤寒论，以薤白治利者，取其行水也，水去则利止，用当斟酌，不可过使，须有是证乃用。或问干呕胁痛，小柴胡十枣汤皆有之，一和解一攻伐何也，盖小柴胡证，邪在半表半里间，外有寒热往来，内有干呕诸病，所以不可攻下，宜和解以散表里之邪，十枣汤证，外无寒热，其人(仅)(仅)汗出，此表已解也，但头痛心下痞鞭满，引胁下痛，干呕短气者，邪热内蓄，而有伏饮，是里未和也，与十枣汤以下热逐饮，有表证而干呕胁痛者，乃柴胡汤证，无表证而干呕胁痛者，即十枣汤证也，上文所言头痛者，乃饮家有此证，不可以常法拘，仲景所以述此者，恐后学见其头痛，以为表不解，不敢用也。或问同是心下有水气，干呕欬喘，一用小青龙汤主之，一用十枣汤主之，何也，盖小青龙，治未发散表邪，使水气自毛窍而出，乃内经所谓开鬼门法也，十枣汤，驱逐里邪，使水气自大小便而泄，乃内经所谓洁净府去陈莖法也，夫饮有五，皆内啜水浆，外受湿气，郁蓄而为留饮，流于膈，则为支饮，令人欬喘寒，吐沫背寒，流于肺，则为悬饮，令人欬唾，痛引缺盆，流于心下，则为伏饮，令人胸满，呕吐，寒热眩晕，流于肠胃，则为痰饮，令人腹鸣，吐水，胸胁支满，或作泄泻，或肥或瘦，流于经络，则为溢饮，令人沉重，注痛，或作水气跗肿，芫花大戟甘遂之性，逐水泄湿，能直达水饮窠囊隐僻之处，但可徐徐用之，取效甚捷，不可过剂，泄人真元也，陈言三因方，以十枣汤药为末，用枣肉和丸，以治水气喘急浮肿之证，盖善变通者也，昔杜任问孙兆曰，十枣汤，究竟治甚病，孙曰，治太阳中风，表解里未和也，杜曰，何以知里未和，孙曰，头痛，心下痞满，胁下痛，干呕，汗出，此知里未和也，杜曰，公但言病证，而所以里未和之故，要紧处，总未言也，孙曰，某尝于此未决，愿听开谕，杜曰，里未和者，盖痰与躁气，壅于中焦，故头痛，干呕，短气汗出，是痰膈也，非十枣不治，但此汤不宜轻用，恐损人于倏忽，用者慎之。大抵痰亦水湿之病耳，盖痰涎之为物，随气升降，无处不到，入于心则迷窍而成癫8259，妄言妄见，入于肺则塞窍而成欬唾，稠粘，喘急，背冷，入于肝则留伏蓄聚，而成胁痛干呕，寒热往来，入于经络，麻皮头痛，入于筋骨，则头项胸背胁腰，手足牵引隐痛，然治痰须治其本，痰之本，水也湿也，得气与火则凝滞，而为痰，为饮，为涎，为涕，为癖，故十枣汤逐水去湿，正所以治痰膈耳，中风病误下，热邪内陷，而成结胸诸法。大陷胸汤方。大黄〔六两去皮〕、芒硝〔一升〕、甘遂〔一钱为末〕，右三味，以水六升，先煎大黄，取二升，去滓，内芒硝，一两沸，内甘遂末，温服一升，得快利，止后服，结胸兼涉阳明，仍用本汤。大陷胸丸。结胸似涉柔痉。〔丸成煮汤，连滓服〕。大陷胸丸方。大黄〔半斤去皮〕、葶苈〔半斤熬〕、芒硝〔半斤〕、杏仁〔半斤去皮尖熬黑〕，右四味，捣筛二味，内杏仁芒硝合研，如脂，和散取如弹丸一枚，别捣甘遂末一钱七，白蜜二合，水二升，煮取一升，温顿服之，一宿乃下，如不下，更服取下为效，禁如药法。结胸项强者。胸满鞭痛，能仰而不能俛也，有汗项强为柔痉，此虽有汗，其项强，乃胸中满实，而不能俛，非是中风痉急，故曰如柔痉，不用汤液，而用丸剂，何汤主荡涤，用大陷胸汤，以其从心下至少腹皆鞭痛，三焦皆实，故用汤以荡之，此惟上焦满实用汤液，恐伤中下二焦之阴，故用丸以攻之。按痉，音痴，恶也，当作痉，音径，风强病也。太阳经伤寒营方

辨伤寒证，用麻黄发汗，大纲总法。

麻黄汤方。麻黄〔三两去节〕、桂枝〔三两去皮〕、甘草〔一两炙〕、杏仁〔七十个汤浸去皮尖〕，右四味，以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取二升半，去滓，温服八合，覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息。太阳病头痛发热，身疼腰痛，骨节疼痛，恶风无汗而喘，麻黄汤主之。按太阴少阴有身热而无头痛，盖二经皆不上头故也，厥阴有头痛而无身热，若身热而又头痛，属太阳经也。伤寒头痛，属三阳，乃邪气上攻也，太阳专主头痛，阳明少阳，亦有之，三阴无头痛，盖太阴少阳二经，至胸而还，惟厥阴循喉咙，上入颞颥出额，会于巅，故亦有头痛，伤寒头痛，太阳经居多，头角痛，属少阳经，头额痛，及鼻，属阳明经，头顶痛，属厥阴经。足太阳经，起目内眦，循头背腰腠，故所过疼痛不利，寒邪外束，人身之阳，不得宣越，故今发热，寒邪在表不能任寒，故令恶寒，寒主闭藏，故令无汗，人身之阳，既不得宣越于外，则必壅塞于内，故令作喘，寒气刚劲，故令脉紧。仲景治伤寒，无汗用麻黄，有汗用桂枝，历代名医，未有究其精微，尝绎思之，似有一得云，津液为汗，汗即血也，在营则为血，在卫则为汗，夫寒伤营，营血内濇，不能外通于卫，卫气固闭，津液不行，故无汗，发热而憎寒，夫风伤卫，卫气外泄，不能内护于营，营气虚弱，津液不固，故有汗，发热而恶风，然风寒之邪，由于皮毛而入，皮毛者肺之合也，肺主卫气，包罗一身，天之象也，是证虽属乎太阳，而肺实受邪气，其证时兼面赤，怫郁欬嗽，以及痰喘而胸满者，非肺病乎，盖皮毛外闭，则邪热内攻，而肺气膈郁，故用麻黄甘草，同桂枝引出营气之邪，达之肌表，佐以杏仁泄肺而利气，是则麻黄汤，虽太阳发汗重剂，实为发散肺经火郁之药也。辨脉浮，宜用麻黄汤发汗一法。辨脉浮数，宜用麻黄汤发汗一法。即脉不紧但浮，及浮数，俱必用此。辨伤寒欲传不传，心悸而烦，宜用建中一法。太阳中篇连大纲，止此三法。变法用桂枝汤加减七法。小建中汤。桂枝〔三两去皮〕、芍药〔六两〕、甘草〔二两炙〕、生姜〔三两切〕、胶饴〔一升〕、大枣〔十二枚擘〕，右六味，以水七升，煮取三升，去滓，内胶饴，更上微火，消解，温服一升，日三服，呕者不可用建中汤，以甜故也。按山僻绝无医药之区，每遇头痛发热，用蜜法，山椒炒鸡，炊饭一饱，津津发汗，岂非得建中意乎。服麻黄汤，得汗后，察脉辨证，有次第不同三法。一法伤寒发汗，解半日许，复烦脉浮者，可更发汗。宜桂枝汤，方见上篇。再按发汗已解，因表疏外邪内袭，可更发汗，宜桂枝汤，仲景意中，蚤已虑其正虚，桂枝解肌，诚正法也，昌欲表虚之体，少和人参，助正驱邪，免致再袭三袭，留连而至殆耳，略加人参，托出其邪，岂不善乎，粗医不行微汗，辄至表疏邪入，汗而又汗，展转增变，卒至莫救，可为寒心。一法发汗已，脉浮数烦渴者，宜表里两解，五苓汤。方见上篇。一法汗出而渴，五苓散不渴者，茯苓甘草汤。茯苓甘草汤方。茯苓〔三两〕、桂枝〔二两去皮〕、生姜〔三两切〕、甘草〔一两〕，右四味，以水四升，煮取二升，分温三服。辨脉浮紧浮数，尺脉反迟反微，不可发汗二法。再按二条，但论其法，然无药也，宜用建中汤，生其津液，津液充，则谷气传肾而生精血，所以自致表里俱实，便自出汗而愈，可见津液精血，人身之至宝也，服麻黄汤，汗后病不解，有恶寒恶热，不同治一法。芍药甘

草附子汤方。恶寒者虚也。芍药〔三两〕、甘草〔二两炙〕、附子〔一枚泡去皮切八片〕，已上三味，以水五升，煮取一升五合，去滓，分温服。调胃承气汤方。不恶寒但热者，实也，当和胃气，与此方。大黄〔四两，去皮，清酒浸〕、芒硝〔半斤〕、甘草〔二两炙〕，右三味，咀，以水三升煮取一升，去滓内芒硝，更上微火煮令沸，少少温服。服黄麻汤后，身痛，脉沉迟者，宜行补散一法。桂枝加芍药生姜人参新加汤方。桂枝〔三两去皮〕、芍药〔四两〕、甘草〔二两炙〕、人参〔三两〕、生姜〔四两切〕、大枣〔十二枚劈〕，右六味，以水一斗一升，微火煮取三升，去滓，分温服。〔如桂枝法〕。或问经言表邪盛，脉浮而紧，法当身疼痛，宜以汗解之，况身疼皆系表邪未尽，此又加人参芍药生姜以益血，何也，曰表邪盛，则身疼，血虚则身亦疼，其脉浮紧者邪盛也，其脉沉微者血虚也，盛者损之则安，虚者益之则愈，仲景凡言发汗后，以外无表证，内无热证，止余身疼而已，若脉稍浮盛，则为表邪未尽解，今言脉沉迟，此血虚而致然也，故加人参生姜芍药以养血。服麻黄汤后，不可误用桂枝，及饮水灌水过多一法。麻杏甘石汤方。治喘饮水灌水。麻黄〔四两去节〕、杏仁〔五十个，去皮尖〕、甘草〔二两炙〕、石膏〔半斤，碎，绵裹〕，右四味，以水七升，先煮麻黄，减一升，去上沫，内诸药，煮取二升，去滓，温服一升。本麻黄汤证，误下表邪未尽，气逆变喘一法。麻黄杏仁甘草石膏汤。误下变喘。方同前。服麻黄汤后，有阳气暴虚，叉手自冒心悸，及耳聋无闻，二法。桂枝甘草汤方。桂枝〔四两去皮〕、甘草〔二两炙〕，右二味，以水三升，煮取一升，去滓顿服。按心下悸，及耳聋无闻，皆阳气暴虚，仲景止用桂枝甘草二味，补虚之义，显明易见，如二证大虚，又必多用人参矣，服麻黄汤后，有阳气暴虚，阴邪上逆，脐下悸，腹胀满，二法。茯苓桂枝甘草大枣汤方。欲作奔豚，预伐其邪。茯苓〔半斤〕、桂枝〔四味，去皮〕、甘草〔二两炙〕、大枣〔十二枚劈〕，右四味，以甘澜一斗，先煮茯苓，减二升，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服，作甘澜法，取水三斗，置大盆内，以杓扬之，水上有珠子五十千颗，相逐取用之。厚朴生姜甘草半夏人参汤方。汗后腹胀满。厚朴〔半斤去皮炙〕、生姜〔半斤切〕、半夏〔半斤洗〕、人参〔一两〕、甘草〔四两炙〕，右五味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。服麻黄汤后，不繇误下，津干饮结，胃困变痞一法。生姜泻心汤方。生姜〔四两，切〕、甘草〔三两炙〕、人参〔三两〕、干姜〔一两〕、黄芩〔三两〕、半夏〔半斤洗〕、黄连〔一两〕、大枣〔十二枚劈〕，右八味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。误下成痞，用泻心汤方次第不同四法。一法误下后，再误下，客热虚痞，用甘草泻心汤。一法误下后，复发汗恶寒，先解表，用大黄黄连泻心汤。一法上有阴气，协热邪作痞，用大黄黄连泻心汤矣，而阴气乘阳虚作痞，用附子泻心汤。一法心下满，而不痛者，用半夏泻心汤。甘草泻心汤方。甘草〔四两〕、黄芩〔三两〕、半夏〔半斤洗〕、大枣〔十二枚劈〕、干姜〔一两〕、黄连〔一两〕，右六味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。病在表而反下之，则逆矣，下而虚其中气，则表邪乘之而入，虚不任邪，今人谓之挟热利也，火性急速，穀虽入而未及化，故谷不化，虚阳上迫，故令腹中雷鸣。中虚不能化气，故令痞鞭而满，胃虚客气上逆，故令干呕，心烦不得安，人参甘草大枣，胃虚之圣药也，半

夏干姜，呕逆之圣药也，黄连黄芩，痞热之圣药也。相传伊尹汤液，原有甘草泻心汤，治证同上，仲景本此方，而但去人参，可见先哲皆有祖述，不似后人一味臆骋。〔此云去人参，未是〕。海云，伊尹汤液，此汤七味，今监本无人参，脱之也，此为定衡。大黄黄连泻心汤方。大黄〔二两〕、黄连〔一两〕，右二味，以麻沸汤二升，渍之须臾，绞去滓，分温再服。按结胸之脉沉实，其病谓之实邪，故下之也急，痞气之脉，关脉必浮，其病谓之虚邪，故下之也缓，彼用大黄则煎之，乃取其气味厚，此用大黄即渍之，取其气味薄也。大黄乃足太阴，手足阳明，手足厥阴，五经血分之药，凡病在五经之血分者，宜用之，若在气分用之，是谓诛伐无过矣，故仲景言治心下痞满，按之软者，用大黄黄连泻心汤主之，此正泻脾胃之湿热，非泻心也，病发于阴而反下之，则作痞满，乃寒伤荣血，邪气乘虚结于上焦，胃之上脘在于心，故曰泻心，实泻脾也，素问云，太阴所至为痞满，又云浊气在上，则生8250胀是矣，病发于阳，而反下之，则成结胸，乃热邪陷入血分，亦在上脘分野，大陷胸汤丸，皆用大黄，亦泻脾胃血分之邪，而降其浊气也，若结胸在气分，则只用小陷胸汤，痞满在气分，则用泻心汤矣。〔8250音噤，肉胀起也〕。麻沸汤即热汤，一名百沸汤，一名太和汤，味甘平无毒，主治助阳气，通经络。附子泻心汤方。大黄〔二两〕、黄连〔一两〕、黄芩〔一两〕、附子〔一枚，炮去皮，别煮取汁〕，右四味，初三味，以麻沸汤二升渍之，绞去滓，内附子汁，分温再服。按心下满而痛者，为实，为结胸鞭满不痛者，为虚，为痞气，不满不痛，但烦闷者，为支结，保命集云，脾不能行气于四藏，结而不散，则为痞，大抵诸痞皆热也，故攻痞之药皆寒剂，其一加附子，是以辛热佐其寒凉，欲令开发痞之拂郁结滞，非攻寒也，先发汗，或下后，阳气虚，故恶寒汗出，太阳证云，发汗后恶寒者虚也，此加附子，恐大黄黄连损其阳也，非补虚也。半夏泻心汤方。半夏〔半斤，洗〕、黄芩〔三两〕、干姜〔三两〕、甘草〔三两〕、人参〔三两〕、黄连〔一两〕、大枣〔十二枚，劈〕，右七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。按至于下后，邪气传里，亦有阴阳之异，若下后阳邪传里者，则结于胸中为结胸，以胸中为阳受气之分，与大陷胸汤，以下其结，阴邪传里者，则留于心下为痞，以心下为阴受气之分，与半夏泻心汤，以通其痞。服泻心汤，痞不解，烦渴，小便不利，用五苓两解表里一法。前第九条，五苓汤方，两解表里，于此更治痞满，服泻心汤，复误下，利不止，宜治下焦一法。赤石脂禹余粮汤方。赤石脂〔一斤，碎〕、禹余粮〔一斤，碎〕，已上三味，以水六升，煮取二升，去滓，分三服，下之，利不止者，下之虚其里，邪热乘其虚，故利，虚而不能禁固，故不止，更无中焦之证，故曰病在下焦，涩可以固脱，故用赤石脂，重可以镇固，故用禹余粮，然惟病在下焦者可以用，若病在中焦，而误以为虚者，则二物之气，益坏于中，气实者固而而瀉之，则邪无自而泄，必增腹胀且痛矣，慎之慎之。再按难经曰，中焦者，在胃中脘，主腐熟水穀，下焦者，当膀胱上口，主分别清浊，主出而不内，以传道也，灵枢曰，水穀者常居于胃中成糟粕，而俱下于小肠而成下焦，渗而居下，济泌别汁，循下焦而渗入膀胱焉，然则利在下焦者，膀胱不渗，而大肠滑脱也，禹余粮甘平，消痞鞭，而镇定其脏腑，赤石脂甘温，固阳虚而收其滑脱也，若膀胱不渗，水谷不分，更当导利小便，令分清之，使府司各行其事，始无余治而愈也。汗吐

下解后，余邪挟饮作痞，用旋复代赭石汤一法。旋复代赭石汤方。旋复花〔三两〕、人参〔二两〕、生姜〔五两切〕、代赭石〔一两〕、半夏〔半斤，洗〕、甘草〔三两炙〕、大枣〔十二枚，劈〕，右七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。汗吐下而解，则中气必虚，虚则浊气不降而上逆，故作痞鞭，逆气上干于心，心不受邪，故噫气不除。内经宣明五气篇，曰五气所病，心为噫，是也，旋复之咸，能饮痞鞭而下气，代赭之重，能镇心君而止噫，姜夏之辛，所以散逆，参甘大枣之甘，所以补虚，或曰汗吐中虚，肺金失冷，肝气乘脾，而作上逆，逆气干心，心病为噫，此方用代赭石，所以镇心，亦所以平肝也，亦是究理之论。昌用此方，治反胃多痰，气逆并哕者，愈千人矣。伤寒下早，亦成结胸之证四法。一法辨大结胸，用大陷胸汤。热实脉沉紧，心下痛，按之不鞭，水饮结在胸胁，主大陷胸汤。〔原文〕一法辨小结胸，用小陷胸汤。正在心下，按之则痛，脉浮微滑，发热，微恶寒，头疼微呕，心下支结，用柴胡桂枝汤。〔原文〕一法热结在里，与结胸异治。一法辨邪热在表，心下支结，但治其表。小陷胸汤方。黄连〔一两〕、半夏〔半升洗〕、括蒌实〔一枚大者〕，右三味，以水六升，先煮括蒌，去滓，内诸药，煮取二升，去滓，分温三服。大陷胸汤方。水饮结在胸胁，仍用此方。方见前。柴胡桂枝汤方。不宜大小限胸之法，用此方。柴胡〔四两〕、黄芩〔一两半〕、人参〔一两半〕、桂枝〔一两半〕、甘草〔一两〕、半夏〔二合半〕、生姜〔一两半切〕、芍药〔一两半〕、大枣〔六枚劈〕，右九味，以水七升，煮取三升，去滓，分温服。辨伤寒太阳兼少阳，连上共五法。小柴胡汤方。柴胡〔半斤〕、黄芩〔三两〕、半夏〔半斤洗〕、人参〔三两〕、甘草〔三两〕、生姜〔三两切〕、大枣〔十二枚劈〕，右七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。伤寒四五日，身热恶风，头项强胁下满，手足温而渴者，小柴胡汤主之。〔原文〕伤寒五六日，中风往来，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴或腹中痛，或胁下痞鞭，或心下悸，小便不利，或不渴，身有微热，或欬者，小柴胡汤主之。〔原文〕〔加減去〕若胸中烦满而不呕，去半夏人参，加括蒌实一枚。若渴者，去半夏，加人参，合前成四两半，括蒌根四两。若腹中痛，去黄芩，加茯苓四两。若不渴，外有微热者，去人参，加桂枝三两，温服取微汗愈。若欬者，去人参大枣生姜，加五味子半升，干姜二两。经曰，伤寒中风有柴胡证，但见一证便是，不必悉具，邪在表则寒，邪在里则热，今邪在半表半里之间，未有定处，是以寒热往来也，邪在表则心腹不满，邪在里则心腹胀满，今止言胸胁苦满知邪气在表里也，经曰，阳入之阴则静，默默者，邪方自表之里，在表里之间也，能食不能食，烦不烦，呕不呕，皆然邪初入里未有定处，则所处不一，故有或为之证，柴胡证，但见一证便是，不必悉具，正指此或为之证也。伤寒阳脉涩阴脉弦，法当腹中急痛者，先与小建中汤，不瘥者，与小柴胡汤主之。〔原文〕小建中汤方。方见前。服小建中汤不瘥者，盖少阳属木，其脉弦，木盛则土受克，故涩而急痛也，故伐木以救土也。柴胡桂枝干姜汤方。柴胡〔半斤〕、桂枝〔三两去皮〕、干姜〔三两〕、黄芩〔三两〕、括蒌根〔四两〕、牡蛎〔三两熬〕、甘草〔二两炙〕，右七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服，初服微烦，后服汗出便愈。按已发汗，而复下之，虽不失先发后攻之

序，及当汗而反下之宜，然既汗之，邪当自散，若不待其全解后，内实而复下之，是犹伤于早也，乌得不结，然已发汗，则邪势已衰，虽或失之下早，故结亦当微也。伤寒五六日，已发汗，而复下之，胸胁满微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热心烦者，此为未解也，柴胡桂枝干姜汤主之。〔原文〕太阳病，十日以去，脉浮细而嗜卧者，外解已也，设胸满胁痛者，与小柴胡汤，脉浮者，用麻黄汤。〔原文〕脉微细而嗜卧者，大邪已退，血气乍虚，而支体倦怠也，胸满胁痛，则少阳未除，故与小柴胡以和之，脉但浮则邪还表，故与麻黄以发之。柴胡加龙骨牡蛎汤方。柴胡〔四两〕、半夏〔二合洗〕、龙骨〔一两半〕、人参〔一两半〕、茯苓〔一两半〕、铅丹〔一两半〕、桂枝〔一两半，去皮〕、生姜〔一两半〕、大黄〔二两〕、牡蛎〔一两半〕、大枣〔六枚，劈〕，右十一味，以水八升，煮取四升，内大黄，切如碇子，更煮一二沸，去滓，温服一升。辨下后胸满烦惊，身重困笃，用此汤。〔原文〕病久脉代结心动悸，宜补胃生津，兼散邪，用炙甘草汤一法。炙甘草汤方。甘草〔四两，炙〕、生姜〔三两切〕、桂枝〔三两去皮〕、麦门冬〔半斤〕、麻子仁〔半斤〕、大枣〔十二枚，劈〕、人参〔二两〕、生地〔一斤〕、阿胶〔二两〕，右九味，以清酒七升，水八升，先煮前药八味，取三升，去滓，内胶烊消尽，温服一升，日三服，一名复脉汤。误下，下利不止，身疼痛，宜先救里后救表一法。先救里用四逆汤。四逆汤方。甘草〔二两炙〕、干姜〔一两半〕、附子〔一枚〕，右三味咀，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服，强人用大附子一枚，干姜三两。服后身疼痛，便清自调者，急救表，用桂枝汤。方见上篇。辨误下，引邪内入，用栀子汤取吐，三法。病人粪微溏者，不可服。一法下后烦满不安，用栀子厚朴汤。栀子厚朴汤方。栀子〔十四枚，劈〕、厚朴〔四两姜炙〕、枳实〔四两，汤浸，去瓢炒〕，已上三味，以水三升半，煮取一升半，去滓，分三服，温进一服，得吐，止后服。一法误用丸药，大下身热微烦，用栀子干姜汤。栀子干姜汤方。栀子〔十四枚，劈〕、干姜〔二两〕，右二味，以水三升半，煮取一升半，去滓，分二服，温进一服，得吐，止后服。一法大下后，身热心中结痛，用栀子豉汤。栀子豉汤方。栀子〔十四枚劈〕、香豉〔四合，绵裹〕，右二味，以水四升，先煮栀子，得二升半，内豉，煮取一升半，去滓，分为二服，温进二服，得吐，止后服。又本方一法。发汗若下，烦热胸中窒者，用此方。〔原文〕。发汗吐下后，虚烦不眠，反复颠倒懊憹者，用此方。〔原文〕又加味二法。若少气者，栀子甘草豉汤。于前方内，加倍甘草。若呕者，栀子生姜豉汤。于前方内，加倍生姜甘草。辨下后，复发汗之脉证，昼夜静躁一法。干姜附子汤方。昼日烦躁，夜而安静，脉沉微，身无大热者。干姜〔一两〕、附子〔一枚，生用，破八片〕，右二味，以水三升，煮取一升，去滓顿服。按用姜附二味，偏于辛热者，恢复重虚之阳，而求以协和于偏胜之阴也。辨吐下后复汗，身为振摇动惕，久成痿废二法。茯苓桂枝白朮甘草汤方。茯苓〔四两〕、桂枝〔三两去皮〕、白朮〔二两〕、甘草〔二两炙〕，右四味，以水六升，煮取三升，去滓，分温三服。辨伤寒热瘀，小便反利，为蓄血，用抵当丸一法。抵当丸方〔上篇用抵当汤〕。水蛭〔二十个，熬〕、虻虫〔二十五个，熬，去翅〕、桃仁〔二十个，去皮尖〕、大黄〔二两〕，右四味，杵分为四丸，以水一升，煮一丸，取七合，服啐时，当自下血，若不下，更服。辨伤寒

风湿相搏，身体烦疼，脉证二法。桂枝附子汤方。桂枝〔四两，去皮〕、附子〔三枚，炮去皮，破八片〕、生姜〔三两切〕、甘草〔三两，炙〕、大枣〔十二枚，劈〕，右五味，以水六升，煮取三升，去滓，分温三服。去桂枝加白朮汤方。大便利者，用此。于桂枝附子汤方内，去桂枝，加朮三两，余依前法。甘草附子汤。甘草〔二两，炙〕、附子〔九枚，泡去皮脐〕、白朮〔二两〕、桂枝〔四两去皮〕，右四味，以水六升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服，初服得微汗，则解能食，汗出复烦者，服五合，恐一升多者，宜服六七合为妙。按上条顶伤寒，此条顶中风无疑，本文痛不可近，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿语，皆是中风，可见风寒与湿相搏，冬月若此，而风与湿湿热湿相搏，夏月反若彼，王叔和云，伤寒所致太阳痉湿喝三种，宜应别论，以为与伤寒相似，故此见之，果何说耶，太阳经证，痉湿喝居先，伤寒证居后，眩眩无定，乃后代咸为取宗焉，伤寒书，诚疑而难读之矣。辨伤寒发黄，有寒湿相搏三法。麻黄连轺赤小豆方。麻黄〔二两〕、赤小豆〔一升〕、杏仁〔四十枚，去皮尖〕、连轺〔二两，连翘根也〕、大枣〔十二枚，劈〕、生姜〔二两，切〕、甘草〔一两，炙〕、生梓白皮，已上八味，以潦水一斗，先煮麻黄，再沸，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服，半日则尽。瘀血在里，身必发黄，用前方。〔原文〕茵陈蒿汤方。茵陈蒿〔六两〕、栀子〔十四枚，劈〕、大黄〔三两〕，右三味，以水一斗，先煮茵陈，减六升，内二味，煮取三升，去滓，分温三服，小便当利，若尿如皂角汁状，色正赤，一宿腹减，黄从小便去也。身黄如橘子色，小便不利，腹微满者，用前方。〔原文〕栀子柏皮汤方。栀子〔十五枚，劈〕、甘草〔一两炙〕、黄蘗〔一两〕，右三味，以水四升，煮取一升半，分温再服。身黄发热者用前方。按热已发出于外，则与瘀热不同，正当随热势而亟散其黄，俾不留于肌表也，前条热瘀，故用麻黄，此条发热，反不用麻黄，正所谓寒湿中求之，不尽泥伤寒之定法矣，此隶太阳中篇，惟仲景乃识其旨，所谓者何，盖四条已发于痉湿喝三种，淤热蒸黄之先，凡近岂能窥乎，至于总入阳明发黄，尤为肤浅矣。附越脾汤方。麻黄〔六两〕、石膏〔八两〕、生姜〔二两〕、甘草〔二两〕、大枣〔十二枚〕。太阳经风伤卫寒伤营方大青龙汤，风寒两伤，大纲总法。大青龙汤。麻黄〔六两，去节〕、桂枝〔二两，去皮〕、甘草〔二两炙〕、杏仁〔四十枚，去皮尖〕、生姜〔三两切〕、石膏〔如鸡子大，绵裹，碎〕、大枣〔十二枚，劈〕，右七味，以水九升，先煮麻黄减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，取微似汗，汗出多者，温粉扑之，一服汗者，停后服，汗多亡阳，遂虚恶风烦躁，不得眠也。服青龙汤，厥逆筋惕肉瞤，此为逆也，用真武汤救之。〔原文〕真武汤方。茯苓〔三两〕、芍药〔三两〕、生姜〔二两，切〕、白朮〔二两〕、附子〔一枚，炮，去皮，破八片〕，右五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服。此乃少阴经之方，先录于此。按成注，谓不久厥，吐利，无少阴里证，大谬，无少阴证者，但欲寐，尚不止少阴疑似，况敢言不久厥吐利等耶。麻黄味甘温，桂枝味辛热，寒则伤营，必以甘缓之，风则伤卫，必以辛散之，此风寒两伤，营卫俱病，故以甘辛相合，而为发散之剂，甘草味甘平，杏仁味甘苦，苦甘为助，佐麻黄以发表，大枣味甘温，生姜味辛温，辛甘相合，佐桂枝以解肌，石膏味甘，微寒，而使石膏为重剂，而又专达肌表者也。大青龙

汤，发汗之重剂，非桂枝所同，用之稍逆，则又有亡阳之失，若脉微弱，汗出恶风者，不可服，服之，则厥逆筋惕肉瞤，此为逆也。伤寒发热恶寒，烦躁，身心无奈者，发汗则愈，譬若亢热已极，一雨而凉，其理可见也，若见其躁热，投以寒凉，其害岂胜言哉。中风脉浮紧，伤寒脉浮缓，仲景以青龙对之，证候与脉相对，无不应手而愈。风伤卫，卫气也，寒伤荣，荣血也，荣行脉中，卫行脉外，寒邪居脉中，非特营受病，邪自内作，则并与卫气犯之，则浸淫入骨，亦自有浅深也。太阳中风，脉浮紧，发热恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁者，大青龙汤主。〔原文〕伤寒脉浮缓，身不疼，但重，乍有轻时，无少阴证者，前汤发之。〔原文〕大青龙汤，仲景治伤寒发热，恶寒烦躁者则用之，夫伤寒邪气在表，不得汗出，其人烦躁不安，身心无如之奈何，如脉浮紧，或浮数者，急用此汤，发汗则愈，若不浮紧而数，无恶寒身疼者，亦不可用，所以脉证不明者，多不敢用也。仲景治伤寒，一则桂枝，二则麻黄，三则青龙，桂枝治中风，麻黄治伤寒，青龙治中风见寒脉，伤寒见风脉，三者如鼎立，人皆能言之，而不晓前人处方用药之意，故医遂多不用，昌谓脉缓而浮者中风也，故啬啬恶风，淅淅恶寒，翕翕发热，仲景以桂枝对之，脉紧而啬者伤寒也，故有头痛发热，身疼腰痛，骨节疼痛，恶寒无汗而喘，仲景以麻黄对之，至于中风脉浮紧，伤寒脉浮缓，仲景皆以青龙对之，昌为究之，风伤卫，则风邪干阳，阳气不固，发越而为汗，是以自汗，是表虚，故仲景用桂枝以发其邪，芍药以和其血，盖中风则病在脉之外，其病稍轻，虽同曰发汗，实解肌之药耳，所以仲景于桂枝证云，令半身(仅)(仅)微似有汗，不可如水淋漓，病必不除，可知中风，不可大发汗，汗过则反动营血，邪气乘虚袭之，故病不除也，寒伤营，则寒邪入阴血，而营行脉中者也，寒邪居脉中，非特营受病，邪自内作，则并与卫气犯之，久则浸淫入骨，是以汗不出而热，齿齲而烦冤，仲景以麻黄发其汗，又以桂枝助其发散，欲涤除内外之邪营卫之病耳，大抵二药皆发汗，以桂枝发其卫之邪，麻黄开营卫之病，治自有浅深也，何以验之，观仲景第十九证云，病当自汗出者，此为营气和，营气和者，外不谐，以卫气不共营气和谐故也，以营行脉中，卫行脉外，复发其汗，营卫和则愈，宜桂枝汤，又四十七证云，发热汗出，此为营弱卫强，故使汗出，欲救邪风者，宜桂枝汤，是知中风汗出者，营和而卫不和，又第一卷云，脉浮而紧，浮则为风，紧则为寒，风则伤卫，寒则伤营，俱病者即烦疼，当发其汗，是知伤寒浮紧者，营卫俱病也，此麻黄汤中并用桂枝，此仲景之言也，至于青龙，虽治伤风且寒脉，伤寒见风脉之病，然仲景又云，阳微恶风者，不可服，服之厥逆，便有筋惕肉瞤之症，故青龙一证，尤难用药，须是形证谛当，然后可行。热盛而烦，手足自温，脉浮而紧，此伤风见寒脉也，不烦少热，四肢微厥，脉浮而缓，此伤寒见风脉也，二者为营卫俱病，法宜大青龙汤。小青龙汤方。麻黄〔去节〕、桂枝、芍药〔酒炒〕、细辛、甘草〔炙〕、干姜〔各三两〕、半夏、五味〔半升〕。伤寒表不解，心下有水气，干呕发热而欬，或渴或利或噎，或小便不利，少腹满，或喘者，小青龙汤主之。〔噎音渴，食质气不通也。原文〕伤寒心下有水气，欬而微喘，发热不渴，服已渴者，此寒去欲解也，小青龙汤主之，〔原文〕。或问小青龙与小柴胡证，皆呕而发汗，表里之证，大概彷彿，何故二方用药之不同，曰夫伤寒表不解，里热未甚，而渴欲饮水，不能多，不当与之，以腹中热尚少，而不能消，水

饮停蓄，故作消证，然水寒作病，非温热之剂不能解，故用小青龙发汗散水，原其理初无里证，因水寒以致然也，若小柴胡汤，则系伤寒发热之邪传里，在于半表半里之间，热气内攻，故生诸证，是二证，虽曰表里俱病，至其中之寒热，则全不同，故用药有姜桂柴苓之异耳。干姜附子汤方。干姜、附子。下之后，复发汗烦躁，不得眠者，干姜附子汤主之。〔原文〕此当与栀子鼓汤证参看，盖下后烦不得眠，一也，而用药有寒热不同故尔。服姜附汤有二法，一法当热服，手少阴心也，水包火，热服以接心火，身表寒盛，外火少也，寒从外生，热从内消，譬如冻死，寒在外也，一法当寒服，足少阴肾也，寒邪入水，令冷服以类肾水，身表微热，内水多也，热从外生，寒从内消，譬如饮冷，寒在内也。麻黄杏仁甘草石膏汤方。方见前。发汗后，汗出而喘，无大热者，麻黄杏仁甘草石膏汤主之。〔原文〕予观仲景常言发汗后，乃表邪悉解，止余一证而已，故言不可更行桂枝汤，今汗出而喘，无大热，乃上焦余邪未解，当用此方以散之，夫桂枝加厚朴杏仁汤，乃桂枝证悉具，而加喘者用之，注言汗出而喘，以为邪气壅甚，非桂枝所能发散，此误也，况身无大热，更无证，何故复言表邪必盛，其后章下后，不可更行桂枝汤条下，注曰，汗下虽殊，其不当损正气则一，其言有至理存焉，可见汗后所注之误矣，大抵当时因事发机，前后失于照应，故有此等之弊也。桂枝甘草汤方。桂枝、甘草、大枣。发汗过多，其人叉手，自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之。〔原文〕悸心动也，怔怔忪忪，不能自安也，有气虚而悸，阳气内弱，心下空虚也，有停水饮而悸，心为火而恶水，水既内停，心不自安也，有汗下后而悸，汗为心液，汗去心虚，如鱼离水在，故悸与惊不同。茯苓甘草大枣汤方。茯苓、桂枝、甘草、大枣。发汗后，其人脐下悸者，欲作奔豚，茯苓甘草大枣汤主之。〔原文自明〕厚朴生姜半夏甘草人参汤方。厚朴、生姜、半夏、甘草、人参汗后腹胀满者，前汤主之。〔原文自明〕或问太阳篇中，发汗后诸证，不言太阳病，固所当然，亦合列于伤寒之右，何故止言发汗后腹胀者，厚朴生姜半夏甘草人参汤主之，曰凡言发汗后者，以外无表证，里无别邪，止有腹痛一事而已，除此之外，即获全安，夫伤寒二字，岂可易言哉，其传变吉凶，犹反掌耳，可与所余一证而并例哉，乱其诸汗后，不殊此意。芍药甘草附子汤方。芍药、甘草、附子。发汗病不解，反恶寒者虚故也，芍药甘草附子汤主之。〔原文自明〕四逆汤方。方见前。发汗若下之，病仍不解烦躁者，茯苓四逆汤主之。〔原文〕五苓散方。方见前。太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈，若脉浮，小便不利，微热消渴者，与五苓散主之。〔原文〕水道为热所蔽，故令小便不利，小便不利，则不能运化津液，故令渴，水无当于五味，故用淡以治水，茯苓猪苓泽泻白朮，虽有或润或燥之殊，然其为淡则一也，故均足以利水，桂性辛热，辛热则能化气，内经曰，膀胱者州都之官，津液藏焉，气化则能出矣，此用桂之意也，浊阴既出下窍，则清阳自出上窍，又热随溺而泄，则渴不治可以自除，虽然小便不利，亦有因汗下之后，内亡津液而致者，不可强以五苓散利之，强利之，则重亡津液，益亏其阴，故曰大下之后，复发汗，小便不利者，亡津液故也，勿治之，得小便利必自愈，师又曰，太阳随经之邪，直达膀胱，小便不利，其人如狂者，此太阳之邪，不传他经自入其府也，五苓散主之，是使阳邪由溺而泄耳。发汗见脉浮数，烦渴者，五苓散主之。

〔原文〕按太阳标病，传入标之本，发渴溺不利，以此散导之，邪自膀胱而出也，若未渴，用五苓散，反引邪气入里，而不能解也，故易老云，即太阳经下药也，若伤寒太阳脉紧而渴者，不宜用此。中风发热，六七日不解而烦，有表里证，欲饮水，水入则吐者，名曰水逆，五苓散主之。本以下之故，心下痞，与泻心伤，痞不解，其人渴而口燥烦，小便不利者，五苓散主之。太阳病，寸缓关浮尺弱，其人发热汗出，复恶寒不呕，但心下痞者，此以医下之也，如其不下者，病人不恶寒，而渴者，此转属阳明也，小便数者，大便必鞭，不更衣，十日无所苦也，渴欲饮水，少少与之，但以法救之，宜五苓散。〔原文〕或问上条云，小便数者大便必鞭，不更衣十日，无所苦也，尝有四五日，六七日，不大便者，即为攻之，今言十日不更衣，而不用攻伐，何也，曰此非结热，乃津液不足，虽十日不更衣，亦无所苦也，经曰阳明病，本自汗出，医更重发汗，病已瘥，尚微烦不了了者，此大便必鞭故也，以亡津液，胃中干燥，故令大便鞭，当问其小便日几行，本小便日三四行，今日再行，即知大便不久出，为小便数少，以津液足胃中，故知不久大便也，夫不便者，若有潮热譫语可下之证者，然后可以攻之，其不大便，而无诸下证者，此津液不足，须当自审，慎勿以日数久，而辄为攻下也。五苓散，为太阳里之下药也，太阳高则汗发之，下则引而竭之，渴者邪入太阳里也，当下之，使从膀胱出也。肾燥膀胱热，小便不利，此药主之，小便利者不宜用，然太阳病，热而渴，小便虽利，亦宜五苓散主之。当服不服，则生何证，答曰，当服不服，则穀消水去，必致阳明躁火，郁胃发黄，故有调胃汤证，此太阳入本，失下也，由不曾服五苓散故也。不当服，服之则生何证，答曰，不当服而服之，是为犯本，小便强利，津液重亡，侵阳之极，则侵阴而成血证也，轻则桃仁承气汤，重则抵当汤，故五苓散，调和阴阳者也，乃太阳阳明之间，故为调和之剂，酒毒小便赤涩，宜五苓散，但热在中焦，未入太阳之本，小便自利而清，乃津液已行者，若与五苓散利之，则重涸肾水，不惟重涸肾水，而酒毒之热，亦不能去，以故上下不通，而溺澹，则为发黄证也，若入血室，则为蓄血，用五苓散以泻湿热。太阳证，伤寒自外入，其标本有二说，以主言之，膀胱为本，经络为标，以邪言之，先得者为本，后得者为标，此乃客邪之标本也，治当从容之标本。又小肠火为本，膀胱水为标，乃寒毒之气，从标入本，邪与手经相合，而下至膀胱，五苓主之，以方内桂枝阳中之阳，茯苓阳中之阴，相引而下于本，导出邪气。

手经 自上之下 足经丙火 壬水

小肠 自下之上 膀胱火邪之气，从下之上，以内为本，水中有火，火为客气，当再责其本，两肾相通，又在下部，责在下焦，下焦如渫，相火明也，生地黄黄蘗主之，邪从本受，下焦火邪，遗于小肠，是热在下焦，填塞不便，自内而之外也，盖生地黄黄蘗黄连，乃阴中之阳，为里之表药，若五苓之桂朮泽泻猪苓茯苓，乃阳中之阴，为表之里药也。治酒病宜发汗，若止以五苓利小便，炎焰不肯下行，故曰火郁则发之，辛温则散之，是从其火体也，乃知利小便，湿去热不去，动大便，尤为疏远，大便者有形质之物，酒者无形，水也，从发而汗之，最为之近，以使湿热俱去

，盖治以辛温，发其火也，佐以苦寒，除其湿也。茯苓甘草汤方。茯苓、桂枝〔二两〕、甘草〔一两〕、生姜〔一两〕。伤寒汗出而渴者，五苓散主之，不渴者，茯苓甘草汤主之。〔原文〕伤寒厥而心下悸者，宜先治水，当服茯苓甘草汤，却治其厥，不尔水渍入胃，必作利也。〔原文〕金匱要略曰，水停心下，甚者则悸，厥虽寒胜，然以心下悸为水饮内甚，先与此汤治其水，而后治其厥，若先治厥，则水饮浸渍入胃，必作下利。凡治悸，其法或镇固之，或化散之，惟饮之为悸，甚于他邪，虽有余邪，必先治悸，何者以水停下，无所不入，侵于肺为喘嗽，传于胃为秽噎，溢于皮肤为肿，渍于肠间为利，其厥之病甚重，犹先治水，况病之浅者乎。白虎汤方。石膏〔一斤〕、知母〔六两〕、甘草〔二两〕、粳米〔六合〕。伤寒脉浮滑，此表有实，里有寒，白虎汤主之。〔原文〕按前篇云诸热在里，表里俱热者，白虎汤主之，又曰其表不解，不可与白虎汤，此云脉浮滑，表有实，里有寒者，必表里字讹耳，又阳明一证云，脉浮迟，表虚里寒，四逆汤主之，又少阴一证云，里寒外热，通脉四逆汤主之，以此相参，其讹益明矣，又阳明篇曰，脉浮而疾者，小承气汤，既用承气汤，是里热也，又厥阴篇曰，脉滑而厥者，里有热，白虎汤主之，是为滑为里热也明矣，况知母石膏，岂应以水济水，成氏随文释之谬也。海云，此表有热，里有寒，非寒冷之寒，寒邪之寒，亦自有理可思。伤寒脉浮而厥者，里有热也，白虎汤主之。〔厥阴原文〕粳米本草诸家，共言益脾胃，如何白虎汤用之入肺，以其阳明为胃之经，色为西方之白，故入肺也，然治阳明之经，即在胃也，色白味甘寒，入手太阳，又少阴证，桃花汤，用此甘以补正气，竹叶石膏，用此甘以补不足，垣云，身以前，胃之经也，胸胃肺之室也，邪在阳明，肺受火制，故用辛寒以清肺，所以号为白虎汤也。活人云，谓白虎汤治中喝，汗后一解表药耳，非正伤寒药也，而夏日阴气在内，白虎尤宜戒之，夫白虎汤，具载仲景之书，证治昭然明白，何为非正伤寒之药也，况伤寒论，言无表证者，可与白虎汤，今云汗后一解表药耳，于法既无表证，何解之有，又曰，夏月阴气在内，白虎尤宜戒之，而明理论，又云，立秋后不可服，秋则阴气半矣，白虎大寒，若不能禁，服之而为哕逆不能食，或虚羸者有矣，夫伤寒之法，有是证则投是药，安可拘于时而为治哉，假如秋冬之间，患伤寒，身如表证，而大烦渴，于法合用白虎汤，苟拘其时，何以措手，若以白虎为太寒，其承气又何宜于冬月耶，既以夏宜戒，秋不可行，然则宜乎何时也，虽然，经云必先岁气，无伐天和，此言常也，假如贼邪变出阴阳寒暑，亦当舍时而从证，岂可以时令拘哉。三阳合病，腹满身重，难以转侧，口不仁而面垢，讞语遗尿，发汗则讞语，下之则额上生汗，手足逆冷，自汗出者，白虎汤主之。〔原文〕垣云，入足阳明，手太阳，味苦寒润，治有汗骨蒸，肾经气劳，泻心，仲景用此治不得眠者，烦躁也，烦者肺也，躁者肾也，以石膏为君主，佐以知母之苦寒，以清肾之源，缓以甘草粳米之甘，而使不速下也，经云，胸中有寒者，瓜蒂散吐之，又云，表热里寒者，白虎汤主之，瓜蒂知母，味皆苦寒，而治胸中寒，及里寒何也，答曰，成无已注云，即伤寒寒邪之毒，为热病也，读者要逆识之，如论语言乱臣十人，书曰惟以乱臣，其能乱而四方，乱皆治也，乃治寒者也，故云乱民，乱四方也，仲景所言寒之一字，举其初而言之，热病在其中矣，若以寒为寒冷之寒，无复苦寒之剂，兼言白虎证，脉，尺寸俱长，则热可知矣。白虎加人参汤五法。药

即汤见。许云，有人初病呕吐，俄为医者下之，已七八日而内外发热，予诊之曰，尝用白虎加人参汤，或曰既吐复下，且重虚矣，白虎何用乎，予曰仲景云，若吐下后七八日不解，热结在里，表里俱热者，白虎加人参汤，正相当也，盖呕吐者，热留胃脘，而致令虚火上逆，三投汤而愈，仲景既云，伤寒若吐若下后，七八日不解，表里俱热者，白虎加人参汤主之，又云伤寒脉浮，发热无汗，其表不解，不可与白虎，又曰脉浮滑，此以表有热，里有寒，白虎加人参汤主之，国朝林亿校正，谓仲景于此，表里自差矣，余谓不然，大抵白虎能除伤寒中喝，表里发热，故前后二证，或云表里俱热，或云表热里寒，皆可服之，一种脉浮无汗，其表不解，全是麻黄与葛根证，安可行白虎也，林亿见所称表里不同，便谓之差，是亦不思之过也。张云，用药有迟速之弊，故设法以关防，法有关防不尽者，则着方以拯治也，便如上二条，前条乃仲景设法以关防也，后条乃伤寒病，若吐若下后，七八日不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴口舌干燥而烦，饮水数升者，以白虎加人参汤主之，此二条乃着方以拯治也，夫白虎汤，专治大烦大渴，古人设法之意，惟恐表证未罢，而辄用之，治有太速之弊，若背微恶寒，及时时恶风二证，其中烦渴已甚，非白虎不能遏也，必候表邪俱尽，未免有太迟之愆也，此乃法之关防不尽者，故着方以拯治也，苟不着方，必然违法，此方法之妙，所以不可偏废也，或问白虎汤，仲景以表不解者，不可与，又时时恶风，背上恶寒者，此有表也，以白虎主之何也，盖石膏辛凉，解足阳明本经热，蒸蒸发热，潮热表里皆热，舌燥烦渴之圣药也，且时时者，时或恶风而不常也，背上恶者，但觉微恶而不甚也，所以于盛热躁渴而用，则无疑矣，若夫表证恶寒，常在背上，恶寒而加躁渴者，切不可用也，又太阳经发热，而渴无汗者，不可与之，但汗后，脉洪大而渴者，则可与之，加少阴伤寒，面赤烦躁，身热，与夫胃虚恶心，大便不实，脉弱食少，无大热者，切不可用也，如误用之，则倾危可立而待矣。

卷四

太阳合阳明方 桂枝加葛根汤。桂枝汤加葛根。太阳病，项背强，几几，反汗出，恶风者主之，〔原文〕几几项背拘强之状。按后证葛根汤，乃桂枝汤中加麻黄葛根也，其证无汗，故以麻黄发之，此证有汗，故去麻黄，而曰桂枝加葛根汤也，若有麻黄，则亦葛根汤矣。葛根汤。桂枝汤加麻黄、葛根。太阳病，项背强，几几，无汗恶风，葛根汤主之。〔原文〕风寒伤经络之经，则所过但痛而已，未至于强，风寒伤经骨之筋，则所过筋急强直，而成刚痙，痙字之讹也，曰刚痙，无汗之名也，本草云，轻可去实，葛根麻黄，形气之轻者也，此以风寒表实，故加二物于桂枝汤中。太阳与阳明合病者，必自下利，葛根汤主之。〔原文〕太阳与阳明合病，不下利但呕者，葛根加半夏汤主之。〔原文〕葛根加半夏汤。方见本汤。凡合病必自下利，下利里证也，今之庸医，皆曰漏底伤寒不治，仲景则以前方主之，盖以邪气并于阳，则阳实而阴虚，阴虚故下利也，以此汤散经中表邪，则阳不实而阴气平，利不治而自止也，惟明者知之，其脉必弦而长。张云，凡合病皆下利，各从外证以别焉，夫太阳病，头项痛，腰脊强，阳明病，目疼鼻干，不得卧，少阳病，胸胁痛，耳聋，凡遇两经病证齐见，而下利者合病也，然但见一证便是，不必悉具也，仲景不言脉证，止言太阳与阳明合病者，以前章所论，包含已上之证，即此理也，况各经之证，所见不一，难为定论乎。按合病者，三阳合病也，谓二阳经，或三阳经，同俱受邪，相合而病，故曰合病，此病之不传者也，并病者亦指三阳而言，并者催并督并之谓，前病未解，后病已至，有迫逼相并之义，此病之传者也，且如太阳阳明并病一证，若并而未尽，是传未过，尚有表证，仲景所谓太阳病不罢，面色赤，阳气怫郁在表，不得越，烦躁气短是也，犹当汗之以各半汤，若并之已尽，是谓传过，仲景所谓太阳证罢，潮热手足汗出，大便鞭而讞语者是也，法当下之，以承气汤，是知传则入府，不传则不入府也，所以仲景论太阳阳明合病，止出三证，加前太阳阳明并病，则言其有传变如此也，然此皆三阳病耳，与三阴无干，若与三阴合病，即是两感矣，所以三阴无合病例也。梔豉汤。方见太阳中篇。发汗吐下后，虚烦不得眠者，主之。〔原文下六条同〕懊者懊恼，懞者郁闷貌，心中懊懊懊恼，烦懞懞懞，郁郁不舒，愤愤无奈，此又烦闷而甚者也，由下后表之，阳邪乘内陷，郁而不发，结伏于心胸之间，故如是，按梔子色赤味苦，入心而治烦，香豉色黑味咸，入肾而治躁。发汗，若下之而烦热，胸中窒者主之。伤寒五六日，大下之后，身热不去，心中结痛者，未欲解也，宜主之。阳明病，脉浮而紧，咽燥口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒，少恶热，身重，若发汗则燥，心愤愤反讞语者，主之。烦者气也，躁者血也，气主肺，血主肾，烦躁俱在上者，肾子通于肺母也，故用梔子以治肺烦，用香豉以治肾躁，烦躁者懊恼不得眠也。或曰，烦者心为之烦，躁者心为之躁，何烦为肺，躁为肾耶，夫心者君火也，与邪热相接，上下通热，金以之而躁，水以之而亏，独存火耳，故肺肾与之合而烦躁焉，此烦虽肺，躁虽肾，其实心火为之也。阳明病下之，其外有热，手足温不结胸，心中懊恼，饥不能食，但烦汗出者主之。下利后更烦，按之心下濡者，为虚烦也，宜此汤。下利后不烦，为欲解，若更烦而心下坚者，为谷烦，此烦是心下濡者，是邪热乘里，客于胸中为烦也，

与此汤吐之则愈。按此汤惟吐无形之虚烦则可，若用之以去实，则非豉子所能宜矣，实者须瓜蒂散主之。凡服梔子汤，病人粪微溏者，不可与服之。仲景用梔子汤治烦，胸为高之分也，故易老云，轻飘而象肺，色赤而象火，故能泻肺之火也，本草不言吐，仲景用此为吐者，梔子本非吐药，为邪气在上，拒而不纳故令人上吐，邪因得以出，经曰，高者因而越之，此之谓也，或用梔子利小便，实非利小便，清肺也，肺气清，而化膀胱为津液之府，小便得以出也，本经云，治大小肠热，幸与庚合，又与丙合，又能泄戊，其先入中州故也，去皮泄心火，连皮泄肺火，入手太阴少阴经。麻仁丸。大黄、枳实、厚朴、芍药、麻仁、杏仁。趺阳脉浮而濡，浮则胃气强，濡则小便数，浮濡相搏，大便则难，其脾为约，麻仁丸主之。〔原文〕成无己曰，约者结约之约，胃强脾弱，约东津液不得四布，但输膀胱，故小便数，而大便鞭，故曰脾约，与此丸以下脾之结躁，肠润结化，津液入胃，大便利小便少而愈矣，愚切有疑焉，既曰约，脾弱不能运也，脾弱则土亏矣，必脾气之散，脾血之耗也，原其所由，必久病大汗大下之后，阴血枯槁，内火燔灼，热伤元气，必伤于脾，而成此证，伤元气者，肺金受火，气无所摄，伤脾者，肺为脾之子，肺耗则液竭，必窃母气以自救，金耗则木寡于畏，土欲不伤不可得也，脾失转输之令，肺失传送之官，宜大便秘而难下，小便数而无藏蓄也，理宜滋阴血，使孤阳之火不炽，而金行清化，木邪有制，脾土清健，而运行精液，乃能入胃，则肠润而通矣，今以大黄为君，枳实厚朴为臣，虽有芍药之养血，麻仁杏仁之温润，为之佐使，用之热盛而气实者，无有不安，若与热虽盛，而气不实者，虽得暂通，保无有脾愈弱而肠愈燥者乎，后之用此方者，慎勿胶柱而鼓瑟。茵陈蒿汤。茵陈〔六两〕、大黄〔二两〕、梔子〔十四枚〕。阳明病，发热汗出，此为热越，不能发黄也，但头汗出，身无汗，剂颈而还，小便不利，渴饮水浆者，此为瘀热在里，身必发黄，茵陈蒿汤主之。〔原文。下三条同〕伤寒八九日，身黄如橘子色，小便不利，腹微满者，茵陈蒿汤主之。梔子柏皮汤。梔子、柏皮。伤寒身黄发热者，梔子蘘皮汤主之。茵陈蒿汤，治热湿也，梔子蘘皮汤，治躁热也，如苗涝则湿黄，旱则躁黄，湿则泄之，躁则润之也，此二药治阳黄也。麻黄连轺赤小豆汤。方见三卷。伤寒瘀热在里，身必发黄，麻黄连轺赤小豆汤主之。连轺，用连翘根也，气寒味苦，主下热气，梓白皮，气寒味苦，主热毒，去三虫，时气瘀热之剂，必以苦为主，又曰大热之气，寒以取之是也。潦水，即霖雨后行潦之水，亦取其发纵之极，流而不滞，不助湿也。右三汤，其茵陈汤，是欲泄涤其热也，梔子与麻黄二汤，是欲解散其实也，为治不同，总之皆折火彻热之剂耳，色加烟熏黄，乃湿病也，一身尽痛，色加橘子黄，乃黄病也，一身不痛，间发黄，活人云，病人寒湿，在里不散，热蓄于脾胃，腠理不开，瘀热与宿谷相薄，郁蒸不消化，故发黄，然发黄与瘀血外证及脉，俱相似，但小便不利为黄，小便自利为瘀血，要之发黄之人，心脾蕴积，发热引饮，脉必浮滑而紧数，若瘀血证，即如狂，大便必黑，此为异耳。或问白虎证，亦身热烦渴，引饮，小便不利，何以不发黄，答曰，白虎与发黄证相近，遍身汗出，此为热越，白虎证也，头面汗出，颈已下都无汗，发黄证也。又问太阳病，一身尽痛，发热，身如熏香者何，曰太阳中湿也，仲景云，伤寒发汗已，身目为黄，所以然者，以寒湿在里不解故也，以为不可下也，于寒湿中求之。或问伤寒发黄，惟阳明与太阴有之，

俱信小便利者，不能发黄何也，盖黄者土之正色，以太阴与阳明，俱属土，故发黄也，其黄之理，外不能汗，里不得小便，脾胃之土，为热所蒸，故色见于外而发黄也，若小便利者，热不内蓄，故不能变黄也，其有别经之发黄者，亦由脾胃之土受邪故也。抵当汤。抵当丸。二方俱见太阳篇。血流下焦而瘀者，蓄血也，大抵伤寒先看面目，次看口舌。次看心下至少腹，以手揣之，若少腹鞭满而小便不利者，是津液留结，可利小便，若小便自利者，是蓄血证，可下瘀血。伤寒失汗，热蓄在里，热化为血，其人善忘而如狂，血善逸，则善忘，血下蓄，则内急，用药以取尽黑物为效，大抵看伤寒病人，心下两胁少腹，但有鞭满处，以手按则痛者，便当问其小便何如，若小便不利，乃是水与气，若小便自利者，为有血也。太阳病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在下焦，少腹当鞭满，小便自利者，下血乃愈，抵当汤主之。〔原文。下三条同〕仲景凡称太阳证脉沉者，皆谓发热恶寒，头项强痛，而脉反沉也，其证兼发狂，小腹痛者，为蓄血，此条抵当汤是其例也。自经而言，则曰太阳，自腑而言，则曰膀胱，阳邪由经而入，结于膀胱，故曰随经瘀热在里。太阳病，身黄，脉沉结，少腹鞭，小便不利者，为无血也，阳明证，其人喜忘者，必有蓄血，所以然者，本有久瘀血，故令喜忘，屎虽鞭，大便反易，其色必黑，宜抵当汤下之。病人无表里证，发热六七日，虽脉浮数者，可少下之，假令已下，脉数不解，而下不止，必协热而便脓血也，或问攻下之法，须外无表证，里有下证，然后可攻，上言无表里证，况脉更浮数，何故言可以下之，曰此非风寒之所病，是由内伤而致然也，若外不恶寒，里无谵语，但七八日发热，内烁津液，乃阳盛阴虚之时，苟不攻之，其热不已，必变生焉，故云虽脉浮数可下，不待沉实而攻之，夫内伤者，经曰趺阳脉浮而数，浮则伤胃，数则伤脾，此非本病，医特下所为也，仲景之意，不外是理，凡伤寒当下之证，皆往太阳阳明在经之邪，而入于腑，故下之，今不言阳明病，而但曰病人无表里证，此非自表之里而病也，但为可下，故编于阳明篇中，学者宜详玩焉。伤寒有热，少腹痛，应小便不利，今反利者，为有血也，当下之，不可余药，宜抵当丸。按成注身黄屎黑，喜忘发狂，亦是推广之词，若依上文，只是满而不鞭耳。抵当汤丸，药味同剂，如何是二法，盖喜忘发狂，身黄屎黑者，疾之甚也，但小腹满鞭，小便利者轻也，故有汤丸之别，桃仁大黄等分，水蛭虻虫，多者作汤，三之二者作丸，作丸之名，取其数少而缓也，故汤用煎服一升，丸止服七合也。活人云，若用抵当汤丸，更宜详慎，审其有无表证，若有蓄血而外不解，亦未可使用，宜先用桂枝汤以解外，缘热客膀胱太阳经也。大陷胸汤。方见前。太阳病，脉浮而动数，浮则为风，数则为热，物则为痛，数则为虚，头痛发热，微盗汗出，而反恶寒者，表未解也，医又下之，动数变迟，宜大陷胸汤。按太阳病，在表未曾解，在表而攻里，可谓虚矣，而况所得之脉，皆浮而动数乎，今得误下，动数变迟矣，而又曰胃中空虚，又曰短气躁烦，虚之甚矣，借曰阳气内陷，心下同鞭，而可迅攻之乎，岂大陷胸之力，缓于承气，况已下者不可再下，宁不畏其虚乎，且经明曰，结胸脉浮大者，不可下，下者死，又曰结胸证悉具，烦躁者死，今曰脉浮，又曰烦躁，大陷胸果可用乎，彼阳病实下结，胃中空虚，客气动膈，心下懊憹者，以栀子豉汤吐胸中之邪，况太阳失下后，明有虚证乎。伤寒六七日，结胸热实，脉沉而紧，心下痛，按之不鞭者，大陷胸汤主

之。〔原文。下三条同〕 经言所以成结胸者，以下之太早故也，此不云下后，但云伤寒六七日，结胸热实，此亦不因下早而结胸者，何也，夫下早结胸事之常，热实结胸事之变，其热实传里为结胸，乃法之关防不尽者，故仲景述其证，以注方于其下也，于此可见古人用心，曲尽其妙，且如下章，以水结胸胁，但头汗出者，以大陷胸汤主之，亦在常法之外，故条例其证，以彰其理也，亦或其人本虚，或曾吐下，而里气弱，外邪因入，故自为结胸者也，然所入之因不同，其证治则一理而已。伤寒十余日，热结在里，后往来潮热者，与大柴胡汤，但结胸，无大热者，此为水结在胸胁也，但头微汗出者，大陷胸汤主之。太阳病重发汗，而复下之，不大便五六日，舌上躁而渴，日晡所，小有潮热，从心下至少腹鞭满，而不可近者，大陷胸汤主之。按太阳病，已重发汗，表则虚矣，若复下之，更又虚矣，不大便五六日，可见津液之耗矣，非若前章之未曾发汗，而但下之伤于早尔，今虽有鞭痛，而可以迅攻之乎，若曰，潮热于申酉，系阳明，属调胃承气证，既又曰少有潮热，犹可疑待之间，将无他法以缓取之乎。按潮热本属阳明也，太阳潮热，惟此一证耳，杂病太阳潮热，则在己午，更玩一小字，则知邪于太阳为多，阳明为少。伤寒五六日，呕而发热者，柴胡汤证具，而以他药下之，柴胡证仍在者，若上下满而鞭痛者，此为结胸也，大陷胸汤主之。小陷胸汤。方见前。文蛤散。方见前。白通散。葱白〔四茎〕、干姜〔一两〕、附子〔一枚〕、人尿〔五合〕、猪胆汁〔一合〕。小结胸病，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷胸汤主之。〔原文。下同〕上云文，鞭满而不可近者，是不待按而亦痛也，此云按之则痛，是手按之，然后作痛尔，上文云，至少腹是通一腹而言之，此云正在心下，则少腹不鞭痛可知矣，热微于前，故云小结胸也，且结胸脉沉紧，或寸浮关，沉今脉浮滑，知热气犹浅，尚未深结，所以用此汤，除胸膈上结热也。病在阳，应以汗解之，反以冷水濯之，若灌之，其热被却，服文蛤散，不瘥者，与五苓散，寒实结胸无热证者。与三物小陷胸汤，白通散亦可服。大陷胸汤，太阳本药也，大陷胸丸，阳明药也，小陷胸汤，少阳药也，大陷胸汤，治热实，大陷胸丸，兼喘，小陷胸治痞。按经云，结胸脉浮大，不可下，下之则死，张云，用药如用兵，知可而进，知难而退，此理势之必然也，夫寸浮关沉，乃结胸可下之脉，今脉浮大，心下虽结，其表邪尚未全结也，若辄下之，重虚其里，外邪复聚，而必死矣，仲景所以言此为箴戒，使无踵其弊也，其脉既不可攻，当候其变而待其实，假如小结胸证，其脉浮滑，按之则痛，故知邪非深结，亦不敢下，无过解除心下之热耳，小陷胸汤主之，或又曰，结胸倘有外证，大陷胸可用否，予曰，结胸无外证，或有微热，或有小潮热，仲景已明言之，其余别无表证，若有外证，其邪亦未结实，不可以结胸论也，经曰，伤寒六七日，发热恶寒，支节烦疼，微呕，心下支结，外证未去，柴胡桂枝汤主之，又伤寒六七日，已发汗，而复下，胸胁微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热，心烦者，此为未解也，柴胡桂枝干姜汤主之，已上之证，虽云心下支结，及言胸胁满微结二条，俱有外证，所以柴胡加桂枝，及加干姜以和解之，如无外证，止有胸腹结实而痛者，方为结胸病也。阳明少阳各方大承气汤方。厚朴〔去痞〕、枳实〔泄满〕、芒硝〔软坚〕、大黄〔荡实必痞满燥实，四证全者方可用〕。小承气汤方。厚朴、枳实、大黄。调胃承气汤方。芒硝、大黄、甘草。发汗后，不恶寒者，虚故也，不恶寒，

但恶热者，实也，当和胃气，与调胃承气汤。〔原文。下三十四条同〕太阳病未解，脉阴阳俱停，必先振慄汗出而解，若欲下之，宜调胃承气汤。伤寒十三日过经不解，谵语者以有热，当以调胃承气汤下之。太阳病，过经十余日，心下温温欲吐，而胸中痛，大便反溏，腹微满，郁郁微烦，先此时自极吐下者，可与调胃承气汤。阳明潮热，大便微鞭者，可与大承气汤。恐有躁屎，欲和之法，与小承气汤。伤寒若吐若下后，不解，不大便，五六日上至十余日，大承气汤主之，若一服利止后服。此段分作三截看，自伤寒若吐若下后，不解不大便，五六日至十余日，日晡所发潮热，不恶寒，独语加见鬼状，止为上一截，是将潮热谵语，不恶寒不大便，对为现证，下文又分作一截，以辨剧者微者之殊，微者但发热谵语，但字为义，以发热谵语之外，别无他证，其用承气汤一方，利止后服，见其热轻，犹恐下之太过也，至于剧者，发则不识人，循衣摸床，惕而不安，微喘直视，如此热极证危，不可不决死生以断，断以脉弦者生，濇者死，此阳热已极，若脉弦为阴未绝，犹可下之以复其阴，若弦濇为阴绝，不可救药而必死矣，潮热者，若潮汐之来，不失其时，一日一发，按时而发者，谓之潮热，若日三五发者，即是发热，非潮热也，潮热属阳明，阳明旺于未申，必于日晡时发，乃为潮热。谵语者，谓乱言无次，数数更端也，郑声者，语郑重其烦也，只将一字内，言重迭，频言之，终日殷勤，不换他声也，盖神有余则能机变而乱语，数数更端，神不足则无变声，而只守一声也，此虚实之分也，谵语属阳，郑声属阴，经云实则谵语，虚则郑声，谵语者，颠倒错乱，言出无伦，常对空独语，如见鬼状，郑声者，郑重其烦，语虽谬而郑重其烦，谆谆不已，老年人，遇事则谆语不休，以阳气虚故也，此谵语郑声，虚实之所以不同也，二者本不难辨，但阳盛里实，与阴甚隔阳，皆能错语，须以他证别之，大便秘，小便赤，身热烦渴而妄语者，乃里实之谵语也，小便如常，大便洞下，或发躁，或反发热而妄言者，乃阴隔阳之谵语也。阳明病谵语，发潮热，脉滑而疾者，小承气汤主之，因与承气一升，腹中转失气者，更服一升。阳明病，其人多汗，以津液外出，胃气躁，大便必鞭，鞭则谵语，小承气汤主之。阳明病谵语有潮热，反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也，若能食，但鞭耳，宜大承气汤下之。汗出谵语者，以有躁屎在胃中，此为风也，须下之，虽经久，可下之，下之若早，语言必乱，以表虚里热故也。宜大承气汤，或问经言胃中有躁屎五六枚何如，答曰，夫胃为受纳，大肠为传送之府，躁屎岂有在胃中哉，故经言穀消水去形亡也，以是知在大肠，而不在胃也明矣。按胃实者，非有物也，地道塞而不通也，故使胃实，是以腹如仰瓦，注曰，胃上口为贲门，胃下口为幽门，幽门接小肠上口，小肠下口，即大肠上口也，大小二肠相会为阑门，水渗泄入于膀胱，粗滓入于大肠，结于广肠，广肠者地道也，地道不通，土壅塞也，则逆，上行至胃，名曰胃实，所以言阳明当下者，言上下阳明经不通也，言胃中有躁屎五六枚者，非在胃中，通言阳明也，言胃是连及大肠也，以其胃为足经，故从下而言之也，从下而言，是在大肠也，若胃中实有躁屎，则小肠乃传导之府，非受盛之府也，启元子云，小肠承奉胃司，受盛糟粕，受已复化，传入大肠，是知躁屎在小肠之下，即非胃中有也。二阳并病，太阳证罢，旦发潮热，手足(仅)(仅)汗出，大便难而谵语者，下之则愈，宜大承气汤。阳明病，下之，心中懊憹而烦，胃中有躁屎者可攻，腹微满，初头鞭，后必溏，不可攻之，

若有躁屎者，宜大承气汤，病人烦热，汗出则解，又如症状，日晡所发热者，属阳明也，脉实者宜下之，脉浮虚者，宜发汗，下之与大承气汤，大下后，六七日，不大便，烦不解，腹满痛者，此有躁屎也，所以然者，本有宿食故也，宜大承气汤，病人小便不利，大便乍难乍易，时有微热，喘冒不能卧者，此有躁屎也，宜大承气汤。太阳病，三日发汗不解，蒸蒸发热者，属胃也，调胃承气汤主之。伤寒吐后，腹胀满者，与调胃承气汤。太阳病，若吐若下若发汗，微烦，小便数，大便因鞕者，与小承气汤和之愈。得病二三日，脉弱，无太阳柴胡证，烦躁，心下鞕，至四五日虽能食，与小承气汤，少少与微和之，令小安，至六日与承气汤一升，若不大便六七日，小便少者，虽不能食，但初头鞕，后必溏，未定成鞕，攻之必溏，须小便利，尿定鞕，乃可攻之，宜大承气汤。阳明病，发热汗多者，急下之，宜大承气汤。发汗不解，腹满痛者，急下之，宜大承气汤。腹满不减，减不足言，当下之，宜大承气汤。或谓减不足言，复曰当下之，何也，曰此古之文法如是也，言腹满不减，当下之，宜大承气汤，此满而不减之谓也，若时满时减者，不可以当下而论，假如太阳篇中云，伤寒不大便，六七日，头痛有热者，与承气汤，其小便清者，知不在里，仍在表也，当须发汗，若头痛必衄，宜桂枝汤，缘桂枝为当发汗而设，非为治衄也，其减不足言之说，亦不外乎是理也。阳明少阳合病，必下利，其脉不负者顺也，负者失也，互相克贼，名为负也，脉浮而数者，有宿食也，当下之，宜大承气汤。少阴病，得之二三日，口燥咽干者，急下之，宜大承气汤。少阴病，自利清水，色纯青，心下必痛，口干燥者，急下之，宜大承气汤。少阴病，六七日，腹胀不大便者，急下之，宜大承气汤。或问承气汤，阳明当下之证宜用，今少阴病亦用何也，盖胃为水谷之海，主养四旁，四旁有病，皆能传之入胃，其胃土燥，则肾水干，以二三日则口燥咽干，是热之深，传之速也，故曰急下，以全肾水，夫土实则水清，谓水谷不相混，故自利清水而口干燥，此胃土湿热而致然也，下利色青，青肝也，乃肝邪传肾，缘肾之经脉，从肺出络心注胸中，由是而心下痛，故急下以去实热，逐肾邪，其六七日腹胀不大便，以入府之邪壅甚，胃土胜，则肾涸，故急下以逐胃热，滋肾水，盖阳明与少阴，皆有急下之条，然而证虽不同，其入府之理则一，是以皆用大承气也。下利谵语者，有躁屎也，宜小承气汤。大法秋宜下。凡服下药，用汤胜丸，中病即止，不必尽剂。下利三部脉皆平，按之心下鞕者，急下之，大承气汤。下利脉迟而滑者，内实也，利未欲止，当下之，大承气汤。问曰，人病宿食，何以别之，师曰，寸口脉浮而大，按之又涩，尺中亦微而涩，故知有宿食，当下之，宜大承气汤。下利不欲食者，以有宿食故也，当下之，宜大承气汤。下利瘥后，至其年月日复发，以病不尽故也，当下之，宜大承气汤。下利脉反滑，当有所去，下之乃愈，宜大承气汤。病腹中满痛者，此为实也，当下之，宜大承气汤。脉双弦而迟者，必心下鞕，脉大而紧者，阳中有阴也，可以下之，宜大承气汤。或问承气汤，仲景有大小调胃之名何也，然伤寒邪热，传受入里，谓之入府，府者聚也，盖邪热与糟粕，蕴而为实也，实则潮热谵语，手心濈濈汗出者，此躁屎所为也，如人壮大热大实者，宜大承气汤下之，又热结不坚满者，故减去厚朴枳实，加甘草而和缓之，故曰调胃承气也，若病大，而以小承气攻之，则邪气不伏，病小而以大承气攻之，则过伤正气，且不及还可再攻，过则不能复救，可不谨哉，仲景曰

，凡欲行大承气，先与小承气一锤，腹中转失气，乃有躁屎也，可以大承气攻之，不转失气，甚不可攻，攻之则腹胀，不能食而难治，又曰，服承气汤，得利，慎勿再服，此谆谆告戒也，凡用攻法，必先妙算，料量合宜，则应手而效，若不料量，孟浪攻之，必至杀人。按阳明一证，分为太阳正阳少阳三等，而以大小调胃承气下之者，按本草曰，大黄酒浸，入太阳经，酒洗入阳明经，浸久于洗，得酒气为多，故能引之于至高之分，若物在山巅，人迹不及，必射以取之也，故仲景以调胃承气，收入太阳门，而大黄下注曰，酒浸，及详其用本汤，一则曰少少温服，二则曰当和胃气，与调胃承气汤，又详本汤之证，则曰不吐不下心烦者，又发汗不解，蒸蒸发热，又吐后腹胀满，是太阳阳明，去表未远，其病在上，不当攻之，故宜缓剂以调和之也，及至正阳阳明，则皆曰急下之，与大承气汤，而大黄下，注曰酒洗，是洗轻于浸，微升其趋下之性，以治其中也，至于少阳阳明，则去正阳而逼太阴，其分为下，故小承气汤中大黄，不用酒制，少阳不宜下，故又曰少与，曰微溏之，勿令大泄，此仲景之妙法也，东垣不审胃之云者，乃仲景置调胃承气于太阳篇，太阳不宜下，故又称胃以别之，却踵成氏之谬，以小承气治太阳脾约之证，以调胃承气，治正阳阳明大承气之证，余故不能无辨。海云，大小调胃三承气之汤，必须脉浮头痛，恶风恶寒，表证尽罢，而反发热，恶热譫语，不大便，方可用之，若脉浮紧，下之必结胸，若脉浮缓，下之必痞气，已上三法，不可差也，若有所差，则无形者有遗害，假令调胃承气证，用大承气下之，则愈后元气不复，以其气药犯之也，大承气证，用调胃承气下之，则愈后神凝不清，以其气药无力也，小承气汤，若用芒硝下之，则或下利不止，变而成疟矣，三承气岂可差乎。陶云，大凡伤寒邪热，传里结实，须看热气浅深用药，今之庸医，不分当急下，与宜微和胃气之论，一概用大黄芒硝，乱投汤剂下之，因兹而毙者多矣，余谓伤寒之邪，传害非一，治之则殊，病有三焦俱伤者，则痞满躁实兼全，俱宜大承气汤，盖厚朴苦温以去痞，枳实苦寒以泄满，芒硝咸以润燥软坚，大黄苦寒以泄实去热，病斯愈矣，若邪在中焦，则有躁实坚三证，故用调胃承气汤，以甘草和中，芒硝润燥，大黄泄实，不用枳朴，恐伤上焦虚无氤氲之元气，调胃之名，自此始矣，若上焦受伤，则痞而实，用小承气汤，而以枳实厚朴除痞，大黄泄实去热，去芒硝不伤下焦血分之真阴，谓不伐其根本也，若夫大柴胡汤，则有表证尚未除，而里证又急，不得不下者，只得以此汤，通表里而缓治之，又有老弱及血气两虚之人，亦宜用此，故经云，转药孰紧，有芒硝者紧也，大承气最紧，小承气次之，调胃承气又次之，其大柴胡加大黄，小柴胡加芒硝，方为转药，盖为病轻者设也，仲景又云，荡涤伤寒热积，皆用汤液切禁丸药，不可不知。猪苓汤方。猪苓、泽泻、茯苓、滑石、阿胶〔各一两〕。阳明病，若脉浮发热，渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之。〔原文〕按此浮字，误也，活人云，脉浮者，五苓散，脉沉者，猪苓汤，则知此证脉字下，脱一不字也，据太阳篇内五苓散，乃猪苓泽泻茯苓三味中加桂白朮也，阳明篇内猪苓汤，乃猪苓泽泻茯苓三味中加阿胶滑石也，桂与白朮味甘辛，为阳主外，阿胶滑石味甘寒，为阴主内，奉议之言，亦可谓不失仲景之旨矣，第奉议欲区别二药分晓，不觉笔下以沉对浮，遂使后人致疑三阳证中，不当言脉沉，更不复致疑经文之有阙也，更详太阳证，固常脉浮，而阳明为表之里，故其脉不曰浮而曰长，盖长者，不浮不沉，中之

脉也，成氏直以脉浮释之，而朱氏却以脉沉言之，胥失之矣，若曰脉浮者，五苓散，不浮者猪苓汤，则得仲景之意矣，又详少阴篇，病下利六七日，欬而呕渴，心烦不得眠者，猪苓汤一条，虽不言脉沉，然少阴之脉必沉也，岂活人以少阴对太阳一证而言之欤，以此推之，成氏随文误释明矣。阳明病，汗出多而渴者，不可与猪苓汤，以汗多胃中躁，猪苓汤利其小便故也。〔原文〕针经曰，水谷入于口，输于肠胃，其液别为伍，天寒衣薄则为溺，天热衣厚则为汗，是汗溺一液也，多为津液外泄，胃中干燥，故不可与猪苓汤利小便也。小柴胡汤。方见太阳中篇。伤寒五六日中风，往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸，小便不利，或不满，身有微热，或欬者，与小柴胡主之。〔原文。下二十条同〕或问少阳胆经，萦纡盘屈，皆多于各经，及观少阳篇中，治病至简，又不闻何药为本经之正法，何也，夫经络所据，身之后属太阳，太阳为阳中之阳，阳分也，身之前属阳明，阳明为阳中之阴，阴分也，阳为在表，阴为在里，少阳在身之侧，夹于表里之间，故曰半表半里，太阳膀胱，水寒也，阳明大肠，金躁也，邪在阴阳二分之一中，近后膀胱水则恶寒，近前阳明躁则发热，故往来寒热也，治法，太阳在标可汗而解，麻黄是也，在本可渗而解，五苓散是也，阳明在标可以解肌，葛根是也，在本可下而解之，承气汤是也，独少阳居中，不表不里，开窍于胆，有入无出，故禁发汗，禁利大便，禁利小便，惟宜和之以小柴胡汤，故名三禁汤，冷热均平，从于中治，乃和解之剂，若犯之则各随上下前后，本变中变，与诸变不可胜数，医者宜详之。本方加减法。血弱气尽腠理开，邪气因入，与正气相搏结于胁下，正邪分争，往来寒热，发作有时，默默不欲饮食，脏腑相连，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之。〔原文〕按血弱气尽，至结于胁下，是释胸胁苦满句，正邪分争，是释往来寒热句。此是倒装法也，至默默不欲饮食，兼上文满痛而言也，若脏腑相连四句，乃释心烦喜呕也。服柴胡汤已渴者，属阳明也，以法治之。得病六七日，脉迟浮弱，恶风寒，手足温，医二三下之，不能食，而胁下满痛，面目及身黄，头项强，小便难者，与柴胡汤，后必下重口渴，而饮水呕者，柴胡汤不中与也，食谷者哕。〔原文。哕一决切，渊入声，逆气也。〕伤寒四五日，身热恶风，头项强，胁下满，手足温而渴者，小柴胡汤主之。

〔原文〕伤寒阳脉濡，阴脉弦，法当腹中急痛者，先与小建中，不瘥者，与小柴胡汤主之。伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。凡柴胡汤证而下之，若柴胡证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却发热，汗出而解。太阳病，通经十余日，及二三下之后，四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡汤，呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也，与大柴胡下之则愈。伤寒十三日不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利，此本柴胡证，先服小柴胡汤以解外，后宜芒硝主之。伤寒五六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便硬，脉细者，此为阳微结，必有表复有里也，可与小柴胡汤，设不了了者，得屎而解。阳明病，发潮热，大便溏，小便自可，胸胁满不结者，小柴胡汤主之。阳明病，胁下硬满，不大便而呕，舌上白胎者，可与小柴胡汤，上焦得通，津液得下，胃气因和，身濈然汗出而解也。阳明中风，脉弦浮大而短气者，小柴胡汤主之。本太阳病不解，转入少阳者，胁下硬满，干呕不能食，往来寒热，尚未吐下，脉沉紧者，与小柴胡汤。呕而发热

者，小柴胡汤主之。伤寒瘥已后，更发热者，小柴胡汤主之，脉浮者以汗解之，脉沉实者以下解之。妇人中风七八日，续得寒热发作，有时经水适断者主之。妇人中风，发热恶寒，经水适来，得之七八日者主之。妇人伤寒发热，经水适来，昼日明了，夜即譫语者主之。仲景伤寒论中，言妇人者，止此三条耳。活人书，言妇人伤寒治法，与男子不同，男子先调气，女子先调血，此大略之辞耳，要之脉紧无汗为伤寒，脉缓有汗为中风，热病脉洪大，中暑细弱，其证一也，当汗当下，岂必调血而后行津液耶，仲景伤寒论，不分男女，良以此欤，此论固当，犹为未也，仲景亚圣也，世医所知，仲景不知，有是理乎，圣人创物，贤者述之，事可以为天下则，圣人已先据之矣，何待世人明之乎，圣人不言，以其同诊也，后人不知汤液之源，故立为后人法，则异于男子常人，所具聪明眼者，肯以此为是乎，然以药考之，则可知也，假令桂枝芍药，固营而开卫非血药而何，麻黄防风，虽为之发汗，本治女子余疾，非血药而何，白虎小柴胡中，知母则治热，柴胡则调经，皆气中之血虚也，当归地黄，不言可知为血药，白朮人皆以为气剂，本草言能利腰脐间血，非血药乎，大抵用之在阳，便是气药，用之在阴，便是血药，若男子与女人伤寒，皆营卫受病，其证一也，何以云男先调气，女先调血也，此二句，云岐子以为治杂病法之常体，非为伤寒设也，其所以然者，以其任冲盛而有子，月事行有期，有热入血室一证，不得不异也，在妊孕不得不保，在经血不得不调，表里汗下，何尝有异也，无汗下药中增损，自有调保之义，活人云，妊娠不用桂枝半夏桃仁，柴胡汤减半夏为黄龙汤，是则是矣，必竟蓄血极而邻于死，须抵当汤丸，则安得不用，止是减剂从轻可也，故黄帝云，妇人身重毒之，何如，岐伯曰，有故无殒，亦无殒也，大聚大积，其可犯也，衰其大半而止，过者死，此所以有从轻之义，盖由诸此，以知桂枝半夏桃仁，可用处必用，不可全无，但当从轻则可耳，保安丸中有桂附牛膝，皆堕胎之剂，以其数多之中些少，是亦从轻而无妨也，又为引用，必须少而不可无也，大意如此，后之君子，更宜详定，保剂多，破剂少，破者从其保，破剂多，安剂少，安者从其破，此理不可不知。又寒热多少例，寒者多，热者少，热不为之热，热者多，寒者少，寒不为之寒。按岐伯之论，谓妊妇之用毒药，可用而不可过也，妇人怀孕谓之重身，欲用毒药以治其病者，正以内有病之故，则有病以当毒药，其子必无殒也，不惟子全，而母亦无殒也，但大积大聚，或病甚不堪，不得不用此以犯之，祇宜察其大半而止，药行彼病自渐去，若过用其药，则败损真气死矣。按男子亦有热入血室证，经云阳明病，下血譫语，此热入血室，但头汗出，刺期门，盖冲脉为血海，即血室也，男女均有之，男子下血譫语，妇人寒热似疟，皆为热入血室，迫血下行，则为胁热而利，挟血之脉，乍濇乍数，或沉伏，血热交并，则脉洪盛，大抵男子多在左手，女多在右手见之也。或问小柴胡，近世治伤寒发热，不分阴阳而用之，何也，然柴胡之苦平，乃足少阳经，伤寒发热之药，除半表半里之热，及往来寒热，小有日晡潮热也，佐以黄芩之苦寒以退热，半夏生姜之辛以退寒，人参大枣之甘温以助正气，解渴生津液，则阴阳和而邪气解矣，但太阳经之表热，阳明经之标热，皆不能解也，如用之，岂曰无害，若夹阴伤寒，面赤发热，脉沉足冷者，服之立至危殆，可不慎哉，及内虚有寒，大便不实，脉息小弱，与妇人新产发热，皆不可用也。夷坚志云，朱肱吴兴人，尤深于伤寒，在南阳，太守盛次仲疾

作，召视之，曰小柴胡汤证也，请并进三服，至晚乃觉满，又视之，问所服药安在，取视乃小柴胡散也，肱曰，古人制咀，剉如麻豆大，煮清汁饮之，名曰汤，所以入经络，攻病取快，今乃为散，滞在膈上，所以胸满而病自如也，因旋制自煮以进，两服遂安。小建中汤。方见三卷。伤寒阳脉涩，阴脉弦，法当腹中急痛者，先与小建中汤，不瘥者，与小柴胡汤主之。垣云，芍药味酸，于土中泻木为君，饴糖甘草，甘温补脾养胃为臣，水挟木势，亦来侮土，故脉弦而腹痛，肉桂太辛热，佐芍药以退寒水，姜枣甘辛温，发散阳气，行于经络皮毛为使，故名建中。大柴胡汤。柴胡〔八两〕、大黄〔二两〕、枳实〔四枚〕、半夏〔半斤〕、黄芩〔三两〕、芍药〔三两〕、生姜〔五两〕、大枣〔十二枚〕。太阳病，过经十余日，及二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡汤，呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也，与大柴胡汤下之，则愈。〔原文。下四条同〕伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者，与大柴胡汤。有人病伤寒，心烦喜呕，往来寒热，医以小柴胡与之，不除，予曰，脉洪大而实，热结在里，小柴胡安能去之，仲景云，伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者，与大柴胡汤，三服而病除，盖大黄荡涤蕴热，伤寒中要药。

〔大柴胡，酒洗，生用。〕按柴胡大黄之药，升降同剂，正见仲景处方之妙，柴胡升而散外邪，大黄降而泄内实，使病者热退气和而自愈。伤寒发热，汗出不解，心下痞鞭，呕吐而下利者，大柴胡汤主之。伤寒后脉沉，沉者内实也，下解之，宜柴胡汤。或问大柴胡，若内烦里实者，固宜用也，其呕而下利者，亦用之何也，夫治病节目，虚实二者而已，里虚者，虽便难而勿攻，里实者虽吐利而可下，经曰，汗多则便难，脉迟尚未可攻，以迟为不足，即里气未实故也，此以大柴胡主之，凡吐利，心腹濡软为里虚，呕吐而下利，心下痞鞭者，为里实也，下之当然，况太阳病，过经十余日，及二三下之后，四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡汤，呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也，与大柴胡汤下之则愈，二节病证，虽有参差，其里实同一机也，皆与大柴胡者宜也。病若二十日以上，有下证者，止宜大柴胡汤，恐承气太峻，盖伤寒过经，则正气多虚故也。有人患病伤寒，目痛鼻干，不得卧，大便不通，尺寸脉洪大已数日，一夕汗出，予谓速以大柴胡汤下之，医骇曰，阳明自汗，津液已涸，法当用蜜煎，何须苦用下药，余谓曰，予虽知蜜煎稳当，岂知大柴胡汤，乃仲景不传之妙，公安能知之，余力争，竟投大柴胡二贴愈，仲景论阳明之病，多汗者急下之，人多谓已是自汗，若又下之，岂不表里俱虚，又如论少阴云，少阴病一二日，口干咽燥者，急下之，人多谓证发于阴，得之日浅，但见干燥，若更宜下，岂不阴气愈甚，举此二端，则其可疑者，不可胜数，此仲景之书，人罕能读也，余谓仲景言急下之者，亦犹急当救表，急当救里之说，凡称急者，为立变，谓纔见汗未至，津液干燥，便速下之则为精捷，免致用蜜煎也。三阴及各证方桂枝加芍药汤。即于桂枝汤内倍加芍药。桂枝加大黄汤。即于桂枝汤内加大黄。本太阳病，医反下之，因尔腹满时痛者，属太阴也，桂枝加芍药汤主之。〔原文。下二条同〕表证未罢，而医下之，邪乘里虚，当作结胸，今不作结胸，而作腹满时痛，是属于太阴里气不和，故腹满时痛耳，时痛者有时而痛，非大实之痛也，故但与桂枝汤以解表，加芍药以和里。大实痛者，桂枝加大黄汤主之。大凡表证未罢，仍当解表，若误下以虚其里，则余邪乘虚而入内，作大实痛，曰大实痛，则非时而痛

者可例矣，故前方但倍芍药，而此则加大黄，加大黄者，取其苦寒能荡实也。或问太阴有可下者乎，曰有，经云，乃太阳证，医反下之，因尔腹满时痛，桂枝加芍药汤，大实痛，桂枝加大黄汤，易老云，此非本有是证，以其错下，脾传于胃，故为误下传也。治病必求其本，假令腹痛，桂枝加芍药，桂枝加大黄，何为不用芍药大黄之属，却于桂枝汤内加之，盖以病从太阳中来，当以太阳为本也，又如结胸证，自高而下，脉浮者不可下，故先用麻黄汤解表已，然后以陷胸汤下之，是亦求其本也，至于蓄血下焦，血结膀胱，是亦从太阳中来，侵尽无形之气，乃侵膀胱中有形之血。太阴为病脉弱，其人续自便利，设当用大黄芍药者宜减之，以其人胃气弱，易动故也。当归四逆汤。当归、桂枝、芍药、细辛〔各三两〕、甘草〔炙〕、木通〔各二两〕、大枣〔二十五枚〕。当归四逆加吴茱萸生姜汤。药即方见。手足厥，脉细欲绝者，当归四逆汤主之。〔原文下同〕若其人内有久寒者，宜当归四逆，加吴茱萸生姜汤主之。〔原文下同〕按此承上文言，虽有手足厥，脉细欲绝证候，若其人内有久寒，则加吴茱萸生姜，以散久寒而行阳气，曰久寒者，陈久之寒，对下直中寒也，明矣。下利脉大者虚也，以其强下之故也，设脉浮革，因尔肠鸣者，属当归四逆汤主之。四逆汤。方见太阳中篇。伤寒医下之，续得下利清穀不止者，当救里，宜四逆汤。〔原文。下十条同〕病发热头疼，脉反沉者，若不瘥，身体疼痛，当救其里，宜四逆汤。发热头痛，表病也，脉反沉者，里脉也，经曰表有病者，脉当洪大，今脉反沉迟，故知愈也，见表病而得里脉，则当瘥，若不瘥，为内虚寒甚，与此汤救其里。自利不渴者，属太阴，以其脏有寒故也，当温之，宜四逆辈。经言辈字者，为药性同类，惟轻重优劣不同耳，凡太阴自利不渴，师言有用理中而愈者，甚则理中加附子而获安者，凡言辈者盖加此，夫四逆汤，甘辛相合，乃大热之剂，苟轻用之，恐有过度之失，所以仲景不为定拟也，莫若以理中循循而用之，至为平稳，如不得已者，四逆方为用也。少阴病，脉沉者，急温之，宜四逆汤。少阴病，饮食入口，则即吐，心中温温欲吐，复不能吐，始得之，手足寒，脉弦迟者，此胸中实，不可下也，当吐之，若膈上有寒，饮干呕者，不可吐也，急温之，宜四逆汤。大汗出，热不去，内拘急，四肢疼，又下利厥逆而恶寒，四逆汤主之。大汗若大利而厥冷者，四逆汤主之。呕而脉弱，小便复利，身有微热见厥者，难治，四逆汤主之。吐利汗出，发热恶寒，四肢拘急，手足厥冷者，四逆汤主之。既吐且利，小便复利，而大汗出，下利清穀，内寒外热，脉微欲绝者，四逆汤主之。〔属霍乱〕麻黄附子细辛汤。麻黄、细辛〔二两〕、附子〔一枚〕。少阴病，始得之，反发热脉沉者，前汤主之。〔原文。下三条同〕或问论传经之邪，自三阳传至太阴，太阴则传少阴，此不言传经，而言始得之何也，曰传经者，古人明理之法之意如此，安可执一而论哉，夫三阳伤寒，多自太阳入，次第而传至厥阴者，固有也，其三阴伤寒，亦有自利不渴，始自太阴而入者，今少阴病始得之，反发热，正由自入，故云始得之，缘少阴无身热，而今有热，故言反发热，以不当发热而热也，为初病邪浅，故与麻黄附子细辛汤，以发散之，按六经中，但少阴证难辨，此条要看一反字，是以阴证虽云不用麻黄，今既始得之，反发热脉沉，所以用麻黄附子细辛，以温散之耳。少阴病，得之二三日麻黄附子甘草汤，微发汗，以二三日无里证，故微发汗也。详仲景发汗汤剂，各分轻重不同，如麻黄桂枝汤，青龙各半越婢等汤

，各有差等，至于少阴发汗二汤，虽同用麻黄附子，亦有加减轻重之别，故以加细辛为重，加甘草为轻，辛散甘缓之义也，其第一证，以少阴本无热，今发热，故云反也，盖发热为邪在表而当汗，又兼脉沉属阴而当温，故以附子温经，麻黄散寒，而热须汗解，故加细辛，是汗剂之重者，第二证既无表寒之可温，又无里热之可下，求其所以用麻黄附子之义，则是脉亦沉，方可名曰少阴病，身亦发热，方行发汗药，又得之二三日，病尚浅，比之前证亦稍轻，故不重脉证，而但曰微发汗，所以去细辛，加甘草，是汗剂之轻者。黄连阿胶汤。黄连〔四两〕、黄芩〔一两〕、芍药〔二两〕、阿胶〔三两〕、鸡子黄〔二枚，生用〕少阴病，得之二三日已上，心中烦，不得卧，前汤主之。〔原文〕附子汤。附子〔一枚炮〕、白朮〔二两〕、茯苓、白芍、人参。少阴病，得之一二日，口中和，其背恶寒者，当灸之，附子汤主之。〔原文。下同〕按背者，胸中之府，诸阳受气于胸中，而转行于背，内经曰，人身之阴阳者，背为阳，腹为阴，阳气不足，阴寒气盛，则背为之恶寒，若风寒在表而恶寒者，则一身尽寒矣，但背恶寒者，阴寒气盛可知，如此条是也，又或者阴气不足，阳气内陷，入于阴中，表阳新虚，有背微恶寒者，经所谓伤寒无大热，口燥渴心烦，背微恶寒，白虎加人参汤主之是也，一为阴寒盛气，一为阳气内陷，何以明之，盖阴寒为病，则不能消耗津液，故于少阴病，则曰口中和，及阳气内陷，则热烁津液为干，故于太阳病，则口燥舌干而渴也，要辨阴阳寒热不同者，当于口中润燥详之。按伤寒，以阳为主，上件病皆阴胜，几于无阳矣，辛甘皆阳也，故用附朮参苓，所以散寒而养阳，辛温之药过多，则恐有偏阳之弊，故又用芍药之酸以扶阴，经曰火欲实，本当平之，此用芍药之意也。少阴病，身体痛，手足寒，骨节痛，脉沉者，附子汤主之。桃花汤。干姜〔一两〕、赤石脂〔一斤〕、粳米〔一升〕。少阴病，下利便脓血者，桃花汤主之。〔原文不同〕少阴病，二三日，至四五日，腹痛，小便不利，下利不止，便脓血者，桃花汤主之。此证自三阳传来者，纯是热证，成无已因其下利，而曰协热，因其用干姜，而曰里寒，余谓不然，盖少阴肾水也，主禁固二便，肾水为火所灼，不能济火，火热克伐大肠金，故下利，且便脓血，此方用赤石脂，以其性寒而涩，寒可以济热，澀可以固脱，用干姜者，假其热以从治，犹之白通汤，加人尿猪胆，干姜黄连黄芩人参汤，用苓连，彼假其寒，此假其热，均之假以从治尔，经曰，寒者热之，热者寒之，微者逆之，甚者从之，逆者正治，从者反治，从少从多，观其事也，正此之谓，用粳米，恐石脂性寒，损胃，故用以和之，向使少阴有寒，别干姜一两之寡，岂足以温，赤石脂一斤之多，适足以济寒而杀人矣，岂仲景之方乎。猪肤汤。猪黑皮、白米粉。少阴病，下利咽痛，胸满心烦者主之。〔原文〕肤乃是彘猪，刮下黑皮，礼运疏云，革肤内厚皮，肤革外薄皮，语云肤浅，义取诸此。按白粉，乃白米粉也，其铅粉亦名白粉，又名定粉，又名胡粉，主治积聚痞利，与白粉不同。甘草汤。即甘草一味。桔梗汤。甘草、桔梗、连翘、薄荷、竹叶、梔子、黄芩。少阴病，二三日，咽痛者，可与甘草汤，不瘥者，可与桔梗汤。〔原文〕苦酒汤。药即方见。少阴病，咽中生疮，不能语言，声不出者，苦酒汤主之。〔原文〕半夏汤。药即方见。半夏散。药即方见。少阴病，咽中痛，半夏散及汤主之。〔原文〕或问六经伤寒，皆不言咽痛，惟少阴篇中，有咽痛咽伤之证，何也，夫少阴咽痛，乃经络所系，盖少阴之脉，上贯肝膈

，入肺，循喉咙，系舌本，故有咽伤痛之患，内经曰，所生病者，咽肿，上气噎干及痛，此经脉所系，邪气循行而致然也。白通汤。葱白〔四茎〕、干姜、附子〔一枚〕。白通加猪胆汁。药即方见。少阴病，下利，白通汤主之。〔原文。下同〕少阴病，下利，脉微者，与白通汤，利不止，厥逆无脉，干呕烦，者白通加猪胆汁汤主之。服汤脉暴出者死，微续者生。按少阴属肾，水藏也，得天地闭藏之令，主禁固二便，客寒居之，则痛而失其体，不能制水，故下利，葱白之辛，所以通阳气，姜附之辛，所以散阴寒，故即葱白而名之曰白通。或谓白通汤，及白通加猪胆汤，真武汤，与通脉四逆汤，皆为少阴下利而设，除用姜附相同，其余之药，俱各殊异，何也，曰病殊则药异，少阴下利，寒气已甚，非姜不能治，此下利之理以无殊，至兼有之证不一，则用药当各从其宜，如白通汤，用姜附以散寒止利，则加白葱以通调阳气，若利而干呕烦者，寒气太甚，内为格拒，而姜附非烦者之所宜，必呕而不纳故加人尿猪胆汁，候温冷而服之，以人尿猪胆汁，皆咸苦性寒之物，自纳而不阻，至其所则冷体皆消，热性便发，又真武汤，治少阴病，二三日不已，至四五日腹满，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，为有水气，故多或为之证，夫水气者则寒湿也，肾主之，肾病不能制水，水饮停蓄为水气，腹痛寒湿内甚也，四肢沉重，疼痛，寒湿，外甚也，小便不利，自下利者，湿甚而水谷不能别也，经曰，脾恶湿，甘先入脾，茯苓白朮之甘，以益脾逐水，寒湿所胜，平以辛热，湿淫所胜，佐以酸辛，故用附子芍药生姜之酸辛，以温经散湿，太阳篇中，小青龙汤证，亦为有水气，故多或为之证，如真武汤者，不殊此理也，通脉四逆，治少阴下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝者，为里寒，身热恶寒，而面色赤，为外热，此阴甚于内，格阳于外，不相通，与通脉四逆汤，以散阴通阳，其或为之证，依法加減而治之，已上四证，俱云下利，而兼有或为之证，不一，是以用药大同而小异也。或云白通汤，用附子凡四证，惟真武汤一证熟附，余皆生用，何也，凡附子，生用则温经散寒，非干姜佐之则不可，炮熟，则益阳除湿，用生姜相辅，允为宜矣，干姜辛热，故佐生附，而用生姜辛温，少资熟附之功，原佐使之妙，无出此理，然白通等汤，以下利为重，其真武汤证，以寒湿相搏，附子亦用炮熟，仍用生姜以佐之，其生熟之用，轻重之分，无过此理也。真武汤。方见三卷内。太阳病，发汗，汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩身瞤动，振振欲擗地者，真武汤主之。〔原文〕少阴病，二三日不已，至四五日腹痛，小便不利，四肢沉重，头痛自下利者，此为有水气，其人或欬，或小便利，或下利，或呕者主之。〔原文〕通脉四逆汤。四逆加葱〔四茎〕除甘草。少阴病，下利清谷，里寒外热者主之。〔原文。下同。〕下利清谷，里寒外热，汗出而厥者主之。四逆散。甘草、柴胡、枳实〔炒〕、芍药〔生用各一两〕。少阴病，四逆其人或欬或悸，或小便利，或腹中痛，或泄利下重者，四逆散主之。〔原文〕此寒邪传至少阴，里有结热，则阳气不能交接于四末，故四逆而不温，用枳实，所以破结气而除里热，用柴胡所以升发真阳而回四逆，甘草和其不调之气，芍药收其失位之阴，是证也，虽曰阳邪在里，甚不可下，盖伤寒以阳为四逆，有阴进之象，若复用苦寒之药以下之，则阳益亏矣，是在所忌，论曰诸四逆者，不可下之，盖为此也。大凡初服药时，无是证，服药后而生新证者，故经曰，若吐若汗若下后之证是也，即坏病也，当以何逆而治之，若初服药有是证，

服药后，只是原证如故，不见新有证候者，只是病未退，仲景所谓服汤一剂尽，病证犹在者，更作服也，汗下同法，清碧杜先生曰，阳热病难疗，阴寒病易治，盖热者传经变态不一，阴寒不传，治之亦一定法耳，仁庵严先生云，凡医他人治过伤寒，须究前证曾服何药，倘证交杂，先以重者为主，次论轻者，假如传经之邪，治有三法，在皮肤者汗之，在表里两间者和解之，在里者下之，此自外入内之治也，至若体虚之人，交接阴阳，饮食不节，则表虚中邪，又非在表可汗之法，必用大热之剂温散，经曰，阴中于邪，必内僇也，表气微虚，里气失守，故使邪中于阴也，方其里气不守，而为邪中，正气怯弱，故成僇也，故经言寒则伤营，营者血也，血寒则凝而不行，致四肢血气不接而厥，身体冷而恶风寒，附子干姜，适得其当，若寒退而热毒内攻，目中不了了，下利清水腹满，又有急下之法，此论少阴经之治法也，若寒退而手足厥，其厥乍凜，腹中痛而小便不利，又有四逆散之治法，所谓少阴传变，与太阳相同者也。猪苓汤。猪苓、茯苓、泽泻、滑石、阿胶。少阴病，下利六七日，欬而呕渴，心烦不得眠者主之。〔原文〕少阴病下利，而主此方者，分其小便，而下利自止也，渴欲饮水，小便不利，而主此方者，导其阳邪，絳溺而泄，则津液运化，而渴自愈也，然猪苓质枯，轻清之象也，能渗上焦之热，茯苓味甘，中宫之性也，能渗中焦之湿，泽泻味咸，润下之性也，能渗下焦之湿，滑石性寒，清肃之令也，能渗湿中之热，四物皆渗利，则又有汗多亡阴之惧，故用阿胶佐之，以存津液于决渎耳。乌梅丸。乌梅〔三百个〕、细辛、桂枝、人参、附子〔炮〕、黄蘗〔六两〕、黄连〔一斤〕、干姜〔十两〕、当归〔四两〕、川椒〔去目〕、苦酒〔醋也〕，浸乌梅一宿，去核蒸熟，和药蜜丸。凡厥者，阴阳气不相顺接，便为厥，厥者，手足逆冷是也。〔原文〕伤寒脉微而厥，至七八日，肤冷，其人躁，无暂安时者，此为藏厥，非为蛭厥也，蛭厥者，其人当吐蛭，今病者静，而复时烦，此为藏寒，蛭上入膈，故烦，须臾复止，乌梅丸主之。〔原文〕蛭音为，人腹中长虫，俗曰食虫是也。胃中冷必吐蛭，吐蛭人皆知为阴也，然亦有阳证吐蛭者，盖胃中空虚，既无谷气，故蛭上而求食，至咽而吐，又看别证何如，不可专以胃冷为说，会记一人阳黄吐蛭，又大发斑，阳毒证，口疮，咽吐蛭，皆以冷剂取效，是亦有阳证矣。麻黄升麻汤。麻黄、升麻、干姜、官桂、芍药、甘草、黄芩。伤寒六七日，大下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不至，咽喉不利，吐脓血，泄利不止者，为难治，麻黄升麻汤主之。仲景麻黄升麻汤，为下坏之剂，而寸脉沉迟，或厥或咽喉不利，欬嗽脓血，或下利不止，断作难治，此药有桂枝汤，有麻黄汤，有干姜芍药甘草汤，有白虎汤，内更有少阳药，黄芩是也，此是三阳合而标病，不应下而下之，坏而成肺痿也，若脉不迟者，去干姜官桂，不下下利者亦去之，寸口脉小者，去黄芩，此宜随证而加减之也，前人全用药，以其前证悉备，故用三阳标药治之，经曰，治病必求其本是也。干姜黄连黄芩人参汤。方见本汤。伤寒本自寒下，医复吐下之，寒格更逆，吐下者主之。〔原文〕白头翁汤。白头翁〔二两〕、秦皮、黄连、黄蘗〔三两〕。热利下重者，白头翁汤主之。〔原文下同〕下利欲饮水者，以有热故也，白头翁汤主之。四逆加人参汤。本方加人参〔一两〕。问曰，病发热头痛，身疼，恶寒，吐利者，此属何病，答曰，此为霍乱，自吐下又利止，复更发热也。恶寒脉微而复利，利止，亡血也，四逆加人参汤主之。〔原文〕理中丸。本

方等分蜜丸。霍乱头疼发热，身疼痛，热多欲饮水者，五苓散主之。寒多不用水者，理中丸主之。〔原文〕大病瘥后喜唾，久不了了者，胃上有寒，当此丸药温之，宜理中丸。〔原文〕适脉四逆加猪胆汁汤。以白通汤加人尿猪胆汁。吐已下断，汗出而厥，四肢拘急不解，脉微欲绝者主之。〔原文〕烧裙散。即裙裆烧灰也。伤寒阴阳易之为病，其人身体重，少气，少腹里急，或引阴中拘挛，热上冲胸，头重不欲举，眼中生花，膝胫拘急者，烧裙散主之。〔原文〕取此物者，亦以病因于阴阳感召而得，故亦以阴阳之理治之，又且五味入口，咸入肾，腐入肾，秽入肾，乃浊阴归地之意也，裙裆味咸而腐，故能入少阴烧之则温，故足以化气，化之则浊，故足以入膀胱，经曰，浊阴归六腑是也，药物虽陋，而用意至微。枳实栀子豉汤。枳实、栀子〔十四枚〕、淡豉〔四合〕。大病瘥后，劳复者枳实栀子豉汤主之，若有宿食者，加大黄如棋子大五六枚。〔原文〕浆水汤。浆水味甘酸而性凉善走，故解烦渴，化滞物，其法以炊粟米，热投冷水中，五六日，味酸生白花，色类浆故名，若浸至败者害人。牡蛎泽泻散。大病瘥后，从腰以下有水者主之。〔原文自明〕是书也，学精天地人，事备儒仙佛，所以语皆见孔，统证药方以入微字，可针茅超，前后合而擅美，向犹患于四卷之秘，未竭。先生之藏，兹获订与诸篇并行，是诚斯世之幸，但期观者玩其辞必尽索其解，勿仅大意之求用者，得其旨于以大其施，无等陈言之视，始克驱除百病，不负。先生种橘之苦心，庶几弘济群生，俾慰吾友后梓之隐念云，古海昏愚山堂后学周瑞冠多氏谨识。